

Examen Génétique / 2026

1. Dans une liaison phosphodiester entre deux nucléotides consécutifs d'une chaîne d'ADN, quelles positions hydroxyles de l'ose sont impliquées dans l'estérification du groupement phosphate ?

- A. Le C2' du premier nucléotide et le C5' du deuxième nucléotide
- B. Le C3' du premier nucléotide et le C5' du deuxième nucléotide
- C. Le C5' du premier nucléotide et le C3' du deuxième nucléotide
- D. Le C1' du premier nucléotide et le C3' du deuxième nucléotide
- E. Le C3' du premier nucléotide et le C3' du deuxième nucléotide

2. Parmi les propositions suivantes concernant les bases azotées et la structure des acides nucléiques, laquelle est exacte ?

- A. La purine est un hétérocycle simple à 6 sommets comportant 2 atomes d'azote
- B. L'uracile remplace la thymine dans l'ARN et possède un groupement méthyle en position 5
- C. La liaison N-glycosidique unit le C1' du ribose au N9 des purines ou au N1 des pyrimidines
- D. L'ADN double brin est stabilisé uniquement par des liaisons covalentes entre les deux brins
- E. La guanine est une pyrimidine présente à la fois dans l'ADN et l'ARN

3. Un technicien de laboratoire souhaite précipiter l'ADN à partir d'un lysat cellulaire. Quelle condition favorise la précipitation de l'ADN ?

- A. Abaisser la concentration en sels à un niveau très faible
- B. Ajouter de l'eau distillée afin de diminuer la force ionique de la solution
- C. Ajouter de l'éthanol en présence d'une forte concentration saline
- D. Chauffer la solution à 95°C pendant 10 minutes
- E. Abaisser le pH de la solution à 4

4. Une enzyme hydrolyse spécifiquement les liaisons phosphodiester d'un brin d'ARN messager à partir de son extrémité 3'. De quelle catégorie d'enzyme s'agit-il ?

- A. Une ADN ligase
- B. Une exonucléase
- C. Une topoisomérase
- D. Une glycosylase
- E. Une ARN polymérase

5. Parmi les nucléotides modifiés suivants, lequel constitue la coiffe ajoutée à l'extrémité 5' de l'ARNm eucaryote lors de sa maturation ?

- A. La 5-méthylcytidine
- B. La 6-méthyladénosine
- C. La 7-méthylguanosine
- D. La 2'-O-méthyladénosine
- E. La 5-méthyluridine

6. Quelle est la nature de la liaison chimique qui unit l'acide aminé à l'extrémité 3'CCA de l'ARNt ?

- A. Liaison peptidique
- B. Liaison phosphodiester
- C. Liaison carboxy-ester
- D. Liaison hydrogène
- E. Liaison N-glycosidique

7. Un échantillon d'ARN monocaténaire présente une absorbance à 260 nm plus élevée qu'un échantillon d'ADN bicaténaire de même concentration molaire en nucléotides. Quelle est la principale explication physico-chimique de ce phénomène ?

- A. L'ARN contient l'uracile dont le coefficient d'extinction est supérieur à celui de la thymine
- B. L'ARN possède un groupement 2'-OH qui augmente l'absorption des bases
- C. La structure en boucle- tige de l'ARN absorbe mieux les rayons que la double hélice.
- D. L'ARN contient une proportion plus élevée de bases puriques que l'ADN
- E. L'empilement des bases dans la double hélice d'ADN réduit l'absorbance par effet hypochrome

8. Un chercheur traite deux échantillons, l'un d'ARNm et l'autre d'ADN, avec une solution de NaOH 0,1 M pendant 30 minutes. Il observe que l'ARNm est totalement dégradé alors que l'ADN reste intact. Quelle est la principale explication de cette différence de stabilité ?

- A. L'ARN contient des bases uraciles plus sensibles aux bases que les thymines de l'ADN
- B. L'ADN est protégé par des protéines histones -
- C. L'ARN possède un groupement 2'-OH impliqué dans l'hydrolyse alcaline
- D. L'ARN est monocaténaire et donc plus exposé aux enzymes
- E. L'ADN contient plus de liaisons hydrogène qui protègent la double hélice

9. On chauffe progressivement une solution d'ADN bicaténaire jusqu'à sa dénaturation, puis on refroidit lentement la solution. Quelle séquence d'événements spectrophotométriques dans l'UV est attendue ?

- A Augmentation de l'absorbance à la dénaturation, puis retour à la valeur initiale après refroidissement lent
- B. Diminution de l'absorbance à la dénaturation, puis augmentation après refroidissement lent
- C. Aucune variation lors de la dénaturation, et augmentation après refroidissement lent
- D. Augmentation irréversible de l'absorbance même après refroidissement lent
- E. Déplacement du pic de 260 nm vers 280 nm lors de la dénaturation

10. Au niveau d'une fourche de réplication, pourquoi la synthèse d'un brin est-elle continue tandis que celle de l'autre brin est discontinue ?

- A. Parce qu'un seul des deux brins parentaux peut servir de matrice à la fois
- B. Parce que les deux brins parentaux sont antiparallèles et que l'ADN polymérase ne synthétise que dans le sens 5'→3'
- C. Parce que la concentration en dNTP est insuffisante pour synthétiser les deux brins simultanément
- D. Parce qu'il n'y a qu'une seule ADN polymérase par fourche de réplication
- E. Parce que les amorces ne sont disponibles que sur un seul des deux brins

11. Lors de la réplication de l'ADN, l'ADN polymérase nécessite une séquence amorce pour initier la synthèse. Cette contrainte enzymatique s'explique par le fait que :
- A. L'amorce fournit l'énergie nécessaire à la formation des liaisons phosphodiester
 - B. L'amorce permet le recrutement des facteurs d'élongation au niveau de la fourche de réplication
 - C. La présence d'amorce stabilise la structure en double hélice de l'ADN matrice
 - D. L'ADN polymérase ne catalyse l'addition de désoxyribonucléotides que sur une extrémité 3'-OH libre préexistante
 - E. L'amorce assure la reconnaissance du site d'origine de réplication par l'hélicase
12. Concernant la transcription chez les eucaryotes :
- A. L'ARN polymérase II synthétise les ARNr majeurs
 - B. Le brin codant est transcrit directement
 - C. La synthèse d'ARN se fait dans le sens 5' -> 3
 - D. La transcription nécessite une amorce
 - E. Les introns sont absents du transcrit primaire
13. Le facteur TFIIF intervient dans :
- A. La terminaison de la traduction
 - B. L'ouverture locale de l'ADN
 - C. La synthèse des histones
 - D. La polyadénylation
 - E. La fixation des ribosomes
14. Concernant l'épissage alternatif :
- A. Il produit plusieurs protéines à partir d'un même gène
 - B. Il survient uniquement chez les procaryotes
 - C. Il élimine tous les exons
 - D. Il bloque la transcription
 - E. Il nécessite les ribosomes
15. Concernant le code génétique :
- A. Il est ambigu
 - B. Il est universel
 - C. Un codon code plusieurs acides aminés
 - D. Il est spécifique aux eucaryotes
 - E. Les codons se chevauchent
16. Le site A du ribosome correspond :
- A. Au site de sortie de l'ARNt
 - B. Au site accepteur de l'ARNt aminoacylé
 - C. Au site de fixation de l'ADN
 - D. Au site de synthèse des lipides
 - E. Au site catalytique de réplication

17. La peptidyl-transférase est portée par :

- A. La grande sous unité ribosomal
- B. L'ADN polymérase
- C. Les histones
- D. Les facteurs sigma
- E. Les protéines membranaires

18. L'euchromatine est caractérisée par :

- A. Une forte condensation
- B. Une activité transcriptionnelle élevée
- C. Une absence d'histones
- D. Une inactivité génique totale
- E. Une réplication impossible

19. La méthylation de l'ADN concerne principalement :

- A. Les adénines
- B. Les cytosines des îlots CpG
- C. Les uraciles
- D. Les ribosomes
- E. Les protéines membranaires

20. Concernant les enhancers :

- A. Ils inhibent toujours la transcription
- B. Ils agissent uniquement en aval du gène
- C. Ils augmentent la transcription génique
- D. Ils remplacent les promoteurs
- E. Ils sont traduits en protéines

21. En génétique médicale, la notion d'hétérozygotie est fondamentale pour l'interprétation des transmissions alléliques. Concernant la localisation des allèles différents chez un individu hétérozygote pour un gène autosomique, quelle proposition décrit correctement la situation chromosomique en phase G2 du cycle cellulaire ?

- A. Les deux allèles différents sont portés par les deux chromatides sœurs d'un même chromosome répliqué
- B. L'allèle muté est systématiquement porté par le chromosome paternel, l'allèle sauvage par le chromosome maternel
- C. Les deux allèles distincts sont situés sur les deux chromosomes homologues de la paire, chaque chromosome répliqué portant deux chromatides sœurs identiques pour l'allèle qu'il contient
- D. L'hétérozygotie résulte d'une inactivation aléatoire d'un chromosome de la paire, masquant l'un des deux allèles
- E. Les allèles différents sont localisés sur des loci distincts d'un même chromosome

22. Un enfant présente un phénotype sanguin A dans le système ABO. Sa mère est de groupe O et son père de groupe AB. Concernant le génotype de cet enfant au locus ABO, quelle affirmation est exacte ?

- A. Il est nécessairement homozygote AA, l'allèle A étant dominant et s'exprimant exclusivement
- B. Il est nécessairement hétérozygote AO, la mère ne pouvant transmettre qu'un allèle O
- C. Il peut être soit AA soit AO, la transmission paternelle de l'allèle A ou B étant équiprobable
- D. Il est nécessairement homozygote, les groupes sanguins suivant un mode de transmission monogénique récessif
- E. Il est hétérozygote AO ou AB, le père de groupe AB pouvant transmettre indifféremment l'un de ses deux allèles

23. Un patient présente une mutation de type « non-sens » dans un gène autosomique de transmission récessive. Il est hétérozygote pour cette mutation. Quelle est la conséquence phénotypique la plus probable ?

- A. Le patient présente la pathologie car la protéine produite est tronquée
- B. Le patient développe systématiquement une forme atténuée de la maladie
- C. La mutation entraîne obligatoirement un décalage du cadre de lecture
- D. Le patient est asymptomatique car l'allèle normal produit suffisamment de protéine fonctionnelle
- E. Le patient ne développe pas la maladie mais ne peut transmettre la mutation qu'à ses fils

24. Selon la nomenclature officielle des mutations, la notation « c.1617C>G (p.Tyr539*) » correspond à :

- A. Une mutation non-sens créant un codon stop en position 539 de la protéine
- B. Une mutation faux-sens avec remplacement de la tyrosine en 539 par un autre acide aminé
- C. Une mutation synonyme sans modification de la protéine
- D. Une délétion de la cytosine en position 1617 entraînant un décalage du cadre de lecture
- E. Une insertion créant un nouveau codon en position 539

25. Une femme est porteuse d'une translocation robertsonienne équilibrée entre les chromosomes 14 et 15 [45,XX,rob(14;15)]. Quelle affirmation concernant sa descendance est correcte ?

- A. Tous ses enfants auront un caryotype normal à 46 chromosomes
- B. Ses gamètes sont systématiquement normaux car la translocation est équilibrée
- C. Elle présente un retentissement phénotypique sévère lié à la perte d'un chromosome
- D. Sa méiose peut produire des gamètes déséquilibrés, exposant la descendance à des monosomies ou trisomies
- E. Aucun risque sur la descendance, car le risque de monosomie ou trisomie pour la descendance est en cas de translocation robertsonienne sur les chromosomes sexuels

26. L'oxydation de la guanine en 8-oxo-guanine perturbe l'appariement normal avec la cytosine. Quelle est la conséquence mutationnelle de cette lésion après deux cycles de réplication ?

- A. Une transition GC -> AT
- B. Une transversion GC -> TA
- C. Une délétion d'un nucléotide entraînant un décalage du cadre de lecture
- D. Une insertion créant un codon stop prématuré
- E. Aucune mutation, car la 8-oxo-guanine s'apparie normalement avec la cytosine

27. L'exposition de l'ADN à des agents alkylants peut conduire à la méthylation de la guanine en position O-6 (6-O-méthyl-guanine). Quelle est la conséquence de cette modification lors de la réplication de l'ADN ?

- A. La guanine méthylée forme un dimère avec la guanine adjacente
- B. La guanine méthylée s'apparie normalement avec la cytosine par trois liaisons hydrogène
- C. La guanine méthylée s'apparie avec l'Adénine, conduisant à une transversion G=C vers T=A
- D. La guanine méthylée s'apparie avec la thymine, conduisant à une transition G=C vers A=T
- E. La guanine méthylée bloque systématiquement la progression de la fourche de réplication

28. Un patient est exposé aux rayons ultraviolets (200-300 nm). Quel type de lésion de l'ADN est spécifiquement induit par ce type d'agression ?

- A. Dimères de pyrimidine
- B. Pontages covalents 6-4 entre bases pyrimidiques situées sur des brins opposés de l'ADN
- C. Oxydation de la guanine en 8-oxo-guanine
- D. Désamination de la cytosine en uracile
- E. Alkylation de l'adénine en 3-méthyladénine

29. Un enfant présente une hypersensibilité cutanée extrême aux UV, un vieillissement accéléré, des troubles de la pigmentation et un risque accru de tumeurs. Le caryotype est normal. Quel mécanisme de réparation déficient évoquez-vous en priorité ?

- A. défaut du système de réparation des mésappariements
- B. défaut du système BER
- C. défaut du système NER
- D. défaut de réparation par recombinaison
- E. défaut du système de réparation des cassures simple brin de l'ADN

30. À propos des délétions interstitielles : cocher la proposition inexacte

- A. Elles respectent les télomères
- B. Elles nécessitent deux points de cassure
- C. Elles concernent obligatoirement deux chromosomes différents
- D. Elles entraînent la perte d'un segment intercalaire
- E. Elles peuvent être observées dans le syndrome de Prader-Willi

31. Le syndrome d'Angelman est le plus souvent lié à :

- A. Une délétion du chromosome 15 paternel
- B. Une délétion du chromosome 15 maternel
- C. Une délétion terminale du chromosome 13
- D. Une délétion interstitielle
- E. Une monosomie complète du chromosome 15

32. Concernant les maladies liées à l'empreinte génomique, cocher la proposition exacte

- A. Le phénotype dépend uniquement de la présence ou de l'absence de la mutation.
- B. L'origine parentale de l'allèle transmis peut modifier l'expression de la maladie.
- C. Les maladies à empreinte touchent uniquement les hommes.
- D. L'empreinte génomique concerne uniquement les chromosomes sexuels.
- E. Une mutation soumise à empreinte ne peut jamais être transmise à la descendance.

33. Concernant la translocation $t(8;14)(q24;q32)$ impliquant le gène MYC : Quelle proposition est fausse ?

- A Le point de cassure 8q24 correspond au locus MYC
- B. Le locus 14q32 correspond aux chaînes lourdes des immunoglobulines
- C. La translocation entraîne habituellement une perte importante de matériel génétique
- D. L'activation de MYC résulte d'un effet de position transcriptionnel
- E. Cette anomalie est typiquement observée dans le lymphome de Burkitt

34. Le syndrome de Warkany, cocher la combinaison exacte

- 1- Est diagnostiqué au caryotype
- 2- C'est une trisomie 8 de toutes les cellules de l'organisme
- 3- C'est un syndrome viable
- 4- Un syndrome uniquement observé dans le cas de trisomie 21

A-1,2,3,4 B-1,2,3 C-1,2 D 1,3 E-2,3

35. A la suite des résultats d'une analyse de sang, un médecin a proposé à une femme enceinte la réalisation du caryotype ci-dessous de son fœtus

Quelle proposition est exacte concernant ce caryotype?

35- C'est celui d'un sexe masculin dont la formule chromosomique est $2n+1=47$

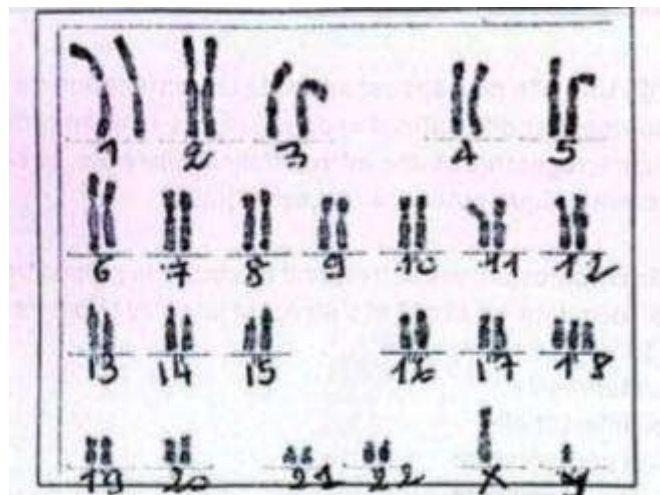
2- C'est une anomalie non équilibrée

3- Il est issu de la fécondation d'un gamète au caryotype normal par un gamète porteur de 2 chromosomes 18

4- Il est issu de la fécondation de 2 ovocytes par 1 spermatozoïde

5- C'est une polyploidie

A-1,2,3,4 B-1,2,3,5 C-1,2,4,5 D. 1,2,3 E-1,2,4



36. Un garçon de 8 ans est admis pour épisodes de saignements prolongés après des traumatismes minimes. Les examens biologiques montrent un déficit sévère en facteur VIII de coagulation. L'étude moléculaire met en évidence une anomalie chromosomique touchant le gène F8.

- 1- cette anomalie chromosomique est une inversion
 - 2- elle est due à 2 cassures sur les 2 bras d'un même chromosome
 - 3- elle entraîne la coupure du gène du facteur 8 de la coagulation
 - 4- cette anomalie touche le centromère du chromosome X
- A) 1,2,3,4 B) 1,2,3 C) 1,3,4 D) 1,3 E) 2,3,4

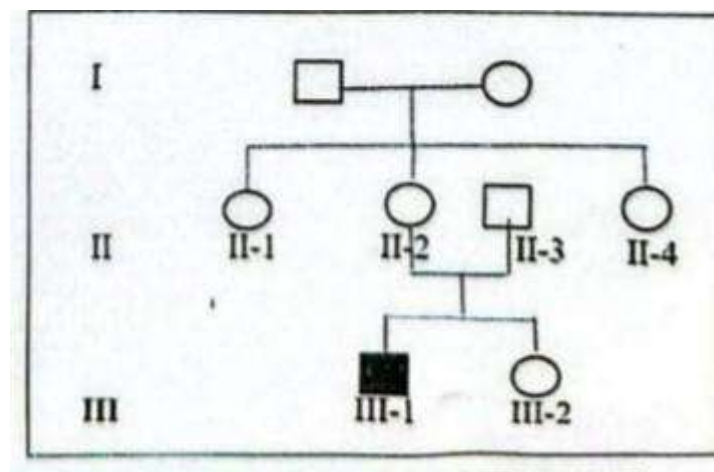
[Questions 37 et 38) : Concernant l'arbre généalogique suivant, l'étude moléculaire met en évidence chez l'enfant III-1 une anomalie de la région 15q11-q13 compatible avec un syndrome d'Angelman. On considère que la femme II-2 est porteuse d'une délétion de la région A du chromosome 15.

37. Quelle affirmation est exacte ?

- A. Tous les enfants de II-2 hériteront de la délétion.
- B. Aucun enfant de II-2 ne peut hériter de la délétion.
- C. À chaque grossesse, II-2 a 50 % de risque de transmettre la délétion.
- D. Seuls les garçons peuvent hériter de la délétion.
- E. La délétion est obligatoirement létale.

38. Quelle hypothèse explique le mieux la maladie de III-1

- A. III-1 a hérité de la délétion de sa mère
- B. III-1 a obligatoirement hérité de la délétion de son père.
- C. III-1 présente forcément une nouvelle mutation.
- D. La maladie est liée au chromosome Y.
- E. La maladie est mitochondriale



(Questions 39 et 40) Une fille de 4 ans est adressée en consultation de génétique pour retard global du développement et difficultés d'apprentissage. L'examen clinique retrouve une microcéphalie, une micrognathie et une microphthalmie bilatérale. Le caryotype met en évidence une anomalie chromosomique notée : 46,XX,del(13)(q32)

39. Cette anomalie chromosomique correspond à : cocher la proposition exacte

A Une délétion débutant en 13q32 et s'étendant jusqu'au télomère du bras long du chromosome 13

B. Une délétion terminale

C. Une délétion interstitielle

D. Une inversion péricentrique

E. Une translocation équilibrée

40. Concernant cette anomalie : cocher la proposition inexacte

A Elle résulte généralement d'un seul point de cassure

B. Les télomères ne sont pas conservés

C. Il existe une perte d'un segment distal du chromosome

D. Le chromosome atteint est raccourci

E. Le nombre total de chromosomes est diminué

Examen U1 2^{ème} / 2026

Partie 1 : Anatomie

Q1-Le thorax :

1. Le rachis dorsal présente une courbure convexe en avant
2. Le bord supérieur du sternum présente 2 incisures jugulaires
3. La 5^a côte s'articule avec le corps vertébral de T4
4. La 6^e côte s'articule avec le corps vertébral de T6
5. La 6^e côte s'articule avec le processus transverse de T6

A (1,4,5) B (4,5) C (2,3,4) D (3,4,5) E (2,4,5)

Q2-La configuration extérieure du cœur :

1. La face sterno-costale regarde en avant et à gauche
2. Le segment atrial de la face diaphragmatique est représenté par les atriums droit et gauche
3. Le segment ventriculaire de la face pulmonaire est représenté par le ventricule gauche
4. Le bord gauche supérieur sépare les faces antérieure et latérale gauche

A (1,3) B (3,4) C (2,4) D (1,4) E (2,3)

Q3 -La configuration intérieure du cœur :

1. La paroi latérale de l'atrium droit est marquée par les muscles pectinés
2. L'apex du ventricule droit est occupé par les colonnes charnues de 1^{er} et 2^a ordre
3. La paroi latérale de l'atrium gauche présente l'ostium de l'auricule gauche
4. L'ostium de l'aorte est au-dessus et à gauche de l'ostium atrio-ventriculaire gauche

A (1,4) B (2,3) C (3,4) D (1,3) E (2,4)

Q4-Les vaisseaux du cœur :

1. L'artère inter-ventriculaire antérieure se termine dans le sillon inter-ventriculaire antérieur
2. L'artère coronaire gauche irrigue le 1/3 antérieur de la cloison inter-ventriculaire
3. Les petites veines du cœur sont issues des parois cardiaques
4. Le collecteur lymphatique principal draine les ventricules

A (1,4) B (1,2) C (3,4) D (2,3) E (2,4)

Q5-Le sinus coronaire reçoit les affluents suivants :

1. La veine de Marshall
2. La petite veine coronaire
3. La veine de Galien
4. La veine interventriculaire antérieure
5. La veine postérieure du ventricule gauche

A (1,2,5) B (2,3,5) C (1,2,4) D (2,3,4) E (1,2,3)

Q6-Le péricarde :

1. Le mésocarde postérieur est la zone dépicardisée du cœur
2. Le sinus transverse est appelé cul de sac de Haller
3. La fossette rétro-cave d'Allison est un diverticule entre la veine cave supérieure et la veine pulmonaire inférieure droite
4. La vascularisation artérielle du feuillet viscéral du péricarde séreux est assurée par les artères coronaires

A (1,2) B (1,4) C(1,3) D(2,4) E (2,3)

Q7-Les rapports du cœur :

1. La face antérieure répond aux vaisseaux thoraciques (mammaires)
2. La face inférieure répond au lobe droit du foie
3. La face gauche répond au nerf phrénique gauche
4. La base répond aux vertèbres thoraciques de T4 à T8

A (1,2) B (2,4) C (1,3) D (1,4) E (2,3)

Q8 - Le système artériel :

1. L'aorte est à l'origine de toutes les artères du corps sauf celles du cœur
2. L'isthme aortique est un rétrécissement situé à l'union du segment 2 de la crosse aortique et l'aorte thoracique descendante.
3. L'aorte thoracique est placée en arrière de l'œsophage en bas
4. L'aorte abdominale est placée à droite de la veine cave Inférieure
5. Les artères surrénales supérieures sont des branches collatérales de l'aorte abdominale

A (2,3,5) B (2,4,5) C (3,4) D (1,2,3) E (2,3)

Q9 -Le système lymphatique :

1. Le conduit thoracique naît à la hauteur de L1.
2. Le conduit thoracique reçoit le tronc broncho-médiastinal gauche
3. La grande veine lymphatique droite draine l'hémi-abdomen droit
4. Les tonsilles sont des organes lymphoïdes primaires

A (1,2) B (2,4) C(1,3) D (1,4) E (2,3)

Q10-La trachée :

1. La division trachéale est projetée sur le côté droit du rachis
2. Le muscle trachéal est placé en avant de la lame transversale
3. Le losange de la trachéotomie est délimité par les bords médiaux des muscles omohyoïdiens dans son triangle supérieur
4. La trachée thoracique répond à la veine brachio-céphalique droite à droite
5. Les veines trachéales se jettent dans les veines œsophagiennes

A (1,2,4) B (1,3,5) C (1,2) D (1,2,5) E (2,3,5)

Q11 -Les bronches segmentaires droites :

1. 2 est la bronche ventrale
2. 5 est la bronche caudale
3. 6 est la bronche de Nelson
4. 8 est la bronche baso-dorsale
5. 9 est la bronche baso-latérale

A (3,5) B (1,3) C (2,3,5) D (1,2,3) E (1,2,4)

Q12-Les poumons :

1. Le sommet dépasse l'orifice supérieur du thorax
2. Le lobe moyen du poumon droit occupe la partie antéro-Inférieure du poumon
3. Les veines lobulaires suivent le même trajet que les artères lobulaires
4. La face médiastinale du poumon gauche répond au sillon du tronc artériel brachio-céphalique

A (1,2,3) B (2,3) C (1,2) D (2,4) E (1,2,4)

Q13-La plèvre :

1. Le feuillet viscéral s'enfonce dans les scissures
2. Le dôme pleural représente le feuillet viscéral qui tapisse le sommet du poumon
3. Le cul de sac costo-diaphragmatique est inférieur et médial
4. Le cul de sac costo-médiastinal antérieur est rétro-sternal

A (1,3) B (3,4) C (2,4) D (1,4) E (1,2)

Q14-Le diaphragme et le nerf phrénique :

1. Le pilier gauche est plus épais que le droit
2. Le hiatus œsophagien se projette sur T10
3. Le foramen de la veine cave Inférieure est aménagé dans le centre phrénique
4. Le péricarde adhère à la foliole ventrale
5. Le nerf phrénique descend dans le médiastin moyen

A (1,2,3) B (2,3,4) C (3,4,5) D (2,4,5) E (1,2,4)

Q15-Le larynx :

1. Le cartilage aryténoïde est formé par la réunion de deux lames latérales, dénommée proéminence laryngée
2. Le larynx possède un squelette osseux
3. Il est relié par des membranes fibreuses à l'os hyoïde
4. Le larynx est situé en regard des vertèbres cervicales C4, C5 et C6
5. L'épiglotte est reliée par différentes structures au cartilage thyroïde, à l'os hyoïde, aux aryténoïdes et à la base de langue

A (1,3) B (1,2,3) C (4,5) D (1,3,5) E (1,4,5)

Q16-Le larynx :

1. Les cartilages aryténoïdiens ont une base qui repose sur le chaton coracoïdien
2. La face antéro-interne des cartilages aryténoïdes donne Insertion aux cordes vocales inférieures
3. Les muscles à fonction sphinctérienne du larynx sont les muscles thyroaryténoïdiens et muscles cricothyroïdiens
4. L'étage sus-glottique présente une fente sagittale

A (1,2) B (1,3) C (1,4) D (2,4) E (2,3)

Q17-Concernant le médiastin supérieur, quelle(s) structure(s) y trouve-t-on ?

- A. La trachée
- B. La crosse de l'aorte
- C. Les veines brachiocéphaliques et la veine cave supérieure
- D. Les nerfs vague et phrénique
- E. Toutes les réponses sont correctes

Q18-À propos du médiastin :

- A. Le niveau de la division trachéale permet de diviser le médiastin en un médiastin antérieur et un médiastin postérieur
- B. La crosse de la veine azygos surcroise la bronche souche gauche et passe du médiastin postérieur au médiastin
- C. La crosse de l'aorte surcroise la bronche souche droite et passe du médiastin postérieur au médiastin antérieur
- D. La crosse de l'aorte surcroise la bronche souche gauche et passe du médiastin antérieur au médiastin postérieur
- E. Toutes les réponses sont fausses

Partie 2 : Histologie

Q19- Concernant le développement du tube cardiaque primitif :

- 1. Il dérive du mésoderme para-axial
- 2. Il apparaît dès la 3^e semaine du développement
- 3. Il résulte de la fusion de deux tubes endocardiques
- 4. Le ventricule primitif devient le ventricule gauche
- 5. L'aire cardiaque primitive se situe initialement en position céphalique par rapport à la membrane pharyngienne

A (1,2,3,4) B (2,3,4,5) C (3,4,5) D (2,4,5) E (2,3,5)

Q20 - La paroi cardiaque :

- 1. L'endocarde comprend un endothélium, un tissu conjonctif sous-endothélial, une couche musculo-élastique et une couche sous-endocardique
- 2. Le myocarde est plus épais à droite qu'à gauche
- 3. L'épicarde correspond à la feuille viscérale du péricarde séreux
- 4. Le myocarde contient du tissu fibreux vascularisé
- 5. L'épicarde contient du tissu adipeux

A (1,3,5) B (1,2,5) C (1,3,4) D (2,4,5) E (1,2,3)

Q21-Concernant les vaisseaux sanguins :

- 1. Les veines possèdent une média plus épaisse que les artères correspondantes
- 2. Les valvules velneuses sont des replis de l'endothélium et du tissu conjonctif sous-endothélial
- 3. Les capillaires sinusoïdes se trouvent dans la moelle osseuse et le foie
- 4. L'endothélium des capillaires continus possède des pores
- 5. Les capillaires fenêtrés se trouvent dans les reins

A (1,3,5) B (2,3,4) C (2,3,5) D (1,4,5) E (2,4,5)

Q22 -Concernant la structure de la paroi artérielle :

- 1. La média des artères élastiques contient de nombreuses lames élastiques concentriques
- 2. La limitante élastique Interne est absente dans les artères musculaires
- 3. Les artères musculaires présentent une adventice riche en vasa vasorum
- 4. Les artérioles possèdent quelques (s 3) couches musculaires lisses
- 5. La tunique interne comprend un endothélium pavimenteux simple

A (1,2,3) B (1,3,4,5) C (1,2,3,5) D (2,3,4,5) E (1,2,4,5)

Q23 - Quelle particularité distingue les cellules du tissu nodal ?

- A. Elles sont striées et plurinucléées
- B. Elles présentent de nombreux tubules T
- C. Elles sont plus petites, pauvres en myofibrilles et riches en glycogène
- D. Elles possèdent des disques Intercalaires très développés
- E. Elles sont Identiques aux cellules du myocarde contractile

Q24-Concernant l'origine embryologique des voies respiratoires :

- 1. L'épithélium des voies respiratoires dérive du mésoderme splanchnopleure
- 2. L'épithélium trachéobronchique dérive de l'entoblaste du plancher du pharynx
- 3. L'épithélium des fosses nasales est d'origine ectoblastique
- 4. Le bourgeon respiratoire apparaît à la 6^e semaine du développement
- 5. Les poumons dérivent du mésoderme para-axial

A (1,2,3) B (2,3,4) C (2,3,5) D (2,3) E (2,3,4,5)

Q25-Concernant l'épithélium alvéolaire :

- A. Les pneumocytes de type I assurent la synthèse du surfactant
- B. Les pneumocytes de type II se différencient en cellules à poussière
- C. Le surfactant tapisse la surface alvéolaire pour diminuer la tension superficielle
- D. Les pneumocytes de type II sont des cellules plates à noyau aplati
- E. Les pneumocytes de type I représentent une bordure ciliaire

Q26- Concernant la structure histologique de la trachée :

- A. L'épithélium trachéal est un épithélium pavimenteux stratifié
- B. Les glandes séro-muqueuses se trouvent dans la sous-muqueuse
- C. Les cellules caliciformes sont absentes dans la trachée normale
- D. La trachée présente des anneaux cartilagineux hyalins Incomplets
- E. Le muscle trachéal lisse ferme la partie antérieure de l'anneau cartilagineux

Q27-Concernant les bronches et les bronchioles :

- 1. Les bronches intrapulmonaires possèdent une muqueuse cillée et des glandes séro-muqueuses
- 2. Les bronchioles terminales contiennent encore du cartilage hyalin
- 3. Les bronchioles respiratoires portent à la fois un épithélium cubique et des zones alvéolées
- 4. Les cellules de Clara sécrètent des protéines protectrices et du surfactant
- 5. Les bronches extra-hilaires sont dépourvues de muscle lisse

A (1,3,5) B (1,2,3) C (3,4,5) D (1,4,5) E (1,3)

Q28 -Concernant la moelle osseuse rouge hématogène :

- 1. Elle est présente uniquement chez le nouveau-né
- 2. Elle contient des sinusoides sanguins bordés par un endothélium discontinu
- 3. Les adipocytes y sont absents
- 4. C'est le siège de l'hématopoïèse adulte
- 5. Elle est entourée d'une capsule fibreuse

A (2,4) B (2,4,5) C (1,2,4,5) D (2,3,4,5) E (2,5)

Q29-Concernant l'organisation de la moelle osseuse hématogène :

1. Les cellules souches hématopoïétiques reposent sur la lame basale des sinusoides
2. Les mégacaryocytes émettent leurs prolongements cytoplasmiques à travers la paroi des sinusoides
3. Les réticulocytes sont des cellules anucléées
4. Les myéloblastes y assurent la production des globules rouges
5. Les lymphocytes B mûrissent dans la moelle osseuse

A (1,2,3) B (2,3,4) C (2,3,5) D (2,4,5) E (2,3)

Q30-Concernant le thymus :

1. Il dérive des troisième et quatrième poches branchiales ectoblastiques
2. Il contient une zone corticale riche en lymphocytes immatures
3. La médullaire thymique contient les corpuscules de Hassall
4. Les capillaires thymiques sont fenêtrés pour faciliter le passage des antigènes
5. Il reste fonctionnel toute la vie sans involution

A (1,2,3) B (2,3) C (2,3,4) D (3,4) E (3,4,5)

Q31-Concernant le ganglion lymphatique :

1. La zone corticale profonde est riche en lymphocytes T
2. Les follicules lymphoïdes primaires contiennent des centres germinatifs
3. La médullaire contient des cordons riches en lymphocytes B et plasmocytes
4. L'afflux lymphatique se fait par les vaisseaux efférents situés au hile
5. Le sinus sous-capsulaire est absent chez l'adulte

A (1,2) B (1,3) C (1,3,5) D (3,5) E (3,4,5)

Q32-Concernant la rate :

1. La pulpe blanche contient des artérioles centrales entourées de gaine lymphoïde T-dépendante
2. La pulpe rouge est composée de cordons de Billroth et de sinusoides spléniques
3. La rate possède un cortex et une médullaire comparables au thymus
4. Les sinus veineux spléniques sont tapissés par un endothélium continu
5. La capsule splénique est fine et dépourvue de fibres musculaires lisses

A (1,2,5) B (2,3,4) C (1,3,5) D (1,2) E (1,2,4,5)

Q33-Quelle est la principale controverse histologique concernant la vascularisation splénique

- A. L'origine de l'artère splénique
- B. La présence de capillaires sinusoides
- C. Le rôle des veines trabéculaires
- D. L'absence de barrière endothéliale
- E. L'existence d'une double circulation ouverte et fermée

Partie 3 : Physiologie

Q34-Effet du système nerveux sympathique sur le cœur :

- A. Il diminue la fréquence cardiaque (effet chronotrope -)
- B. Il réduit la conduction auriculo-ventriculaire (effet dromotrope -)
- C. Il augmente la contractilité myocardique (effet inotrope +)
- D. Il agit uniquement sur le nœud sinusal
- E. Il inhibe la dépolarisation diastolique lente

Q35-Automatisme cardiaque :

- A. Il dépend exclusivement du système nerveux sympathique
- B. Il est lié à la dépolarisation diastolique lente (DDL)
- C. Il correspond à une contraction sans activité électrique
- D. Il est absent au niveau du nœud sinusal
- E. Il résulte de la présence d'un potentiel de repos stable

Q36-Phase de contraction isovolumétrique :

- A. La valve aortique est ouverte
- B. Le volume sanguin ventriculaire diminue rapidement
- C. Les deux valves mitrale et aortique sont fermées
- D. La pression ventriculaire reste stable
- E. Le sang est éjecté vers l'aorte

Q37-Bruits cardiaques et foyers d'auscultation :

- A. B1 entendu au foyer mitral - fermeture des valves auriculo-ventriculaires - début de la systole
- B. B1 entendu au foyer aortique - ouverture des valves sigmoïdes - fin de la systole
- C. B2 entendu au foyer tricuspide - ouverture des valves auriculo-ventriculaires - début de la diastole
- D. B2 entendu au foyer mitral - fermeture des valves sigmoïdes - fin de la diastole
- E. B1 et B2 sont tous deux des bruits de haute fréquence

Q38-Débit sanguin coronaire (DSC) :

- A. Le DSC représente 100 % du débit cardiaque total
- B. Le DSC normal est d'environ 250 ml/min, soit 5 % du débit cardiaque
- C. Le DSC diminue pendant l'effort
- D. Il est identique en systole et en diastole au niveau des deux ventricules
- E. Le DSC est maximal en systole pour le ventricule gauche

Q39- Régulation du débit sanguin coronaire (DSC) :

- A. Le DSC s'adapte aux besoins en O₂ du myocarde tant que la pression de perfusion est comprise entre 70 et 140 mm
- B. Le DSC reste inchangé lors des variations de la fréquence cardiaque
- C. Une pression de perfusion > 140 mmHg entraîne une vasodilatation coronaire
- D. Une pression de perfusion < 70 mmHg entraîne une vasoconstriction coronaire
- E. L'autorégulation du DSC dépend du système nerveux autonome

Q40-Débit cardiaque (Qc) et sa régulation :

- A. Le débit cardiaque correspond au volume de sang éjecté par les oreillettes par unité de temps
- B. Le débit cardiaque est identique chez tous les individus, quel que soit leur âge ou leur taille
- C. Le système nerveux sympathique diminue la fréquence cardiaque et le débit cardiaque
- D. L'augmentation de la précharge augmente le débit cardiaque en augmentant le volume d'éjection systolique
- E. Une augmentation de la postcharge augmente toujours le débit cardiaque

Q41-Régulation de la pression artérielle (PA) :

- A. La régulation de la volémie est le principal mécanisme de régulation à court terme de la PA
- B. Les mécanorécepteurs répondent aux variations brutales de la PA comprises entre 50 et 200 mmHg
- C. Le système rénine-angiotensine diminue la pression artérielle par vasodilatation
- D. Les volorécepteurs détectent les variations du taux d'oxygène dans le sang
- E. Le facteur auriculaire natriurétique (FAN) provoque une vasoconstriction intense

Q42-Mesure de la PA par méthode auscultatoire :

- A. Le brassard doit être gonflé à une pression légèrement inférieure à la pression systolique
- B. Le brassard doit être placé sur le poignet
- C. La première perception du bruit indique la pression artérielle systolique
- D. Le bruit disparaît immédiatement après la pression systolique
- E. La pression diastolique correspond au moment où les sons deviennent plus forts

Q43-Courbe $\Delta V / \Delta P$ (Compliance) thoraco-pulmonaire :

- A. À 60 % de la capacité vitale se situe le volume d'équilibre de l'ensemble thoraco pulmonaire
- B. Le niveau ventilatoire de repos (NVR) correspond à la capacité résiduelle fonctionnelle
- C. À haut volume pulmonaire, le poumon exerce une force de rétraction et le thorax une force de distension élastique et l'ensemble tend à augmenter le volume
- D. À bas volume pulmonaire, le thorax tend à diminuer de volume et à l'inverse le poumon tend à augmenter de volume
- E. À bas volume pulmonaire, la force de rétraction pulmonaire dépasse la force de distension thoracique

Q44-Volume sanguin total (VST) :

- A. 3 % du poids du corps
- B. 5 % du poids du corps
- C. 8 % du poids du corps
- D. 12 % du poids du corps
- E. 15 % du poids du corps

Q45-Une leucopénie traduit généralement :

- A. Une infection bactérienne
- B. Une infection virale
- C. Une augmentation du nombre de globules blancs
- D. Une augmentation des plaquettes
- E. Un excès de fibrinogène

Q46-Le facteur de Von Willebrand :

- A. Est une enzyme hépatique
- B. Est synthétisé uniquement par le foie
- C. Favorise l'adhésion plaquettaire au collagène
- D. Est un anticoagulant physiologique
- E. Est un dérivé du fibrinogène

Q47-L'hémostase primaire correspond :

- A. À la formation du réseau de fibrine
- B. À l'activation du facteur XII
- C. À l'occlusion de la brèche vasculaire par les plaquettes
- D. À la dissolution du caillot
- E. À la libération de plasmine

Q48-Première réaction après une lésion vasculaire :

- A. Une vasodilatation réflexe
- B. Une vasoconstriction localisée
- C. Une agrégation plaquettaire immédiate
- D. Une activation enzymatique du fibrinogène
- E. Une fibrinolyse

Q49- La vitamine K est nécessaire à la synthèse de :

- A. Facteurs I, II, V, X
- B. Facteurs II, VII, IX, X
- C. Facteurs III, IV, V
- D. Facteurs VIII, IX, XI
- E. Facteurs V, VII, VIII, X

Q50-Surfactant :

- A. Il est synthétisé par les pneumocytes de type I
- B. Il favorise la formation d'une Interface air-liquide à l'intérieur de l'alvéole
- C. Il est uniquement constitué de protéines hydrosolubles
- D. Il ne commence à être produit qu'à la naissance
- E. Il assure la stabilité alvéolaire et maintient l'espace alvéolaire sec

Q51-Volume de l'espace mort anatomique :

- A. Augmente chez le sujet obèse
- B. Diminue en cas de respiration rapide et superficielle
- C. Est appelé également espace mort alvéolaire
- D. Est un mélange équilibré d'air frais et non frais
- E. Est constitué uniquement d'air non frais

Q52- La carbaminohémoglobine est une forme de transport sanguin de :

- A. L'acide carbonique
- B. Le gaz carbonique
- C. Le monoxyde de carbone
- D. L'oxygène et le gaz carbonique
- E. Le gaz carbonique et le monoxyde de carbone

Q53-Séjour en haute altitude entraîne, sauf

- A. Une hypoventilation
- B. Un effet shunt
- C. Une augmentation de 2,3-DPG
- D. Une déviation vers la droite de la courbe de Barcroft
- E. Une vasoconstriction pulmonaire

Q54- Une bradypnée est une réponse ventilatoire rétroactive secondaire à :

- A. Un état d'acidose
- B. Une baisse de la PaO₂
- C. Une section du nerf vague
- D. Le réflexe de Hering-Breuer
- E. Un accident à l'étage bulbaire

Partie 4: Biophysique

Énoncé 01 : Un patient présente une polyglobulie sévère, entraînant un hématicrite très élevé. Cette condition est associée à une hypertension artérielle et des signes d'hypoperfusion périphérique. L'analyse biophysique se concentre sur l'écoulement du sang dans un vaisseau de rayon R , longueur L , sous un gradient de pression ΔP .

Q55-Viscosité sanguine et taux de cisaillement :

- A. Le sang est un liquide newtonien, donc η est constante quel que soit α
- B. Le sang est non newtonien ; sa viscosité augmente lorsque le taux de cisaillement augmente (rhéo-épaississement)
- C. Le sang est non newtonien ; la viscosité dépend de l'hématocrite et diminue lorsque le taux de cisaillement augmente
- D. La viscosité du sang ne dépend que de l'hématocrite
- E. Toutes les réponses fausses

Q56-Augmentation de la viscosité apparente (η_{app}) :

- A. Augmente la résistance vasculaire et diminue le débit
- B. Diminue la résistance vasculaire
- C. N'affecte que marginalement le débit
- D. Maintient le débit constant par augmentation de L
- E. Toutes les réponses fausses

Q57-Vasoconstriction et augmentation de la viscosité :

- A. L'augmentation de la viscosité a le plus d'impact
- B. La diminution du rayon a le plus d'impact (puissance 4)
- C. Les deux facteurs ont un effet similaire
- D. La résistance ne dépend pas du rayon
- E. Toutes les réponses fausses

Q58-Régime turbulent et sténose :

- A. Le régime turbulent apparaît lorsque Re est faible (< 2000)
- B. Le régime turbulent est moins bruyant que le régime laminaire
- C. Le régime turbulent est audible sous forme de souffle
- D. L'augmentation de la vitesse n'a pas d'impact sur le régime d'écoulement
- E. Toutes les réponses fausses

Q59 - Conséquence d'un faible taux de cisaillement :

- A. La viscosité diminue
- B. Les macromolécules plasmatiques se dispersent
- C. Les hématies s'agrègent en rouleaux, augmentant la viscosité
- D. Le profil de vitesse devient parfaitement parabolique
- E. Toutes les réponses fausses

Q60-Position allongée pour mesure de la PA :

- A. Pour éliminer l'effet de la gravité
- B. Pour augmenter l'effet de la gravité
- C. Pour mesurer l'effet de la gravité
- D. Pour garantir une mesure précise
- E. Toutes les réponses fausses

Examen U2 2^{ème} / 2026

Partie 1 : Anatomie

Cocher la réponse juste pour toutes les questions

Q1/ La cavité buccale et les glandes salivaires :

1. Le philtrum marque la lèvre supérieure
2. Le voile du palais se continue en haut par l'uvule
3. Le corps de la langue est fixé sur l'os hyoïde
4. Le canal de stenson est le canal excréteur de la parotide
5. La glande submandibulaire est paire

A(1,2,4) B(2,3,5) C(2,4,5) D(1,4,5) E(1,3,4)

Q2/ Le pharynx :

1. Les parois latérales du rhino-pharynx présentent l'ostium pharyngien de la trompe auditive
2. Les piliers du voile du palais limitent la tonsille palatine
3. Le fascia péri-pharyngien tapisse la face profonde des muscles du pharynx
4. L'innervation motrice est assurée par le vague et le sympathique

A (1.2) B(1.4)C(1.3)D(2.4) E(2.3)

Q3/ Parmi les artères du pharynx ;

- A. L'artère pharyngienne ascendante
- B. L'artère palatine ascendante
- C. L'artère ptérygo-palatine
- D. L'artère thyroïdienne supérieure
- E. Toutes les réponses sont justes

Q4/ Le bloc duodeno-pancréatique :

1. Est accolé par le fascia de Treitz
2. Répond aux vaisseaux mésentériques inférieurs dans sa loge
3. L'artère pancréatico-duodénale inférieure est une branche de la mésentérique supérieure.
4. Les arcades veineuses se jettent dans la veine cave inférieure.
5. Les lymphatiques sont tributaires des chaînes lymphatiques hépatiques.

A (1.2,3) B(1.3)C(3,4,5) D(1,3,5) E(1.3,4)

Q5/Le jéjuno-iléon :

1. Les anses grêles du groupe gauche sont allongées transversalement
2. Chaque anse grêle présente deux faces planes
3. La racine du mésentère mesure 5 à 6 mètres

A (1.2) B(1.4)C(3,4) D(2.4) E(1,3)

Q6/ Le jéjuno-iléon :

1. Les artères naissent du bord droit de l'artère mésentérique supérieure
2. La veine mésentérique supérieure est à gauche de l'artère mésentérique supérieure
3. Les lymphatiques aboutissent au tronc lombaire gauche
4. Le plexus mésentérique supérieur est une extension du plexus coeliaque

A(1.2) B(1.4)C(3,4) D(2.4) E(1,3)

Q7/ Les parties libres du colon :

1. Le 1/3 gauche du colon transverse
 2. Le colon iliaque
 3. Le caecum
 4. Le colon transverse à gauche de D2
 5. Le colon transverse en entier
- A(1,2,3,4) B(1,3,4) C(1,2,3) D(1,3,4,5) E(2,4,5)

Q8/ Le caecum peut avoir une situation :

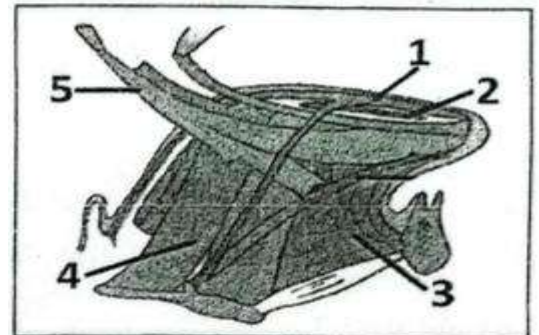
- 1., Pelvienne
 2. Sus-hépatique
 3. Sus-iliaque
 4. Ombilicale
- A(1,2,3) B(1,2,3,4) C(2,4) D(1,3) E(2,3)

Q9/ La rate :

1. Elle est maintenue par le pédicule splénique
 2. La face viscérale est médiale
 3. Le bord supérieur sépare la face diaphragmatique de la surface rénale
 4. l'artère splénique est placée en bas de la veine splénique
- A(3,4) B(1,4) C(1,2) D(2,4) E(2,3)

Q10/ Le schéma ci-joint :

1. Le muscle longitudinal supérieur
 2. Le muscle longitudinal inférieur
 3. Le muscle mylo-hyoidien
 4. Le muscle hyo-glosse
 5. Le muscle palato-glosse
- A(1,4) B(2,3,5) C(1,2,4,5) D(1,4,5) E(3,4)



Q11/ L'œsophage

1. La jonction pharyngo-œsophagienne, est au niveau de C3.
 2. Il fait suite au pharynx au niveau du bord inférieur du cricoïde.
 3. L'œsophage cervical répond en avant à la trachée et le nerf récurrent droit.
 4. La coupe horizontale passant par Th 4 correspond au segment interazygo-aortique.
- A(1,2) B(1,3) C(1,4) D(2,3) E(2,4)

Q12/ Le foie

1. Les moyens de fixité : la veine porte, les replis péritonéaux et le grand omentum.
 2. Sa face supérieure, répond à la plèvre, au poumon droits et à la masse cardio-
 3. Le secteur latéral droit, comprend deux segments le VI(antéro-inférieur) et le VII péricardique(postéro-supérieur).
 4. Le segment rétro-duodéno-pancréatique du pédicule hépatique concerne seulement le conduit cholédoque.
- A(1,2,4) B(2,3,4) C(1,2,3,4) D(2,3) E(2,4)

Q13/ La paroi antéro-latérale de l'abdomen

1. Ses repères osseux sont représentés par l'appendice xiphoïde, le rebord costal, les épines iliaques, les crêtes iliaques, et en bas les deux épines du pubis.
2. Ces formations musculaires sont doublées en profondeur par un plan fibreux, le fascia transversalis et par le péritoine pariétal.
3. La gaine des droits : Dans ses 2/3 supérieurs est très faible en arrière où elle n'est constituée que par le fascia transversalis
4. L'étage sus-mésocolique contient l'œsophage abdominal, l'estomac, l'intestin grêle, et le colon.

A(1,2,4) B(1,4) C(1,2) D(2,3) E(2,4)

Q14/ Le rectum

1. Le cap du rectum, est situé entre en crânial, le rectum pelvien, en caudal, le rectum périnéal.
2. Le rectum pelvien présente des plis transversaux permanents de forme semi-lunaire valvules rectales de (Houston)
3. Le segment péritonéal, le péritoine descend obliquement sur les faces antérieure et postérieure du rectum.
4. Les artères rectales inférieures naissent de chaque côté des artères hypogastriques

A(1,2) B(1,4) C(1,2,3) D(2,3) E(2,4)

Q15/ L'estomac :

1. L'angulus est la petite courbure, qui débute au cardia, descend verticalement puis décrit un coude.
2. Le cardia, regarde à droite, en haut et en avant, en regard de T11, à deux cm à gauche de la ligne médiane.
3. La pars flaccida est la partie centrale, elle est en avant du vestibule de la bourse omentale et de la naissance du tronc cœliaque.
4. Rapports péritonéaux et moyens de fixité sont à droite les deux feuillets de péritoine viscéral forment le petit omentum,

A(1,2,3) B(1,2,4) C(1) D(2,3) E(1,2,3,4)

Q16/ L'estomac

- A. l'irrigation artérielle est sous la dépendance du tronc cœliaque, né de la face antérieure de l'aorte
- B. L'artère gastrique droite ou pylorique, est une branche de bifurcation de l'artère gastrique droite qui se jette dans la veine cave inférieure
- C. Le cercle de la petite courbure est constitué par la veine gastrique gauche et la veine gastroduodénale.
- D. Projection pariétale le 1/3 supérieur de la face antérieure répond à la paroi thoracique et qui correspond à la face inférieure du poumon gauche.
- E. Toutes les réponses sont justes.

Q17/ Le foie :

1. Le sillon de la veine cave inférieure se trouve sur sa face dorsale.
2. Sur sa face inférieure, on retrouve le hile hépatique
3. Sur sa face inférieure se trouve le lobe caudé (de lobe de Spiegel).
4. Les rapports de sa face inférieure se font avec la presque totalité des organes susmésocoliques.

A (1,2) B (2,3) C(1,2,3,4) D(1,4) E(1,3)

Q18/

- A. En arrière de l'estomac, la bourse omentale communique avec le vestibule par le foramen bursaeomentalis.
- B. La partie crâniale de la bourse omentale, répond à la poche rétro-gastrique.
- C. Segment hilaire: les branches terminales de la veine porte occupent le plan postérieur, du pédicule hépatique.
- D. L'artère hépatique commune naît du tronc coélique, elle donne l'artère hépatique propre qui monte sur le flanc gauche de la veine porte.
- E. Toutes les propositions sont justes.

Q19/

- A. Le cardia, regarde à droite, en regard de T10, à deux cm à droite de la ligne médiane.
- B. Le bord libre du petit omentum, est étendu de D3 (3ème duodénum) en bas au hile du
- C. Le lobe carré est entre la gouttière de la veine cave inférieure et le sillon du ligament foie en haut.
- D. Dans l'étage sous-mésocolique la face postérieure de l'estomac répond à l'angle rond duodéno-jéjunal, et les premières anses grêles du jéjunum.
- E. La petite courbure entre en rapport avec la région coeliaque de Luschka placée en avant du petit omentum.

Q20/

1. Le muscle oblique externe de l'abdomen est le plus profond et le plus étendu.
2. La ligne blanche est un raphé médian, fibreux xypho-pubien, formé par l'entrecroisement des fibres musculaires de la paroi antéro-latérale de l'abdomen.
3. En caudal, l'espace sous-péritonéal, compris entre le péritoine pariétal et le plancher pelvien.
4. La pars condensa est la portion par où passe l'artère hépatique droite

A (1,2) B (3) C(3,4) D(4) E(1,3)

HISTOLOGIE : (Cochez la réponse juste)

21- Parmi les éléments suivants, lequel n'appartient pas au stroma de la villosité intestinale

- A- Fascicules de fibres musculaires lisses
- B- Tissu conjonctif glandulaire
- C- Vaisseaux lymphatiques
- D- Capillaires sanguins
- E- Des fibres nerveuses

22- Les plaques de Peyer :

- A- Sont des nodules séreux
- B- Sont superficielles uniquement
- C- Touchent muqueuse et sous-muqueuse
- D- Sont absentes chez l'adulte
- E- Sécrètent des enzymes digestives

23- L'appendice se distingue du côlon par :

- A- Villosités longues
- B- Cryptes beaucoup plus profondes
- C- Anneau lymphoïde quasi circulaire
- D- Absence totale de glandes
- E- Épithélium stratifié

24- Le parenchyme intra lobulaire du foie comporte les éléments suivants sauf un lequel ?

- A- Des cellules hépatiques
- B- Des capillaires sanguins
- C- Des canalicules biliaires
- D- Des capillaires lymphatiques
- E- Des fibres grillagées

25- Le vaisseau efférent du foie est :

- A- La veine porte
- B- La veine cave inférieure
- C- L'artère hépatique
- D- La veine sus hépatique
- E- L'aorte

26- Le système vasculaire fonctionnel du lobule hépatique est :

- A- Un système vasculaire purement veineux intercalé entre la branche de la veine porte et la veine centro lobulaire
- B- Un système vasculaire provenant des ramifications de l'artère hépatique
- C- Un système artério-veineux intercalé entre l'artère hépatique et la veine porte
- D- Un système vasculaire artériel représenté par le réseau capillaire sinusoidé
- E- Un système vasculaire purement veineux intercalé entre la veine hépatique et la veine porte

27- Le sang qui pénètre dans le foie par l'artère hépatique :

- A- Est fortement oxygéné.
- B- Chemine dans le système fonctionnel du foie
- C- Contient des métabolites de l'hémoglobine produits dans la rate.
- D- Est déversé dans des capillaires vrais inter hépatocytaires
- E- Contient de la bile formée par les hépatocytes à partir des métabolites.

28- Les canaux biliaires intra hépatiques sont des conduits véhiculant la bile et délimités par

- A- Un épithélium cylindrique pseudostratifié
- B- Un épithélium cubique simple
- C- Un épithélium endothéliforme dépourvu de membrane basale
- D- Une simple dépression en gouttière des parois des cellules hépatiques adjacentes.
- E- Une simple dépression en gouttière des parois des cellules endothéliales adjacentes.

29- Quel canal pancréatique est entouré d'un sphincter musculaire lisse ?

- A- Canal interlobulaire
- B- Tube intercalaire
- C- Canal intra-lobulaire
- D- Canal de Santorini
- E- Canal de Wirsung

30- l'épithélium de la muqueuse buccale est :

- A. Prismatique simple kératinisé
- B. Pavimenteux pluristratifié non kératinisé sur toute la cavité buccale
- C. Pavimenteux pluristratifié non kératinisé sauf gencive et palais osseux
- D. Cubique stratifié
- E. Repose directement sur le muscle

31-Les papilles caliciformes :

- A. Sont dispersées
- B. Ne contiennent pas de bourgeons du goût
- C. Sont au nombre de 9 à 11 disposées en V lingual
- D. Sécrètent l'amylase
- E. Ne présentent pas de sillon

32-Les glandes de Von Ebner :

- A. Sont muqueuses
- B. S'abouchent au fond du vallum
- C. Sécrètent des mucines
- D. Sont endocrines
- E. Appartiennent à la glande sublinguale

33-La glande salivaire purement séreuse est :

- A. Sublinguale
- B. Sous-maxillaire
- C. Parotide
- D. Glandes accessoires
- E. Von Ebner

34-Le croissant de Gianuzzi correspond à :

- A. Cellules muqueuses centrales
- B. Cellules séreuses périphériques
- C. Canal intercalaire
- D. Canal strié
- E. Cellules endocrines

35-La musculature œsophagienne est :

- A. Toujours lisse
- B. Toujours striée
- C. Striée en haut, mixte au milieu, lisse en bas
- D. A trois couches
- E. Sans plexus

36-Les cellules principales gastriques sécrètent :

- A. HC
- B. Facteur intrinsèque
- C. Pepsinogène
- D. Gastrine
- E. Histamine

37-Les cellules pariétales sécrètent :

- A. Pepsine
- B. Mucine
- C. HCl et facteur intrinsèque
- D. Gastrine
- E. Sérotonine

Partie 3 : LA PHYSIOLOGIE

38. La sécrétion salivaire :

- 1/ Est contrôlée par le système nerveux autonome
- 2/ Est stimulée par le parasympathique
- 3/ Est inhibée par le sommeil
- 4/ Dépend d'une régulation hormonale
- 5/ Est inhibée par le sympathique

A / 1, 2, 4 B/ 1, 3, 4, 5 C/2, 3, 4 D/ 1,2, 3 E/ 3, 4, 5

39. Concernant la déglutition : cocher la réponse fausse

- A Elle permet le passage du bol alimentaire vers l'estomac
 - B/Le temps buccal est volontaire
 - C/ Le temps pharyngien est involontaire
 - D/ Le temps œsophagien débute par la relaxation du SSO
 - E/ La respiration se poursuit normalement pendant le temps pharyngien
40. À propos de la motricité de l'œsophage : cocher la réponse fausse
- A/ Le péristaltisme primaire est déclenché par la déglutition
 - B/ Le péristaltisme secondaire nécessite obligatoirement une déglutition
 - C/ Le SIO est une zone de haute pression
 - D/ Le NO et le VIP favorisent la relaxation du SIO
 - E/ Le péristaltisme est contrôlé par le système nerveux entérique

41. La régulation paracrine de la sécrétion gastrique implique les médiateurs suivants :

- 1/ l'histamine
 - 2/ la somatostatine
 - 3/ la gastrine
 - 4/ le peptide vasoactif intestinal (VIP)
- A/1+2 B/ 1+3 C/ 1+2+3 D/ 1+2+4 E/ 1+2+3+4

42. La cimetidine bloque la sécrétion acide gastrique par :

- A/ l'inhibition de la pompe H⁺/K⁺ ATPase des cellules pariétales
- B/ l'inhibition de la sécrétion de la gastrine par les cellules G
- C/ le blocage des récepteurs H₂ des cellules bordantes
- D/ le renforcement de la sécrétion des prostaglandines
- E/ toutes les propositions sont justes.

43. Concernant la motricité gastrique, la relaxation réceptrice est :

1/ une fonction de l'estomac proximal

2/ une réponse motrice préprandiale

3/ un réflexe long vago-vagal

4/ abolie par la vagotomie

A/1+2 B/1+3 C/1+2+3 D/ 1+3+4 E/2+3+4

44. Le rôle principal de la bile est :

A/ La digestion des protéines

B/ L'absorption des vitamines hydrosolubles

C/ L'émulsification des lipides

D/ La neutralisation de l'acidité gastrique

E/ La sécrétion d'enzymes digestives

45. L'hormone responsable principalement de la vidange vésiculaire est :

A/ La sécrétine

B/ La gastrine

C/ La CCK

D/ La somatostatine

E/ Le VIP

46. L'enzyme pancréatique sécrétée sous forme déjà active est :

A/Le trypsinogène

B/ La chymotrypsine

C/ L'amylase pancréatique

D/ La procarboxypeptidase

E La proélastase

47. La sécrétine stimule principalement :

A/ La sécrétion enzymatique pancréatique

B/ La contraction de la vésicule biliaire

C/ La sécrétion d'eau et de bicarbonates pancréatiques

D/ La sécrétion d'acide gastrique

E/ La sécrétion de bile concentrée

48. Le passage du fructose à travers la membrane apicale de l'entérocyte se fait par :

A/ Un symport Na^+ /fructose

B/ Un transport actif primaire

C/ Une diffusion facilitée Na^+ -indépendante

D/ Un cotransport H^+ /fructose

E/ Une endocytose

49. L'étape clé qui déclenche l'activation en cascade des enzymes protéolytiques pancréatiques est

A/ L'action de la pepsine gastrique

B/ L'activation du trypsinogène par l'entérokinase

C/ La libération de CCK

D/ L'action des peptidases intracytoplasmiques

E/ La dénaturation acide des protéines

50. L'absorption intestinale de la vitamine B12 se fait :

A/ Dans le jéjunum par diffusion passive

B/ Dans le duodénum via la transcobalamine II

C/ Dans l'iléon sous forme libre

D/ Dans l'iléon sous forme complexe avec le facteur intrinsèque

E/ Dans le côlon par transport actif

51-Cocher la proposition exacte parmi les suivantes : Une cuprémie et une ceruléoplasminémie basses sont rencontrées dans :

1-Maladie de Wilson

2-Maladie de Menkes

3-brulures étendues

4-défaut d'absorption du cuivre alimentaire

A-1, B-1,2,3 C-1, 3, 4 D-2, 3, 4 E-1, 2, 3, 4

52- Quelle est la principale cause de toxicose cuprique aigue ?

A-maladie de Wilson

B-cirrhose biliaire primitive

C-hémopathies malignes

D-Contamination de l'alimentation par le cuivre de la vaisselle

E-maladie de Menkes

53- Quelle est la conséquence possible d'une exposition chronique à des niveaux élevés de manganèse ?

A-Maladie d'Alzheimer

B- Maladie de Parkinson-like

C- Sclérose en plaques

D- Encéphalopathie toxique

E- toutes ces propositions

54-Parmi les éléments suivants lesquels ont un rôle dans la fertilité masculine ?

1-vit E

2-Zn

3-Se

4-cu

5-F

A-1, 2 B-1, 2, 3 C-1, 2, 4 D- 1, 3,4 E-1, 2, 3, 5

55- Quelle proposition n'est pas associée aux coumarines ?

A- Elles ont des propriétés anti inflammatoires

B- Elles ont des propriétés antioxydantes

C- Elles ont des propriétés analogues aux philloquinones

D- Elles ont des propriétés anticoagulantes

E- Elles sont contenues dans le cèleri et le persil

56- Quelle maladie est liée à une carence en Zinc ?

A-Maladie coéliquaue

B-Acné

C-Maladie de Parkinson

D-Ostéoporose

E-Maladie de Kashin-Beck

57- A propos du récepteur soluble de la transferrine, cocher la proposition inexacte

A- Il dérive de la protéolyse du récepteur membranaire des cellules erythroblastiques de la MO

B- Sa concentration plasmatique reflète la demande en fer des cellules

C- Il permet aux cellules de l'organisme de capter le fer sanguin

D- En cas de carence en fer, sa concentration plasmatique augmente en même temps que la concentration plasmatique de la ferritine

E- Dans le plasma, il est lié à la transferrine

58- Quel est le taux d'absorption du fer alimentaire ?

A-5%

B-10%

C-20%

D -30%

E-50%

59- A propos de l'Hepcidine, cocher la proposition inexacte :

A- C'est une protéine codée par un gène situé sur le chromosome 19

B- Elle bloque la Ferroportine exprimée sur les membranes enterocytaires et hépatiques

C- Son expression est contrôlée par la protéine codée par le gène de l'Hemojuveline (HJV)

D- Elle n'est pas fonctionnelle dans l'hémochromatose de type 2B

E- Elle réduit l'apport du fer provenant des transfusions sanguines

60- où se trouve la thiaminase et quel est son rôle ?

A- Dans le lait, elle détruit la thiamine

B- Dans la chair crue du saumon, elle détruit la vitamine B1

C- Dans les œufs cuits, elle détruit la biotine

D- Dans les légumes crus, elle détruit la vitamine C

E- Aucune proposition exacte

Examen U3 2^{ème} / 2026

Partie 1 : Anatomie

Q1/Concernant les rapports de l'uretère lombaire :

1. Le bord médial du rein est un rapport latéral de l'uretère droit
2. L'aorte abdominale est située latéralement par rapport à l'uretère gauche.
3. Le nerf génito-crural est un rapport postérieur de l'uretère droit.
4. Les vaisseaux gonadiques sont des rapports latéraux de l'uretère gauche
5. Le 2^{ème} duodénum est un rapport antérieur de l'uretère droit.

A (1,3,5) B(1,2,5) C(2,3,4) D(1,2,3) E(1,4,5)

Q2/ Concernant les rapports de l'uretère pelvien

1. Chez l'homme, le canal déférent passe au-dessus de l'uretère.
2. Chez l'homme, les vésicules séminales sont situées en arrière de l'uretère.
3. Chez la femme, l'uretère est situé en dedans du ligament large.
4. Chez la femme, l'artère utérine croise l'uretère par l'arrière.

A (1.4) B(2.3) C(3.4) D(1.2) E(2.4)

Q3/ Concernant les vaisseaux et nerfs de l'uretère :

1. Les artères proviennent des artères rénales et gonadiques.
2. L'artère iliaque commune fournit des branches urétériques.
3. Les veines sont indépendantes du trajet artériel.
4. Le drainage lymphatique rejoint les nœuds inguinaux.

A(1.4) B(1.2) C(2.4) D(2.3) E(1.3)

Q4

1. Les reins sont des glandes situées à la partie basse de la région retro-péritonéale
2. Les reins peuvent être précisés chez le vivant par la radiographie simple.
3. Le rein gauche est plus haut situé que le rein droit.
4. Le rein gauche est situé entre le bord inférieur de T11, et le bord inférieur de L3

A (1+2) B (1+3+4) C(1+3) D (2+3) E (3+4).

Q5/

1. Le rein est constitué d'une capsule muqueuse périphérique: la capsule rénale.
2. Les colonnes de Bertin situées entre les pyramides de Malpighi.
3. Les rapports du rein droit: péritoine pariétal postérieur, face viscérale du foie (lobe hépatique droit).
4. Toutes les réponses sont fausses.

A(1+2) B(1+3) C(4) D(1+2+3) E(2+3).

Q6/

1. Les rapports du rein gauche: tête du pancréas
2. Le rein gauche a des rapports internes représentés essentiellement par l'aorte abdominale.
3. Les veines rénales se situent à la hauteur du disque intervertébral entre la première et la 2^{ème} vertèbre lombaire
4. La veine rénale gauche passe en arrière de l'aorte abdominale, en avant de l'artère mésentérique supérieure.

A (1+2) B (1+3+4) C (2+3) D (1+2+3+4) E (3+4).

Q7/ Concernant la vessie :

1. La face supérieure de la vessie est en rapport avec le caecum et l'appendice à droite.
2. La partie supérieure de la base de la vessie est en rapport avec le col utérin chez la femme.
3. La vessie est irriguée en bas et en avant par les rameaux vésicaux des artères rectales moyennes.
4. L'innervation est mixte, elle provient du plexus mésentérique supérieur.

A (1+4) B (2+3) C (3+4) D (1+2) E (1+2+4)

Q8/ A propos de l'urètre :

- A. L'urètre féminin s'étend du col de la vessie à la vulve où il s'ouvre par l'orifice interne de l'urètre
- B. L'urètre féminin traverse le diaphragme uro-génital et présente deux parties fonctionnellement différentes.
- C. Les lymphatiques de l'urètre féminin aboutissent aux nœuds lymphatiques latéro-aortiques.
- D. L'urètre féminin est un conduit urinaire et génital.
- E. L'urètre masculin présente 3 dilatations, le segment le plus étroit est le méat urinaire.

Q9/ Indiquez la réponse fausse :

- A. « Le sinus bulbaire » est situé dans le bulbe du pénis
- B. Certaines artères de l'urètre masculin proviennent des branches vésico-prostatiques des artères vésicales inférieures.
- C. Certains lymphatiques du col de la vessie se terminent aux nœuds lymphatiques du promontoire.
- D. La partie diaphragmatique de l'urètre féminin est entourée par le muscle « uréthro-vaginal »
- E. Le Cul-de-sac recto-génital (Douglas) est situé en avant du cul de sac vésico-génital

Partie 2 : Histologie : cochez la réponse juste

10. Concernant la topographie cortico-médullaire du néphron, quelle proposition est exacte

- A. Tous les segments du néphron sont exclusivement corticaux
- B. Le tube contourné distal est strictement médullaire
- C. Le tube contourné proximal reste majoritairement cortical avec un segment droit médullaire
- D. L'anse de Henlé est exclusivement corticale
- E. Le tube contourné proximal est exclusivement cortical

11. La pyramide de Ferrein correspond à :

- A. Une expansion médullaire dans la corticale
- B. Une pyramide médullaire drainée par un calice majeur
- C. Un segment du tube collecteur
- D. Une colonne de Bertin hypertrophiée
- E. Une expansion corticale dans la médullaire

12. La particularité ultrastructurale essentielle de l'endothélium glomérulaire est :

- A. Une membrane basale discontinue
- B. Une absence totale de membrane basale
- C. Un endothélium fenêtré
- D. Une bordure en brosse
- E. Un endothélium continu

13. La macula densa est une structure spécialisée appartenant :

- A. Au tube collecteur
- B. Au tube contourné proximal
- C. À l'artériole afférente
- D. Au tube contourné distal
- E. A l'anse de Henlé

14. L'absence de lame élastique interne est caractéristique de :

- A. L'artère interlobaire
- B. L'artériole afférente
- C. L'artère interlobulaire
- D. L'artère arciforme
- E. L'artériole efférente

15. Le segment du néphron sans bâtonnets et sans bordure striée est :

- A. Le tube contourné proximal
- B. Le tube contourné distal
- C. L'anse de Henlé
- D. Le tube collecteur

16. Quel est l'ordre de traversée de l'ultrafiltrat à travers la barrière de filtration glomérulaire ?

- A. Podocytes -> Membrane basale -> Endothélium fenêtré
- B. Membrane basale -> Endothélium fenêtré -> Podocytes
- C. Endothélium fenêtré -> Membrane basale -> Podocytes
- D. Endothélium fenêtré -> Podocytes -> Membrane basale

17. Le gradient osmotique médullaire indispensable à la concentration des urines est créé par :

- A. Le tube collecteur
- B. Le tube contourné proximal
- C. Les capillaires péri-tubulaires
- D. Le tube contourné distal
- E. L'anse de Henlé

18. L'urothélium est particulièrement résistant à l'urine grâce :

- A. À sa richesse en kératine
- B. Aux jonctions serrées uniquement
- C. À la couche musculaire sous-jacente
- D. Aux uroplakines
- E. Aux cellules moyennes

19. Concernant la paroi des voies urinaires, toutes ces propositions sont justes sauf une laquelle ?

- A. L'épithélium de la muqueuse est de type pseudo stratifié polymorphe
- B. Le chorion de la muqueuse est conjonctivo-vasculaire glandulaire
- C. La présence d'uroplakine dans les cellules épithéliales évite la rupture de la paroi pendant la phase de remplissage de la vessie.
- D. Au niveau du 1/3 inférieur de l'uretère, la musculature comporte 03 couches
- E. L'épithélium de la vessie vide rétracté contient des cellules en raquettes.

20. A propos des tubes collecteurs de Bellini toutes ces propositions sont justes sauf :

- A. Leur paroi est composée d'un seul type cellulaire cubique simple
- B. Ils sont situés dans la région médullaire
- C. Ils s'ouvrent dans les petits calices après avoir traversé le sommet des pyramides de Malpighi
- D. Ils sont situés dans les colonnes de Bertin
- E. C'est un segment sans bordure striée et sans bâtonnets basaux

21. La musculature vésicale est caractérisée par :

- A. Deux couches bien individualisées
- B. Trois couches à disposition plexiforme
- C. Une couche longitudinale unique
- D. Une couche striée
- E. Une couche circulaire interne et une couche longitudinale externe

Partie 3 : Physiologie : Cochez la réponse juste

22. Quel est le pourcentage approximatif du débit cardiaque destiné aux deux reins ?

- A/5-10%
- B/20-25%
- C/ 40-50%
- D/60-70%
- E/90%

23. Quel élément de la barrière de filtration est responsable de la sélectivité en charge ?

- A/ l'endothélium fenêtré
- D/ les cellules mésangiales
- B/ la membrane basale glomérulaire
- E/ la Capsule de Bowman
- C/ les pédicelles des podocytes

24. La formule conceptuelle de la pression nette de filtration (PNF) s'exprime par :

- A/ $PNF = P_{Heb} - P_{Hcg} - \pi_{cg}$
- B/ $PNF = P_{Hcg} + P_{Heb} - \pi_{cg}$
- C/ $PNF = \pi_{cg} - (P_{Heb} + P_{Hcg})$
- D/ $PNF = P_{Hcg} - P_{Heb} - \pi_{cg}$
- E/ $PNF = \pi_{cg} - (P_{Heb} - P_{Hcg})$

25. Concernant le débit de filtration glomérulaire (DFG) :

- 1/ un DFG de 90 ml/min correspond à la limite inférieure de la fonction rénale normale
- 2/ un DFG de 40ml/min représente une insuffisance rénale modérée
- 3/ le DFG augmente physiologiquement avec l'âge
- 4/ le DFG devient nul après 70 ans

A/1+2 B/2 C/2+3 D/ 1+3+4 E/2+3+4

26. L'application de la formule MDRD pour l'estimation du DFG, ne nécessite pas :

- A/ créatininémie
- B/ créatininurie
- C/ Age et sexe
- D/ poids
- E/ propositions B et D

27. Le suivi d'une insuffisance rénale aiguë (IRA) repose sur :

- A/ le dosage de la créatininémie
- B/ la créatininurie des 24h
- C/ l'estimation du DFG par CKD-Epi
- D/ la mesure directe du DFG
- E/ l'albuminurie des 24h

28. La macula densa détecte principalement :

- A/ une hypernatrémie
- B/ la concentration de NaCl dans le tube distal
- C/ la concentration du NaCl dans le tube proximal
- D/ une hypokaliémie
- E/ une hyperkaliémie

29. Quel est l'effet du blocage de l'angiotensine II sur les résistances artériolaires et la pression glomérulaire ?

- A/ l'augmentation des résistances et de la pression intraglomérulaire
- B/ la diminution des résistances et baisse de la pression intraglomérulaire
- C/ la diminution des résistances et augmentation de la pression intraglomérulaire
- D/ l'augmentation des résistances et baisse de la pression intraglomérulaire
- E/ aucun effet sur la pression intraglomérulaire mais diminution des résistances

(30-31). On considère une substance X filtrée à 60 mg/min et sécrétée jusqu'à un T_m de 40 mg/min

30. Quelle(s) proposition(s) est (sont) correcte(s) concernant la substance X ?

- A/ la quantité réabsorbée est de 20 mg/min
- B/ la clairance de X est égale au DFG
- C/ la clairance de X est égale à UV/P
- D/ les propositions A et B sont justes
- E/ toutes les propositions sont justes

31. Quelle est la quantité de substance X excrétée par minute ?

- A/ 20 mg/min
- B/ 40 mg/min
- C/ 60 mg/min
- D/ 100 mg/min
- E/ 120 mg/min

32. Parmi les substances suivantes, laquelle fait l'objet d'une réabsorption contrôlée dans le tube proximal ?

- A/ l'eau
- B/ le sodium
- C/ les phosphates
- D/ le glucose
- E/ les acides aminés

33. Le segment tubulaire responsable d'une réabsorption hydro-sodée découplée est :
A/ le tube proximal
B/ l'anse de Henlé
C/ la partie initiale du tube distal
D/ la partie terminale du tube distal
E/ le canal médullaire
34. L'élément vertical responsable de la création du gradient osmotique cortico-papillaire (GOCP) est :
A/ l'écoulement à contre-courant des urines
B/ l'écoulement en circuit fermé
C/ la perméabilité de la branche ascendante au Na*
D/ la perméabilité de la branche descendante à l'H₂O
E/ les propositions C et D sont justes
35. À propos du transport du glucose, laquelle des propositions est exacte ?
A/ les SGLT1 assurent 90% de la réabsorption du glucose
B/ le transport du glucose est sans limite de capacité
C/ la réabsorption et la filtration du glucose sont toujours linéaires
D/ la réabsorption du glucose n'est jamais contrôlée
E/ aucune proposition n'est juste
36. Le furosémide est un diurétique qui :
1/ agit au niveau du segment proximal du néphron
2/ engendre une fuite urinaire du Ca²⁺
3/ augmente fortement le GOCP
4/ favorise la sécrétion distale du K⁺
A/ 1+3 B/ 1+4 C/ 2 D/ 2+3 E/ 2+4
37. Dans un diabète insipide néphrogénique (périphérique) :
A/ la réabsorption hydrique proximale est réduite
B/ le taux d'ADH sanguin est diminué
C/ les récepteurs V1 sont altérés
D/ la soif est rare
E/ la clearance de l'eau libre (CH₂O) est positive
38. À propos de la miction, les potentiels post-synaptiques excitateurs (PPSE) :
1/ proviennent de la région lombosacrée
2/ sont d'origine corticale
3/ renforcent la contraction du sphincter urétral externe
4/ sont fonction du volume vésical
A/ 1+3 B/ 1+4 C/ 2 D/ 2+3 E/ 2+4
39. Une incontinence urinaire associée à une urgenturie et des cystalgies :
A/ est secondaire à une faiblesse sphinctérienne
B/ s'observe chez la plupart des obèses
C/ est souvent physiologique chez le sujet jeune
D/ décrit une hyperactivité vésicale
E/ les propositions C et D sont justes

Partie 4 : Biochimie

40- Cocher la proposition exacte parmi les combinaisons suivantes :

1-Dans un tampon acétique si la concentration de l'acide acétique est bien plus grande que celle de l'acétate de sodium, le pH sera faible

2-Une respiration rapide agit sur les systèmes tampons du sang en augmentant le pH

3-si la concentration de la base conjuguée dans un tampon est multipliée par 10, le pH augmente d'une unité

4-Le pH d'un système tampon est influence par le pH du milieu dans lequel il se trouve

A-1,2 B-1,2,3 C-1,2,3,4 D-2,3,4 E-1,4,5

41-En ce qui concerne le système tampon phosphate, cocher la proposition exacte ;

1-il agit à l'intérieur des cellules du tube contourné distal

2- physiologiquement sa composante acide est plus représentée dans l'urine primitive

3- il est d'origine plasmatique

4- il permet d'acidifier les urines

A-1,2 B-1,2,3 C-2,3 D-2,3,4 E-4,5

42-En cas d'acidose, quel mécanisme est principalement utilisé par le LCR pour compenser la baisse du pH

A- Augmentation de la production de bicarbonates

B- Augmentation de la concentration en protéines

C- Diminution de la concentration en ions sodium

D- Augmentation de la fréquence respiratoire

E- Aucune proposition exacte

43-Quel est le rôle de la réaction de l'acide carbonique (H_2CO_3) dans la régulation du pH ?

A-elle augmente le pH lorsqu'elle se dissocie

B-elle diminue le pH en se combinant avec des ions H^+

C-elle aide à maintenir l'équilibre entre HCO_3^- et CO_2

D- elle n'a aucun rôle dans le système tampon

E- toutes ces propositions sont inexactes

44-Quel est l'effet d'une hyperventilation sur le pH sanguin et comment les chémorécepteurs carotidiens réagissent-ils ?

A-diminution du pH, les chémorécepteurs informent le cerveau de diminuer la respiration

B-augmentation du pH, les chémorécepteurs informent le cerveau d'augmenter la respiration

C-Aucun effet sur le pH, les chémorécepteurs sont inactifs

D- Augmentation du pH, les chémorécepteurs informent le cerveau de diminuer la respiration

E- aucune proposition exacte

45-En cas d'acidose respiratoire, quel mécanisme rénal est activé pour compenser l'augmentation du CO_2 ?

A- Augmentation de l'excrétion des bicarbonates

B- Diminution de l'excrétion des ions H^+

C- Augmentation de la réabsorption des bicarbonates et de l'excrétion des ions H^+

D- Augmentation de l'excrétion des ions K^+

E- Aucun mécanisme compensatoire

46- Quelle proposition concernant l'excès de base ou BE est exacte ?

1. Il est positif s'il est supérieur à 2
2. Il est négatif s'il est inférieur à 0
3. Un BE égal à 0 est normal
4. Il est négatif en cas d'acidose métabolique

A-1,2 B-1,3 C-1,2,3,4 D-1,3,4 E-2,3,4

47- Quelle est la signification d'un pKa élevé pour un acide ?

- A- l'acide est très fort et se dissocie facilement
- B- l'acide est faible et se dissocie difficilement
- C- l'acide n'a aucune influence sur le pH
- D- l'acide est neutre

E- aucune proposition exacte

48- Cocher la combinaison exacte concernant le TAP :

1. C'est la différence entre les anions indosés et les cations indosés
2. C'est la différence entre les cations dosés et les anions dosés
3. Le TAP doit être corrigé en cas d'hyperalbuminémie
4. Un TAP élevé indique que la somme des anions non mesurés a augmenté

A-1,2 B-1,2,3 C-1,2,4 D-1,2, 3,4 E-2,4

49- lorsque les reins ne parviennent pas à excréter les acides non volatils, quel effet cela a-t-il sur le TAU (trou anionique urinaire) ?

- A- Le TAU diminue
 - B- Le TAU augmente
 - C- Le TAU reste inchangé
 - D- Le TAU devient négatif
- E- Aucune proposition exacte

50- cocher la combinaison la plus exacte concernant l'anhydrase carbonique :

- 1- C'est une enzyme qui décompose le bicarbonate en dioxyde de carbone et en H₂O
- 2- Elle facilite la conversion du CO₂ en bicarbonate pour tamponner les acides
- 3- Elle est principalement active dans les globules rouges et les reins
- 4- Son inhibition produit une acidose métabolique avec augmentation des chlorures sanguins

A-1,2,3,4 B-1,2,3 C-2,3,4 D-2,3 E-3,4

Cas clinique ; QCM 51,52,53,54 et 55

Madame Z, 60 ans, présentant des antécédents de diabète et de maladie pulmonaire obstructive chronique consulte pour une fatigue et confusion, et dyspnée progressive. Sa fréquence respiratoire est de 30/mn et l'examen neurologique montre une légère obnubilation.

Les résultats de son bilan :

pH : 7,25

pCO₂ : 55 mmHg

HCO₃: 18 mEq/L

Sodium : 138 mEq/L

Potassium : 6,0 mEq/L

Chlorure : 104 mEq/L

51- Quel est le principal diagnostic suspecté chez cette patiente ?

- A) Acidose métabolique
- B) Acidose respiratoire
- C) Acidose mixte
- D) Alcalose respiratoire
- E) alcalose métabolique

52- Quel facteur contribue principalement à l'acidose métabolique dans ce cas ?

- A) Hypoxie
- B) Acidocétose diabétique due à l'hyperglycémie
- C) Insuffisance rénale
- D) Déshydratation
- E) aucune proposition exacte

53- quelle est la valeur du TAP de cette patiente :

- A-18
- B-22
- C-16
- D-24
- E- 14

54-l'augmentation de la kaliémie est en rapport avec, cocher la proposition exacte :

- 1. La rétention de K⁺ au niveau tubulaire distal
- 2. L'intervention rénale pour compenser l'acidose métabolique
- 3. La sortie de K⁺ intracellulaire vers le milieu vasculaire en échange d'un H⁺
- 4. L'insuffisance respiratoire

A-1,2 B-1,3 C-1,2,3 D-2,3,4 E-1,2,3,4

55-un tel trouble acido-basique peut s'installer dans les situations suivantes, lesquelles ?

- 1. Une insuffisance rénale chez une personne atteinte de mucoviscidose
- 2. Une acidose tubulaire distale
- 3. Une intoxication par le furosémide
- 4. Une personne asthmatique chez qui survient une insuffisance rénale

A-1,2,3,4 B- 1,2,3 C-1,3,4 D-1,4 E-aucune situation

56- En cas d'acidose respiratoire avec une fonction rénale normale, cocher la combinaison exacte parmi les suivantes :

1. L'augmentation du taux de bicarbonates est un signe de compensation
2. L'acidité titrable sera élevée
3. La pO₂ est abaissée
4. Le taux de chlorures est élevé
5. Un BE (excès de base) positif est un signe de compensation

A-1,2,3 B-1,2,3,4 C-1,2,3,5 D-1,3,4,5 E-1,2,3,4,5

57-Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond à une acidose respiratoire compensée ?

- A- pH=6,40 Pco₂=22 HCO₃⁻ = 18
- B- pH=7,40 Pco₂=22 HCO₃⁻ = 18
- C- pH=6,40 Pco₂=80 HCO₃⁻ = 24
- D- pH=6,40 Pco₂=39 HCO₃⁻ = 42
- E- pH=7,40 Pco₂=80 HCO₃⁻ = 42

58- Quel facteur peut influencer les résultats de la gazométrie si l'échantillon est exposé à l'air ?

- A- La pCO₂ augmente
- B- La pO₂ diminue
- C- La pCO₂ diminue
- D- La natrémie augmente
- E- Aucun impact

59-Quel critère indique qu'un déséquilibre acide-base est compensé :

- A- pH normal avec des valeurs anormales de pCO₂ et HCO₃⁻
- B- pH normal avec des valeurs normales de pCO₂ et HCO₃⁻
- C- pH en dehors de la plage normale
- D- pCO₂ et HCO₃⁻ normaux
- E- Aucune proposition exacte

60-Quelles sont les situations qui diminuent la réabsorption tubulaire des bicarbonates :

1. Hypokaliémie
2. Acidose tubulaire proximale
3. Hypercalcémie
4. Hypocapnie

A-1,2,3 B-1,3,4 C-1,2,3, D-2,3,4 E-2,4

Examen U4 2^{ème} / 2026

Partie 1 : Anatomie

Cocher la réponse juste pour toutes les questions

Q1/ Concernant l'appareil génital féminin :

1. Les trompes sont vascularisées par les artères ovariennes et utérines
2. L'ovaire présente trois faces
3. Le fornix représente l'extrémité supérieure du vagin
4. Le clitoris est situé à la jonction des grandes lèvres

A(1,4) B(1,3) C(1,2) D(2,3) E(3,4)

Q2/ Concernant l'utérus :

1. L'utérus est incliné d'arrière en avant
2. La portion supra-vaginale du col est percée de l'orifice externe du col
3. La face ventrale de la portion supra-vaginale du col est recouverte du péritoine
4. Les nerfs proviennent du plexus hypogastrique inférieur

A(1,4) B(2,4) C(1,2) D(2,3) E(3,4)

Q3/ Concernant l'appareil génital masculin :

- A. La verge est constituée par 3 structures érectiles : 1 corps caverneux ; 2 corps spongieux.
- B. La situation normale des testicules est intra pelvienne.
- C. L'innervation de la prostate est assurée par le plexus caelique.
- D. La prostate est contenue dans une loge fibreuse ; la paroi de cette loge est constituée en arrière par la lame préprostatique.
- E. La vésicule séminale s'étend entre la vessie et le rectum.

Q4/ Concernant l'appareil génital masculin :

1. Le testicule est enveloppé par une membrane fibreuse résistante appelée le médiastinum testis.
2. Les enveloppes du testicule sont formées par la paroi abdominale qui est refoulée par le testicule
3. Le conduit épидидymaire reçoit les canalicules efférents du testicule
4. Le canal déférent se termine par une portion étroite: l'ampoule déférentielle
5. Toutes les réponses sont justes.,

A (1+2) B (4+5) C (2+3) D (2+4) E (1+5)

Q5/ Parmi les propositions suivantes, laquelle est exacte ?

- A. Le muscle élévateur de l'anus comprend trois faisceaux : pubo-coccygien, pubo-rectal et ilio-coccygien, et participe à la continence et au soutien des viscères abdominaux.
- B. Le muscle constricteur de la vulve (sphincter de la vulve) fait partie du plan superficiel du périnée et est responsable de la fermeture volontaire de l'orifice vaginal
- C. Le muscle bulbo-spongieux appartient au plan moyen du périnée.
- D. Le sphincter externe de l'anus est un muscle strié involontaire qui ne reçoit aucune innervation volontaire.
- E. Les muscles superficiels du périnée féminin ne participent pas à la continence urinaire.

Q6/ L'axe hypothalamo-hypophysaire :

- A. Au-dessous de l'hypophyse les rapports se font avec le chiasma optique
- B. Le lobe antérieur formé de tissu nerveux et prend le nom d'adénohypophyse.
- C. Les artères proviennent toutes de la carotide interne, elles sont au nombre de 3.
- D. La glande hypophyse est située au-dessus de l'hypothalamus
- E. La glande hypophyse est située en arrière de la protubérance annulaire

Q7/ Concernant la glande surrénale :

- A. Est située de part et d'autre de D10
- B. La veine surrénale moyenne se draine dans la veine rénale à droite.
- C. L'artère surrénale supérieure née de l'artère phrénique inférieure
- D. Les rapports postérieurs des surrénales correspondent au diaphragme et la 7^{ème}, 8^{ème} côtes.
- E. Les rapports antérieurs de surrénale gauche sont le corps du pancréas et la rate.

Q8/ La glande mammaire :

- A. Est une glande, exocrine tubulo-alvéolaire.
- B. Située en regard de l'espace compris entre la 5^{ème} et la 8^{ème} côte.
- C. Les moyens de fixation du sein sont très développés.
- D. Les artères proviennent directement de l'artère sub-clavière.
- E. Elle répond au plan musculo-fascial profond par le muscle oblique externe, muscle droit de l'abdomen et muscle dentelé antérieur.

Q9/ Concernant la glande thyroïde :

- 1. La glande thyroïde est formée de deux lobes latéraux reliés par un isthme généralement projeté en regard des 2^e à 4^e anneaux trachéaux.
- 2. B. La thyroïde occupe la région cervicale antérieure et s'étend approximativement de la vertèbre C3 à C7.
- 3. La face postérieure des lobes thyroïdiens est en rapport étroit avec les glandes parathyroïdes et le nerf laryngé récurrent, généralement situé dans le sillon trachéo-œsophagien.
- 4. Les éléments du paquet vasculo-nerveux du cou constituent le principal rapport postérieur de la glande thyroïde.
- 5. L'innervation fonctionnelle de la glande thyroïde est assurée uniquement par le nerf laryngé récurrent.

A(1,2) B(1,3) C(3,5) D (1,2,5) E(1,3,4)

Partie 2 : HISTOLOGIE : (cochez la réponse juste)

10) Au cours du développement embryologique de l'hypophyse, l'adénohypophyse dérive de :

- A. L'ectoblaste du stomodéum
- B. L'endoblaste du pharynx primitif
- C. Le mésenchyme céphalique
- D. Le neuroectoblaste du diencéphale
- E. La crête neurale

11) Les neurones magnocellulaires hypothalamiques se caractérisent par :

- A. Un cytoplasme non colorable par la méthode de Gomori
- B. Une terminaison au niveau des capillaires du plexus porte
- C. Une sécrétion de neuropeptides hypophysiotropes
- D. Une localisation dans les noyaux supra-optiques et paraventriculaires
- E. Une innervation directe de l'adénohypophyse

12) Les corps de Hering correspondent à :

- A. Des cellules gliales spécialisées
- B. Des dilatations axonales contenant des hormones hypothalamiques
- C. Des amas de cellules endocrines basophiles
- D. Des capillaires fenêtrés
- E. Des vésicules provenant de la poche de Rathke

13) Les cellules C de la thyroïde dérivent principalement :

- A. Du mésenchyme cervical
- B. De la poche de Rathke
- C. Des crêtes neurales via le corps ultimo-branchial
- D. Du canal thyreoglosse
- E. Du mésoderme latéral

14) Concernant le canal thyroïdienne, quelle affirmation est correcte ?

- A. Il relie l'ébauche thyroïdienne au pharynx primitif
- B. Il persiste normalement chez l'adulte
- C. Il provient du mésoderme cervical
- D. Il donne naissance aux cellules parafolliculaires
- E. Il forme les lobes thyroïdiens

15) Dans la vésicule thyroïdienne, la colloïde correspond principalement :

- A. À une accumulation de calcitonine
- B. À de la thyroglobuline iodée
- C. À la sécrétion des cellules parafolliculaires
- D. À une accumulation de TSH
- E. À un mélange d'hormones stéroïdes

16) Les cellules de la zone fasciculée de la surrénale présentent :

- A. Un cytoplasme très basophile
- B. Une absence de mitochondries
- C. Un noyau pycnotique
- D. Un cytoplasme riche en inclusions lipidiques
- E. Une sécrétion de catécholamines

17) Concernant la membrane de Slavjanski, quelle affirmation est exacte ?

- A. Elle correspond à la zone pellucide
- B. Elle sépare les cellules folliculeuses du stroma ovarien
- C. Elle apparaît uniquement dans le follicule de De Graaf
- D. Elle disparaît dans les follicules secondaires
- E. Est une matrice extracellulaire glycoprotéique épaisse

18) Pendant la phase sécrétoire de l'endomètre, on observe :

- A. Des glandes droites et étroites
- B. Une absence de glycogène
- C. Des glandes sinueuses à aspect en dent de scie
- D. Une disparition des artérioles spiralées
- E. Une atrophie du chorion

19) Concernant le col utérin, quelle affirmation est correcte ?

- A. L'endocol est bordé par un épithélium pavimenteux stratifié
- B. L'exocol est bordé par un épithélium cylindrique simple
- C. Le col est principalement constitué de muscle lisse
- D. Il ne possède pas de glandes
- E. La jonction pavimento-cylindrique se situe généralement à l'orifice externe

20) Concernant les tubes séminifères, quelle affirmation est correcte ?

- A. Ils sont tapissés par un épithélium pavimenteux simple
- B. Ils possèdent un épithélium germinatif pluristratifié
- C. Ils contiennent uniquement des cellules de Sertoli
- D. Ils sont entourés de muscle strié
- E. Ils sont dépourvus de membrane basale

21) La barrière hémato-testiculaire est principalement formée par :

- A. Les jonctions serrées entre cellules de Sertoli
- B. La membrane basale des tubes séminifères
- C. Les cellules de Leydig
- D. Les cellules myoïdes péritubulaires
- E. Les capillaires fenestrés

22) Concernant le canal déférent, quelle affirmation est correcte ?

- A. Son épithélium est pavimenteux stratifié
- B. Sa musculeuse comporte trois couches
- C. Il est dépourvu de stéréocils
- D. Il possède une musculeuse mince
- E. Il ne possède pas de lumière

23) Au microscope optique, les îlots de Langerhans apparaissent :

- A. Plus foncés que les acini pancréatiques
- B. Identiques aux acini
- C. Totalement invisibles
- D. Entourés d'une capsule épaisse
- E. Plus clairs que le tissu exocrine

Partie 3 : PHYSIOLOGIE

Question 24 : Dans l'exploration fonctionnelle endocrine :

- 1. Une épreuve de stimulation est indiquée en cas de suspicion d'insuffisance.
- 2. Un test est dit positif s'il n'y a aucune réponse de l'organe explore.
- 3. Une pathologie est "secondaire" si elle provient de l'hypophyse ou de l'hypothalamus.
- 4. L'épreuve de freination est utilisée pour confirmer un hyperfonctionnement.

A) 1,3,4 B) 1,2,4 C) 2, 3 D) 1,3 E) 1,2, 3, 4

Question 25 : À propos de l'hormone de croissance (GH) :

1. C'est un peptide de 191 acides aminés avec deux ponts disulfures.
2. Elle est sécrétée par les cellules somatotropes de l'antéhypophyse.
3. Sa demi-vie plasmatique est d'environ 20 à 30 minutes.
4. Elle circule à 90% sous forme liée à la transcortine.

A) 1, 2, 3 B) 2,3,4 C) 1,3,4 D) 1,2 E) 1, 2, 3, 4

Question 26 : La régulation de la sécrétion de la GH fait intervenir :

1. La Ghréline, produite principalement par l'estomac, qui stimule la GH.
2. La Somatostatine (SRIH) qui inhibe à la fois la synthèse et la libération de GH.
3. Le rétrocontrôle négatif exercé par l'IGF-I au niveau hypophysaire et hypothalamique.
4. L'hyperglycémie qui agit comme un puissant stimulant de sa sécrétion

A) 1,2 B) 1,3 C) 2, 4 D) 1, 3, 4 E) 1, 2, 3

Question 27 : Concernant les actions métaboliques de la GH :

1. Elle est hyperglycémisante par augmentation de la glycogénolyse hépatique.
2. Elle diminue le captage du glucose par les muscles.
3. Elle favorise le stockage des triglycérides dans le tissu adipeux.
4. Son action sur le métabolisme protidique est un anabolisme indirect via l'IGF-I.

A) 1,2,3 B) 2, 3, 4 C) 1,2, 4 D) 1, 4 E) 1, 2, 3, 4

Question 28 : Les effets physiologiques du cortisol incluent :

1. Une stimulation de la néoglucogenèse hépatique.
2. Un effet anti-inflammatoire et immunosuppresseur.
3. Une inhibition de la résorption osseuse.
4. Une augmentation de l'acidité gastrique.

A) 1,2,3 B) 1, 2, 4 C) 2, 3, 4 D) 1, 4 E) 1, 2

Question 29 : L'effet "Wolff Chaikoff" correspond à :

1. Une augmentation de la vascularisation thyroïdienne en cas de surcharge d'iode.
2. Une inhibition de l'organification de l'iode en cas d'excès d'iode.
3. Un phénomène d'autorégulation indépendant de la TSH.
4. Une stimulation massive de la synthèse de T4 pour stocker l'iode excédentaire.

A) 1,2 B) 2,3 C) 3,4 D) 2,4 E) 1, 3

Question 30 : Le cycle ovarien est caractérisé par :

1. Une phase folliculaire dominée par la sécrétion d'œstradiol par la granulosa.
2. L'ovulation déclenchée par un pic de LH (rétrocontrôle positif de l'E2).
3. Une phase lutéale où le corps jaune sécrète principalement de la progestérone.
4. La menstruation qui survient si le taux de progestérone augmente brutalement.

A) 1,2 B) 1, 2, 3 C) 2, 3, 4 D) 1,3 E) 2, 3, 4

Question 31: Les effets de la progestérone incluent :

1. La transformation de l'endomètre en "dentelle utérine" pour la nidation.
2. Une action sédatrice sur le myomètre (inhibition des contractions).
3. Une augmentation de la température corporelle au-dessus de 37°C.
4. Une fluidification de la glaire cervicale pour faciliter le passage des spermatozoïdes.

A) 1,2 B) 1, 2, 3 C) 2, 3, 4 D) 1, 2, 4 E) 1, 3, 4

Question 32 : Pendant la grossesse :

1. L'HCG est produite par le placenta et maintient le corps jaune gravidique.
2. Le placenta sécrète de la CRH qui aide à la maturation du poumon fœtal.
3. L'HPL favorise le développement mammaire et augmente la glycémie maternelle.
4. L'ovulation est maintenue grâce à des pics pulsatiles de GnRH.

A) 1,2 B) 1,2,3 C) 2, 3, D) 1, 3 E) 1, 3, 4

Question 33. Les transporteurs du glucose GLUT2 sont exprimés principalement au niveau :

- 1/ des hépatocytes
- 2/ des cellules β des îlots pancréatiques
- 3/ des cellules cérébrales
- 4/ de la membrane apicale des entérocytes

A/ 1+2 B/ 1+3 C/ 2+3 D/ 1+4 E/ 1+2+4

Question 34. Le mode continu de la sécrétion d'insuline :

- 1/ caractérise la phase postprandiale
- 2/ permet le maintien de l'insulinémie basale
- 3/ correspond à une réponse monophasique
- 4/ correspond à une sécrétion pulsatile

A/ 1+3 B/ 2+3 C/ 1+4 D/ 2+4 E/ 1+2+3

Question 35 : La phosphorylation de la périlipine :

- A/ est secondaire à l'action d'une phosphodiesterase (PDE)
- B/ favorise la lipogenèse sous l'action de l'insuline
- C/ active la lipolyse par activation de la lipase hormono-sensible (LHS)
- D/ inhibe la lipolyse par inhibition de la triglycéride lipase (ATGL)
- E/ aucune proposition n'est juste

Question 36 : A propos de la répartition du calcium dans l'organisme, le calcium plasmatique :

- A/ est la seule fraction dosable
- B/ est majoritairement non diffusible
- C/ est égal au double de la fraction ionisée
- D/ voit sa concentration augmenter en cas d'acidose
- E/ aucune proposition n'est juste

Partie 4 : BIOCHIMIE

37-A propos de l'androstenedione, quelle est la combinaison exacte

- 1- c'est un précurseur des œstrogènes et progestérone
- 2- il est majoritairement synthétisé dans la corticosurrénale chez les 2 sexes
- 3- il peut être transformé en testostérone dans le foie
- 4- sa concentration plasmatique est la même chez les 2 sexes
- 5- sa concentration plasmatique est plus élevée chez l'homme

A-1,2,3 B-1,3,4 C-1,3,5 D-2,3,4 E- 2,3,5

38-Quelle combinaison est exacte parmi les suivantes concernant les liposomes ?

1. C'est le lieu de synthèse des hormones stéroïdes
2. Ils représentent une réserve d'hormones stéroïdes
3. Ils sont situés dans le cytoplasme des organes stéroïdes
4. C'est une réserve de cholestérol directement utilisable

A-1,2 B-1,3 C-2,3 D-3,4 E-aucune combinaison exacte

39-Comment les hormones stéroïdes agissent-elles dans l'organisme ?

- A-En se liant à des récepteurs de surface cellulaire
B- En pénétrant directement dans la cellule et en se liant à des récepteurs intracellulaires
C- En modifiant la structure des membranes cellulaires
D- En stimulant la synthèse de protéines dans le cytoplasme
E- En agissant comme neurotransmetteur

40-Un nourrisson de 6 mois est suivi pour cryptorchidie unilatérale droite : le testicule droit n'est pas palpable dans le scrotum. L'examen clinique et l'échographie abdominale n'ont pas permis de retrouver le testicule en position abdominale. Le pédiatre décide de réaliser un test de stimulation à la β -hCG. Avant le test, la testostérone sérique est à 0,2 ng/mL.

Après stimulation, elle s'élève à 3,8 ng/mL. Quelle conclusion peut-on tirer de ce résultat ?

- A. Anorchidie bilatérale
B. Syndrome de Klinefelter probable
C. Cryptorchidie avec testicule abdominal fonctionnel
D. Hypogonadisme hypogonadotrope congénital
E. Syndrome d'insensibilité aux androgènes

41-Une fillette âgée de 5 ans est amenée en consultation pour développement mammaire précoce, apparition de poils pubiens et augmentation de la taille sur les 3 derniers mois. L'examen clinique ne révèle pas d'acné ni de phénomènes de virilisation marquée. Le bilan hormonal montre : Estradiol : élevé, LH : très bas, FSH : bas. Le test de stimulation à la GnRH : pas d'élévation de LH ni de FSH. Une échographie pelvienne met en évidence une masse ovarienne unilatérale de 3 cm, kystique, bien limitée. Quel est le diagnostic le plus probable?

- A-Puberté précoce vraie
B-Syndrome des ovaires polykystiques (SOPK)
C-Pseudo-puberté précoce d'origine ovarienne
D-Hirsutisme
E-Pseudo-puberté précoce causée par les androgènes corticosurrénaux

42-Concernant la régulation hormonale de l'axe hypothalamo- hypophyso-ovarien, une seule proposition est fausse, laquelle ?

- A. L' hyperprolactinémie diminue la pulsatilité de la GnRH
B. La TRH stimule la production de la prolactine
C. L'œstradiol exerce un rétrocontrôle positif sur la LH en fin de la phase folliculaire (pic ovulatoire)
D. La Noradrénaline inhibe la GnRH
E. Au cours de la grossesse, l'augmentation de l'œstradiol freine la sécrétion de la LH et de la FSH

43-Un patient de 32 ans, est suivi pour infertilité depuis 18 mois. Son bilan hormonal retrouve : FSH élevée, LH normale, Testostérone normale. Le spermogramme montre : Volume : 3 ml, pH : 7,4, Nombre de spermatozoïdes : 8 000/ml, Mobilité : 60% à la première heure, Vitalité :

55%. Quelle est l'interprétation la plus cohérente avec ce bilan

A- L'élévation de la FSH traduit une hypersécrétion d'inhibine b par les cellules de Sertoli

B- L'anomalie du spermogramme est une asthénospermie

C- L'élévation de la FSH est secondaire à une diminution de l'inhibine b, reflet d'une spermatogenèse inefficace

D- Une LH normale traduit une fonction testiculaire normale et explique le spermogramme normal.

E- Ce spermogramme est strictement normal

44-Une jeune femme de 19 ans consulte pour aménorrhée secondaire depuis 8 mois après des cycles auparavant réguliers. Elle ne prend aucun médicament. Le bilan hormonal montre : FSH élevée et estradiol bas. Quelle est l'interprétation la plus probable ?

A- Grossesse débutante

B- Hypogonadisme hypogonadotrophique

C- Insuffisance ovarienne primaire

D- Aménorrhée hypothalamique fonctionnelle

E- Hypothyroïdie

45-Un homme de 34 ans consulte pour une infertilité évoluant depuis deux ans.

L'examen clinique retrouve une diminution de la pilosité corporelle et des testicules de volume normal. Le bilan hormonal montre : testostérone totale basse, FSH basse, LH basse. Quelle est l'interprétation la plus probable de ce profil hormonal ?

A. Insuffisance testiculaire primitive

B. Hypogonadisme secondaire hypogonadotrophique d'origine hypothalamo-hypophysaire

C. Hyperestrogénie par tumeur testiculaire

D. Syndrome de Klinefelter

E. Insensibilité aux androgènes

46- A propos de l'hypoaldostéronisme secondaire, quelle proposition est exacte ?

A- Il se manifeste par une hypokaliémie et une acidose métabolique

B- il peut être dû à une insuffisance hépatique

C- la mesure de l'activité rénine est utile pour son diagnostic

D- les propositions B et C sont exactes

E- Les propositions A, B et C sont exactes

47- La thyroïdite subaigüe : cocher la proposition juste

1. Est généralement d'origine virale ou post virale

2. C'est une thyrotoxicose douloureuse

3. Elle est due à une hyperplasie thyroïdienne

4. Elle doit être traitée par des antithyroïdiens de synthèse

5. Se caractérise au début de la maladie par une TSH basse et T4 élevée

A-1,2,3,4 B -1,2,3,5 C-2,3,4,5 D-1,2,4,5 E-1,2,5

48 (suite 49) L'évolution naturelle de la maladie est le plus souvent :

A- hyperthyroïdie permanente

B - hypothyroïdie permanente

C- hyperthyroïdie puis hypothyroïdie transitoire puis guérison

D- évolue vers goitre multinodulaire

E- évolue vers le cancer thyroïdien

49- Laquelle proposition est inexacte concernant la voie Mapkinase ?

A- Elle est activée par des récepteurs tyrosinekinase

B- C'est une voie majeure de prolifération cellulaire

C- Elle est activée d'une façon permanente par des mutations activatrices de Ras dans les cancers

D- Le syndrome de Legius est dû à une activation continue de la protéine Ras

E- L'activation de cette voie est due à l'activation de Ras par phosphorylation

50- L'utilisation des anticorps anti monoclonaux dirigés contre l'EGFR : CRJ

A- C'est une voie de thérapie ciblée anticancéreuse

B- Empêche l'EGF de se fixer sur son récepteur EGFR intracellulaire

C- Elle est utilisée pour traiter le cancer colorectal

D- les propositions A, B et C sont exactes

E- Les propositions A et C sont exactes

51- Parmi les causes d'un excès d'activité hormonale, laquelle est exacte ?

A- une mutation activant constamment les récepteurs de l'hormone

B- une augmentation de la fraction liée plasmatique de l'hormone

C- une anomalie inhibant constamment la protéine Gs

D- une augmentation du taux de protéines transporteuses dans le sang

E- les propositions A, B et C sont exactes

52- Dans l'hypothyroïdie secondaire : (CRJ)

A- le taux de T3 et T4 est diminué

B- Le feedback thyroïde-hypophyse est aboli

C- Le test à la TRH 'n'entraîne pas d'augmentation de la TSH

D- Toutes ces propositions sont exactes

E- Les propositions A et C sont exactes

53- le récepteur à activité guanylcyclase est : CRJ

1. une protéine intracellulaire

2. un canal ionique riche en GTP

3. une protéine membranaire avec activité enzymatique intrinsèque

4. son activation est à l'origine d'une hypertension

5. son activation entraîne les mêmes effets que ceux du monoxyde d'azote (NO) sur la guanylcyclase soluble :

A-1,3,4,5 B- 2,3,4,5 C-3,4,5 D-1,3,5 E-3,5

54- A propos de la somatostatine : CRJ

1. Elle inhibe la sécrétion de TSH

2. Les antagonistes de cette hormone favoriseraient la motilité intestinale

3. Elle est aussi sécrétée par les cellules D du tube digestif

4. Ses récepteurs membranaires inhibent la protéine G (Gi)

A-1,2,3,4 B -1,2,3 C-1,3,4 D-2,3,4 E-3,4

55-Les récepteurs de la prolactine : CRJ

1-ont une activité tyrosine kinase intrinsèque

2-ils sont membranaires

3-la fixation de la prolactine entraîne l'activation de JAK2 membranaire

4-leur mécanisme d'action est une activation de la transcription de gène de production de lait

A-1,2,3,4 B -1,3,4 C-2,3,4 D-2,3 E-1,4

56-le déficit en IGF1 peut être observé dans les situations suivantes :

1. une dénutrition

2. une insuffisance hépatique

3. un déficit en GH

4- une hypothyroïdie

5- E-une Acromégalie

A-1,2,3 B-1,2,3,4 C-1,2,3,4,5 D-1,2,4,5 E-2,3,4

Qcm 57,58,59 et 60 correspondent à un cas clinique

57-Un garçon de 7ans est adressé pour un retard statural sévère avec une petite taille et un poids normal ; Ses parents sont de taille normale

Le bilan biologique : GH basale normale, IGF-1 : très bas,

Le test de stimulation à la GH : GH très élevée

57-Quel diagnostic est le plus probable ?

A-Déficit en GH

B -Résistance à la GH

C-hypothyroïdie

D- retard constitutionnel de croissance

E- malnutrition

58-Cette pathologie correspond au :

A- syndrome de Turner

B-syndrome de cushing

C-syndrome de Laron

D- syndrome de Klinefelter

E- aucune proposition exacte

59-Pourquoi la GH est-elle élevée après stimulation (par hypoglycémie insulinaire)

A-hyperproduction hypophysaire primitive

B- défaut de rétrocontrôle par IGF-1

C-augmentation de la somatostatine

D- Excès de cortisol

E- Excès d'insuline

60-l'anomalie principale est :

A- le gène de la GH

B- le récepteur de la GH

C- le récepteur de l'igf1

D- la sécrétion de GH-RH

E- l'hypophyse

Examen Microbiologie / 2026

1 - Concernant le monde microbien :

- A. Les bactéries possèdent un noyau cellulaire.
- B. La taille des bactéries varie entre 1 et 10 mm.
- C. Les virus sont des cellules simples sans noyau cellulaire.
- D. Les bactéries peuvent se reproduire de manière autonome.
- E. Les virus sont visibles au microscope optique (photonique).

2 - Quel est l'intérêt principal de la microbiologie médicale en santé publique ?

- A. L'étude exclusive de la flore intestinale et du microbiote humain.
- B. L'étude exclusive de la structure moléculaire de l'ADN bactérien.
- C. L'élimination de la totalité des bactéries présentes sur le corps humain.
- D. La production des micro-organismes à grande échelle pour l'industrie agroalimentaire.
- E. La surveillance des épidémies, l'identification des résistances aux antibiotiques et la contribution au développement des vaccins.

3 - La spore bactérienne :

- A. est résistante aux antibiotiques.
- B. est un facteur de virulence.
- C. est un élément obligatoire.
- D. résiste au froid et à la dessiccation.
- E. détermine la forme de la bactérie.

4- Les bactéries auxotrophes :

- A. exigent l'eau et une source de carbone seulement.
- B. ne peuvent pas synthétiser certains facteurs de croissance.
- C. sont non exigeantes.
- D. puisent leur énergie de la lumière.
- E. sont des bactéries aérobies strictes.

5- Les bactéries saprophytes :

- A. sont des micro-organismes qui se nourrissent de matières organiques ou végétales en décomposition dans le milieu extérieur.
- B. sont des bactéries qui vivent des déchets rejetés par les cellules des revêtements cutanéomuqueux.
- C. sont des bactéries non pathogènes pour le sujet immunodéprimé.
- D. sont capables de déclencher une maladie cliniquement définie et physiopathologiquement spécifique chez des hôtes immunocompétents.
- E. constituent la flore normale de l'homme.

6 - À propos de la toxinogénèse :

- A. La toxinogénèse est le pouvoir que possèdent les bactéries d'élaborer des toxines.
- B. Les toxines bactériennes sont des substances toxiques et non antigéniques.
- C. Les toxines sont classées selon leur composition chimique en trois groupes.
- D. Les endotoxines sont des toxines libérées après lyse de bactéries.
- E. Les toxines sont produites par les bactéries à Gram négatif uniquement.

7 - Les plasmides sont :

- A. des molécules d'ADN bicaténaire, circulaires extra-chromosomiques.
- B. des molécules d'ADN bicaténaire, circulaires intrachromosomiques.
- C. des molécules d'ARN bicaténaire, circulaires extra-chromosomiques.
- D. des molécules d'ARN bicaténaire, circulaires intrachromosomiques.
- E. Toutes les réponses sont fausses.

8 - Les céphalosporines :

- A. sont des betalactamines.
- B. agissent par inhibition compétitive.
- C. agissent sur les cocci à Gram positif uniquement.
- D. Leur cible d'action est le ribosome.
- E. font partie des monobactames.

9 - La résistance bactérienne naturelle à un antibiotique :

- A. est un caractère présent chez toutes les souches d'une même espèce.
- B. ne se transmet pas à la descendance.
- C. détermine le phénotype de résistance acquise.
- D. n'est possible que par un seul mécanisme qui est le mécanisme enzymatique.
- E. peut être due à l'acquisition de gènes exogènes.

10 - Concernant l'antibiogramme standard par diffusion en milieu gélose :

- A. Le milieu recommandé est le Mueller-Hinton avec 4 mm d'épaisseur pour les bactéries exigeantes.
- B. La densité d'inoculum doit être ajustée à 0,05 McFarland.
- C. Le test utilise un nombre illimité de disques par boîte si la surface le permet.
- D. Le diamètre d'inhibition est mesuré en mm après incubation.
- E. L'épaisseur du milieu gélose influence le diamètre observe sans modifier la concentration d'antibiotique.

11 - La désinfection de haut niveau permet de :

- A. détruire la plupart des bactéries, mais pas les germes résistants (BK, spores bactériennes).
- B. détruire quelques virus et champignons, mais pas les germes résistants (BK, spores bactériennes).
- C. détruire tous les micro-organismes et les spores bactériennes.
- D. détruire tous les micro-organismes, à l'exception des spores bactériennes.
- E. Toutes les réponses sont fausses.

12 - La stérilisation consiste à :

- A. éliminer certains micro-organismes vivants, de manière durable et réversible.
- B. éliminer certains micro-organismes vivants, de manière momentanée et réversible.
- C. éliminer certains micro-organismes vivants, de manière durable et irréversible.
- D. éliminer tous les micro-organismes vivants de manière momentanée et réversible.
- E. éliminer tous les micro-organismes vivants de manière durable et irréversible.

13 - *Streptococcus pneumoniae* :

- A. C'est une bactérie mobile possédant une ciliature péritriche.
- B. C'est un diplocoque à Gram négatif en forme de flamme de bougie.
- C. Il présente une résistance naturelle et absolue à toutes les bêtalactamines.
- D. Il présente une β -hémolyse franche et totale sur gélose au sang de mouton.
- E. C'est une bactérie exigeante qui nécessite une incubation sous atmosphère enrichie en CO₂ (5 à 10%).

14 - Concernant les bactéries du genre *Neisseria* :

- A. Les *Neisseria* sont des diplocoques en grain de café à Gram négatif, anaérobies stricts.
- B. La capsule polysaccharidique de *Neisseria meningitidis* protège la bactérie de la phagocytose.
- C. *Neisseria gonorrhoeae* est une bactérie très résistante dans le milieu extérieur (bactérie ubiquitaire).
- D. Le traitement de première intention de la gonococcie non compliquée repose sur l'érythromycine per os.
- E. *Neisseria meningitidis* est naturellement résistante à toutes les céphalosporines de 3^{ème} génération (C3G)

16 - *Clostridium botulinum* :

- A. est une bactérie qui sécrète une toxine.
- B. est une bactérie anaérobie-aérotolérante.
- C. La toxine empêche la libération d'un inhibiteur des synapses des neurones moteurs.
- D. est une bactérie bacille à Gram positif, non sporulée.
- E. Toutes les réponses sont justes.

17 - Concernant les bactéries bacilles à Gram positif :

- A. Les bacilles à Gram positif ont une paroi riche en lipopolysaccharides (LPS).
- B. L'espèce *Erysipelothrix rhusiopathiae* est le seul bacille à Gram positif sporulé.
- C. *Bacillus cereus* est un grand bacille à Gram positif, sporulé et aéro-anaérobie facultatif.
- D. La recherche de la catalase permet de différencier le genre *Listeria* du genre *Corynebacterium*.
- E. L'infection par *Bacillus anthracis* chez l'homme se produit par transmission interhumaine directe.

18 - Parmi les éléments suivants, lequel appartient à l'étape pré-analytique du diagnostic bactériologique ?

- A. Lecture de l'antibiogramme.
- B. Réalisation du prélèvement.
- C. Recherche d'antigènes solubles.
- D. Interprétation des résultats.
- E. Ensemencement sur gélose.

19 - Un patient hospitalisé reçoit des antibiotiques depuis 48 heures pour une suspicion de méningite. Quel prélèvement et quelle méthode sont les plus adaptés pour un diagnostic bactériologique pertinent dans ce contexte ?

- A. Culture classique du LCR sur gélose nutritive.
- B. Coloration de Ziehl-Neelsen sur selles
- C. Recherche d'antigènes solubles dans le LCR par immunochromatographie.
- D. Antibiogramme direct sur le sang.
- E. Hybridation ADN sur écouvillon pharyngé.

20 - Concernant les prélèvements monomicrobiens, laquelle des propositions suivantes est correcte ?

- A. Ils sont toujours réalisés au niveau des cavités naturelles.
- B. Ils nécessitent obligatoirement une conservation à +4°C.
- C. Ils concernent des sites normalement stériles.
- D. Ils contiennent toujours plusieurs germes.
- E. Ils peuvent être transportés sans condition particulière.

21 - La taxonomie :

- A. est la description des caractères des groupes d'organismes.
- B. se base uniquement sur des critères phénotypiques.
- C. L'espèce est le maillon essentiel de la classification.
- D. est la classification des organismes.
- E. Des valeurs du G +C % identiques impliquent que les organismes sont proches.

22 - Le peptidoglycane :

- A. est formé d'une couche épaisse chez les bactéries à Gram négatif et d'une couche mince chez les bactéries à Gram positif.
- B. est un hétéropolymère composé de glucides, de protéides et de lipides.
- C. Les chaînes glucidiques sont constituées d'un enchaînement d'acide N-acétylglucosamine.
- D. est une molécule spécifique des bactéries.
- E. est absent de la paroi des mycoplasmes.

23 - La croissance bactérienne :

- A. est l'accroissement ordonné de tous les composants de la bactérie.
- B. est caractérisée par un taux de croissance, qui est le temps requis pour un dédoublement du nombre de bactéries.
- C. Le temps de génération est le nombre de divisions par unité de temps.
- D. dont la cinétique montre 06 phases.
- E. Pendant la phase de latence, le taux de croissance atteint la valeur maximale.

24 - La flore normale de l'homme :

- A. Les bactéries commensales peuvent être réparties en quatre flores principales : cutanée, respiratoire, génitale et digestive.
- B. La flore cutanée est constituée principalement de streptocoques non groupables.
- C. Au niveau de l'arbre respiratoire inférieur, la flore est abondante (10¹⁰/ml de sécrétion)
- D. La flore de la bouche est constituée principalement d'entérobactéries.
- E. La flore commensale empêche l'implantation de bactéries à potentiel pathogène et le développement de bactéries commensales.

25 - Les exotoxines :

- A. sont des toxines libérées après lyse de bactéries.
- B. sont de nature lipopolysaccharidique.
- C. sont transformables en anatoxines.
- D. sont neutralisées par les antitoxines.
- E. sont les antigènes O des bactéries à Gram négatif.

26 - La mutation :

- A. est un changement spontané ou provoqué par un agent mutagène héréditaire.
- B. est stable (transmise à la descendance).
- C. touche plusieurs caractères à la fois.
- D. est brusque et rare.
- E. Toutes les réponses sont justes.

27 - Les glycopeptides :

- A. sont représentés par la gentamicine et l'amikacine.
- B. sont réservés au traitement de la tuberculose.
- C. agissent par toxicité sélective au niveau de la paroi bactérienne.
- D. agissent sur les entérobactéries productrices de bêtalactamases à spectre élargi.
- E. sont des molécules à usage hospitalier agissant spécifiquement contre les bactéries à Gram positif.

28 - La colistine :

- A. agit sur la sous-unité 50S du ribosome.
- B. agit uniquement sur les bactéries à Gram négatif.
- C. fait partie des macrolides.
- D. Agit par toxicité sélective sur la membrane cellulaire
- E. présente une analogie structurale avec l'acide folique.

29- La résistance acquise aux antibiotiques :

- A. est un marqueur d'identification de la bactérie.
- B. définit le profil sauvage d'une bactérie.
- C. est présente chez certaines souches d'une même espèce.
- D. Son support génétique peut être chromosomique ou plasmidique.
- E. Toutes les réponses sont fausses.

30 - À propos de la relation CMB/CMI :

- A. Une CMI basse et une CMB élevée traduisent une tolérance bactérienne.
- B. Un antibiotique peut être bactéricide in vitro et bactériostatique in vivo.
- C. Une CMB égale à la CMI signifie que l'antibiotique n'a aucun effet bactéricide.
- D. Une CMB/CMI = 8 peut correspondre à un antibiotique utilisé en thérapie d'infection invasive.
- E. Une souche tolérante présente un rapport CMB/CMI >32.

31 - Les vaccins vivants atténués :

- A. sont à base de bactéries atténuées par passages successifs en culture durant une longue période.
- B. sont responsables des infections très symptomatiques.
- C. La réponse à ces vaccins est durable après une seule administration.
- D. provoquent une infection inapparente (sans signes pathologiques).
- E. stimulent de façon prolongée l'immunité spécifique surtout cellulaire.

32 - Les vaccins antipneumococciques, polysidiques non conjugués sont :

- A. composés de polysides capsulaires.
- B. immunogènes avant 2 ans à cause de l'immaturité immunologique à cet âge.
- C. administrés en une injection SC ou IM, avec un rappel après 3 à 5 ans.
- D. recommandés chez les sujets immunodéprimés de plus de 5 ans.
- E. Toutes les réponses sont fausses.

33 - Les staphylocoques à coagulase négative :

- A. sont des pathogènes stricts.
- B. ne poussent pas sur des milieux enrichis.
- C. se différencient de *Staphylococcus aureus* par leur culture sur milieu de Chapman
- D. font partie de la flore commensale normale de la peau et des muqueuses humaines.
- E. La production de biofilm est un facteur de virulence majeur chez *Staphylococcus epidermidis*.

34 - Concernant les salmonelles :

- A. Le seul réservoir est l'homme pour les salmonelles non typhoïdiques.
- B. Le diagnostic peut se faire par sérologie de Widal et Felix pour les salmonelles mineures.
- C. Le diagnostic peut se faire à partir d'un prélèvement d'hémoculture pour *Salmonella typhi*.
- D. Ce sont des bactéries à Gram négatif, mobiles.
- E. Ce sont des bactéries qui présentent une résistance naturelle à la colistine.

35- *Pseudomonas aeruginosa* est une bactérie :

- A. aérobie stricte.
- B. bacille à Gram négatif, immobile.
- C. qui peut être responsable d'infections nosocomiales.
- D. exigeante.
- E. Toutes les réponses sont justes.

36 - *Vibrio cholerae* :

- A. est une bactérie exigeante.
- B. est une bactérie qui sécrète une toxine.
- C. Le seul réservoir est l'homme.
- D. est une bactérie sensible au pH alcalin.
- E. Le cholera est une maladie à déclaration obligatoire.

37. Concernant les mycobactéries atypiques :

- A. Elles font partie du complexe tuberculosis.
- B. Ce sont des bactéries acido-alcool-résistantes.
- C. Elles sont naturellement sensibles à la pénicilline G.
- D. Ce sont des bactéries à transmission interhumaine stricte.
- E. Elles sont ubiquitaires et présentes dans l'environnement (eau, sol).

38. La croissance bactérienne :

- A. Est l'accroissement ordonné de tous les composants de la bactérie.
- B. Est caractérisée par un taux de croissance, qui est le temps requis pour un dédoublement du nombre de bactéries.
- C. Le temps de génération est le nombre de divisions par unité de temps.
- D. Dont la cinétique montre 06 phases.
- E. Pendant la phase de latence, le taux de croissance atteint la valeur maximale.

39. L'infection virale aiguë est caractérisée par :

- A. La présence continue du virus dans certains organes.
- B. Des phases de dormance du virus.
- C. Une multiplication virale intense et rapide.
- D. Une période d'incubation courte.
- E. Toutes les réponses sont justes.

40. Parmi les virus suivants, lesquels n'utilisent pas la voie de transmission féco-orale ?

- A. Virus respiratoire syncytial (VRS).
- B. Oreillons.
- C. Rotavirus.
- D. Herpès simplex virus (HSV).
- E. Adenovirus.

41. Les facteurs favorisant l'échappement des virus aux mécanismes de défense de l'hôte sont :

- A. L'état de latence virale.
- B. La voie d'inoculation du virus.
- C. La variabilité génétique du virus.
- D. La quantité du virus au niveau de la porte d'entrée.
- E. Toutes les réponses sont justes.

42. Concernant le virus Herpès simplex (HSV) :

- A. Le HSV-2 est principalement responsable de l'herpès oro-labial.
- B. Les anticorps neutralisants empêchent totalement la survenue de récurrences cliniques.
- C. Les HSV-1 et HSV-2 persistent de manière latente dans les ganglions nerveux sensitifs.
- D. La transmission se fait uniquement par contact direct avec des lésions ou des sécrétions.
- E. Les immunodéprimés sont à risque de développer des formes graves (encéphalites, atteintes disséminées).

43. La flore normale de l'homme :

- A. Les bactéries commensales peuvent être réparties en quatre flores principales : cutanée, respiratoire, génitale et digestive.
- B. La flore cutanée est constituée principalement de streptocoques non groupables.
- C. Au niveau de l'arbre respiratoire inférieur, la flore est abondante.
- D. La flore de la bouche est constituée principalement d'entérobactéries.
- E. La flore commensale empêche l'implantation de bactéries à potentiel pathogène et le développement des bactéries commensales.

44. La résistance bactérienne naturelle à un antibiotique :

- A. Est un caractère présent chez toutes les souches d'une même espèce.
- B. Ne se transmet pas à la descendance
- C. Détermine le phénotype de résistance acquise.
- D. N'est possible que par un seul mécanisme qui est le mécanisme enzymatique.
- E. Peut être due à l'acquisition de gènes exogènes.

45. La résistance acquise aux antibiotiques :

- A. Un marqueur d'identification de la bactérie.
- B. Est le profil sauvage d'une bactérie.
- C. Présente chez certaines souches des mêmes espèces.
- D. Un support génétique peut être chromosomique ou plasmidique.
- E. Toutes les réponses sont fausses.

46. Les virus :

- A. Ont une taille supérieure à celle des bactéries.
- B. Contiennent une molécule d'ADN et une molécule d'ARN.
- C. Sont obligatoirement enveloppés.
- D. Se reproduisent par division binaire et non par réplication.
- E. Sont des parasites intracellulaires.

47. L'enveloppe virale :

- A. Est présente chez tous les virus.
- B. Est constituée de capsomères.
- C. Est un élément qui confère une résistance aux virus.
- D. Est de nature exclusivement protéique.
- E. Est issue des membranes cellulaires de la cellule infectée par le virus.

48. Concernant le poliovirus :

- A. Son réservoir est strictement humain.
- B. Il n'existe pas de vaccin efficace contre ce virus.
- C. Il se multiplie uniquement dans le tissu nerveux.
- D. Sa transmission se fait principalement par l'eau et les aliments.
- E. Il appartient à la famille des Picornaviridae et au genre Echovirus.

49. Le SARS-CoV-2 (coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2) :

- A. Est un virus zoonotique.
- B. Appartient au genre Alphacoronavirus.
- C. Est le plus petit des virus à ARN connus.
- D. Se réplique dans le cytoplasme de la cellule hôte.
- E. Intègre le génome cellulaire immédiatement après la décapsidation dans la cellule.

50. L'efficacité virologique d'un traitement antiviral est évaluée :

- A. In vitro par la croissance de la charge virale sous traitement par rapport à la charge virale initiale
- B. In vivo par la croissance de la charge virale sous traitement par rapport à la charge virale initiale
- C. In vitro par la décroissance de la charge virale sous traitement par rapport à la charge virale initiale.
- D. In vivo par la décroissance de la charge virale sous traitement par rapport à la charge virale initiale.
- E. Toutes les réponses sont justes.

51. Quel est l'intérêt principal de la microbiologie médicale en santé publique ?

- A. L'étude exclusive de la flore intestinale et du microbiote humain.
- B. L'étude exclusive de la structure moléculaire de l'ADN bactérien.
- C. L'élimination de la totalité des bactéries présentes sur le corps humain.
- D. La préservation des micro-organismes à grande échelle pour l'industrie agroalimentaire.
- E. La surveillance des épidémies, l'identification des résistances aux antibiotiques et la contribution au développement des vaccins.

52. Les vaccins vivants atténués :

- A. Sont à base de bactéries atténuées par passages successifs en culture durant une longue période
- B. Sont responsables des infections très symptomatiques.
- C. La réponse à ces vaccins est durable après une seule administration.
- D. Provoquent une infection inapparente (sans signes pathologiques).
- E. Stimulent de façon prolongée l'immunité spécifique surtout cellulaire.

53. Les vaccins antipneumococciques polysidiques non conjugués sont :

- A. Composés de polysides capsulaires.
- B. Immunogènes avant 2 ans à cause de l'immaturité immunologique à cet âge.
- C. Administres en une injection SC ou IM, avec un rappel après 3 à 5 ans.
- D. Recommandés chez les sujets immunodéprimés de plus de 5 ans.
- E. Toutes les réponses sont fausses.

54. *Vibrio cholerae* :

- A. Une bactérie exigeante.
- B. Une bactérie qui sécrète une toxine.
- C. Le seul réservoir est l'homme.
- D. Une bactérie sensible au pH alcalin.
- E. Le choléra est une maladie à déclaration obligatoire.

55. Le VIH (virus de l'immunodéficience humaine) :

- A. Fait partie de la famille des Retroviridae, genre Orthoretrovirus.
- B. Se transmet de la mère à l'enfant pendant la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement.
- C. Le VIH infecte principalement les lymphocytes T CD4, les macrophages et les cellules dendritiques.
- D. La physiopathologie du VIH repose sur la destruction et l'épuisement progressif des lymphocytes T CD4+.
- E. L'ARN polymérase dépendante de l'ADN est responsable de l'insertion de l'ADN proviral dans le génome de la cellule.

56. Le schéma thérapeutique des infections à VIH est basé sur :

- A. 02 molécules d'inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse et 01 molécule d'inhibiteur de la protéase.
- B. 03 molécules d'inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse et 02 molécules d'inhibiteurs de la protéase.
- C. 02 molécules d'inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse et 01 molécule d'inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse.
- D. 02 molécules d'inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse et 02 molécules d'inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse.
- E. 03 molécules d'inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse.

57. Concernant les adénovirus :

- A. Les adénovirus sont exclusivement responsables d'atteintes digestives.
- B. Les sérotypes 40 et 41 sont associés aux gastro-entérites.
- C. La sérologie constitue le diagnostic de référence.
- D. Les adénovirus sont sensibles aux solvants lipidiques.
- E. Le vaccin est recommandé en population générale.

58. Les papillomavirus humains (HPV) :

- A. Ce sont des virus enveloppés.
- B. Leur génome est un ADN bicaténaire circulaire.
- C. La protéine L1 est utilisée dans les vaccins VLP.
- D. E6 et E7 sont des protéines structurales.
- E. Les HPV appartiennent à la famille des Papovaviridae.

59. Concernant le parvovirus B19 :

- A. C'est un virus à ARN.
- B. Il possède une capsid icosaédrique.
- C. Il infecte préférentiellement les précurseurs érythroïdes.
- D. Il est enveloppé.
- E. Il appartient à la famille des Herpesviridae.

60. Un virus à ARN simple brin de polarité négative pénètre dans une cellule. Quelle est la première étape indispensable à l'expression de son génome ?

- A. Traduction directe de l'ARN viral.
- B. Synthèse d'un ADN complémentaire.
- C. Production d'ARNm à partir du génome viral par une transcriptase.
- D. Réplication du génome viral en ARN négatif.
- E. Intégration dans le génome cellulaire.

Examen parasito / 2026

Cas clinique N 01 :

Vous recevez au laboratoire Madame X âgée de 30 ans, primigeste enceinte de 08 semaines d'aménorrhée (SA) pour une sérologie toxoplasmique, La technique utilisée est ELISA (seuil de la technique est 09 UI/ml). Le résultat obtenu est le suivant : IgG : 4 UI/ml et IgM : Positives.

1) Comment interprétez-vous ce résultat et quelle est votre conduite à tenir ?

- A. Ce résultat permet de conclure qu'il s'agit d'une infection toxoplasmique récente
- B. Les IgM détectées peuvent être des IgM non spécifiques ou des IgM spécifiques de début d'infection toxoplasmique
- C. Faire une autre sérologie après 15 jours dans le même laboratoire et par la même technique
- D. Conseiller à la femme les mesures hygiénodietétiques.
- E. Mettre rapidement la femme sous Spiramycine (Rovamycine°).

2) Après votre décision, vous obtenez le résultat suivant: IgG: 100 UI/ml et IgM: Positives, Quelle est votre conclusion et que décidez-vous (sachant que ce résultat obtenu a été confirmé par une autre technique et par un troisième sérum prélevé sans délai) ?

- A. Il s'agit d'une séroconversion toxoplasmique.
- B. Débuter rapidement le traitement préventif à base de Spiramycine (Rovamycine) a la posologie de 9 MUI/j et cela sans fenêtre thérapeutique en attendant le diagnostic de toxoplasmose congénitale.
- C. Une surveillance échographique mensuelle à la recherche d'anomalies fœtales pendant toute la durée de la grossesse avec un suivi sérologique mensuel jusqu'à l'accouchement pour s'assurer de l'observance du traitement par la femme
- D. Programmer une amniocentèse à partir de la 28 SA pour la recherche de toxoplasme dans le liquide amniotique par biologie moléculaire (e) et/ou inoculation à la souris blanche
- E. La contamination maternelle nécessite l'ingestion de kystes contenus dans de la viande peu cuite ou d'oocystes sporulés dans les crudités ou l'eau de boisson.

3) La surveillance échographique détecte une hydrocéphalie, la recherche de l'ADN toxoplasmique dans le liquide amniotique est positive, le résultat de l'inoculation à la souris blanche est en cours. Quelle est votre conclusion et votre conduite à tenir!

- A. La présence de l'ADN du toxoplasme dans le liquide amniotique est en faveur d'une toxoplasmose congénitale.
- B. Il faut changer rapidement le traitement préventif par un traitement curatif à base d'association Pyriméthamine-sulfamide avec adjonction de l'acide folinique en alternance avec de la Spiramycine pendant toute la durée de la grossesse.
- C. Renforcer la surveillance échographique pendant toute la durée de la grossesse.
- D. Une interruption médicale de la grossesse s'impose
- E. Une surveillance sérologique mensuelle avec une surveillance régulière de la toxicité hématologique et cutanée du traitement pendant toute la durée de la grossesse,

4) Au cours d'une consultation chez le gynécologue dans le cadre de son suivi de grossesse Madame X se plaint d'un prurit vaginal intense et de leucorrhées abondantes. Un examen clinique est réalisé retrouve une muqueuse vulvaire et vaginale très érythémateuse et douloureuse au toucher ainsi que des leucorrhées blanchâtres, épaisses et grumeleuses, évoquant une mycose vaginale. De façon générale, quel(s) est(sont) le(s) facteur(s) de risque de candidose vulvo-vaginale ?

- A. La fin de grossesse.
- B. La ménopause
- C. Le portage asymptomatique de Candida par le partenaire sexuel.
- D. L'antibiothérapie à large spectre
- E. Le diabète mal équilibré.

5) Pour poser le diagnostic de candidose vulvo-vaginale chez Madame X, que faites-vous ?

- A. Le diagnostic est uniquement clinique.
- B. Réaliser des hémocultures.
- C. Prélèvement vaginal à l'aide d'écouvillon stérile(s), examen direct, mise en culture et identification des agents fongiques isolés.
- D. Recherche d'antigènes circulants « mannanes »
- E. Recherche d'anticorps anti-mannanes.

6) Quel(s) est(sont) le(s) agent(s) mycosique(s) le(s) plus fréquemment mis en cause

- A. Trichophyton.sp
- B. Candida albicans.
- C. Epidermophyton floccosum.
- D. Candida glabrata
- E. Microsporum canis.

7) Après l'accouchement, dans le cadre de la prise en charge de toxoplasmose congénitale, quelle conduite adoptez-vous chez le bébé ?

- A. Il faut mettre systématiquement le nouveau-né dès sa naissance sous association pyriméthamine-sulfamide avec adjonction d'acide folinique en alternance avec de la spiramycine pendant 1 à 2 ans avec une surveillance régulière de la toxicité hématologique et cutanée du traitement.
- B. Réaliser un fond d'œil sous anesthésie générale à la recherche d'une atteinte oculaire toxoplasmique.
- C. Réaliser une échographie transfontanellaire à la recherche de malformations cérébrales.
- D. Une surveillance sérologique mensuelle
- E. Poursuivre la surveillance ophtalmologique d'une façon régulière en réalisant le fond d'œil jusqu'à l'âge adulte.

8) La fasciolose à *Fasciola hepatica* est une distomatose hépatobiliaire :

- A. Retrouvée en Algérie, contractée suite à l'ingestion de végétaux semi aquatiques sauvages crus contenant des métacercaires enkystées
- B. Qui peut se traduire sur le plan clinique par une hépatite toxi-infectieuse et des manifestations allergiques pendant la phase d'invasion.
- C. Au cours de laquelle, les signes cliniques de la phase d'état sont dus à la présence des douves adultes dans les canaux biliaires
- D. Qui peut être à l'origine d'une hyper éosinophilie sanguine importante évoluant selon la courbe de Lavier à la phase de migration larvaire.
- E. De diagnostic séro-immunologique à la phase d'invasion par la recherche d'anticorps spécifiques dans le sérum et de diagnostic coproparasitologique à la phase d'état par la mise en évidence des œufs operculés caractéristiques.

9) Laquelle ou lesquelles de ces propositions suivantes concernant les poux est (sont) inexacte(s)?

- A. Sont des arthropodes responsables des ectoparasitoses contagieuses et prurigineuses.
- B. La pédiculose corporelle due au « *Pediculus humanus corporis* », se traduit sur le plan clinique par un prurit corporel violent
- C. La phthiriose se manifeste essentiellement par un prurit violent de la région pubienne et le traitement du ou des partenaire(s) sexuel(s) n'est pas indispensable.
- D. La pédiculose de la tête due au *Pediculus humanus capitis* » touche essentiellement les enfants d'âge scolaire, se traduisant sur le plan clinique par un prurit violent du cuir chevelu à prédominance rétro-auriculaire et ou occipitale.
- E. Leur diagnostic est assuré par la mise en évidence de l'ectoparasite et/ou de lentes ; et leur traitement repose sur le traitement du sujet atteint, de son entourage ainsi que le traitement des vêtements et de la literie.

10) Concernant les leishmanioses humaines, quelles sont les propositions exactes ?

- A. Les leishmanioses sont des antroponoses provoquées par des protozoaires flagellés du genre (*Leishmania*), transmis à l'homme par la pique de phlébotomes femelles infectées.
- B. Chez l'homme, la forme parasitaire retrouvée dans les macrophages du système des phagocytes mononucléées est l'amastigote
- C. la leishmaniose viscérale méditerranéenne est principalement due à *Leishmania infantum* dont le chien constitue le principal réservoir domestique.
- d. La leishmaniose cutanée est toujours mortelle en l'absence de traitement spécifique.
- E. Les phlébotomes appartiennent à la famille des Psychodidae et jouent le rôle d'hôte intermédiaire et de vecteur biologique,

11) Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles est (sont) exacte(s) ?

- A. *Entamoeba histolytica* est la seule amibe du colon pathogène pour l'homme, contracté suite à l'ingestion de kystes murs à quatre noyaux souillant les fruits, les légumes ou l'eau de boisson.
- B. L'amoebose hépatique se traduit sur le plan clinique par une hépatomégalie fébrile douloureuse dont le diagnostic est séro-immunologique par la recherche d'anticorps spécifiques dans le sérum
- C. L'amoebose hépatique est secondaire à une amoebose intestinale parfois non diagnostiquée.
- D. L'amoebose intestinale aiguë se traduit sur le plan clinique par un syndrome dysentérique dont le diagnostic est coproparasitologique
- 5. Le traitement de l'amoebose maladie fait appel aux antiamibiens diffusibles (tissulaires) et de contact.

12) Parmi les propositions suivantes, vous retenir :

- A. L'ascaridiose est due à un nématode « *Ascaris lumbricoides* » contracté suite à l'ingestion d'œufs embryonnés présents sur les aliments ou dans l'eau de boisson souillée.
- B. L'oxyurose est une parasitose cosmopolite due à « *Enterobius vermicularis* » particulièrement fréquent chez l'enfant, se traduisant sur le plan clinique par un prurit anal nocturne qui est lié à la migration des femelles gravides vers la marge anale.
- C. Au cours de l'ascaridiose, le diagnostic de la phase intestinale repose généralement sur la mise en évidence des œufs dans les selles
- D. Le scotch-test de Graham réalisé le matin avant la toilette est l'examen de choix pour le diagnostic de l'oxyurose
- E. Au cours de l'oxyurose les phénomènes d'auto-infestation et de réinfestation familiale expliquent la fréquence des récurrences

13) Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles est (sont) exacte(s) ?

- A. Le diagnostic des candidoses profondes repose sur la réalisation répétée d'hémocultures et de la recherche couplée de mannanes circulants et d'anti mannanes
- B. La candidémie est définie par la présence du *Candida* dans le sang objectivée par au moins une hémoculture positive
- C. Les candidoses invasives dues aux *Candidas* répondent bien au fluconazole
- D. Le suivi régulier de la colonisation des muqueuses fait partie de la démarche diagnostique des candidoses invasives
- E. Le diagnostic des candidoses profondes peut être assuré par l'étude mycologique des biopsies des tissus profonds et/ou l'examen direct et mise en culture des liquides biologiques stériles

14) Pour les malassezioses, laquelle de ces propositions suivantes est inexacte ?

- A. La dermite séborrhéique peut se traduire chez un adulte par des lésions erythématosquameuses prurigineuses siégeant aux niveaux du visage et/ou retro auriculaire
- B. Le diagnostic de pityriasis versicolor repose sur le ... cutané qui met en évidence des spores fongiques groupés en « grappe de raisin »
- C. Le pityriasis capitis se traduit sur le plan clinique par une desquamation abondante et prurigineuse du cuir chevelue entraînant une chute de cheveux.
- D. Les malassezioses systémiques sont des mycoses rares et graves, survenant chez les prématurés ou les immunodéprimés sous-alimentation parentérale riches en lipides (intra-lipides
- E. Au cours des malassezioses systémiques le retrait du cathéter souillé et sa mise en culture des milieux additionnels permet le diagnostic

15) Une femme enceinte qui fait une toxoplasmose aiguë au cours de sa grossesse, met au monde un enfant à terme. A la naissance, lesquelles parmi les propositions suivantes concernant cet enfant, retenez-vous

- A. L'atteinte fœtale est obligatoire et l'enfant sera atteint d'une toxoplasmose congénitale
- B. Il peut avoir une sérologie toxoplasmique totalement négative
- C. Il ne peut pas avoir une sérologie toxoplasmique totalement négative.
- D. Même s'il est indemne de toxoplasmose congénitale, la présence d'IgG spécifiques d'origine maternelle est constante.
- E. La négativation d'IgG spécifiques chez l'enfant l'âge de 2 à 4 ans permet d'éliminer une toxoplasmose congénitale

16) Parmi les propositions suivantes laquelle ou lesquelles sont exacte(s) ?

- A. les Intertrigos des petits plis à dermatophytes sont plus fréquents aux niveaux des pieds et ceux à Candida sont plus fréquents aux niveaux des mains
- B. Les Intertrigos à Candida débutent au fond du pli avec des bords irréguliers d'aspect « cinétié » et un enduit blanchâtre au fond du pli,
- C. L'onychomycose à dermatophytes siège aux niveaux des ongles des pieds, sans périonyxis
- D. L'onychomycose à Candida est beaucoup plus fréquente aux niveaux des ongles des mains avec un périonyxis et Candida albicans est l'espèce la plus souvent incriminée.
- E. Les teignes tondantes microscopiques et dermatophytiques touchent surtout les enfants se traduisent sur le plan clinique par des plaques alopéciques

17) Concernant la cryptococcose, quelles sont les propositions exactes ?

- A. La cryptococcose est une mycose opportuniste causée principalement par Cryptococcus neoformans
- B. Les patients présentant une immunodépression cellulaire sont particulièrement exposés à cette infection.
- C. La localisation neuro-méningée représente la forme clinique la plus fréquente et la plus grave
- D. L'examen direct du liquide céphalo-rachidien (LCR) à l'encre de Chine peut mettre en évidence les levures encapsulées.
- E. La recherche d'antigènes cryptococciques dans le LCR ou le sérum possède une excellente sensibilité diagnostique.

18) A propos des aspergilloses respiratoires, vous retenez :

- A. L'aspergillome pulmonaire intra cavitairé résulte d'une colonisation aspergillaire d'une cavité préformée pouvant se traduire sur le plan clinique par des hémoptysies
- B. L'aspergillose pulmonaire invasive est une pneumopathie aigue fébrile résistante aux antibiotiques à large spectre touchent surtout les patients neutropéniques
- C. Au cours de l'aspergillose pulmonaire invasive le scanner thoracique peut montrer des signes radiologiques évocateurs : le signe de halo ou le croissant gazeux.
- D. L'aspergillome pulmonaire intra cavitairé se traduit radiologiquement par l'image en « grelot » et la détection d'anticorps spécifiques dans le sérum assure le diagnostic
- E. Le diagnostic de l'aspergillose pulmonaire invasive repose essentiellement sur la recherche d'antigènes circulants « galactomannanes » et le traitement curatif de première intention fait appel au variconazole (Vfend5).

19) Deux de ces propositions suivantes concernant la toxoplasmose sont exactes, lesquelles?

- A. La primo-infection toxoplasmique peut être due à l'ingestion de viande peu cuite contenant des kystes, ou suite à l'absorption d'oocystes sporules souillés les crudités ou l'eau de boisson.
- B. La primo-infection toxoplasmique peut être due à une greffe d'organe provenant d'un donneur séronégatif pour la toxoplasmose à un receveur séropositif pour la toxoplasmose en pré greffe.
- C. La toxoplasmose congénitale, due au passage transplacentaire de tachyzoïtes, est bénigne en cas de contamination maternelle en début de grossesse.
- D. En cas de contamination maternelle tardive survenue au cours du troisième trimestre de grossesse, la toxoplasmose congénitale est grave,
- E. Le risque du passage du parasite au fœtus augmente avec l'Age de grossesse alors que la gravité de l'atteinte fœtale est inversement proportionnelle à l'age de grossesse.

20) Lesquelles de ces propositions suivantes concernant les amibes libres sont exactes ?

- A. *Nægléria fawleri* est responsable de méningo-encéphalite amibienne primitive et l'examen anatomopathologique des biopsies cérébrales met en évidence des kystes de *Nægléria fawleri*.
- B. Aux niveaux des prélèvements, la mise en évidence des différentes formes d'amibes à l'examen direct et/ou en culture et/ou de l'ADN parasitaire assure le diagnostic.
- C. *Acanthamoeba* sp est une amibe opportuniste pouvant être responsable de kératite et/ou d'encéphalite amibienne granulomateuse; et sa forme kystique est très sensible aux traitements.
- D. *Nægléria fowleri* est contracté par Voie nasale suite à une baignade dans une piscine réchauffée contaminée.
- E. La porte d'entrée d'*Acanthamoeba*.sp est essentiellement oculaire ou cutanée.

21) Concernant le diagnostic biologique des leishmanioses viscérales, quelles sont les réponses exactes ?

- A. La mise en évidence directe des amastigotes sur un frottis médullaire coloré constitue un argument diagnostique de certitude.
- B. La culture du parasite sur milieux spécialisés peut être réalisée dans certains laboratoires de référence.
- C. Les techniques de biologie moléculaire permettent l'identification de l'espèce en cause.
- D. Les tests sérologiques présentent un intérêt particulier dans la leishmaniose viscérale.
- E. La goutte épaisse demeure l'examen de référence pour le diagnostic de la leishmaniose viscérale

22) À propos de la gale humaine, vous retenez :

- A. C'est une ectoparasitose prurigineuse, contagieuse, sexuellement transmissible due au *Sarcoptes scabiei hominis* ", se manifestant par un prurit intense continu à recrudescence et prédominance nocturne.
- B. Les lésions chez l'adulte siègent essentiellement aux niveaux de la plante des pieds et la paume des mains
- C. La gale hyperkératosique de sujet âgé est une forme très prurigineuse et peu contagieuse.
- D. Les lésions chez le nourrisson siègent essentiellement aux niveaux des espaces interdigitaux des mains et/ou des faces antérieures des poignets tout en respectant la paume des mains et la plante des pieds.
- E. Le diagnostic est confirmé par la mise en évidence de l'acarien et le traitement du sujet atteint, de son entourage, de vêtements et de la literie est indispensable.

23) Concernant le paludisme, quelles sont les propositions exactes ?

- A. La transmission habituelle du paludisme s'effectue par la pique d'un moustique femelle du genre *Anophèles* infecté.
- B. *Plasmodium falciparum* est l'espèce responsable de la majorité des formes graves et des décès liés au paludisme.
- C. Les manifestations cliniques associent fréquemment fièvre, frissons, céphalées et altération de l'état général.
- D. Une anémie hémolytique peut apparaître en raison de la destruction des globules rouges parasités.
- E. Une hypereosinophilie sanguine importante constitue un signe biologique caractéristique du paludisme,

24) Toutes les propositions suivantes concernant la toxoplasmose sont exactes sauf deux, lesquelles ?

- A. Le diagnostic est séro-immunologique chez l'immunocompétent par la recherche couplée et systématique d'IgG et d'IgM spécifiques.
- B. La mise en évidence d'une synthèse locale d'anticorps spécifiques dans le liquide céphalorachidien assure le diagnostic de toxoplasmose cérébrale.
- C.. Un contrôle sérologique négatif chez une femme enceinte le jour de l'accouchement, permet d'écarter le risque de toxoplasmose congénitale pour l'enfant.
- D. La séroconversion s'exprime par une sérologie négative qui devient positive confirmée par l'apparition d'IgG spécifiques.
- E. La présence d'IgM spécifiques permet d'affirmer une infection récente.

25) Parmi les manifestations suivantes, lesquelles correspondent à des critères de gravité du paludisme à *Plasmodium falciparum* ?

- A. Coma ou troubles sévères de la conscience définissant le neuropaludisme.
 - B. Insuffisance rénale aiguë secondaire à l'atteinte multiviscérale.
 - C. Hypoglycémie sévère pouvant compromettre le pronostic vital.
 - D. Œdème pulmonaire aigu ou syndrome de détresse respiratoire aiguë
- Prurit généralisé isolé sans autre signe clinique.

26) La conduite à tenir chez une femme enceinte non immunisée et non protégée pour la toxoplasmose consiste en :

- A. Une surveillance sérologique mensuelle pendant toute la durée de la grossesse avec un dernier contrôle 2 à 4 semaines après l'accouchement pour dépister une éventuelle contamination tardive.
- B. Ne pas consommer de crudités crus mal lavés.
- C. Ne pas consommer de la viande saignante ou insuffisamment cuite.
- D. Mettre des gants pour jardiner et bien se laver les mains ensuite.
- E. Un traitement à base de Spiramycine (Rovamycine") pendant toute la durée de la grossesse

27) Concernant les microsporidioses humaines, quelles sont les propositions exactes ?

- A. Les microsporidies sont des microorganismes intracellulaires obligatoires responsables d'infections opportunistes,
- B. Les patients immunodéprimés, notamment les sujets infectés par le VIH, représentent la population la plus exposée.
- C. Les manifestations digestives peuvent se traduire par une diarrhée chronique avec syndrome de malabsorption
- D. Le diagnostic repose sur la mise en évidence des spores grâce à des colorations spécifiques, à la microscopie électronique ou à la PCR.
- E. La transmission nécessite obligatoirement l'intervention d'un moustique du genre Anophèles.

28) Concernant la pneumocystose, quelles sont les propositions exactes ?

- A. La pneumocystose est une infection opportuniste causée par « *Pneumocystis jirovecii* »
- B. Elle survient principalement chez les patients présentant une immunodépression, notamment liée au VIH ou à des traitements immunosuppresseurs.
- C. Les signes cliniques associent fréquemment dyspnée progressive, fièvre et toux sèche.
- D. Le diagnostic peut être réalisé sur un lavage broncho-alvéolaire grâce à l'examen microscopique après coloration.
- E. L'hyperéosinophilie majeure constitue l'anomalie biologique la plus fréquente.

Cas clinique N° 02 :

Une sérologie toxoplasmique faite par la technique EIISA (seuil de positivité : 10 UI/ml) chez une femme bien portante, enceinte de 05 semaines d'aménorrhée, montre le résultat suivant: IgG : 38 UI/ml et IgM : Positives,

29) Que concluez-vous et que décidez-vous ?

- A. Présence d'anticorps anti toxoplasmiques et les IgM détectés peuvent être des IgM spécifiques d'infection récente ou des IgM résiduelles d'une immunité ancienne
- B. Présence d'anticorps anti toxoplasmiques et les IgM détectées peuvent être des IgM non spécifiques
- C. Mettre rapidement la femme sous Spiramycine (Rovamycine") pendant toute la durée de la grossesse.
- D. Dater l'infection par la réalisation du test d'avidité.
- E. Réaliser la technique ISAGA pour les IgM afin de trancher entre les IgM spécifiques et non spécifiques

30) La mesure d'indice d'avidité (IA) donne le résultat suivant : IA= 0,9 (seuil de la technique : 0,5) : et l'ISAGA confirme la spécificité des IgM détectées. Laquelle ou lesquelles parmi les propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

- A. L'IA est en faveur d'une contamination maternelle datant de plus de 20 semaines (plus de 05 mois)
- B. Vu l'âge de la grossesse, l'IA permet d'exclure une infection récente.
- C. Un contrôle sérologique fait après trois semaines, dans le même laboratoire et par la même technique, montre normalement un titre stable d'IgG.
- D. Vu l'âge de la grossesse, les résultats sont en faveur d'une immunité ancienne probable avec des IgM résiduelles.
- E. Aucun suivi n'est nécessaire pour cette femme enceinte.

Examen Pharmacologie / 2026

1. Concernant la voie orale, quelle affirmation est juste

- A) Elle permet d'éviter systématiquement l'effet de premier passage hépatique.
- B) L'absorption se fait majoritairement au niveau de l'estomac grâce à son pH acide.
- C) La biodisponibilité est généralement de 100%.
- D) Elle est contre-indiquée chez un patient inconscient ou présentant des vomissements incoercibles.
- E) Le cycle entéro-hépatique n'influence jamais la durée d'action des médicaments pris par cette voie.

2. La voie intraveineuse est caractérisée par. Cochez la réponse juste

- A) Une latence d'action importante due à la distribution tissulaire.
- B) Une biodisponibilité par définition égale à 100%.
- C) La possibilité d'injecter des solutions huileuses.
- D) L'impossibilité de stopper l'administration en cas de réaction indésirable immédiate.
- E) Une absorption dépendante du pH gastro-intestinal.

3. A propos de la voie rectale, cochez la proposition juste,

- A) Elle est la voie de référence pour les médicaments d'urgence chez l'adulte
- B) Les veines hémorroïdaires ne se jettent pas toutes dans la circulation porte, évitant partiellement
- C) L'absorption y est toujours plus régulière et complète que par voie orale.
- D) Elle est recommandée en cas de diarrhée aigue pour augmenter l'absorption.
- E) Elle permet une administration précise de gros volumes de liquide.

4. Concernant les injections intramusculaires (IM) et sous-cutanées (SC). Cochez la réponse fausse

- A) La voie IM est autorisée chez les patients sous traitement anticoagulant efficace.
- B) La voie SC permet l'administration de faibles volumes de médicaments.
- C) La vascularisation du site d'injection influence directement la vitesse de résorption.
- D) Ces voies évitent totalement le passage hépatique
- E) La voie IM permet l'administration de substances huileuses

5. L'absorption par voie sublinguale :

- 1- Est rapide grâce à la finesse de la muqueuse et à la richesse de la vascularisation locale
- 2- Est rapide grâce au passage direct des principes actifs dans la veine porte
- 3- Elle garantit que 100 % de la dose est absorbée, même si le patient déglutit
- 4- Elle permet une libération prolongée sur 24 heures
- 5- Elle évite la destruction du principe actif par l'acidité gastrique et le premier passage hépatique.

A) 1-3 B) 1-4 C) 1-5 D) 3-5 E) 4-5

6. Concernant la pharmacocinétique des médicaments. Cochez la réponse juste.

- A) La pharmacocinétique se définit par les effets du médicament sur l'organisme
- B) La pharmacocinétique comprend 4 phases : administration, distribution, métabolisme et élimination.
- C) Un médicament administré par voie orale, sa biodisponibilité est de 100 %.
- D) C'est l'effet de l'organisme sur le médicament.
- E) L'effet de premier passage hépatique concerne tous les médicaments après administration orale.

7. Les paramètres pharmacocinétiques permettant de quantifier la phase de l'absorption. Cochez la réponse fausse.

- A. La biodisponibilité
- B. L'aire sous la courbe ASC.
- C. Le volume de distribution Vd.
- D. La concentration maximale (C_{max}).
- E. Le T_{max}.

8. La biodisponibilité. Cochez la réponse fausse

- A. Est la fraction de la dose du médicament administré qui atteint la circulation générale et la vitesse à laquelle elle l'atteint.
- B. Est un paramètre pharmacocinétique mesurant la phase de l'absorption.
- C. Est un paramètre pharmacocinétique mesurant la phase de l'élimination.
- D. La biodisponibilité relative est utilisée pour comparer des formes galéniques.

La biodisponibilité relative est indispensable pour la réalisation des études de bioéquivalence,

9. La diffusion passive des médicaments. Cochez la réponse fausse

- A. La diffusion passive dépend du gradient de concentration.
- B. C'est un mécanisme qui ne consomme pas d'énergie.
- C. Elle n'est pas saturable.
- D. Elle ne nécessite pas de transporteurs.
- E. C'est un transfert via les transporteurs membranaires.

10. Dans le sang, le médicament peut exister sous forme liée aux protéines plasmatiques, Cochez la réponse juste

- A. C'est la forme active.
- B. C'est la forme qui permet au principe actif de diffuser librement et de rejoindre l'organe cible
- C. C'est la forme de transport et de stockage provisoire.
- D. Médicaments fortement liés si le pourcentage de liaison est > 50 %.
- E. La principale protéine impliquée dans la fixation protéique est l'acide alpha 1-glycoprotéine.

11. La P-gp ou Glycoprotéine P. Cochez la réponse juste

- A) Qui a pour nom MDR 1
- B) Impliquée dans la diffusion passive des médicaments.
- C) Augmente l'absorption des médicaments.
- D) Est impliquée dans le métabolisme des médicaments par une oxydation.
- E) Est une protéine d'influx ou sortie

12. Dans un but de traitement et de prophylaxie secondaire d'une thrombose veineuse profonde, une patiente âgée de 56 ans recevait un traitement de longue durée à base de warfarine (anticoagulant oral de type antivitamine K). Quelque temps après, la patiente a présenté des douleurs au niveau des genoux pour lesquelles du diclofenac a été prescrit à raison de un comprimé de 50 mg deux à trois fois par jour. Au lendemain de l'initiation du nouveau médicament, une hémiparésie est soudainement survenue du côté gauche et le diagnostic d'hémorragie intracérébrale a été confirmé.

L'association d'anti-inflammatoires non stéroïdiens AINS (diclofenac) avec des anticoagulants oraux (warfarine), majore :

- A) Le risque de survenue de thromboses.
- B) Le risque de survenue d'ulcère gastrique.
- C) Le risque de survenue d'insuffisance hépatique.
- D) Le risque hémorragique
- E) Le risque de survenue d'insuffisance rénale.

13. Le diclofenac est une molécule qui présente les caractéristiques suivantes :

- 1- Est un médicament fortement lié aux protéines plasmatiques
- 2- Est un médicament faiblement lié aux protéines plasmatiques
- 3- Il présente une affinité plus importante pour son site de liaison à la protéine plasmatique
- 4- Il présente une faible affinité pour son site de liaison à la protéine plasmatique
- 5- En cas de co-administration de diclofénac-warfarine, le diclofénac va déplacer la warfarine de sa liaison aux protéines plasmatiques.

A) 2-4-5 B) 2-3-5 C) 1-3-5 D) 1-3-4 E) 3-4-5

14. Les mécanismes de survenue de cet effet indésirable grave sont :

- 1. Le diclofenac et la warfarine possèdent le même site de liaison sur une protéine plasmatique
- 2. Il s'agit d'une interaction médicamenteuse avec déplacement du médicament possédant la plus faible affinité (la warfarine).
- 3. Il s'agit d'une interaction médicamenteuse avec déplacement du médicament possédant la plus faible affinité (le diclofénac).
- 4. Le diclofenac qui a la plus forte affinité se fixe en priorité sur le site de liaison et majore la fraction libre et active de la warfarine.
- 5- La warfarine qui a la plus forte affinité se fixe en priorité sur le site de liaison et majore la fraction libre et active du diclofenac.

A) 1-2-4 B) 1-3-4 C) 1-3-5 D) 2-4-5 E) 1-2-5

15. La survenue d'une hémorragie sous anti vitamines K, est un effet indésirable. Cochez la réponse fausse

- A) De type A.
- B) En relation avec la dose.
- C) En relation avec les propriétés pharmacologiques des anti vitamines
- D) De type E
- E) C'est un effet indésirable prévisible

16. La toxicité digestive liée à l'administration des AINS Cochez la réponse fautive.

- A) Est un effet indésirable imprévisible.
- B) Est une réaction de type allergique.
- C) Est une réaction idiosyncrasique.
- D) Est un effet indésirable lié aux propriétés pharmacologiques de ces molécules.
- E) Est un effet indésirable de type B.

17. Parmi les mécanismes suivants, lequel peut diminuer l'absorption digestive d'un médicament ?

- A. L'augmentation de la vidange gastrique pour un médicament absorbé dans l'intestin grêle.
- B. La formation de complexes insolubles (chélation) avec des ions bivalents comme le Calcium ou le fer
- C. L'inhibition de la Glycoprotéine P (P-gp) intestinale.
- D. L'augmentation du pH gastrique par des anti-acides pour un médicament basique.
- E. La prise d'un repas riche en graisses pour un médicament très liposoluble.

18. L'administration conjointe de rifampicine et de ciclosporine chez un greffé du rein entraîne :

- A. Une augmentation du risque de rejet du greffon par surdosage.
- B. Une accélération du métabolisme de la ciclosporine entraînant une inefficacité et un risque de rejet greffon
- C. Une inhibition de l'excrétion rénale de la ciclosporine.
- D. Une augmentation de la biodisponibilité de la ciclosporine.
- E. Aucune interaction, car ces médicaments utilisent des voies métaboliques différentes.

19. À propos des interactions pharmacodynamiques. Cochez la réponse juste,

- A. La synergie d'addition se produit lorsque deux médicaments agissent sur des récepteurs différents pour un résultat opposé
- B. La potentialisation signifie que l'effet de l'association est supérieur à la somme des effets de chaque médicament pris isolément.
- C. L'antagonisme est toujours compétitif
- D. L'antagonisme compétitif entraîne une diminution de l'effet maximal sans modifier l'affinité de l'agoniste pour son récepteur.
- E. Toutes les réponses sont fausses.

20. Les pénicillines. Cochez la réponse fautive.

- A. Sont des inhibiteurs du peptidoglycane.
- B. Ces molécules exercent leur effet antibiotique sur les germes possédant une paroi riche en peptidoglycane.
- C. Elles possèdent une activité bactériostatique.
- D. Elles sont des molécules bactéricides.
- E. Les pénicillines du groupe A : Ampicilline, Amoxicilline.

21. La vancomycine. Cochez la réponse juste.

- A. La vancomycine appartient à la famille des aminosides.
- B. Son activité bactéricide est temps dépendante
- C. Son activité bactéricide est concentration dépendante.
- D. La vancomycine diffuse bien dans les compartiments tissulaires profonds.
- E. La vancomycine présente une forte liaison aux protéines plasmatiques.

22. Les antibiotiques suivants agissent au niveau des sous-unités ribosomale 50 S :

- 1- Aminosides.
- 2- Macrolides.
- 3- Phénicolés.
- 4- Pénicillines.
- 5- Tétracyclines.

A) 1 et 2 B) 1 et 3 C) 2 et 3 D) 2 et 5 E) 3 et 5

23. Les quatre antituberculeux de première ligne. Cochez la réponse fausse.

- A) Le pyrazinamide.
- B) L'ethionamide.
- C) L'ethambutol.
- D) La rifampicine.
- E) L'isoniazide

24. En cas d'intoxication ou de surdosage au paracétamol, le métabolite toxique formé est :

- A) Paracétamol sulfoconjugué.
- B) Acetaminophène.
- C) N-acetyl-para-amino-phénol.
- D) N-acetyl-para-benzo-quinone-imine NAPQI.
- E) Paracétamol glucuroconjugué.

25. Le traitement du surdosage au paracétamol comprend l'administration de l'antidote :

- A) Naloxone.
- B) Charbon active.
- C) N-acetylcystéine.
- D) Morphine.
- E) Atropine.

26. Les antalgiques de palier III peuvent induire comme effets indésirables. Cochez la réponse fausse.

- A) Nausées ou vomissements
- B) Diarrhée.
- C) Sédation.
- D) Sècheresse de la bouche.
- E) Dépression respiratoire.

27. L'antidote en cas de surdosage en morphine est :

- A. Naloxone
- B. Paracetamol
- C. N-acétylcystéine
- D. Nalbuphine.
- E. Atropine

28. Le métabolisme de la codéine est à l'origine de la variabilité de sensibilité entre les individus, en grande partie en raison du polymorphisme :

- A) Du CYP 2D6.
- B) Du CYP 3A4.
- C) Du CYP 3A5.
- D) Du CYP 2C9.
- E) Du CYP 2C19.

29. Les récepteurs muscariniques du système nerveux parasympathique. Cochez la réponse fausse

- A) Sont des récepteurs métabotropes.
- B) Sont stimulés par la muscarine.
- C) Sont inhibés par l'atropine.
- D) Sont des récepteurs ionotropes.
- E) Sont des récepteurs couplés à une protéine G.

30. La pilocarpine est une substance parasympathomimétique type muscarinique indiquée pour le traitement de :

- A) Maladie de parkinson.
- B) Intoxications aux digitaliques.
- C) Glaucome.
- D) Vessie hyperactive.
- E) Maladie d'Alzheimer.

31. Les actions de l'atropine sur le système nerveux autonome. Cochez la réponse fausse.

- A) Une mydriase.
- B) Une tachycardie.
- C) Un myosis
- D) Une diminution de la sécrétion salivaire.
- E) Une bronchodilatation.

32. Un essai clinique est dit randomisé lorsque :

- A) Le malade ignore le type de traitement A ou B qu'il reçoit.
- B) L'essai est effectué simultanément par plusieurs centres ou services.
- C) La répartition des sujets ou malades est faite au hasard par tirage au sort.
- D) Un placebo est nécessairement utilisé.
- E) L'essai est fait en double aveugle.

33. Une étude dans laquelle ni le professionnel ni le patient ne sait ce que ce dernier prend est :

- A) Une étude randomisée.
- B) Une étude en cross-over.
- C) Une étude en ouvert
- D) Une étude en double aveugle.
- E) Une étude en simple aveugle.

34. Quel est le site d'action précis et la cible moléculaire des diurétiques de l'anse)?

- A) Le tube contourné proximal via l'inhibition de l'anhydrase carbonique.
- B) La partie descendante de l'anse de Henlé via l'inhibition des aquaporines.
- C) La branche ascendante large de l'anse de Henlé via l'inhibition du co-transporteur $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{2Cl}^-$
- D) Le tube contourne distal via l'inhibition du symport $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{2Cl}^-$.
- E) Le canal collecteur via l'antagonisme des récepteurs à l'aldostérone.

35. L'administration prolongée de furosémide entraîne classiquement :

- A) Une hyperkaliémie et une acidose métabolique.
- B) Une hypokaliémie et une alcalose métabolique.
- C) Une hypercalcémie et une hypernatrémie.
- D) Une hypokaliémie et une acidose métabolique.
- E) Une hyperuricémie et une hyperkaliémie.

36. Parmi les propositions suivantes, quelles sont les contre-indications des ARA II ?

- 1- Sténose latérale des artères rénales ou sténose unilatérale sur rein unique.
- 2- Insuffisance cardiaque chronique.
- 3- Grossesse et allaitement.
- 4- Toux.
- 5- Toutes les propositions sont fausses.

A) 1+2 B) 1+3 C) 1+4 D) 3+4 E) 5

37. À propos des bêta -bloquants. Quelle est la proposition juste:

- A) Un beta-bloquant dit « cardioselectif » bloque principalement les récepteurs B2.
- B) La cardiosélectivité B1 est absolue, quelle que soit la dose administrée.
- C) Le propranolol est un beta-bloquant non selectif (B1 et 2).
- D) Les récepteurs B2 sont principalement situés dans le cœur et augmentent la fréquence cardiaque.
- E) Le bisoprolol est un antagoniste des récepteurs B2 bronchiques.

38. M F, 62 ans, est suivi pour une insuffisance cardiaque stable (FEVG à 35%) et un diabète de type 2 sous insuline. Il est également asthmatique depuis l'enfance, bien qu'il n'ait pas eu de crise majeure depuis 2 ans. Son médecin décide d'introduire un bêtabloquant (le propranolol) pour améliorer son pronostic cardiaque. Deux heures après la première prise, M.F se présente aux urgences pour une dyspnée sifflante intense associée à une sensation d'oppression thoracique. Le patient est pâle, en sueurs, mais ne ressent pas de palpitations malgré une glycémie capillaire mesurée à 0,45 g/L. (hypoglycémie).

Pourquoi le propranolol a-t-il déclenché une crise d'asthme aigue chez ce patient ?

- A) Il stimule les récepteurs β_2 bronchiques.
- B) 1 bloque les récepteurs β_2 bronchiques, empêchant la bronchodilatation physiologique.
- C) Il provoque une libération massive d'histamine par les mastocytes.
- D) Il inhibe l'enzyme de conversion de l'angiotensine au niveau pulmonaire.
- E) Il n'y a pas de lien, c'est une coïncidence liée au stress de la nouvelle prescription.

39. Pourquoi le patient n'a-t-il pas ressenti les signes habituels de son hypoglycémie (tachycardie, palpitations) ?

- A) Le bêta-bloquant a un effet hyperglycémiant masquant.
- B) Le blocage des récepteurs β_1 et β_2 supprime la tachycardie et les tremblements, signes d'alerte adrénergiques de l'hypoglycémie.
- C) Le Propranolol augmente la sensibilité à l'insuline au niveau des muscles.
- D) L'hypoglycémie est due à une interaction pharmacocinétique (inhibition enzymatique).
- E) Les bêta-bloquants favorisent la néoglucogenèse hépatique.

40. Laquelle de ces situations constitue une contre-indication absolue à l'utilisation d'un bêtabloquant non cardiosélectif ?

- A) L'insuffisance cardiaque stable et compensée.
- B) L'asthme (bronchospasme).
- C) L'hypertension artérielle légère.
- D) Le post-infarctus du myocarde.
- E) Le glaucome à angle ouvert (en collyre).

41. A propos des alpha-bloquants, quelle est la réponse juste ?

- A) Les récepteurs alpha 1 sont principalement situés au niveau du cœur.
- B) Le blocage des récepteurs alpha 1 post-synaptiques entraîne une vasoconstriction artérielle.
- C) La Prazosine est un antagoniste sélectif des récepteurs alpha 1.
- D) Les alpha bloquants augmentent les résistances périphériques totales.
- E) Le blocage des récepteurs alpha 1 diminue la libération de noradrénaline.

42. Quel est l'effet indésirable le plus fréquent et le plus caractéristique lors de l'instauration d'un traitement par alpha 1 bloquant ?

- A) Hypertension artérielle de rebond.
- B) Hypotension orthostatique (parfois accompagnée d'une syncope à la première dose).
- C) Bradycardie sinusale.
- D) Constipation opiniâtre.
- E) Toux sèche.

43. Certains alpha1 bloquants (ex : Alfuzosine) sont utilisés dans l'Hypertrophie Bénigne de la Prostate. Quel est le mécanisme recherché ?

- A) Une diminution de la taille (volume) de la prostate.
- B) Un blocage de la conversion de la testostérone en DHT.
- C) Un relâchement des fibres musculaires lisses du col de la vessie et de l'urètre prostatique.
- D) Une augmentation de la force de contraction du détrusor.
- E) Un effet diurétique puissant facilitant la miction.

44. Parmi les molécules suivantes, laquelle est un agoniste sélectif des récepteurs alpha1.

- A) Isoprénaline.
- B) Phényléphrine.
- C) Salbutamol.
- D) Dobutamine.
- E) Clonidine.

45. L'Ephédrine est considérée comme un sympathomimétique à action mixte (directe et indirecte). Son action indirecte consiste à :
- A) Bloquer la dégradation de la noradrénaline par la COMT.
 - B) Favoriser la libération de la noradrénaline stockée dans les vésicules présynaptiques.
 - C) inhiber la recapture de l'adrénaline au niveau de la fente synaptique.
 - D) Agir comme un précurseur direct de la dopamine (comme la L-Dopa).
 - E) Augmenter la synthèse des récepteurs adrénergiques.
46. Comment reconnaît-on visuellement un conditionnement de médicament classé en liste I?
- A) présente un liseré vert sur l'emballage.
 - B) Il présente un liseré rouge entourant les mentions obligatoires.
 - C) Il possède une étiquette "Tête de mort" sur fond orange.
 - D) Il ne comporte aucune marque distinctive particulière.
 - E) Il porte la mention "Uniquement sur ordonnance sécurisée".
47. Quelle est la durée maximale de prescription pour un médicament de liste I, sauf exception réglementaire ?
- A) 7 jours
 - B) 14 jours
 - C) 28 jours
 - D) 12 mois
 - E) 5 ans.
48. Quelle est la caractéristique obligatoire d'une ordonnance pour stupéfiants ?
- A) Elle doit être rédigée sur papier libre avec le tampon de l'hôpital.
 - B) Le nombre d'unités par prise et le nombre de prises doivent être écrits en toutes lettres.
 - C) Elle est valable 1 an pour une délivrance totale immédiate.
 - D) Elle ne peut être rédigée que par des médecins spécialistes en centres de la douleur.
 - E) Elle comporte un liseré vert comme la Liste II.
49. Quelle est la durée (maximale de prescription pour la majorité des stupéfiants (exp : morphine orale) ?
- A) jours.
 - B) 14 jours.
 - C) 28 jours.
 - D) 3 mois.
 - E) 6 mois.
50. Le Baclofène est un myorelaxant d'action centrale. Son mécanisme d'action principal :
- A) Agoniste des récepteurs GABA B.
 - B) Antagoniste des récepteurs GABA A.
 - C) Blocage des canaux sodiques voltage-dépendants.
 - D) Inhibition de la recapture de la noradrénaline.
 - E) Agoniste des récepteurs nicotiniques de la plaque motrice.

Examen UEI 01 3^{ème} / 2026

A/ Physiopathologie

1/ le syndrome du choc cardiogénique :

A- Traduit l'existence d'une hypoxie tissulaire.

B- traduit un transport d'oxygène supérieur à la demande d'oxygène

C- signe l'existence d'un débit cardiaque abaissé.

D- s'accompagne d'une diminution des résistances périphériques.

E- s'accompagne d'une acidose lactique

1 A-C-D 2 B-E. 3 A-B-D 4 A-C-E 5 C-D-E

2/ Les étiologies du choc cardiogénique

A- Syndrome coronarien aigu.

B- Rétrécissement aortique.

C- Infection pulmonaire

D- Déshydratation

E- Embolie pulmonaire massive,

1 A-B-E. 2 A-C-D 3 B-D-E 4 A-B-C 5 C-D-E

3/ Un choc anaphylactique

A- Peut être mortel

B- Peut-être provoqué par un aliment ingéré

C- C'est une réaction d'hypersensibilité type IV

D- Peut être d'origine immunologique

E- Devrait être pris en charge Immédiatement

1 A-B-C-E 2 B D-E 3 A-B-D-E 4 A-C 5 A-B-E

4/ L'hypersensibilité immédiate

A- Peut provoquer un œdème pharyngé

B- Est une pathologie banale et très fréquente

C- Est une anaphylaxie avec un potentiel mortel

D- Survient uniquement chez l'enfant

E- Est pris en charge à domicile en procédant à l'éviction de l'allergène

1 A-B-C 2 A-C 3 B-D- E 4 A-C- E 5 C-D

5/ Concernant les médiateurs protéiques impliqués dans la physiopathologie du choc anaphylactique:

A- L'Histamine est un médiateur majeur libéré par les mastocytes.

B- L'Albumine joue un rôle central dans le déclenchement de la cascade inflammatoire.

C- La Tryptase est un marqueur spécifique de la dégranulation mastocytaire.

D- Le TNF (Tumor Necrosis Factor) participe à la phase Inflammatoire.

E- L'interleukine 3 Intervient dans la régulation et l'activation des cellules effectrices.

1 A-B-C 2 B-D-E 3 A-C-D-E 4 A-C-E 5 A-B-D

6/ Concernant les effets physiopathologiques de l'histamine, cette molécule est à l'origine de :

- A- Une diminution du péristaltisme digestif
- B- Une vasodilatation périphérique
- C- Nausées et vomissements
- D- Un effet chronotrope positif
- E- Une hypersécrétion de mucus

1 A-B-C-D 2 B-C-D-E 3 A-C-E 4 B-D-E 5 A.B-E

7/ Concernant la physiopathologie de l'œdème pulmonaire cardiogénique :

- A- Une augmentation massive de la perméabilité de la membrane alvéolo- capillaire
- B- Une élévation de la pression hydrostatique capillaire pulmonaire (Pc)
- C- Une diminution brutale de la pression oncotique plasmatique
- D- Absence de lésion directe de la membrane alvéolo-capillaire
- E- Une hyperproduction de surfactant

1 A-B 2 B-C 3 B-D 4 A-D 5 C-E

8/ La loi de Starling appliquée à la physiologie des capillaires pulmonaires explique :

- A- Les mouvements de fluides à travers la paroi capillaire
- B- L'équilibre entre les forces hydrostatiques et oncotiques
- C- La contraction des myocytes cardiaques en fonction de l'étirement
- D- L'échange actif de protéines à travers la barrière alvéolo-capillaire
- E- Les conditions favorisant la filtration ou la réabsorption

1 A-B-C 2 B-C-E 3 A-B-E 4 A-D-E 5 B-D

9/ Concernant la distinction et la progression entre Infection, Sepsis et Choc Septique :

- A. L'infection correspond à la réaction de l'hôte face à l'invasion d'un pathogène, sans dysfonction d'organe obligatoire.
- B. Le sepsis se distingue de l'infection simple par une réponse dérégulée de l'hôte entraînant une dysfonction d'organe (score SOFA ≥ 2).
- C- Le choc septique est défini comme un sous groupe du sepsis où les perturbations circulatoires et métaboliques augmentent significativement la mortalité
- D. Pour poser le diagnostic de choc septique, il est impératif d'avoir l'association : besoin de vasopresseurs (pour PAM ≥ 65 mmHg) ET une lactatémie > 2 mmol/L malgré le remplissage vasculaire
- E- L'hyperlactatémie ≥ 2 mmol/L est un critère facultatif (optionnel) pour le diagnostic de choc septique

1 A-B-C-D 2: A-C-D-E 3 B.C-E 4 A.B-E 5 C-D-E

10/ À propos de la réponse Immunitaire innée et du syndrome CARS au cours du sepsis :

A- Les récepteurs PRR (Pattern Recognition Receptors) reconnaissent les motifs PAMP:

comme le LPS des bactéries Gram négatif

B- La phase anti-inflammatoire (CARS) survient toujours après la résolution complète de la phase pro inflammatoire (SIRS)

C- Le TNF- α et l'interleukine-1 β sont des cytokines pro inflammatoires majeures libérées initialement

D. Les cellules souches mésenchymateuses (pMSC) sécrètent de la Procalcitonine (PCT) en réponse à l'infection.

E- L'évolution péjorative est liée à une intensité de la réponse pro-inflammatoire qui l'emporte sur la réponse anti-inflammatoire.

1:A-B-C 2:A-C-D-E 3:B-D-E 4:A-C- E 5:C-D

11/ Concernant la physiopathologie de la défaillance hémodynamique au cours du choc septique :

A- L'hypovolémie est constante dès le début du choc septique

B- La phase hyperkinétique (augmentation du débit cardiaque) est une réponse compensatrice à la baisse des résistances vasculaires systémiques.

C- Le mécanisme principal est une nécrose ischémique irréversible par obstruction des artères coronaires.

D- On observe au niveau cellulaire une "down-régulation" (baisse de sensibilité) des récepteurs β - adrénergiques.

E- Les cytokines inflammatoires exercent un effet Inotrope négatif (baisse de la contractilité) sur le myocarde.

1:A-B-C-E 2:A-B-D-E 3:B-C-D 4:A-C-E 5:C-D-E

12/ Concernant le syndrome de défaillance multiviscérale (SDMV) au cours du choc septique:

A- Il se définit par l'altération fonctionnelle d'au moins deux organes ou systèmes

B- C'est un processus physiopathologique caractérisé par son caractère potentiellement réversible.

C- Il résulte de la généralisation de la réponse inflammatoire et de l'activation diffuse de l'endothélium.

D- Les poumons (SDRA) et les reins (Insuffisance rénale aigue) sont des organes fréquemment atteints

E- Une hyperglycémie est une défaillance endocrinienne, due à la réponse physiologique au stress

1:A C-D 2:A-B-C.D-E 3:B-C-E 4:A-D-E 5:A-B-D

B/ Biochimie

13/ Parmi les propositions suivantes, laquelle peut donner une élévation de la troponine hypersensible sans cause d'ischémie myocardique athéromateuse :

A. Angor stable

B. Angor instable

C. Myocardite

D. Syndrome coronarien aigue

E. Insuffisance hépatocellulaire

14/ Quelle enzyme antioxydante catalyse directement la transformation du superoxyde (O_2^-) en peroxyde d'hydrogène (H_2O_2) et en dioxygène (O_2)?

- A. Catalase
- B. Glutathion peroxydase
- C. Glutathion réductase
- D. Super-oxyde dismutase (SOD)
- E. Hème oxygénase

15/ Homme de 62 ans, opéré il y a 3 semaines pour un carcinome colique droit. Il présente une distension abdominale progressive. L'échographie montre une importante ascite. La ponction révèle un liquide lactescent. Analyse du liquide d'ascite : Triglycérides = 2.80 g/L, Cholestérol = 0,90 g/L, protéines = 12 g/L, culture bactérienne : négatifs.

Au niveau du Plasma : triglycérides = 1.60g/L, Cholestérol : 1.80g/l, protéines 65g/l. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A. Ascite pseudo chyleuse post-chirurgicale
- B. Tuberculose péritonéale
- C. Carcinomatose péritonéale
- D. Ascite chyleuse post chirurgicale par rupture d'un canal lymphatique mésentérique
- E. Pancréatite aigue compliquée

16/ A propos du transport des lipides via les lipoprotéines, donner la réponse fausse

- A. Les HDL transportent le cholestérol du foie aux tissus
- B. Les chylomicrons fournissent les lipides alimentaires de l'intestin aux tissus
- C. Les VLDL transportent les TG et le cholestérol du foie vers les tissus
- D. Les LDL fournissent le cholestérol du foie aux tissus
- E. Les HDL transportent le cholestérol tissulaire au foie

17/ Madame P, 57 ans, 60 kg, 1m65, présente le bilan lipidique suivant: Cholestérol total; 2,78g/L Triglycérides: 4,51g/L, Cholestérol HDL:0,34 g/L, Absence de chylomicron sur gel d'agarose. La patiente est atteinte d'une hyperlipidémie, de quel type s'agit-il?

- A. Type I
- B. Type IIa
- C. Type IIb
- D. Type IV
- E. Type V

18/ Les hyperlipidémies secondaires incluent toutes les situations suivantes, sauf une laquelle

- A Syndrome néphrotique
- B. Hypothyroïdie
- C. Consommation excessive d'alcool
- D. insuffisance hépatique sévère
- E. Diabète sucré

19/ Quelles sont les caractéristiques du sang capillaire?

1. Moins oxygéné et contient moins de glucose
2. Plus oxygéné et le glucose est légèrement plus élevé
3. Exclusivement veineux et ne contient pas de sang artériel
4. Ne peut être prélevé que chez l'adulte
5. Peut être prélevé chez le nourrisson et l'adulte

A=1 B=2+5 C= 3 D=2+4 E=1+5

20/ Dans quel contexte le sang veineux est-il recommandé?

- A. Pour des tests rapides en pédiatrie
- B. Pour les analyses de confirmation et de diagnostic au laboratoire
- C. Pour le prélèvement de liquide de ponction pleurale
- D. Pour la détermination de la gazométrie
- E. Pour les analyses de sueur

C/ Radiologie

21/ Les ultrasons: Cocher la RF.

- a) Sont produites par effet piézo-magnétique
- b) C'est des ondes acoustiques
- c) D'une fréquence supérieure à 20 000Hz.
- d) Ne comportent pas de risque pour la santé
- e) Leur formation est basée sur la déformation de la matière

22/ En échographie les faisceaux perpendiculaires seront: Cochez la RF.

- a) Atténués
- b) Réfléchies.
- c) Détectées par la sonde d'échographie.
- d) Perdue mais continue à être atténuées
- e) Se propagent en ligne droite.

23/ Devenir d'une onde ultrasonore: Cochez la RF.

- a) Atténuées
- b) Réfléchies,
- c) Diffuse.
- d) elle va subir une réfraction.
- e) Absorbée.

24/ Parmi ces propositions, laquelle représente l'impédance la plus élevée : Cochez la RJ

- a) Eau.
- b) Foie
- c) Os
- d) Urine.
- e) Sang.

25/ propriétés des rayons X : cochez la RF

- a) Traverses le corps humain.
- b) Ils provoquent une illumination des émulsions photographiques.
- c) Utilisés en radiothérapie
- d) Ils se propagent en ligne droite.
- e) Provoque illumination de certains sels minéraux,

26/ La relation médecin-malade : (réponse juste)

- A Une relation familiale
- B- Une relation amicale
- C- Une relation asymétrique
- D- Une relation symétrique
- E- Une relation Commerciale,

27/ Une relation médecin - patient harmonieuse doit permettre : (réponse fausse)

- A. Une démarche diagnostique.
- B. L'amélioration de la qualité de vie du patient
- C. La prise en compte du point de vue du patient
- D. Une mauvaise observance thérapeutique.
- E. Un exercice médical le plus confortable possible.

28/ Les composantes de la relation médecin- malade : (réponse fausse)

- A- Communication.
- B- Confiance.
- C- Empathie.
- D- Respect
- E- Transfert et contre transfert.

29/ La prescription médicamenteuse dépend (réponse fausse)

- A. Médecin
- B. Patient.
- C. Symptômes.
- D. Pharmacien.
- E. Cadre légal.

30/ Déroulement de la prescription : (réponse fausse)

- A. Evaluer et définir le problème du patient.
- B. Spécifier l'objectif thérapeutique
- C. Evaluer et définir le problème de la prescription.
- D. Choisir le traitement approprié.
- E. Ecrire l'ordonnance

31/ dans l'observation médicale, cochez la réponse fausse :

- A. L'interprétation diagnostique ne doit jamais apparaître dans la partie « évolution »
- B. Les antécédents doivent être classés par appareils et datés si possible.
- C. L'examen clinique doit distinguer signes positifs et signes négatifs recherches.
- D. Les traitements en cours doivent inclure posologie, vole et durée,
- E. Les données paracliniques sont rapportées sans interprétation.

32/ une perte pondérale est jugée pathologique lorsqu'elle dépasse : RJ

- A. La perte dépasse 10 % du poids habituel en 6mois
- B. La perte dépasse 2 % en 1 semaine
- C. L'IMC chute sous 20 kg/m², quel que soit le contexte
- D. Le rapport poids/taille évolue de façon non symétrique
- E. La perte de poids s'accompagne de Tachycardie

33/ Quel est le signe clinique le plus précoce évocateur d'une dénutrition protéino-calorique : RJ

- A. Fonte musculaire des ceintures
- B. Diminution de la force de préhension
- C. Hypoalbuminémie isolée
- D. Œdèmes déclives
- E. Rétractation des globes oculaires

34/ Parmi ces signes, lequel est le plus spécifique d'une Déshydratation intracellulaire: RJ

- A. Hypotension orthostatique
- B. Sécheresse des muqueuses
- C. Pli cutané lent
- D. Confusion, somnolence, agitation
- E. Extrémités froides, marbrures

35/ Une hyponatrémie aiguë sévère peut donner comme manifestation clinique liée à l'œdème cérébral : RJ

- A. Bradycardie vagale
- B. Crises convulsives
- C. Œdèmes des membres inférieurs
- D. Paresthésies péri-buccales
- E. Tachypnée compensatrice

35/ Lequel de ces éléments sémiologiques est le moins utile dans la caractérisation de la fièvre :

- A. Notion de frissons
- B. Courbe thermique sur 48 heures
- C. Heures précises des pics fébriles
- D. Variation de la fréquence cardiaque par degré de température
- E. Variation du poids corporel

37/ Une fièvre par poussées séparées caractérisée par des baisses incomplètes rythmées fait évoquer

- A. une fièvre d'une Endocardite infectieuse
- B. Brucellose
- C. Pyélonéphrite aiguë
- D. Tuberculose miliaire
- E. Lymphome de Hodgkin

38/ L'ASSOCIATION FIÈVRE ET BRADYCARDIE ÉVOQUANT UNE DISSOCIATION POUSSÉE-TEMPÉRATURE EST CARACTÉRISTIQUE DE

- A. Pneumonie à pneumocoque
- B. Pyélonéphrite aiguë
- C. Fièvre typhoïde
- D. Crise drépanocytaire
- E. Endocardite sur valve native

39/ Auscultation cardiaque : cochez la réponse juste

- A Utilisation systématique du diaphragme pour les bruits graves
- B. L'auscultation se fait toujours en décubitus dorsal strict
- C. Le foyer mitral est mieux entendu en position latérale gauche
- D. Le foyer aortique accessoire se situe au 2^e espace intercostal droit
- E. L'augmentation physiologique du B2 est pathognomonique d'une HTAP

40/ Concernant les souffles : (1RF)

- A. Les souffles d'éjection sont toujours systoliques
- B. Le souffle de régurgitation mitrale est un souffle systolique
- C. Le souffle de communication inter ventriculaire est un souffle systolique
- D. Le roulement diastolique est un souffle de remplissage
- E. Le souffle de régurgitation aortique est un souffle systolique

41/ la Douleur thoracique angineuse typique : RJ

- A. Augmentée par l'inspiration profonde
- B. Soulagée par la position assise
- C. Provoquée par l'effort et cédant rapidement au repos
- D. Irradiant rarement vers le bras gauche
- E. Associée systématiquement à une fièvre

42/ Dans la Péricardite aiguë : (1RF)

- A. La douleur s'accroît lors des mouvements respiratoires
- B. La douleur peut s'accompagner de troubles du rythme supraventriculaire
- C. L'ECG peut montrer des troubles diffus de la repolarisation
- D. La douleur peut s'accompagner d'un frottement péricardique disparaissant en apnée
- E. Le traitement de 1^{ère} intention est l'aspirine

43/ Parmi les signes suivants, lequel n'est pas évocateur du syndrome de tamponnade cardiaque (1RF)

- A. Turgescence des veines jugulaires
- B. Silhouette cardiaque peu mobile en scolie
- C. Signes d'œdème alvéolaire pulmonaire
- D. Diminution inspiratoire de la pression artérielle systolique
- E. Pouls paradoxal

44/ Sur un ECG normal : onde P

- A. Durée normalement > 120 ms
- B. Positive en DII
- C. Toujours négative en V1
- D. Absente lors des tachycardies sinusales
- E. Doit avoir la même amplitude que le QRS

45/ Quel est le facteur de risque cardiovasculaire majeur : RJ

- A. Tabagisme actif
- B. IMC entre 20 et 25
- C. LDL <1 g/L
- D. Antécédent familial d'IDM précoce
- E. Alcool modéré quotidien

46/ Le signe de Harzer est défini par : (1RF)

- A- Perception des battements cardiaques
- B- Auscultation des battements cardiaques
- C- De siège sous xiphoïdien
- D- Témoin d'une hypertrophie ventriculaire droite
- E- Signe d'une insuffisance cardiaque droite

47/ Dans l'insuffisance cardiaque droite : RF

- A. Œdèmes blancs, mous et prenant le godet
- B. Crépitants pulmonaires diffus
- C. Hépatomégalie douloureuse
- D. Reflux hépato-Jugulaire
- E. Expectoration rosée

48/ Quelles sont les anomalies électriques possibles dans les syndromes coronariens aigus sans élévation du segment ST (NSTEMI) : (1RF)

- A. Des ondes T négatives et symétriques
- B. Une lésion sous épocardique non persistante
- C. Un sous-décalage du segment PQ
- D. Une onde T biphasique
- E. Une lésion sous endocardique

49/ Parmi les propositions concernant les syndromes coronariens aigus : (1RJ)

- A. Le syndrome coronarien aigu sans sous-décalage du segment ST (SCA ST-) est dû à une occlusion coronaire aiguë
- B. Aux urgences, le diagnostic de syndrome coronarien aigu ST+ est posé sur l'élévation des troponines
- C. La douleur thoracique peut être absente et remplacée par une dyspnée aiguë
- D. L'ECG est toujours pathologique
- E. L'angor instable ne fait pas partie des syndromes coronariens aigus

50/ Dans l'insuffisance cardiaque : classification NYHA

- A. Stade I: asymptomatique
- B. Stade II : symptômes au moindre effort
- C. Stade III : limitation modérée uniquement
- D. Stade IV : symptômes de repos
- E. Stade II : dyspnée de repos

51/ insuffisance respiratoire hypoxémique : cochez la RJ

- A. $\text{PaO}_2 < 60 \text{ mmHg}$
- B. $\text{PaCO}_2 > 50 \text{ mmHg}$
- C. Cyanose possible
- D. Due uniquement aux BPCO
- E. Correction immédiate par O_2 garantit la guérison

52/ Dans le Syndrome pleural liquidien : cochez la RJ

- A. Matité à la percussion
- B. Murmure vésiculaire augmenté
- C. Diminution des vibrations vocales
- D. Toux sèche classique
- E. Souvent accompagné de tympanisme

53/ Syndrome pleural gazeux (pneumothorax)

- A. Tympanisme à la percussion
- B. VV augmentées
- C. Murmure vésiculaire aboli
- D. Déviation trachéale possible en cas de compression
- E. Matité basithoracique

54/ dans le Syndrome médiastinal postérieur : cocher la RJ

- A Dysphonie
- B. Dyspnée Inspiratoire
- C. Dysphagie
- D. Hémoptysie massive obligatoire
- E. Douleur inter-scapulaire

55/ Dans le Syndrome de condensation pulmonaire on retrouve

- A. Matité
- B. VV diminuées
- C. Souffle tubaire
- D. Bronchophonie augmentée
- E. Murmure vésiculaire normal

56/Dans le Syndrome obstructif sévère : cochez la RJ

- A. Diminution du VEMS
- B. Rapport VEMS/CV augmenté
- C. VV augmenté
- D. CPT diminuée
- E. Réversibilité absente dans tous les cas

57/ La spirométrie permet principalement de mesurer

- A. Le volume résiduel (VR)
- B. La capacité pulmonaire totale (CPT)
- C. Le volume expiratoire maximal en 1 seconde (VEMS)
- D. La diffusion alvéolocapillaire
- E. L'équilibre acido basique

58/ Quelle exploration est la plus adaptée pour évaluer la diffusion alvéolo capillaire

- A. Gazométrie artérielle
- B. Test de marche de 6 minutes
- C. DLCO (test au CO)
- D. Radiographie thoracique
- E. Spirométrie

59/ Quel examen est de première intention devant une dyspnée aiguë

- A Épreuve d'effort
- B. Radiographie thoracique
- C. DLCO
- D. Tomodensitométrie à haute résolution
- E. La gazométrie sanguine

60/ L'oxymétrie de pouls mesure :

- A. La SpO₂
- B. La PaO₂
- C. La PaCO₂
- D. Le pH sanguin
- D. Les bicarbonates

Partie pratique :

Un homme de 56 ans, diabétique de type 2 mal équilibré, tabagique à 30 PA, consulte aux urgences pour dyspnée progressive évoluant depuis 48 heures. Il décrit une orthopnée, une dyspnée paroxystique nocturne et une toux productive avec expectorations mousseuses.

A l'examen :

- Patient polypnéique à 28 c/min
- TA 160/95 mmHg
- FC 110/min, régulière
- SpO₂, 89% à l'air ambiant
- Température 37,3°C
- Turgescence jugulaire ++
- Râles crépitants bilatéraux jusque mi-champs
- Œdèmes des membres inférieurs mous, prenant le godet
- Auscultation cardiaque : B3 audible
- Souffle systolique apexien irradiant vers l'aisselle
- ECG : tachycardie sinusale
- Radio thorax: opacités floconneuses bilatérales, cardiomégalie
- BNP - élevé

61/ Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A. Embolie pulmonaire
- B. Pneumopathie algue
- C. Œdème aigu du poumon cardiogénique
- D. Asthme aigu grave
- E. BPCO décompensée

62/ Quel signe oriente le plus vers une insuffisance cardiaque gauche ?

- A. Œdèmes des membres inférieurs
- B. Hépatomégalie douloureuse
- C. Râles crépitants bilatéraux
- D. Reflux hépato jugulaire
- E. Ascite

63/ Le B3 correspond à :

- A Un bruit de galop diastolique traduisant une surcharge
- B. Une fuite aortique sévère
- C. Un frottement péricardique
- D. Un phénomène normal chez le sujet sain
- E. Un signe spécifique de sténose mitrale

64/ Le souffle systolique à l'apex orienterait vers :

- A. Sténose aortique
- B. insuffisance mitrale
- C. Communication interventriculaire
- D. Insuffisance tricuspide
- E. Sténose pulmonaire

65/ Quel examen complémentaire est le plus urgent ?

- A Échographie cardiaque
- B. Scanner thoracique
- C. Gaz du sang artériel
- D. Cathétérisme cardiaque
- E. IRM cardiaque

66/ Quel facteur peut avoir déclenché cette aggravation ?

- A. Hypothyroïdie
- B. Surdosage en bêta-bloquants
- C. Infection respiratoire
- D. Hypokaliémie
- E. Surdosage en IEC

67/ Le mécanisme des râles crépitants est :

- A. Constriction bronchique
- B. Vibration des bronches moyennes
- C. Ouverture brutale des petites bronchioles Infiltrées de liquide
- D. Passage d'air dans du mucus épais
- E. Turbulence due à un obstacle

68/ Quelle conduite immédiate est correcte ?

- A. Administrer un remplissage IV rapide
- B ; Administrer un diurétique IV (furosémide)
- C. Administrer un bêtabloquant pour contrôler la tachycardie
- D. Allonger complètement le patient
- E. Donner des corticoïdes IV

69/ Quelle anomalie radiologique correspond au tableau ?

- A Signe de Hampton
- B. Hyperclarté thoracique diffuse
- C Opacités en ailes de papillon
- D. Pneumothorax avec ligne pleurale
- E. Épanchement pleural pur

70/ Le BNP élevé indique :

- A. Une infection sévère
- B. Une atteinte rénale aigue
- C. Une souffrance myocardique avec augmentation de la pression de remplissage
- D. Une hémolyse
- E. Une décompensation respiratoire isolée

Examen UEI 2 3^{ème} / 2026

A/ Physiopathologie

1/ Dans l'équilibre acido basique, Cochez la réponse juste

1/l'acide est une molécule capable de fixer des ions H^+

2/L'ORGANISME doit maintenir un état d'équilibre acido-basique constant.

3/une base est une molécule capable de capter des ions H^+ .

4/le PH reflète la concentration des ions H^+ fixé à une molécule.

5/l'organisme contient des composés acides et des composés basiques.

A (2-3-4) B (1-4/5) 2-3-5) D(1-1-5) E(3-4-5).

2/ Cochez la réponse juste :

1/LE PH est dit acide s'il est inférieure à 7,4

2/LE PH est dit basique s'il est inférieure à 7,4.

3/LE PH est dit acide s'il est supérieur à 7,4

4/LE PH est dit basique s'il est supérieure à 7,4.

5/un $PH < 7$ ou un $PH > 7,8$ est incompatible avec la vie.

A (2-4-5) B (1-2-4) C (3-4-5) C (1-4-5) E(2-3-5).

3/ L'équilibre acido basique est maintenu grâce, Cochez la réponse juste

1/tampon extra cellulaire l'acide carbonique(H_2CO_3).

2/les bicarbonates extracellulaire n'ont aucun rôle.

3/aux systèmes tampons.

4/organes excréteurs.

5/rôle immédiat du poumon.

A (2-4-5) B (3-4-5) C(2-3-4) D (1-3-5-) E (1-2-3).

4/ Cochez la réponse juste, Cochez la réponse juste

1/la diminution des HCO_3^- entraine une diminution du PH.

2/l'alcalose métabolique entraine une N_3 hypoventilation.

3/la ventilation n'est pas affecter par le changement du PH.

4/l'acidose métabolique entraine une hyperventilation.

5. 5/le rein est le premier organe qui réagit aux perturbations du PH.

A (1-2-4) B (1-3-4) C (2-4-5) D (1-5) E (3-4-5).

5/ La gazométrie est réalisée chez un patient en état de choc retrouve : PH : 7,24, PO_2 : 60 mmgh PCO_2 : 23mmgh, HCO_3^- : 11mmol/l, Cochez la réponse juste

1/ le patient présente une acidose métabolique compensé.

2/ le taux de bicarbonate (HCO_3^-) est en faveur de l'acidose.

3/ le patient est en acidose métabolique sévère.

4/ le poumon est le seul organe de compensation.

5/ la PCO_2 reflète une hyperventilation.

A (1-4-5) B (3-5) C(2-4-5) D(1 -3- 4) E (2-3-5).

6/ À propos des principes généraux de la thermorégulation :

1. L'être humain est un homéotherme, maintenant sa température entre 36,5°C et 37,5°C.
2. Le compartiment périphérique (enveloppe) maintient une température constante de 37°C.
3. L'hypothalamus antérieur est responsable de la thermogénèse
4. L'hypothalamus postérieur est le centre de la thermolyse.
5. Les réactions enzymatiques intracellulaires optimales surviennent à 37°C.

A (1,5) B. (1, 2,5) C. (3, 4) D.(1, 2, 3,4,5) E. (3,4)

7/ Concernant la classification et les signes de l'hypothermie :

1. L'hypothermie légère (35°C-32°C) se manifeste par une tachycardie et une dysarthrie.
2. L'arrêt des frissons survient durant la phase d'hypothermie modérée (32°C- 28°C).
3. L'onde I d'Osborne est un signe ECG caractéristique de l'hypothermie sévère.
4. L'hypoventilation alvéolaire et la bronchorrhée apparaissent en hypothermie sévère.
5. L'hypothermie profonde (inférieure à 24°C) provoque un arrêt cardiaque et respiratoire.

A.(1 2,5) B. (1,3,4) C. (1, 2, 3, 4, 5) D. (&,2,4) E.(3, 4,5)

8/ Différenciation entre Flèvre et Hyperthermie :

1. La fièvre est caractérisée par une élévation du point de consigne (thermostat) hypothalamique.
2. Dans l'hyperthermie, le point de consigne hypothalamique reste inchangé.
3. La fièvre est une réponse de défense médiée par des pyrogènes.
4. L'hyperthermie peut être liée à une baisse de la thermolyse (ex: coup de chaleur).
5. La fièvre favorise la croissance bactérienne pour accélérer la réponse immunitaire.

A(1, 2, 3, 4) 3. (1, 2, 5) C. (3, 4, 5) D. (1, 3) E. (2, 4)

9/ Concernant la pression intracrânienne (PiC) et la perfusion cérébrale, quelles affirmations sont exactes ? Cochez la réponse juste

1. La PIC normale chez l'adulte est d'environ 10 mmHg
2. L'hypertension intracrânienne (HIC) désigne le retentissement clinique d'une pression intracrânienne (PIC) supérieure à 20 mmHg.
3. La pression de perfusion cérébrale (PPC) se calcule par la formule : $PPC = PAM + PIC$
4. Chez le nouveau-né, la PIC normale se situe entre 1 et 6 mmHg.
5. L'équation de Monroe-Kellie établit que le volume intracranien total est extensible.

A. (1,2, 3). 8. (1,2, 4) C (2,4,5) D.(1,3,5) E (1,3,4)

10/ À propos de l'espace craniorachidien et de la compliance cérébrale, Cochez la réponse juste

1. Le parenchyme cérébral occupe 80 % de l'espace crâniorachidien.
2. Le secteur vasculaire occupe 10 % du volume endocrânien.
3. Le liquide cébrospinal (LCS) est réparti majoritairement dans les ventricules (80 ml).
4. La compliance cérébrale est maximale en phase décompensée de la courbe de Langfitt
5. Dans la phase A (compensation), une grande variation de volume entraîne peu de variation de la PIC.

A (1,2,3) B. (1,2,3,4) C (1,2,5) .(1, 4, 5) E (3,4,5)

11/ Quels sont les mécanismes ou conséquences corrects de l'HIC ?

1. L'œdème vasogénique provient d'une altération de la barrière hémato-encéphalique
 2. Une thrombose veineuse cérébrale peut induire une HIC par réduction de la résorption du LCS.
 3. L'hypersécrétion de LCS par les plexus choroïdes est la cause la plus fréquente d'HIC.
 4. L'ischémie cérébrale est une conséquence directe de la baisse de la PPC en cas d'HIC décompensée.
 5. L'engorgement est la migration du cerveau à travers des orifices ostéoduraux.
- A. (1, 2, 4, 5) B. (1, 2, 3, 4) C. (2, 3, 5) D. (1, 3, 4, 5) E. (1, 2, 3, 4, 5)

B/ Biochimie :

12/ Un homme de 35 ans consulte aux urgences pour céphalées intenses, fièvre à 39°C et raideur de la nuque. Le LCR est clair en eau de roche. L'examen cytologique montre 1200T éléments/mm³ avec 80% de lymphocytes, une glyoccorachie qui est égale à 60% de la glycémie. Quel diagnostic est le plus probable ?

- A. Méningite virale
B. Méningite bactérienne
C. Hémorragie méningée traumatique
E. Méningite tuberculeuse
E. Maladie neuro-dégénérative

13/ Une ponction lombaire est réalisée chez une patiente de 29 ans atteinte de sclérose en plaques en phase de poussée. Les résultats montrent une protéinorachie totale à 1,2 g/L. L'électrophorèse des protéines du LCR révèle une augmentation de la concentration des immunoglobulines avec des bandes oligoclonales non détectables au niveau sérique. Quelle est l'origine principale de l'augmentation des immunoglobulines dans ce cas ?

- A. Synthèse d'origine intrathécale
B. Altération de la barrière hémato-méningée et passage des IgG plasmatiques
C. Réponse immunitaire antimicrobienne in situ
D. Hypoalbuminémie sévère avec fuite protéique dans le LCR
E. Filtration passive normale de l'albumine à travers la barrière intacte

14/ Homme de 22 ans, sans antécédents notables, admis aux urgences pour fièvre à 39,5°C, céphalées intenses, vomissements et raideur de la nuque évoluant depuis 24 heures. La ponction lombaire montre : Aspect du LCR : trouble Protéines : 2,1 g/L, Glucose : 0,25 g/L (glycémie = 1 g/L), Cellules : 1 800/mm³ (90% PNN), Lactate LCR : 6,2 mmol/L. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A. Méningite virale
B. Méningite tuberculeuse
C. Méningite bactérienne aiguë
D. Méningite d'origine cancéreuse
E. Méningite parasitaire

15/ Femme de 19 ans, sans antécédents, consulte pour fièvre modérée (38,2 °C), céphalées diffuses et photophobie depuis 3 Jours. L'état général est conservé, pas de troubles de conscience. Le diagnostic retenu est une méningite virale. Quel profil de LCR est le plus compatible avec ce diagnostic ?

- A. LCR trouble, glucose bas, PNN prédominants, lactate = 5,8 mmol/L
- B. LCR clair, glucose normal, lymphocytes prédominants, lactate = 2,1 mmol/L
- C. LCR clair, glucose bas, PNN prédominants, lactate = 4,6 mmol/L
- D. LCR trouble, protéines > 3 g/L, lactate = 6mmol/L
- E. LCR clair, glucose plus élevé que dans le sang, lymphocytes prédominants

16/ Donner la réponse exacte ; Les enzymes sériques sont généralement :

- A. Synthétisées exclusivement par le foie
- B. Actives uniquement dans le plasma
- C.. D'origine tissulaire et libérées dans le sang
- D. Des hormones protéiques
- E. Toujours spécifiques d'un seul organe

17/ Donner la réponse exacte; Concernant la LDH (lactate déshydrogénase) :

- A. Elle possède une seule isoenzyme
- B. LDH1 est principalement hépatique
- C. LDH5 est surtout cardiaque
- D. Elle est augmentée dans les hémolyses
- E. Elle est spécifique du myocarde

18/ Donner la réponse exacte; L'ASAT est retrouvée principalement :

- A. Dans le rein uniquement
- B. Dans le foie, cour et muscle
- C. Exclusivement dans le foie
- D. Seulement dans le cytosol
- E. Uniquement dans le plasma

19/ Un homme de 58 ans, tabagique, hypertendu, consulte aux urgences pour une douleur thoracique constrictive, rétro-sternale, irradiant vers le bras gauche, évoluant depuis 2 heures, accompagnée de sueurs et de nausées.

À l'examen clinique : TA : 150/90 mmHg, FC : 96 battements/min, FR : 20 cycles/min, SpO2 : 96 % à l'air ambiant, Auscultation cardio- pulmonaire : sans particularité. Un ECG montre un sus-décalage du segment ST en antérieur. Un infarctus du myocarde est alors évoqué. Quel marqueur est le plus spécifique d'une nécrose myocardique ?

- A. ASAT
- B. LDH
- C. CK totale
- D. Troponine
- E. ALAT

20/Quelle enzyme s'élève le plus précocement après un infarctus du myocarde ?

- A. LDH
- B. ASAT
- C. CK-MB
- D. ALAT
- E. Phosphatases alcalines

21/Concernant la cinétique de la CK-MB, quelle affirmation est correcte ?

- A. Elle reste élevée plus de 10 jours
- B. Elle s'élève après 48 heures
- C. Elle se normalise en 72 heures
- D. Elle est spécifique du foie
- E. Elle n'a aucun intérêt clinique

C/ Radiologie

22/ À propos de l'échographie Doppler, quelles affirmations sont correctes ?

- 1. Le doppler pulsé permet le calcul de volume circulant.
- 2. Le polygone de Willis est visualisé par le doppler des TSA.
- 3. Utilise une sonde émettrice et réceptrice au même temps.
- 4. Permet la recherche des sténoses et les thromboses vasculaires.
- 5. L'injection de contraste permet de donner la couleur bleu ou rouge l'or d'un doppler couleur.

A:1+2+3 B : 1+4+5 C : 1+3+4 D:3+4 E: 4+5

23/ Concernant la TDM cérébrale, quelles propositions sont vraies ?

- 1. La densité de LCR est comprise entre 0 et 5 UH
- 2. La densité est exprimée en unité Houston.
- 3. Contre-indiquée chez la femme enceinte
- 4. La densité de la graisse est toujours négative,
- 5. Le scanner de perfusion donne des informations fonctionnelles.

A : 1+2+3 B:1+2+3+4 C : 1+3+5 D: 1+2+4+5 E: 1+3+4+5

24/ Concernant l'hématome extra-dural, quelles affirmations sont vraies ?

- 1. Une collection extra-axiale.
- 2. Forme en croissant
- 3. Siège dans un espace virtuel situé entre la table interne et la dure mère.
- 4. Une collection spontanément hyperdense.
- 5. Nécessite une injection de produit de contraste pour être visualisé.

A: 1+2+3+4 B:2+3+5 C:1+3+4 D : 3+4+5 E : 2+3+4+5

25/ Concernant les séquences IRM, quelles propositions sont justes ?

- 1. Le LCR est noir sur la séquence spine écho T1.
- 2. Le LCR est blanc sur la séquence T2 Flair.
- 3. La séquence T2est une séquence sensible au sang et aux calcifications.
- 4. L'œdème cérébral apparaît en hyper signal FLAIR.
- 5. La diffusion est une séquence fonctionnelle, sensible au déplacement des fluides en extracellulaire.

A+1+3+4 B:1+2+5 C:2+4+5 D : 1+3+4+5 E: 1+2+3+4+5

26/ Concernant l'AVC ischémique, quelles propositions sont correctes ?

1. Urgence diagnostique et thérapeutique.
2. Scanner sans injection de produit de contraste normal au début est possible
3. Le traitement spécifique est la thrombolyse intra veineuse ou la thrombectomie mécanique.
4. Zone d'infarctus ou de ramollissement systématisée dans le territoire de veine occluse.
- 5- Scanner avec injection de produit de contraste est plus sensible que l'IRM.

A:2+3+4 B : 1+2+3 C : 3+4+5 D : 1+4+5 E :1+2+3+4+5

E/ sémiologie clinique

27/ Le purpura : RF

- A. Est une macule pigmentaire.
- B. Est une tache rouge qui s'efface à la vitropression.
- C. Il correspond à une extravasation de globules rouges hors des capillaires.
- D. Est secondaire à une hémorragie sous cutanée.
- E. Peut- être pétéchiiale ou ecchymotique.

28/ La pustule : RF

- A. Est une lésion palpable a contenu liquidien.
- B. De couleur jaunâtre.
- C. Contiennent toujours une sérosité claire.
- D. Folliculaires elles sont souvent bactériennes.
- E. Son diamètre est inférieur à 1 cm.

29/ L'ulcération : RF

- A. Est une lésion en rapport avec une perte de substance cutanée.
- B. Guérit toujours en laissant une cicatrice.
- C. La perte de substance est profonde.
- D. La perte de substance peut atteindre le derme, voire l'hypoderme.
- E. Peut guérir rapidement sans cicatrice.

30/ Les différentes structures représentant les phanères sont : RF

- A. Les cheveux.
- B. Les poils.
- C. Les ongles.
- D. Les muqueuses nasales.
- E. Les glanes sébacées.

31/ L'épiderme est un épithélium malpighien pluristratifié constituée de l'extérieur vers l'intérieur par ces zones distinctes : RF

- A. La couche cornée.
- B. La couche granuleuse.
- C. couche hypodermique
- D. La couche épineuse ou corps muqueux de Malpighi.
- E. La couche basale.

32/ Lors de l'examen d'un membre Inférieur chez un patient alité, un raccourcissement avec perte de l'axe du membre évoque le plus souvent :

- A. Une arthrite
- B. une fracture récente
- C. Une hydarthrose
- D. Une luxation ancienne
- E. Une polyarthrite

33/ Une déformation en varus correspond à un segment de membre dévié :

- A. Vers l'extérieur
- B. Vers l'arrière
- C. Vers l'avant
- D. Vers la ligne m
- E. Vers le haut

34/ La mesure de la longueur du membre supérieur se fait classiquement entre :

- A. L'acromion et l'olécrâne
- B. L'acromion et l'apophyse ulnaire
- C. L'olécrâne et le poignet
- D. L'épaule et le poignet
- E. Le coude et la main

35/ L'augmentation du volume articulaire avec présence d'un liquide citrin correspond à :

- A. Une hémarthrose
- B. Une arthrite septique
- C. Une hydarthrose
- D. Une raideur articulaire
- E. Une luxation

36/ Une limitation de la mobilité articulaire sans signes inflammatoires définit :

- A. Une arthrite
- B. Une polyarthrite
- C. Une hémarthrose
- D. Une raideur articulaire
- E. Une entorse

37/ Chez le sujet normal, l'alignement du rachis en position debout est caractérisé par :

- A. Une scoliose visible
- B. Une rotation vertébrale
- C. rachis rectiligne et vertical
- D. Une cyphose lombaire
- E. Une gibbosité dorsale

38/ La vertèbre proéminente servant de repère pour le fil à plomb est :

- A. C5
- B. C6
- C. C7
- D. T1
- E. L1

39/ L'exagération de la courbure dorsale à convexité postérieure correspond à :

- A. Une lordose
- B. Une scoliose
- C. Une gibbosité
- D. Une cyphose
- E. Une rectitude rachidienne

40/ Le test d'Adams (flexion antérieure du tronc) permet principalement de dépister :

- A. Une lombalgie
- B. Une cyphose
- C. Une scoliose
- D. Une hernie discale
- E. Une arthrose lombaire

41/ La manœuvre de Lasègue est réalisée en décubitus dorsal et explore principalement :

- A. Les racines C5-C6
- B. Les racines T12-L1
- C. Les racines L2-L3
- D. Les racines L4
- E. Les racines L5-S1

42/ Concernant l'EEG dans l'épilepsie :

- 1. Un EEG normal élimine le diagnostic
- 2. Il peut montrer des pointes ou pointes-ondes
- 3. Il aide à la classification des crises
- 4. Il est indispensable pour débuter un traitement
- 5. Il peut être normal entre les crises

A 1+2+2B +3+5 C1+4+5 D 1+2+3+4 RIT5

43/ Concernant les crises épileptiques focales ;

- 1. Elles débutent toujours par une perte de connaissance
- 2. Elles peuvent s'accompagner de manifestations motrices localisées
- 3. Elles peuvent secondairement se généraliser
- 4. L'EEG est toujours normal
- 5. Elles traduisent une origine corticale localisée

A) 2+3+5 B 1+2+5 C 2+4+5 D 1+3+5 E 4+5

44/ À propos des crises généralisées tonico-cloniques :

- 1. Elles comportent une phase tonique suivie d'une phase clonique
- 2. La perte de connaissance est constante
- 3. Elles sont toujours précédées d'une aura
- 4. La morsure de langue est fréquente
- 5. L'état post-critique est habituel

A 1+2+3+4 D 1+2+4+5 C 1+3+4 D 2+3+4+5 E 1-3+4

45/ Concernant le traitement antiépileptique :

1. Systématique après une première crise provoquée
2. Vise à prévenir la récurrence
3. Monothérapie privilégiée
4. Observance conditionne l'efficacité
5. Arrêt toujours définitif

A 1+2+3+4 B 1+2+5 C 2+3+4 D 2+3+5 E 1+3+5

46/ Devant une atteinte médullaire complète :

1. Un déficit moteur sous-lésionnel
2. Niveau sensitif
3. Troubles sphinctériens
4. Paralysie des nerfs crâniens
5. Dissociation sensitivo-motrice

A 1+2+3 B 1+2+5 C 3+4+5 D 2+3+5 E 2+4+5

47/ Les objectifs du diagnostic topographique :

1. Identifier la nature histologique
2. Localiser la lésion
3. Orienter les examens
4. Reposer uniquement sur l'imagerie
5. Se baser sur la clinique

A 1+2+3+4 B 2+3+4 C 2+3+5 D 1+3 E 1+3+5

48/ Concernant le tronc cérébral :

1. Contient les noyaux des nerfs crâniens
2. Des Signes croisés fréquents
3. Fonctions motrices uniquement
4. Troubles de la vigilance possibles
5. Passage des voies longues

A 1+2+3+4+5 B 2+3+4 C 1+2+3+4 D 1+2+4+5 E 3+5

49/ L'évaluation clinique d'un syndrome démentiel est basée sur :

1. Interrogatoire patient
2. Interrogatoire entourage
3. Les Tests cognitifs
4. IRM cérébrale
5. Les activités de la vie quotidienne

A 1+2+3+5 B 2+3 C 1+4+5 D 1+2+3+4 E 4+5

50/ Devant une atteinte du SNP on trouve :

1. une atteinte prédomine en distal
2. Une hypoesthésie tronculaire
3. Abolition des ROT
4. Un signe de Babinski
5. Une faiblesse musculaire

A 1+2+4 B 2+3+4 C 2+3 D 1+2+3+5 E/1+2+3+4

51/ Quelle séquence de l'IRM est la plus sensible pour détecter un AVC ischémique à la phase très précoce

- A. Séquence T2
- B. Séquence de Diffusion (DWI)
- C. Séquence T2 et T1
- D. Séquence T1
- E. Séquence FLAIR

52/ Parmi les éléments suivants, lequel constitue la principale contre-indication à la ponction lombaire ?

- A. Hypertension intracrânienne avec risque d'engagement
- B. Traumatisme crânien récent
- C. Troubles du sommeil
- D. Infection au point de ponction
- E. Fièvre élevée

53/ Quel est l'aspect normal du Liquide Cérébro-Spinal (LCS) lors d'une ponction lombaire ?

- A. Hémorragique
- B. Clair, dit 'eau de roche'
- C. Jaunâtre (xanthochromique)
- D. Trouble
- E. Purulent

54/ Le syndrome de Weber se définit par :

- A. Atteinte du III ipsilatérale et hémiplégie controlatérale
- B. Atteinte du III controlatérale et hémiplégie ipsilatérale
- C. Cécité corticale bilatérale
- D. Ataxie cérébelleuse Ipsilatérale et hémiplégie controlatérale
- E. Atteinte du VII ipsilatérale et hémiplégie controlatérale

55/ Une occlusion de l'artère cérébrale antérieure entraîne typiquement :

- A. Une perte de vision binoculaire
- B. Une hémiplégie à prédominance brachio-faciale
- C. Une hémiplégie à prédominance crurale
- D. Une perte de la vision bincoculaire
- E. Une hémianopsie latérale homonyme isolée

56/ Dans le diagnostic du syndrome méningé, quels sont les trois signes de la triade méningée

- A. Céphalées, vomissements, raideur de la nuque
- B. Vertige, acouphènes, surdité
- C. Céphalées, photophobie, fièvre
- D. Fièvre, coma, convulsions
- E. Aphasie, hémiplégie, hémianopsie

57/ Quel signe clinique correspond à une perte de vision d'un seul œil, souvent d'origine vasculaire ?

- A. Amaurose
- B. Photophobie
- C. Diplopie
- D. Agnosie visuelle
- E. Hémianopsie latérale homonyme

58/ En cas d'atteinte de l'hémisphère dominant (souvent gauche), quel trouble est fréquemment associé à l'hémiplégie ?

- A. Prosopagnosie
- B. Aphasie
- C. Syndrome cérébelleux
- D. Anosognosie
- E. Héminégligence

59/ Un patient présente une paralysie du nerf facial droit et une hémiparésie gauche. Où se situe précisément la lésion ?

- A. Capsule interne droite
- B. Protubérance annulaire (Pont) droite
- C. Mésencéphale droit
- D. Protubérance annulaire (pont) gauche
- E. Mésencéphale gauche

60/ Un syndrome cérébelleux cinétique se manifeste par :

- A. Une dysmétrie et une adiadicocinésie
- B. Une perte de la sensibilité thermo-algésique
- C. Un élargissement du polygone de sustentation
- D. Des hallucinations visuelles complexes
- E. Une hémiplégie massive

Examen UEI 3 3^{ème} / 2026

A/ Sémiologie :

1/ Concernant la sémiologie de l'hypothyroïdie de l'adulte, quelles propositions sont justes?

- A. La peau est volontiers chaude et moite
- B. La voix peut devenir rauque
- C. Les réflexes ostéotendineux peuvent montrer un relâchement lent
- D. L'amaigrissement peut se voir
- E. La constipation est constante

2/Au cours de l'hypothyroïdie, quels signes orientent particulièrement vers un myxoédème

- A. Infiltration cutanée ne prenant pas le godet
- B. Œdèmes déclives prenant franchement le godet
- C. Macroglossie possible
- D. Faciès bouffi et inexpressif
- E. Exophtalmie bilatérale réductible

3/Concernant la sémiologie de l'hyperthyroïdie, quelles propositions sont justes ?

- A. Tachycardie d'effort
- B. Intolérance au froid
- C. Tremblement fin des extrémités
- D. Asthénie paradoxale
- E. Bradycardie sinusale peut se voir

4/ Parmi les éléments suivants, lequel ou lesquels évoquent plus spécifiquement une maladie de Basedow ?

- A. Goitre vasculaire avec thrill ou souffle
- B. Exophtalmie
- C. Myosis serré bilatéral
- D. Rétraction palpébrale
- E. Dermate ocre des jambes

5/Chez un patient suspect d'hyperthyroïdie, quels signes cliniques peuvent être retrouvés ?

- A. Hyperréflexie ostéotendineuse
- B. Perte pondérale malgré appétit conservé ou augmenté
- C. Peau sèche, épaissie
- D. Diarrhée constante
- E. Voix grave

6/Parmi les signes suivants, lesquels constituent des signes d'appel classiques d'un diabète sucré ?

- A. Polyurie
- B. Polydipsie
- C. Polyphagie
- D. Bradypsychie avec constipation isolée
- E. Amaigrissement expliqué

7/Concernant la séméiologie d'un diabète découvert tardivement, quelles propositions sont justes ?

- A. Infections cutanées ou génito-urinaires répétées peuvent révéler la maladie
- B. Un prurit vulvaire peut être révélateur
- C. L'acanthosis nigricans est plus évocateur d'insulinorésistance
- D. L'œdème aigu pulmonaire est un signe spécifique inaugural
- E. L'énurésie secondaire chez l'enfant peut être un mode de révélation

8/ À propos du syndrome cardinal du diabète, quelles propositions sont justes ?

- A. La polyurie est souvent secondaire à une diurèse osmotique
- B. La polydipsie est toujours absente chez le sujet âgé
- C. La polyphagie peut coexister avec un amaigrissement
- D. La xérostomie peut majorer la sensation de soif
- E. L'oligurie est un signe constant

9/Concernant la séméiologie de l'hypoglycémie, quelles propositions sont justes ?

- A. Sueurs
- B. Tremblements
- C. Troubles du comportement
- D. Bradykinésie extrapyramidale spécifique
- E. Convulsions dans les formes sévères

10/ Quels signes relèvent plutôt d'une neuroglucopénie ?

- A. Confusion
- B. Diplopie
- C. Faim impérieuse
- D. Troubles de l'élocution
- E. Palpitations

11/ À propos de l'hypoglycémie, quelles propositions sont justes ?

- A. Elle peut simuler un accident vasculaire cérébral
- B. Elle peut entraîner une perte de connaissance
- C. Les signes adrénergiques sont toujours présents chez le diabétique ancien
- D. Elle peut être favorisée par l'effort chez un patient traité
- E. Elle s'accompagne toujours de fièvre

12/ Concernant l'insuffisance surrénalienne chronique primitive, quelles propositions sont justes ?

- A. Mélanodermie
- B. Asthénie physique prédominant à l'effort
- C. Prise de poids habituelle
- D. Hypotension artérielle possible
- E. Vergetures pourpres larges

13/ Parmi les éléments suivants, lesquels sont évocateurs d'un hypocorticisme chronique ?

- A. Troubles digestifs avec nausées, douleurs abdominales
- B. Appétence pour le sel
- C. Dépigmentation cutanée diffuse constante
- D. Amaigrissement
- E. Œdèmes blancs mous des membres inférieurs

14/ Concernant la crise aiguë surrénalienne, quelles propositions sont justes ?

- A. L'urgence peut être différée
- B. Elle peut associer hypotension sévère et déshydratation
- C. Elle se manifeste typiquement par une hypertension majeure
- D. Des vomissements peuvent être présents
- E. La douleur abdominale peut être présente mais trompeuse

15/ Concernant le syndrome de Cushing, quelles propositions sont justes ?

- A. Obésité facio-tronculaire
- B. Amyotrophie proximale
- C. Hyperpigmentation muqueuse constante
- D. Vergetures pourpres larges
- E. Faciès lunaire

16/ Parmi les signes suivants, lesquels orientent vers un hypercorticisme ?

- A. Fragilité cutanée avec ecchymoses faciles
- B. Hirsutisme chez la femme possible
- C. Hypotension orthostatique constante
- D. Fonte musculaire des racines des membres
- E. Hypertrichose localisée du scalp uniquement

17/ Concernant l'interrogatoire gynécologique, quelles propositions sont justes ?

- A. L'âge de la ménarchie fait partie des éléments importants
- B. Le caractère régulier ou non du cycle menstruel doit être précisé
- C. La date des dernières règles est inutile si la patiente consulte pour douleur pelvienne
- D. La parité et les antécédents obstétricaux doivent être recueillis
- E. Les leucorrhées n'ont pas d'intérêt sémiologique

18/ À propos des métrorragies, quelles propositions sont justes ?

- A. Elles correspondent à des saignements survenant en dehors des règles
- B. Elles doivent être distinguées des ménorragies
- C. Elles sont toujours d'origine utérine
- D. Leur abondance et leur ancienneté doivent être précisées
- E. Elles excluent une grossesse

19/ Concernant les douleurs pelviennes en sémiologie gynécologique, quelles propositions sont justes ?

- A. Il faut préciser le siège, l'irradiation et le mode d'installation
- B. Une douleur cyclique orientée par les règles a une valeur sémiologique
- C. Toute douleur pelvienne chronique est fonctionnelle
- D. Les dyspareunies doivent être recherchées
- E. Les signes urinaires et digestifs associés sont sans intérêt

20/ Au spéculum, quelles observations ont un intérêt sémiologique direct ?

- A. Aspect du col
- B. Origine apparente d'un saignement
- C. Présence et aspect des leucorrhées
- D. Volume utérin exact par mesure centimétrique
- E. Lésions vaginales

21/ Concernant la douleur testiculaire aiguë, quelles propositions sont justes ?

- A. Son début brutal est un élément d'orientation important
- B. Il faut rechercher des signes urinaires associés
- C. La notion de traumatisme est inutile
- D. Une douleur abdominale ou inguinale associée peut exister
- E. L'examen des bourses n'apporte rien

22/ À propos d'une tuméfaction scrotale, quelles propositions sont justes ?

- A. Il faut préciser si elle est douloureuse ou non
- B. La transillumination peut avoir un intérêt sémiologique
- C. Une masse testiculaire dure doit être banalisée chez l'adulte jeune
- D. La distinction entre contenu scrotal et hernie inguino-scrotale est importante
- E. La palpation de l'épididyme est inutile

23/ Concernant la sémiologie prostatique, quelles propositions sont justes ?

- A. Pollakiurie et dysurie peuvent évoquer une atteinte prostatique
- B. Le toucher rectal a un intérêt sémiologique
- C. Une hémospémie n'a jamais de valeur d'orientation
- D. La nycturie peut faire partie des signes fonctionnels
- E. L'interrogatoire sexuel est toujours hors sujet

24/ Concernant la sémiologie des troubles mictionnels, quelles propositions sont justes ?

- A. La dysurie correspond à une difficulté à uriner
- B. La pollakiurie correspond à une augmentation du volume de chaque miction
- C. La nycturie correspond à des mictions nocturnes anormales
- D. L'impériosité mictionnelle doit être

Recherchée

- E. La rétention chronique est toujours douloureuse

25/ À propos de l'hématurie, quelles propositions sont justes ?

- A. L'hématurie initiale oriente plutôt vers une origine basse urétrale
- B. L'hématurie terminale peut orienter vers une atteinte cervico-prostatique ou vésicale
- C. L'hématurie totale est toujours glomérulaire
- D. Il faut rechercher la présence de caillots
- E. Toute coloration rouge des urines est une hématurie

26/ Concernant les coliques néphrétiques, quelles propositions sont justes ?

- A. La douleur siège typiquement dans la fosse lombaire
- B. Elle peut irradier vers les organes génitaux externes
- C. Elle est volontiers soulagée par l'immobilité stricte
- D. Elle peut s'accompagner de nausées ou vomissements
- E. Une envie fréquente d'uriner peut être associée selon le niveau de l'obstacle

27/ À propos de la douleur rénale ou urétérale, quelles propositions sont justes

- A. Le contact lombaire peut être douloureux
- B. Une douleur lombaire fébrile doit faire évoquer une atteinte infectieuse
- C. La douleur vésicale est typiquement maximale en plein milieu du cycle menstruel
- D. Les brûlures mictionnelles orientent volontiers vers une atteinte du bas appareil urinaire
- E. Une douleur lombaire exclut une cause non urinaire

28/ Concernant l'examen clinique de l'appareil urinaire, quelles propositions sont justes ?

- A. La recherche d'un globe vésical peut être utile
- B. La palpation des fosses lombaires est dépourvue d'intérêt
- C. L'examen des organes génitaux externes peut contribuer au diagnostic
- D. Le toucher rectal peut faire partie de l'examen urologique chez l'homme
- E. La prise de la pression artérielle est sans intérêt en pathologie urinaire

29/ Parmi les tableaux suivants, lesquels sont compatibles avec un diabète non équilibré au stade de complications ?

- A. Polyurie, polydipsie, amaigrissement
- B. Prurit génital récidivant
- C. Sueurs, tremblements, faim brutale systématiques
- D. chute de cheveux
- E. Bradycardie, constipation, frilosité

30/ Quel(s) tableau(x) clinique(s) oriente(nt) le plus vers un hypercorticisme plutôt qu'un hypocorticisme ?

- A. Mélanodermie diffuse, hypotension, amaigrissement
- B. Vergetures pourpres larges, amyotrophie proximale, faciès lunaire
- C. Asthénie, envie de sel, troubles digestifs
- D. Fragilité cutanée avec ecchymoses faciles
- E. Hypoglycémies à répétition comme signe cardinal principal

B/ Biochimie :

31/ Donnez la réponse fausse ; dans

L'insuffisance rénale aigue

- A. Elle peut s'accompagner d'un syndrome oligo-anurique
- B. Traitée précocement et efficacement, l'IRA fonctionnelle est souvent réversible
- C. La principale étiologie de l'IRA organique est la nécrose tubulaire
- D. L'IRA post rénale représente, est la moins fréquente de toutes les IRA
- E. Le rapport Na urinaire/K urinaire est supérieur à 1 dans l'IRA fonctionnelle

32/ Donnez la ou les réponses justes concernant la physiologie rénale:

- A. L'urée urinaire constitue la forme principale d'élimination des déchets azotés chez l'homme
- B. Le rein est à l'origine de la synthèse de la 25-OH vitamine D
- C. L'ADH (hormone antidiurétique) est la principale hormone régulant la diurèse
- D. La clairance de l'inuline constitue la méthode de référence pour l'évaluation des fonctions tubulaires
- E. Le rein intervient dans le métabolisme de l'érythropoïétine pour assurer son élimination

33/ Donnez la ou les réponses

Justes, une déshydratation extracellulaire (DEC) + une hyperhydratation intracellulaire (HIC) s'accompagne :

- A. D'une augmentation de l'hématocrite
- B. D'une hypoprotidémie
- C. D'une hypernatrémie
- D. D'une hypoglycémie
- E. D'une baisse de l'osmolalité plasmatique

34/ Concernant l'équilibre hydro électrolytique, quelle est la réponse

- A. L'eau représente 75% du poids juste corporel de l'adulte
- B. La majeure partie de l'eau corporelle se trouve au niveau du secteur extracellulaire
- C. Une kaliémie basse avec une kaliurie élevée est en faveur d'une perte glomérulaire du potassium
- D. Une augmentation de la volémie est responsable d'œdèmes
- E. Toutes ces réponses sont fausses

35/ Donner la ou les réponses justes concernant L'hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO)

- A. Est une épreuve de surveillance du diabète
- B. Consiste en l'ingestion d'une charge glucosée variable en fonction de l'âge et du sexe
- C. Est une épreuve de diagnostic du diabète sucré chez les malades avec intolérances au glucose
- D. Est réservée uniquement pour le diagnostic du diabète gestationnel chez la femme enceinte.
- E. Une femme enceinte ayant une seule valeur supérieure aux normes lors de l'épreuve permet de poser le diagnostic du diabète gestationnel

36/ Un garçon de 6 ans est adressé pour troubles neurologiques sévères avec agitation, mouvements choréiques et automutilation. Bilan : Hyperuricémie majeure (> 100 mg/L). Antécédents familiaux masculins similaires ont été documentés. Quelle(s) proposition(s) est (sont) correcte(s) ?

- A. Il s'agit probablement d'un déficit partiel en HGPRT
- B. La transmission est autosomique récessive
- C. L'anomalie touche la voie d'élimination des purines
- D. L'accumulation d'hypoxanthine augmente la production d'acide urique
- E. Des crises de goutte peuvent apparaître secondairement

37/ Un adolescent atteint d'une glycogénose de type I présente une hyperuricémie persistante. Quels mécanismes participent à cette hyperuricémie ?

- A. Augmentation de la synthèse de novo des purines
- B. Diminution de l'excrétion urinaire de l'acide urique
- C. Déficit en HGPRT
- D. Accumulation de lactates
- E. Diminution du PRPP

38/ Un homme de 58 ans présente : Calcémie : 100 mg/L ? Albuminémie: 28 g/L ; Quelle proposition est fausse ?

- A. La calcémie corrigée est normale
- B. La calcémie corrigée est Augmentée
- C. Il s'agit d'une hypercalcémie vraie
- D. La calcémie corrigée est de 112 mg/L
- E. Il s'agit d'une hypocalcémie vraie

C/ Radiologie

39/ Quel examen est le plus performant dans le dépistage du cancer du sein: réponse juste.

- A- IRM mammaire.
- B- Echographie seule
- C- Couple mammographie- échographie
- D- Mammographie seule.
- E- Couple IRM mammaire- échographie.

40/ Quelles sont les incidences les plus utilisées en mammographie: réponse juste

- A- Cranio-caudale et oblique externe
- B- Cranio-caudale et oblique interne
- C- Cranio-caudale seule
- D- Oblique interne seule
- E- De face sans compression

41/ Indication de l'échographie mammaire ; réponse fausse.

- A- Femme âgée.
- B- Seins denses.
- C- Contexte post-opératoire.
- D- Grossesse
- E- Seins inflammatoires.

42/ La classification ACR se base sur : réponse fausse.

- A- Description de la densité mammaire.
- B- Description des lésions cutanées mammaires.
- C- description des opacités mammaire
- D- Description des calcifications mammaires
- E- Utilise un lexique unique commun

43/ Une densité mammaire BI-RADS

2: réponse juste.

- A- Sein dense homogène
- B- Sein grasseux homogène
- C- Sein dense hétérogène
- D- Sein grasseux hétérogène
- E- Sein sans tissu glandulaire

44/ Selon la classification de l'ACR, une opacité est analysée selon: réponse juste.

- A. Ses contours.
- B. Sa taille
- C. Sa densité.
- D. Sa forme
- E. Leur nombre.

45/ Selon la classification de l'ACR, les calcifications mammaire sont analysées selon: réponse juste.

- A. Leur densité.
- B. Leurs tailles.
- C. Leurs morphologies.
- D. Leur nombre
- E. Leur distribution.

46/ Une opacité mammaire bien circonscrite, ronde, non micro lobulée, non calcifiée, et non liquidienne a l'échographie, serait classée selon l'ACR : réponse juste

- A- BI-RADS 1
- B- BI-RADS 2
- C- BI-RADS 3
- D- BI-RADS 4
- E- BI-RADS 5

47/ Un nodule a contours Irréguliers avec micro-calcifications a l'échographie est classé selon TI- RADS : réponse juste.

- A- TI-RADS 1
- B- TI-RADS 2
- C- TI-RADS 3
- D- TI-RADS 4
- E- TI-RADS 5

48/ La classification TI-RADS : réponse fausse.

- A- Un lexique illustré
- B- Se base sur l'échographie et le doppler.
- C- Un compte rendu standardisé
- D- Donne un score du risque de malignité
- E- Donne des recommandations de prise en charge
- D/ Physiopathologie

49/ Quel est l'état du potassium sérique total lors d'une acidocétose diabétique? (RJ)

- A) Il est toujours bas
- B) il est augmenté
- C) il est souvent normal ou élevé (faux positifs); alors que le stock total est diminué
- D) il est sans importance
- E) il doit toujours être recherché avant l'administration de l'insuline

50/ Quelle est la cause principale de la production de corps cétoniques ? (RJ)

- A) l'accumulation de glucose dans la cellule
- B) la carence en insuline qui stimule la lipolyse
- C) un excès de protéines
- D) une alimentation trop riche en gras
- E) un défaut d'élimination

51/ l'acidocétose diabétique : (RF)

- A) est due à une carence en insuline
- B) est une acidose métabolique avec hypoglycémie
- C) est une hyperglycémie avec corps cétoniques
- D) est une acidose métabolique avec hyperglycémie
- E) est un désordre métabolique aigu

52/ parmi les signes cliniques de l'acidocétose diabétique on retrouve : (RF)

- A) Des vomissements
- B) une déshydratation
- C) une respiration de kussmaul
- D) une haleine fétide
- E) des pétéchie

53/ Concernant la régulation de la Na-K-

ATPase et ses conséquences sur le potassium, quelles sont les propositions exactes ?

- A) Elle sort 3 ions Na^+ de la cellule et y fait entrer 2 ions K^+
- B) L'acidose sévère active cette pompe afin de favoriser la sortie de H^+ hors de la cellule
- C) Les catécholamines α -1 exercent un effet inhibiteur sur cette pompe
- D) Cette pompe est présente exclusivement au niveau des cellules excitables (neurones, myocytes)
- E) L'augmentation de la concentration extracellulaire en K^+ exerce un rétrocontrôle positif qui active la pompe

54/ Concernant les effets de l'acidose sur les mouvements du potassium, quelles sont les propositions exactes ?

- A) L'acidose métabolique hyperchlorémique provoque une sortie importante de K^+ du compartiment intracellulaire
- B) L'acidose métabolique organique (ex : acidose lactique) provoque une sortie de K^+ d'amplitude identique à l'acidose hyperchlorémique
- C) Au niveau rénal, l'acidose diminue la sécrétion distale de potassium
- D) Le mécanisme principal de sortie cellulaire de K^+ lors de l'acidose minérale est la diminution de l'activité de la Na-K-ATPase
- E) L'acidose active la H-K-ATPase de la cellule intercalaire α , favorisant la réabsorption rénale de K^+

55/ Concernant les effets de l'alcalose sur le potassium, quelles sont les propositions physiopathologiques exactes ?

- A) Au niveau cellulaire, elle provoque une entrée de K^+ dans les cellules par échange H^+/K^+ transmembranaire
- B) Au niveau rénal, elle stimule la sécrétion distale de potassium par les cellules principales
- C) Au niveau rénal, elle diminue l'électronégativité luminale du tubule distal
- D) Une augmentation de 0,1 unité de pH sanguin fait baisser la kaliémie d'environ 0,5 mmol/L
- E) Elle active la pompe H-K-ATPase de la cellule intercalaire α

56/Concernant les mécanismes entraînant une hypokaliémie par transfert intracellulaire du potassium, quelles sont les propositions exactes ?

- A) L'insuline stimule la Na-K-ATPase, favorisant l'entrée de K⁺ dans les cellules
- B) La stimulation des récepteurs bêta-2 adrénergiques (ex: salbutamol) augmente l'entrée de K⁺ dans les cellules musculaires
- C) L'acidose métabolique hyperchiorémique provoque une entrée de KO dans les cellules par échange H⁺/K⁺
- D) L'alcalose métabolique provoque une entrée de K⁺ dans les cellules pour compenser la sortie des protons H⁺
- E) L'hypertonie extracellulaire favorise l'entrée de K⁺ dans les cellules par mécanisme de solvant drag

57/ Concernant les mécanismes de transfert extracellulaire responsables d'une hyperkaliémie, quelles sont les propositions exactes ?

- A) La rhabdomyolyse provoque une hyperkaliémie par libération massive du potassium contenu dans les myocytes
- B) Le syndrome de lyse tumorale provoque une hyperkaliémie par libération massive de potassium liée à la destruction des cellules cancéreuses
- C) Les beta-bloquants provoquent une hyperkaliémie en bloquant les récepteurs bêta-2, empêchant ainsi l'entrée cellulaire de potassium
- D) L'hypertonie extracellulaire, telle observée lors d'une hyperglycémie majeure, provoque une entrée de potassium dans les cellules par déshydratation cellulaire
- E) L'intoxication par la digoxine provoque une hyperkaliémie en activant fortement la Na-K-ATPase

58/ L'hypophosphorémie : (Cochez la ou les réponses justes)

- A. Est souvent symptomatique.
- B. Est classée sévère lorsqu'elle est à 0.30 mmol/L
- C. Est plus fréquente en réanimation
- D. Est peut-être secondaire à une hyperparathyroïdie, un syndrome de dénutrition ou un syndrome de Fanconi.
- E. Donne un tableau de troubles digestifs seulement.

59/ Les étiologies de l'hyperphosphorémie sont : (Cochez la ou les réponses justes)

- A. L'hémolyse.
- B. L'hyperthyroïdie.
- C. L'hyperparathyroïdie.
- D. L'acidocétose diabétique.
- E. Alimentation riche en poissons

60/ Concernant les dysphosphorémies : (Cochez la ou les réponses justes)

- A. L'hypophosphorémie peut être liée à un transfert intracellulaire.
- B. L'alcalose respiratoire peut provoquer une hypophosphorémie de transfert.
- C. L'insuffisance rénale chronique entraîne une diminution du phosphate.
- D. La lyse tumorale est responsable d'une libération massive du phosphate.
- E. L'hyperparathyroïdie diminue l'excrétion rénale du phosphore.

Examen UEI 4 3^{ème} / 2026

A/ Sémiologie

1/ Un patient de 58 ans décrit une douleur épigastrique transfixiante, calmée partiellement par l'anteflexion. Quelles propositions orientent le plus vers une origine pancréatique ?

- A. Irradiation dorsale en barre, indépendante de la respiration.
- B. Douleur améliorée par le décubitus dorsal strict.
- C. Défense épigastrique toujours proportionnelle à l'intensité douloureuse dès la première heure.
- D. Vomissements sans soulagement durable de la douleur.
- E. Antécédent récent de colique biliaire ou d'alcoolisation massive.

1. A+C+D 2. A+D+E 3. A+B+E 4. C+D+E 5. A+C+D

2/ Devant une dysphagie, quelles combinaisons font privilégier une dysphagie œsophagienne organique obstructive plutôt qu'un trouble moteur ?

- A. Début pour les solides puis extension secondaire aux liquides.
- B. Évolution lentement progressive avec amaigrissement.
- C. Dysphagie intermittente depuis des années, identique pour solides et liquides.
- D. Odynophagie fébrile isolée après antibiothérapie.
- E. Régurgitations alimentaires non acides possibles au-dessus de l'obstacle.

1. A+C+D 2. B+C+E 3. A+B+E 4. C+D+E 5. A+B+D

3/ A propos de l'hématémèse, quelle combinaison est sémiologiquement correcte ?

- A. Elle implique une extériorisation de sang par vomissement, distincte d'une hémoptysie.
- B. Un méléna associé renforce l'hypothèse d'une hémorragie digestive haute.
- C. L'absence de douleur épigastrique élimine une cause ulcéreuse.
- D. Le sang rouge vif peut traduire un saignement actif abondant.
- E. Le lavage naso-gastrique clair exclut formellement une lésion duodénale.

1. A+C+D 2. A+B+D 3. B+D+E 4. C+D+E 5. A+B+E

4/ Un abdomen augmente de volume est examiné. Quelle combinaison soutient le diagnostic clinique d'ascite libre plutôt que météorisme ou masse ?

- A. Matité déclive des flancs avec tympanisme péri-ombilical.
- B. Matité immobile en décubitus latéral
- C. Signe du flot positif malgré interposition de la main sur la ligne médiane.
- D. Ombilic éversé et circulation veineuse collatérale possible.
- E. Tympanisme diffus sans modification positionnelle.

1. A+C+D 2. B+C+D 3. A+B+E 4. C+D+E 5. A+D+E

5/ Parmi les éléments suivants, lesquels forment une combinaison compatible avec un ictère cholestatique extra-hépatique ?

- A. Urines foncées et selles décolorées.
- B. Prurit souvent précoce.
- C. Douleur de l'hypochondre droit avec fièvre et frissons dans une angiocholite.
- D. Bilirubine non conjuguée isolée, sans cholurie.
- E. Grosse vésicule palpable indolore en cas d'obstacle malin bas situé possible.

1. B+D+E 2. C+D+E 3. A+B+C+E 4. A+B+D 5. A+C+D

6/ Quelle combinaison caractérise le mieux une douleur biliaire non compliquée ?

- A. Siège épigastrique ou hypochondre droit, parfois irradiée vers l'épaule droite.
- B. Durée typique de quelques minutes seulement, toujours inférieure à 10 minutes.
- C. Déclenchement post-prandial gras possible.
- D. Fièvre élevée persistante obligatoire.
- E. Agitation douloureuse possible, sans contracture généralisée.

1. B+C+D 2. C+D+E 3. A+C+E 4. A+B+C 5. A+D+E

7/ Devant une diarrhée chronique, quelle combinaison oriente vers une malabsorption grêlique ?

- A. Selles volumineuses, luisantes, flottantes et difficiles à évacuer.
- B. Amaigrissement avec appétit conservé ou augmenté.
- C. Ténésme et faux besoins au premier plan.
- D. Ballonnement post-prandial avec borborygmes.
- E. Sang rouge strié sur selles dures isolées.

1. C+D+E 2. A+D+E 3. A+C+D 4. A+B+D 5. B+C+E

8/ Quelle combinaison est la plus évocatrice d'un syndrome dysentérique ?

- A. Émissions afécales faites de glaires, pus ou sang.
- B. Douleurs coliques soulagées par l'émission.
- C. Faux besoins et ténésme.
- D. Selles grasses abondantes sans urgence rectale.
- E. Vomissements alimentaires anciens non digérés.

1. B+D+E 2. A+B+E 3. C+D+E 4. A+C+D 5. A+B+C

9/ À propos des vomissements, quelle combinaison aide à localiser un obstacle digestif haut

- A. Vomissements précoces post-prandiaux en cas d'obstacle gastrique ou pylorique.
- B. Vomissements fécaloïdes tardifs dans certaines occlusions basses.
- C. Soulagement durable de la douleur pancréatique après vomissement.
- D. Déshydratation et alcalose métabolique possibles si pertes gastriques répétées.
- E. Vomissements bilieux toujours impossibles si l'obstacle est au-delà du pylore.

1. B+C+D 2. A+B+D 3. A+C+E 4. A+B+D 5. C+D+E

10/ Quel assemblage distingue le méléna d'une coloration noire non hémorragique ?

- A. Aspect noir, luisant, goudronneux et odeur fétide caractéristique.
- B. Association possible à hypotension orthostatique ou tachycardie.
- C. Recherche d'une prise de fer ou de bismuth utile pour le diagnostic différentiel.
- D. Réaction au toucher rectal toujours normale si le saignement est ancien.
- E. Origine digestive haute fréquente mais non exclusive.

1. B+D+E 2. A+B+D 3. B+C+E 4. A+C+D 5. A+B+C

11/ Quelle combinaison plaide contre une appendicite typique non compliquée et impose d'élargir le raisonnement ?

- A. Début épigastrique puis migration vers la fosse iliaque droite.
- B. Diarrhée sanglante avec ténésme intense.
- C. Douleur pelvienne cyclique chez une femme en âge de procréer.
- D. Contracture généralisée d'emblée avec état de choc.
- E. Anorexie et fébricule modérée.

1. B+C+D 2. A+C+D 3. A+D+E 4. A+B+E

12/ Quel profil sémiologique évoque le plus une occlusion mécanique du grêle ?

- A. Douleurs abdominales paroxystiques avec intervalles d'accalmie.
- B. Vomissements précoces, parfois bilieux.
- C. Météorisme central modéré possible.
- D. Arrêt des matières et des gaz toujours inaugural.
- E. Bruits hydro-aériques augmentés au début.

1. A+C+D 2. A+B+C+E 3. C+D+E 4. B+D+E 5. A+B+D

13/ Dans la sémiologie d'une péritonite, quelle combinaison est correcte ?

- A. Contracture involontaire, permanente et douloureuse.
- B. Douleur aggravée par la toux ou les mouvements.
- C. Disparition possible de la respiration abdominale.
- D. Douleur calmée par les secousses du brancard.
- E. Touchers pelviens pouvant révéler une douleur du cul-de-sac de Douglas.

1. B+C+D 2. A+B+C+E 3. A+D+E 4. C+D+E 5. A+B+D

14/ Quel groupe de signes oriente vers une hypertension portale cliniquement constituée ?

- A. Splénomégalie.
- B. Circulation veineuse collatérale abdominale.
- C. Ascite.
- D. Hépatomégalie douloureuse pulsatile obligatoire.
- E. Antécédent d'hémorragie par rupture de varices œsophagiennes possible.

1. C+D+E 2. A+B+D 3. B+D+E 4. A+C+D 5. A+B+C+E

15/ Un reflux gastro-œsophagien est plus probable si l'on associe :

- A. Pyrosis rétro-sternal ascendant post-prandial.
- B. Régurgitations acides majorées par l'antéflexion ou le décubitus.
- C. Dysphagie progressive avec amaigrissement comme signe banal rassurant.
- D. Toux nocturne ou enrouement possible.
- E. Soulagement par antiacides possible.

1. C+D+E 2. A+B+D+E 3. B+C+E 4. A+B+C 5. A+C+D

16/ Quelle combinaison permet de distinguer une douleur ulcéreuse duodénale typique ?

- A. Épigastralgie rythmée par les repas.
- B. Douleur tardive post-prandiale ou nocturne, calmée par alimentation/antiacides.
- C. Irradiation scapulaire droite fébrile constante.
- D. Périodicité par poussées possible.
- E. Douleur systématiquement augmentée par la prise alimentaire dès les premières bouchées.

1. B+C+D 2. C+D+E 3. A+D+E 4. A+C+E 5. A+B+D

17/ Une constipation est plus inquiétante sur le plan sémiologique si elle s'accompagne de :

- A. Début récent après 50 ans.
- B. Alternance récente diarrhée-constipation.
- C. Rectorragies ou anémie ferriprive.
- D. Ancienneté depuis l'enfance sans modification.
- E. Amaigrissement inexpliqué.

1. A+B+D 2. A+C+D 3. C+D+E 4. B+D+E 5. A+B+C+E

18/ Parmi les éléments suivants, quelle combinaison décrit une douleur colique fonctionnelle plutôt qu'une douleur péritonéale ?

- A. Douleur spasmodique avec épisodes et accalmies.
- B. Soulagement après défécation ou émission de gaz.
- C. Contracture invincible de la paroi.
- D. Modification avec le stress et le transit.
- E. Aggravation constante par la toux avec immobilité absolue recherchée.

1. C+D+E 2. A+C+D 3. B+C+E 4. A+D+E 5. A+B+D

19/ Quel assemblage est le plus cohérent avec une insuffisance hépatocellulaire avancée ?

- A. Astérisis et troubles du sommeil inversé.
- B. Angiomes stellaires et érythrose palmaire.
- C. Syndrome hémorragique patent.
- D. Hyperpilosité diffuse et virilisation.
- E. Foetor hepaticus possible.

1. A+C+D 2. A+B+D 3. A+B+C+E 4. B+D+E 5. C+D+E

20/ Dans l'analyse d'une masse abdominale, quelle combinaison est correcte ?

- A. Le caractère mobile à la respiration suggère un organe sous-diaphragmatique comme foie ou rate.
- B. Une masse battante expansile évoque un anévrisme aortique plutôt qu'une simple transmission.
- C. La matité à la percussion permet toujours de distinguer foie et rein.
- D. Le contact lombaire oriente vers une origine rénale.
- E. Le bord inférieur tranchant régulier peut appartenir à une hépatomégalie.

1. B+C+E 2. C+D+E 3. A+B+C 4. A+C+D 5. A+B+D+E

21/ Quelle combinaison correspond le mieux à un syndrome anémique d'installation progressive ?

- A. Pâleur cutanéomuqueuse, surtout conjonctivale.
- B. Dyspnée d'effort puis de repos selon la gravité.
- C. Tachycardie et souffle systolique fonctionnel possibles.
- D. Cyanose centrale constante.
- E. Tolérance parfois étonnamment bonne si installation lente.

1. C+D+E 2. B+D+E 3. A+C+D 4. A+B+C+E 5. A+B+D

22/ Devant une anémie, quelle combinaison oriente vers une hémolyse plutôt que vers une carence martiale pure ?

- A. Ictère conjonctival discret avec urines foncées possibles selon le mécanisme.
- B. Splénomégalie.
- C. Douleurs osseuses métaphysaires isolées comme signe cardinal
- D. Crises déclenchées par certains médicaments ou infections possibles selon l'étiologie.
- E. Koïlonychie et pica comme éléments dominants.

1. C+D+E 2. A+B+D 3. A+C+E 4. B+C+E 5. A+D+E

23/ Quel ensemble décrit un purpura thrombopénique typique ?

- A. Purpura pétéchiial non infiltré, non effaçable à la vitropression.
- B. Prédominance déclive possible.
- C. Ecchymoses spontanées et bulles hémorragiques buccales si sévère
- D. Hémarthroses profondes répétées au premier plan.
- E. Splénomégalie massive obligatoire.

1. C+D+E 2. A+B+E 3. A+B+C 4. A+C+D 5. B+D+E

24/ Quelle combinaison oriente vers un déficit de l'hémostase secondaire plutôt qu'un trouble plaquettaire ?

- A. Hématomes profonds.
- B. Hémarthroses.
- C. Saignement immédiat, superficiel, cutanéomuqueux exclusif.
- D. Saignement retardé après geste invasif.
- E. Purpura pétéchiial diffus comme manifestation dominante.

1. B+D+E 2. A+B+D 3. C+D+E 4. A+C+E 5. A+B+C

25/ Une adénopathie est cliniquement plus suspecte de malignité si elle est :

- A. Dure, pierreuse ou ferme, peu douloureuse.
- B. Fixée aux plans profonds.
- C. Sus-claviculaire gauche.
- D. Molle, douloureuse, inflammatoire dans un contexte infectieux évident.
- E. Associée à fièvre prolongée, sueurs nocturnes et amaigrissement.

1. C+D+E 2. A+B+C+E 3. A+B+D 4. B+D+E 5. A+C+D

26/ Quel assemblage est le plus évocateur d'un syndrome tumoral hématologique ?

- A. Polyadénopathies périphériques.
- B. Splénomégalie et/ou hépatomégalie.
- C. Douleurs osseuses diffuses.
- D. Prurit aquagenique possible dans certains syndromes myeloproliferatifs.
- E. Rectorragies isolées après selle dure comme signe principal.

1. B+D+E 2. C+D+E 3. A+B+E 4. A+B+C+D 5. A+C+E

27/ Quel profil clinique évoque une neutropénie sévère ?

- A. Fièvre parfois isolée, sans foyer clinique évident.
- B. Ulcérations buccales ou angine ulcero-necrotique.
- C. Absence fréquente de pus malgré infection bactérienne.
- D. Polyglobulie rubiconde obligatoire.
- E. Risque vital même avec examen pauvre.

1. A+C+D 2. C+D+E 3. A+B+C+E 4. A+B+D 5. B+D+E

28/ Quel assemblage décrit le mieux un syndrome d'insuffisance médullaire ?

- A. Anémie avec asthénie et dyspnée.
- B. Infections répétées par neutropénie.
- C. Saignements cutanéomuqueux par thrombopénie.
- D. Hyperleucocytose isolée toujours nécessaire au diagnostic clinique.
- E. Atteinte simultanée possible des trois lignées.

1. A+B+C+E 2. A+C+D 3. C+D+E 4. B+D+E 5. A+B+D

29/ Quelle combinaison aide à reconnaître une splénomégalie à l'examen clinique ?

- A. Masse de l'hypochondre gauche descendant vers la fosse iliaque droite.
- B. Encoche du bord antero-interne parfois palpable
- C. Mobilité respiratoire.
- D. Contact lombaire franc constant comme pour un rein.
- E. Matite de Traube ou signe de Castell possible.

1. A+B+C+E 2. A+B+D 3. A+C+D 4. B+D+E 5. C+D+E

30/ Quel groupe de signes évoque une carence en vitamine B12 avancée ?

- A. Glossite de Hunter douloureuse avec langue lisse.
- B. Paresthésies, troubles proprioceptifs ou démarche ataxique.
- C. Ictère discret possible par hémolyse intramédullaire.
- D. Koïlonychie isolée comme signe le plus spécifique.
- E. Splénomégalie.

1. A+B+C 2. A+B+D 3. A+C+D 4. B+C+E 5. C+D+E

31/ À propos du purpura vasculaire, quelle combinaison est correcte ?

- A. Purpura souvent palpable ou infiltré.
- B. Prédominance déclive aux membres inférieurs.
- C. Plaquettes nécessairement très abaissées.
- D. Arthralgies ou douleurs abdominales associées possibles selon l'étiologie.
- E. Disparition à la vitropression.

1. A+C+E 2. B+D+E 3. A+B+D 4. A+B+C 5. C+D+E

32/ Quel ensemble est le plus compatible avec une hémorragie aigue extériorisée significative

- A. Pâleur, sueurs, soif et malaise.
- B. Tachycardie puis hypotension orthostatique.
- C. Temps de recoloration allongé et extrémités froides.
- D. Hémoglobine initiale toujours immédiatement basse dès les premières minutes.
- E. Agitation ou confusion possible si choc.

1. A+B+C+E 2. A+B+D 3. A+B+D 4. B+D+E 5. C+D+E

33/ Quelle combinaison distingue mieux un saignement d'origine plaquettaire d'un saignement par déficit en facteur de coagulation ?

- A. Épistaxis, gingivorragies et ménorragies.
- B. Purpura pétéchial.
- C. Saignement immédiat après petite plaie.
- D. Hémarthroses profondes récurrentes.
- E. Hématomes musculaires profonds retardés.

1. A+B+C 2. C+D+E 3. B+D+E 4. A+C+D 5. A+B+E

34/ Quelle combinaison évoque le plus une drépanocytose symptomatique lors d'une crise vaso-occlusive ?

- A. Douleurs osseuses intenses, souvent des os longs ou du rachis.
- B. Facteurs déclenchants possibles : infection, froid, déshydratation, hypoxie.
- C. Ictère chronique ou splénomégalie/hypersplénisme dans certaines phases.
- D. Purpura pétéchial isolé comme manifestation principale.
- E. Syndrome thoracique aigu possible devant douleur thoracique, fièvre et dyspnée.

1. C+D+E 2. A+B+C+E 3. A+B+D 4. A+C+D 5. B+D+E

35/ Devant une pancytopenie, quelle combinaison clinique oriente vers une cause centrale médullaire plutôt qu'une hypersplénie isolée ?

- A. Syndrome anémique, infectieux et hémorragique associés.
- B. Absence de splénomégalie palpable n'excluant pas une cause centrale.
- C. Douleurs osseuses et signes généraux associés possibles.
- D. Correction complète et immédiate des cytopénies après décubitus.
- E. Antécédent d'exposition toxique, chimiothérapie ou irradiation à rechercher.

1. A+B+D 2. A+C+D 3. B+D+E 4. A+B+C+E 5. C+D+E

B/ Biochimie

36/ Un homme de 62 ans présente une masse du côlon sigmoïde avec ACE = 28 ng/mL (N<5). Quelle est la meilleure utilité clinique de ce marqueur ?

- A. Diagnostic histologique.
- B. Dépistage de masse.
- C. Suivi post-opératoire.
- D. Confirmation définitive du cancer.
- E. Aucune utilité.

37/ Une normalisation de l'ACE après chirurgie évoque :

- A. Une récurrence.
- B. Une réponse thérapeutique favorable.
- C. Une métastase hépatique.
- D. Une erreur analytique.
- E. Un arrêt de suivi.

38/ Donner la combinaison exacte : Un patient présente PAL 11, GGT 11, bilirubine conjuguée 1. Le profil peut évoquer :

- 1. Cytolyse pure
- 2. Cholestase
- 3. Obstacle biliaire
- 4. Hémolyse
- 5. Hépatopathie cholestatique

A=1 B=2+3 C=4 D=2+3+4+5 E =2+3+5

39/ Donner la combinaison exacte : Peuvent traduire une insuffisance hépatocellulaire :

1. Hypoalbuminémie.
2. Diminution du facteur V.
3. Allongement du TP.
4. Hypertransaminasémie isolée.
5. Toutes ces réponses sont fausses.

A=1 B=1+2 C=1+2+3 D=1+4 E =2+3+5

40/ Dans le contexte d'une fistule pancréatique, quel mécanisme explique la présence de 2 fractions d'albumine lors de l'électrophorèse ?

- A. La présence de 2 gènes codant pour l'albumine
- B. La digestion enzymatique partielle de l'albumine par le suc pancréatique.
- C. Une surproduction d'albumine par le pancréas.
- D. Une absorption altérée de l'albumine au niveau intestinal.
- E. Une surcharge pancréatique en enzymes protéolytiques.

41/ Laquelle des propositions suivantes concernant l'alpha-foetoprotéine (AFP) est correcte

- A. L'AFP est produite exclusivement par les cellules du pancréas.
- B. Des niveaux élevés d'AFP peuvent indiquer une grossesse normale.
- C. L'AFP est un marqueur tumoral utile pour le diagnostic du cancer de la prostate.
- D. Des niveaux élevés d'AFP sont associés au carcinome hépatocellulaire.
- E. L'AFP n'est jamais présente chez les adultes en bonne santé.

42/ Dans un dépistage néonatal, quel biomarqueur sanguin dose sur papier buvard au 3^{ème} jour de vie permet le dépistage de la mucoviscidose ?

- A. Élastase pancréatique.
- B. Trypsinogène immunoréactif.
- C. Chlorure sérique.
- D. Lipase pancréatique.
- E. Recherche de mutation CFTR.

43/ Parmi ces tests, lequel permet de poser le diagnostic différentiel entre la malabsorption intestinale et l'insuffisance pancréatique ?

- A. Dosage de la lipase sanguine.
- B. Dosage de l'amylasurie.
- C. Test isotopique à la trioléine marquée.
- D. Test au para-amino-benzoïque.
- E. Test de stimulation à la sécrétine.

C/ Radiologie

44/ Les lésions élémentaires recherchées par l'imagerie en cas de polytraumatisé (RJ) :

- 1- Hémopéritoine
- 2-Occlusion intestinale aigue
- 3- Choc septique
- 4- Perforation digestive
- 5- Hémorragie active

A : 1+2+4 B : 1+2+3+5 C : 2+4+5 D: 1+4+5 E :1+3+5

45/ Les hématomes des organes pleins en imagerie présentent les caractéristiques suivantes (RJ)

1- Hyperdense sur le scanner avec injection

2- Intra-parenchymateux

3- Intra-capsulaire

4- Hypodense sur le scanner avec injection

5- Collection de sang

A : 1+2+3+4+5 B : 1+2+5 C : 2+3+4+5 D : 2+4+5 E : 1+2+3+5

46/ Le choc hypovolémique en imagerie (RJ) :

1- Veine cave inférieure plate

2- Aorte réduite de calibre

3- Surrénales à faible rehaussement

4- Anses intestinales dilatées faiblement rehaussées

5- Rate à faible rehaussement

A : 1+3+5 B : 1+2+3 C : 1+3+4+5 D : 2+4+5 E : 1+2+5

47/ Une lésion hépatique de grade 1 de MIRVIS est caractérisée par (RJ) :

1- Devascularisation d'un seul lobe

2- Avulsion capsulaire

3- Hématome central de 10 à 30 mm de diamètre

4- Infiltration peri-portale

5- Fracture superficielle de moins de 10 mm

A : 1+2+4+5 B : 1+2+3+4 C : 1+2+5 D : 2+3+4+5 E : 2+4+5

48/ Les diagnostics différentiels d'un pneumopéritoine sont (RJ) :

1- Clartés graisseuses sous-diaphragmatiques

2- Syndrome de CHILADITI

3- Clarté colique inter-hépatorénale

4- Clarté pulmonaire

5- Abscès sous-phrénique

A : 1+2+3+5 B : 1+2+4 C : 1+2+4+5 D : 1+3+5 E : 1+2+3+4

49/ Caractéristiques d'une masse intra-péritonéale à l'ASP (RJ) :

1- Cernée par des clartés digestives

2- N'efface pas les contours du psoas

3- N'efface pas les contours des reins

4- Pas de destruction des vertèbres

5- Refoule les clartés digestives

A : 1+2+4+5 B : 1+4+5 C : 1+2+3+4+5 D : 2+3+4+5 E : 1+3+4+5

D/ Physiopathologie

50/ Concernant la bilirubine non conjuguée :

1- Elle est liposoluble

2- Elle circule liée à l'albumine

3- Elle est potentiellement neurotoxique

4- Elle est facilement éliminée dans les urines

5- Elle augmente lors des hémolyses

A. (1+2+3+5) B. (1+2+3) C. (2+4+5) D. (4+5) E. (1+2+3+4+5)

51/ Concernant les ictères cholestatiques :

- 1- Les selles peuvent être décolorées
 - 2- Les urines sont souvent foncées
 - 3- Le prurit est fréquent
 - 4- La bilirubine non conjuguée est toujours prédominante
 - 5- Les phosphatases alcalines sont souvent augmentées
- A. (1+2+3) B. (1+2+3+5) C. (2+4+5) D. (4+5) E. (1+2+3+4+5)

52/ Concernant l'angiocholite aigue :

- 1- Elle associe classiquement fièvre, douleur de l'hypochondre droit et ictère
 - 2- Elle est le plus souvent liée à une obstruction biliaire infectée
 - 3- Une antibiothérapie précoce est nécessaire
 - 4- Un drainage des voies biliaires est toujours chirurgical
 - 5- Elle peut évoluer vers un choc septique
- A. (1+2+3) B. (1+3+5) C. (1+2+3+5) D. (2+4) E. (4+5)

53/ Concernant l'hépatite fulminante :

- 1- Elle correspond à une insuffisance hépatique aigue grave
 - 2- Elle peut s'accompagner d'encéphalopathie hépatique
 - 3- Le taux de prothrombine est un élément pronostique important
 - 4- Une prise en charge en réanimation peut être nécessaire
 - 5- Une transplantation hépatique peut être discutée dans les formes sévères
- A. (1+2+3) B. (1+5) C. (2+4+5) D. (1+2+3+4+5) E. (3+4)

54/ Concernant la cirrhose, quels éléments anatomiques contribuent à l'augmentation de la résistance intra-hépatique ?

- 1- La fibrose hépatique
 - 2- Les nodules de régénération
 - 3- La vasodilatation artériolaire splanchnique
 - 4- L'état de choc
 - 5- La vasoconstriction intra-hépatique
- A. (1+2+3) B. (4+5) C. (2+4+5) D. (1+2+5) E. (1+2+3+4+5)

55/ Concernant la répartition du magnésium dans l'organisme, quelles affirmations sont exactes ?

- 1- Le stock total est d'environ 1 000 mmol (25 g)
 - 2- Plus de 60 % est stocké dans l'os
 - 3- Seulement 1 % circule dans le volume extracellulaire
 - 4- Dans le plasma, 45 % est lié aux protéines
 - 5- La magnésémie normale se situe entre 0,75 et 1,4 mmol/L
- A. (1+2+3) B. (1+3+4+5) C. (2+3+4+5) D. (1+2+3+5) E. (1+2+3+4+5)

56/ Concernant la démarche diagnostique de l'hypomagnésémie, quelles affirmations sont exactes ?

- 1- Une magnésurie < 1 mmol/24h oriente vers une origine extra-rénale
 - 2- Une magnésurie > 2 mmol/24h signe une perte rénale
 - 3- EF Mg > 1 % est en faveur d'une étiologie rénale
 - 4- Une magnésémie normale exclut formellement une déplétion intracellulaire
 - 5- Une magnésurie intermédiaire (1-2 mmol/24h) justifie supplémentation et réévaluation
- A. (1+2+3+4) B. (1+2+3+5) C. (2+3+4+5) D. (1+3+4+5) E. (1+2+3+4+5)

57/ Concernant les mécanismes physiopathologiques de l'hypermagnésémie, quelles affirmations sont exactes ?

- 1- Administration de sulfate de magnésium per os inversant le flux paracellulaire
- 2- Hypermagnésémie possible si apports dépassent capacités rénales et/ou DFG réduit
- 3- Acidose métabolique aiguë peut provoquer une hypermagnésémie par redistribution
- 4- Excès de magnésium dans le dialysat peut provoquer une hypermagnésémie
- 5- Hypermagnésémie toujours associée à une hypocalcémie

58/ Concernant les manifestations cliniques de l'hypermagnésémie, quelles affirmations sont exactes ?

- 1- Asymptomatique jusqu'à 2 mmol/L
 - 2- Au-delà de 2 mmol/L, altère la transmission neuromusculaire
 - 3- Inhibe le système nerveux sympathique entraînant une vasoconstriction
 - 4- Perturbe la conduction cardiaque par blocage des canaux Ca^{2+}
 - 5- Effets aggravés par l'hypocalcémie
- A. (1+2+3) B. (1+2+4+5) C. (2+3+4+5) D. (1+3+4+5) E. (1+2+3+4+5)

59/ Quels sont les facteurs de coagulation vitamine K dépendants ?

- 1- II
 - 2- IV
 - 3- VI
 - 4- IX
 - 5- X
- A : 1+2+3 B : 2+3+4+5 C : 2+3+4 D : 1+3+4+5 E : 1+2+4+5

60/ Un allongement isolé du Temps de Céphaline Activée (TCA) avec un Temps de Prothrombine (TP) normal oriente vers un déficit en :

- 1- Facteur VII
- 2- Facteur VIII
- 3- Facteur IX
- 4- Facteur V
- 5- Vit K

A : 1+2+3 B : 2+3 C : 3+5 D : 1+4 E : 2+4+5

Examen Cardio G2 / 2026

Q 1. Concernant le diagnostic et la prise en charge initiale d'une suspicion d'insuffisance cardiaque, quelles propositions sont vraies ? RJ

1-Un BNP/NT-proBNP normal rend l'insuffisance cardiaque peu probable.

2-L'échocardiographie est l'examen clé pour confirmer l'IC et préciser le mécanisme (FEVG, valves ...).

3-Les diurétiques de l'anse, utilisés seuls, réduisent la mortalité

4-L'oxygène doit être donné systématiquement même si la saturation est normale

5-Une cause déclenchante doit être recherchée (ischémie, infection, FA rapide, iatrogénie ...).

A. (1,2,5) B. (1,2,3) C. (2,3,5) D. (1,4,5) E. (1,2, 4)

Q 2. Concernant la cardiomyopathie hypertrophique (CMH), quelle proposition est la plus exacte ? RJ

A. La CMH est toujours secondaire à une HTA chronique.

B. Le souffle systolique augmente typiquement lors de la manœuvre de Valsalva (ou à l'effort).

C. Le traitement de première intention du gradient obstructif est le furosémide.

D. L'ECG est habituellement normal

E. Les dérivés nitrés sont indiqués dans la CMH obstructive pour traiter les douleurs thoraciques.

Q3. Chez un patient avec cardiomyopathie hypertrophique (CMH), quel élément fait craindre un risque élevé de mort subite (RJ)

A-Antécédent d'arrêt cardiaque récupéré ou tachycardie ventriculaire soutenue

B-Syncope Inexpliquée

C-Tachycardies ventriculaires non soutenues (TVNS) au Holter ECG

D-Antécédent familial de mort subite (surtout jeune)

E-Toutes les réponses sont justes

Q 4. Concernant la dysplasie/cardiomyopathie arythmogène du ventricule droit (DAVD), quelles propositions sont vraies

1-Peut donner des palpitations et des syncopes par tachycardie ventriculaire

2-À l'ECG, se caractérise par la présence d'une onde Epsilon

3-La tachycardie ventriculaire est l'arythmie redoutée

4-Le sport intensif est conseillé car il protège le cœur

5-Il faut souvent limiter les sports intenses/compétitifs

A.(1,2,3,5) B.(1,3,4) C. (2, 4,5) D. (1, 4,5) E. (3, 4,5)

Q 5: Concernant les diurétiques de l'anse : (RJ)

A. Ils diminuent la filtration glomérulaire au niveau du tube proximal.

B. Induisent une alcalose métabolique en augmentant l'excrétion de bicarbonates.

C. Ils réduisent la calciurie.

D. Inhibent le cotransporteur $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{2Cl}^-$ au niveau de la branche ascendante de Henlé.

E. Ils entraînent une hyperkaliémie.

Q 6- Quels sont les facteurs favorisant une poussée d'insuffisance cardiaque (la ou les RJ)

- A. Une infection broncho-pulmonaire
- B. Une intervention chirurgicale abdominale
- C. Une anémie
- D. Un écart de régime
- E. Un trouble du rythme

Q7- Quelle est la conduite à tenir devant une tamponnade ? (la ou les RJ)

- A. Réhydratation
- B. Chirurgie cardiaque en urgence
- C. Oxygénation nasale
- D. Ponction péricardique
- E. Remplissage par macromolécules

Q 8. Dans quelle classe se situe le furosémide ? (R)

- A. Antidiabétiques
- B. Diurétiques agissant sur les canaux glucosodiques du tube contourné proximal
- C. Épargneurs de potassium
- D. Traitement de fond de l'insuffisance cardiaque à FE réduite seule.
- E. AB justes

Q 9. La cardiomyopathie hypertrophique : (R)

- A. Peut entraîner une obstruction à l'éjection VG
- B. Nécessite sa mise sous B bloquants si obstructive
- C. N'a aucune relation avec l'HTA
- D. Peut entraîner une Insuffisance cardiaque
- E. A toujours un caractère familial

Q 10. La gravité d'une embolie pulmonaire est reflétée par (cochez la ou les bonnes réponses) :

- A. Les D dimères
- B. La saturation en oxygène
- C. Le dosage des troponines et des peptides natriurétiques
- D. Le Score PESI.
- E. La dysfonction du ventricule droit à l'échocardiographie.

Q 11 : Les signes électriques d'une embolie pulmonaire : (R)

- A. Troubles du rythme supra ventriculaire
- B. Sous-décalage du PQ
- C. Bloc de branche droit
- D. Aspect S1Q3
- E. Des ondes T négatives en V1

Q12; Chez un patient de 35 ans sans contre-indication à l'anticoagulation, le choix de prothèse le plus approprié est : (R)

- A. Prothèse biologique
- B. Prothèse mécanique
- C. Homogreffe
- D. Valvuloplastie
- E. Aucune de ces réponses

Q13 : Parmi les examens de surveillance immédiate après angioplastie, on réalise systématiquement :

- A. Un ECG de contrôle
- B. Une IRM cardiaque
- C. Un test d'effort
- D. Aucun examen si le patient est stable et asymptomatique
- E. Troponines

Q14: L'élévation du LDL-cholestérol au-dessus de 70 mg/dL (1,8 mmol/L) après angioplastie traduit : (RJ)

- A. Un objectif thérapeutique atteint
- B. Un risque faible de récurrence
- C. Une situation tolérable chez le sujet âgé
- D. Une indication à intensifier le traitement par statine
- E. Le LDL ne figure pas comme cible après angioplastie

Q15 : Chez un patient de 45 ans, opéré pour rétrécissement aortique serré, sans contre-indication à l'anticoagulation, quelle prothèse est la plus indiquée ? (RJ)

- A. Prothèse biologique, car moins thrombogène
- B. Prothèse mécanique, pour sa durabilité supérieure
- C. Homogreffe aortique, pour éviter l'anticoagulation
- D. Prothèse biologique, car mieux tolérée hémodynamiquement
- E. TAVI

Q16: Les effets cardiaques des tonicardiaques sont :

- A. Une vasodilatation systémique
- B. Une augmentation de la fréquence cardiaque
- C. Une augmentation de la contractilité myocardique
- D. Une accélération de la conduction auriculo-ventriculaire.
- E. Une augmentation du débit cardiaque

Q17. La digoxine est contre-indiquée en cas de :

- A. Bloc auriculo-ventriculaire complet non appareillé
- B. Fibrillation auriculaire chronique
- C. Insuffisance cardiaque systolique
- D. Flutter auriculaire
- E. Insuffisance cardiaque à FE préservée

Q18: Quel paramètre biologique doit être surveillé régulièrement chez un patient traité par digoxine ?

- A. Glycémie
- B. Kaliémie
- C. Calcémie
- D. Urée seule
- E. Digoxinémie

Q19. Concernant l'hypertension artérielle (HTA) secondaire (RF)

- A. Représente plus de 50 % des HTA chez l'adulte
- B. Concerne environ 5 à 10 % des HTA chez l'adulte
- C. Fréquente chez le sujet jeune
- D. Suspectée devant une hypertension résistante
- E. Nécessite une prise en charge spécialisée

Q20. Toutes les causes suivantes peuvent être responsables d'HTA secondaire, sauf une : (RJ)

- A. Néphropathies parenchymateuses
- B. Hyperaldostérionisme primaire
- C. Intoxication à la rétrovirale
- D. Insuffisance veineuse chronique
- E. Sténose de l'artère rénale

Q21. Mme H.R, âgé de 46 ans, non diabétique, non-fumeur. Pression artérielle en consultation = 135/85 mmHg, bilan biologique normal, SCORE cardiovasculaire faible. Concernant ce patient (RF)

- A. Il s'agit d'une hypertension artérielle
- B. Il s'agit d'une PA élevée
- C. Une MAPA ou une automesure est indiquée pour confirmer le diagnostic
- D. Un traitement médicamenteux n'est pas indiqué d'emblée
- E. La prise en charge repose en première intention sur des mesures hygiéno-diététiques

Q22. La triade « céphalées - sueurs - palpitations » associée à une HTA est en faveur de (RJ):

- A. Coarctation de l'aorte
- B. Adénome de Conn
- C. Phéochromocytome
- D. Sténose des artères rénales
- E. Aucune de ces propositions

Q23. Dans l'hypertension artérielle secondaire, le traitement étiologique est médical dans (RJ)

- A. Coarctation de l'aorte
- B. Adénome de Conn
- C. Phéochromocytome
- D. Sténose des artères rénales
- E. Hyperplasie des surrénales

Q24. Hypotension artérielle orthostatique est définie (RJ)

- 1. Est définie par une chute d'au moins 20 mmHg de la pression systolique lors du passage couché → debout
 - 2. Est définie par une chute d'au moins 20 mmHg de la pression diastolique lors du passage couché → debout
 - 3. Doit systématiquement être recherchée chez le sujet diabétique
 - 4. Doit systématiquement être recherchée chez le sujet âgé sous traitement antihypertenseur
- A. 1, 3, 4 B. 2, 3, 4 C. 1, 2, 4 D. 1, 2, 3 E. 1, 3

Q25. Dans l'hypertension artérielle, l'ECG peut montrer (RF)

- A. Fibrillation auriculaire
- B. Hypertrophie ventriculaire gauche de type systolique
- C. Signes de cardiopathie ischémique
- D. Hypertrophie auriculaire gauche
- E. Hypertrophie ventriculaire gauche de type diastolique

Q26. Hypertension artérielle blouse blanche (RJ)

- A. PA élevée en consultation et normale à domicile
- B. PA normale en consultation et élevée à domicile
- C. PA élevée en consultation et à domicile
- D. Fréquence > 50 %
- E. Aucune de ces propositions

Q27. Dans l'hypertension artérielle, toutes ces classes thérapeutiques entraînent une réduction de la morbi-mortalité cardiovasculaire sauf une. Laquelle ?

- A. Inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC)
- B. Inhibiteurs des récepteurs de l'angiotensine II (ARA II)
- C. Beta-bloquants
- D. Diurétiques thiazidiques
- E. Antihypertenseurs centraux

Q28. Dans l'hypertension artérielle, toutes ces associations sont synergiques sauf une. Laquelle ?

- A. IEC + inhibiteurs calciques
- B. ARA II + inhibiteurs calciques
- C. IEC + ARA II
- D. Beta bloquants + diurétiques
- E. ARA II + diurétiques thiazidique

Q29. La dissection de l'aorte : (RF)

- A. Peut entraîner une tamponnade
- B. Anisophymie et anisotension sont typique de cette situation
- C. L'athérosclérose en est la principale cause.
- D. Il ne faut jamais baisser la Pression artérielle systolique car risque d'hypoperfusion
- E. La maladie de Marfan est à évoquer si morphotype en faveur.

Q30. La dissection de l'aorte : (RF)

- A. L'échocardiographie transoesopahgienne est une des meilleures méthodes diagnostiques
- B. Le scanner cardiaque peut faire le diagnostic
- C. Le voile intimal divise la lumière en vrai et faux chenal
- D. Est toujours de sanction chirurgicale même après passage à la chronicité
- E. Est urgence diagnostique et aucun examen paraclinique ne doit retarder la prise en charge.

Q31. Les signes électriques d'une embolie pulmonaire : (RF)

- A. Troubles du rythme supra ventriculaire
- B. Sous décalage du PQ
- C. Bloc de branche droit
- D. Aspect S1Q3
- E. T négatives en V1V2V3

Q32. La triade de Virchow associe: (RJ multiple)

- A. Lésion pariétale
- B. Cause génétique
- C. Hypercoagulabilité
- D. Stase
- E. Thrombopénie

Q33. La radiographie du thorax en cas d'embolie pulmonaire peut montrer : (RJ multiple)

- A. Hyperclarté localisée
- B. Plages d'opacités non systématisées
- C. Opacité triangulaire à base pleurale
- D. réaction pleurale localisée.
- E. Arc moyen gauche convexe sur sa partie supérieure

Q.34 : En cas de probabilité élevée d'embolie pulmonaire : (R] multiple)

- A. Se passer des D Dimères
- B. Les D Dimères gardent leur place pour le diagnostic
- C. Calculer le risque de choc par le score PESI
- D. Faire une Echocardiographie et des BNP pour évaluer le risque de choc
- E. Commencer le traitement d'emblée

Q35. Chez un patient âgé de 65 ans dont l'auscultation cardiaque était normale deux mois auparavant, on constate devant une dyspnée d'effort durant depuis quelques jours, l'apparition d'un souffle systolique intense dans un contexte par ailleurs normal (pas de fièvre, pas de douleur, ECG normal ...)

Quelle cause doit-on évoquer ?

- A. Endocardite bactérienne
- B. Prolapsus mitral
- C. Rupture de cordage mitral
- D. Infarctus du myocarde
- E. Rupture d'un pilier mitral

Q36. Parmi les mécanismes physiologiques d'augmentation du débit cardiaque lors de la grossesse, une est fausse, laquelle ?

- A. L'hypercontractilité myocardique
- B. La tachycardie
- C. La rétention hydro-sodée
- D. La diminution des résistances artérielles systémiques

L'augmentation de la pression veineuse aux membres inférieurs

Q37-Parmi les médicaments suivants, lequel est autorisé lors d'une® grossesse:

- A. le ramipril (IEC)
- B. L'amiodarone
- C. Le metoprolol (Bbloquant)
- D. La digoxine
- E. Le valsartan (ARA II)

Q 38. Concernant le BBG complet (Cochez la réponse juste)

- A. S'inscrit avec un aspect QS sur les dérivations précordiales antérieures (V1-V3).
- B. S'inscrit avec un aspect RS sur les dérivations précordiales latérales V5-V6.
- C. Nécessite toujours une implantation de pacemaker.
- D. Nécessite l'administration de l'Isuprel en urgence.
- E. Le QRS est < 120 ms.

Q 39. Concernant le bloc auriculo ventriculaire (cochez la réponse juste) :

- A. Il est toujours symptomatique
- B. Il touche exclusivement les sujets âgés
- C. Peut-être causé par certains médicaments comme les bêtabloquants
- D. Nécessitent toujours une implantation de PM.
- E. Toutes les réponses sont fausses.

Q 40. Quelle est la molécule de choix dans la PEC d'un BAV complet secondaire à un SCA

STEMI inférieur (cochez la réponse juste) ;

- A. ISUPREL
- B. ADRENALINE
- C. NORADRENALINE
- D. ATROPINE
- E. SALBUTAMOL.

Examen Cardio G6/ 2026

Q1- (choix unique)

Femme 74 ans, HTA, diabète, dyspnée d'effort + œdèmes discrets. ECG : FA permanente. Echographie : FEVG 58%, pas de valvulopathie sévère.

Parmi les éléments suivants, lequel oriente le plus vers une insuffisance cardiaque à FE préservée plutôt qu'une cause non cardiaque de dyspnée ?

A. FEVG $\geq$ 50% seule

B. Dilatation de l'oreillette gauche + signes de dysfonction diastolique + NTpro BNP à 2540 pg/ml

C. Troponine normale

D. Râles crépitants + ronflants au niveau de l'hémichamp pulmonaire gauche

Radiographie thoracique normale

Q2-(associations)

Devant un OAP cardiogénique (dyspnée brutale, râles, HTA fréquente), quelles mesures sont appropriées en première ligne ?

1. Position assise, monitoring, voie veineuse

2. Ventilation non invasive (CPAP/VNI) si détresse respiratoire

3. Diurétique de l'anse IV si congestion

4. Remplissage vasculaire systématique

5. Vasodilatateur si TA élevée

A.(1,2,3,5) B. (1,2,4) C. (2, 3,4) D. (1,3,4,5) E. (1,2, 5)

Q3-(associations)

Chez un patient avec IC FEVG réduite (HFrEF), quels médicaments peuvent décompenser/aggraver l'IC et doivent être évités ou utilisés avec grande prudence ?

1. AINS (ibuprofène ...)

2. Verapamil (ou diltiazem)

3. Glitazones (pioglitazone)

4. Paracétamol

5. Corticoides à fortes doses au long cours

A.(1,2,3,5) B. (1, 3,4) C. (2, 4, 5) D. (1, 2, 4) E. (4 uniquement)

Q4-(choix unique) Patient avec CMH obstructive symptomatique (dyspnée/angor d'effort) et gradient. Quel traitement est le plus classiquement proposé en première intention ?

A. Dobutamine

B. Bêtabloquant

C. Nitrés au long cours

D. Diurétique à forte dose d'emblée

E. Digoxine

Q5-(associations) Associer chaque vignette au diagnostic le plus probable.

Vignette 1 : Homme 22 ans, sportif, palpitations + syncope. ECG : anomalies en VI-V3.

Épisodes de TV à morphologie type BBG.

Vignette 2 : Femme 35 ans, dyspnée progressive, écho : VG dilaté + FEVG 25%, IM fonctionnelle possible, pas d'HVG.

Diagnostics :

A. DAVD / cardiomyopathie arythmogène

B. CMD (cardiomyopathie dilatée)

C. CMH

A-(1-A;2-B) B. (1-B;2-A) C (1-C:2-+B) D.(1-A;2-C) E.(1-C:2-A)

Q6. La triade de Durozier : (RJ) Choix multiple

A. Typique de la fuite mitrale.

B. Claquement d'ouverture de la mitrale.

C. Signe que la valve mitrale est très calcifiée.

D. Comporte un roulement diastolique.

E. Typique de sténose mitrale qu'elle soit souple ou calcifiée.

Q7. Quels signes électrique et clinique sont pathognomonique d'une péricardite aigue: (RF)
Choix multiple

A. Frottement péricardique.

B. L'alternance électrique.

C. Le sous décalage du segment PQ

D. Le sus-décalage de ST diffus et concave vers le haut.

E. La vibration péricardique.

Q8. Les complications possibles d'une péricardite tuberculeuse (RF)

A. La récurrence.

B. La tamponnade.

C. La forme constrictive.

D. L'hypertension portale.

E La forme purulente.

Q9. Quel est le principal paramètre d'évaluation clinique d'une insuffisance cardiaque : (RJ)

A. La classification de la NYHA.

B. L'étiologie sous-jacente.

C. Le facteur précipitant.

D. Par le degré de congestion.

E. La fraction d'éjection.

Q10. Quels éléments orientent vers une insuffisance mitrale aigue ?

1. Installation brutale

2. Œdème aigu pulmonaire

3. VG dilaté

4. Contexte infectieux

5. Souffle toujours intense

A. 1+2 B. 1+2+4 C. 2+3 D. 1+4 E. 3+5

Q11 : Quels éléments sont compatibles avec une insuffisance mitrale fonctionnelle ?

1. VG dilaté
 2. Altération de la FEVG
 3. Feuillet normaux
 4. Excès de tissu valvulaire
 5. Remodelage ventriculaire
- A. 1+2 B. 1+2+3-5 C. 2+4 D. 1+3 E. 3+4

Q 12: Lors de l'auscultation d'un rétrécissement mitral, quels signes retrouve-t-on ?

1. Souffle diastolique latéro-sternal gauche
 2. Troisième bruit
 3. Claquement d'ouverture
 4. Diminution du B1
 5. Roulement diastolique de pointe
- A. 3+5 B. 1+3 C. 2+4 D. 1+5 E. 4+5

Q13. Un patient fébrile présente un OAP avec souffle systolique apex récent. Quels diagnostics évoquer ?

1. Endocardite compliquée
 2. IM aigue
 3. RM serré
 4. Rupture de cordage
 5. IM fonctionnelle chronique
- A. 1+2 B. 1+2+4 C. 2+3 D. 3+5 E. 1+5

Q14. Concernant l'anticoagulation dans le rétrécissement mitral :

1. Les anticoagulants oraux directs (AOD) sont indiqués en première intention
 2. Les antivitamines K (AVK) sont le traitement de référence
 3. La cible d'INR est entre 2 et 3 v
 4. L'anticoagulation est indiquée en cas de fibrillation atriale
 5. L'aspirine seule est suffisante pour prévenir le risque embolique
- A. 1+3 B. 2+3+4 C. 1+4 D. 2+5 E. 3+5

Q15. Un des éléments suivants doit faire suspecter un abcès septal dans l'endocardite : (RJ)

- A. Persistance de la fièvre.
- B. Persistance d'une hyper leucocytose
- C. CRP élevée
- D. Une fuite aortique
- E. Un Bloc auriculo ventriculaire a l'ECG.

Q16. L'examen de première intention devant la suspicion de l'AOMI est : (RJ)

- A. Angio-IRM
- B. Echodoppler veineux des membres inférieurs
- C. IPS
- D. Artériographie
- E. Rigidité du pouls

Q17. Les digitaliques sont définis comme :(RJ)

- A. Des médicaments inotropes négatifs
- B. Des médicaments augmentant la contractilité myocardique
- C. Des médicaments augmentant fortement la consommation d'oxygène du myocarde d
- D. Des médicaments uniquement antiarythmiques
- E. Des vasodilatateurs périphériques

Q18. La digoxine agit principalement par : Choix multiple

- A. Inhibition de la Na^+/K^+ ATPase
- B. Augmentation du sodium intracellulaire
- C. Diminution du calcium intracellulaire
- D. Augmentation du calcium intracellulaire-
- E. Inhibition des canaux sodiques rapides

Q19. Parmi les contre-indications des digitaliques : Choix multiple

- A. Bloc auriculo-ventriculaire du 2^e ou 3^e degré
- B. Syndrome de WPW
- C. Hypokaliémie
- D. Cardiomyopathie hypertrophique obstructive
- E. Insuffisance rénale sévère

Q20. Les signes de toxicité digitalique peuvent inclure : Choix multiple

- A. Extrasystoles
- B. Troubles digestifs
- C. Vision jaune ou verte
- D. Tachycardie sinusale isolée
- E. Confusion

Q21. La surveillance d'un patient sous Digoxine comprend : Choix multiple

- A. ECG
- B. Kaliémie
- C. Fonction rénale
- D. Digoxinémie
- E. Glycémie

Q22. Le traitement spécifique de l'intoxication digitalique grave est : (RJ)

- A. Atropine
- B. Lidocaine
- C. Digibind (anticorps anti-digoxine)
- D. Bétabloquants
- E. Vérapamil

Q23. Parmi ces molécules, laquelle ne fait pas partie du traitement des symptômes du syndrome coronaire chronique : (RJ)

- A. Diltiazem
- B. Molsidomine
- C. Ramipril
- D. Vérapamil
- E. Les B-bloqueurs

Q24. Chez un patient de 85ans sans contre-indication à l'anticoagulation présentant une sténose aortique serrée, le traitement est: (RJ)

- A. Prothèse biologique par voie chirurgicale.
- B. Prothèse mécanique par voie chirurgicale
- C. Homogreffe.
- D. Valvuloplastie.
- E. Une implantation par cathétérisme d'un TAVI.

Q 25: Quels sont les facteurs favorisant une poussée d'insuffisance cardiaque (indiquer la ou les RJ)

- A. Une infection broncho-pulmonaire
- B. Une intervention chirurgicale abdominale
- C. Une anémie
- D. Un écart de régime
- E. Un trouble du rythme

Q26 : Quel est l'élément sémiologique qui permet d'affirmer l'origine cardiaque d'une hépatomégalie (RJ)

- A. Œdème des membres inférieurs
- B. Ascite
- C. Reflux hépato jugulaire
- D. Caractère douloureux
- E. Circulation collatérale

Q 27. Des diurétiques: (RJ)

- A- Les thiazidiques restent efficaces en cas d'insuffisance rénale sévère.
- B- Les thiazidiques provoquent une hyperkaliémie et une acidose métabolique.
- C- Les anti aldostérone entraînent une alcalose métabolique et une hypokaliémie
- D- Les anti aldostérone sont théoriquement contre indiqués en cas d'insuffisance rénale sévère.
- E- Les thiazidiques font partie du traitement de fond de l'insuffisance cardiaque.

Q 28: Parmi les propositions concernant les troubles de conduction, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?

- A. Un bloc auriculo-ventriculaire I (BAV I) peut être responsable d'une syncope.
- B. Dans un BAV III, le rythme auriculaire et le rythme ventriculaire sont réguliers.
- C. Dans le BAV II type Mobitz II, l'espace PR s'allonge progressivement avant que l'onde P ne soit bloquée.
- D. La présence d'un bloc de branche gauche doit faire rechercher une cardiopathie sous-jacente
- E. Dans le BSA III, il y a plus d'ondes P bloquées que conduites.

Q29. Concernant les communications inter-atriales, cochez la ou les réponse(s) juste (s)

- A- Elle peut être secondaire à un defect au niveau du septum membraneux
- B- Elle peut être secondaire à un defect au niveau du septum secundum
- C- La fermeture chirurgicale est indiquée si le rapport de débit est égal à 1
- D- La fermeture percutanée est une option thérapeutique
- E- Elle est en général bien tolérée à la naissance

Q30. A propos des cardiopathies congénitales avec shunt "gauche -droite" isolé, cochez la ou les réponse(s) juste (s)

- A- La complication commune et la plus redoutable est une insuffisance cardiaque gauche
- B- La complication commune et la plus redoutable est une augmentation irréversible des résistances artérielle pulmonaire
- C- La cyanose est présente dès la naissance
- D- L'inversion du shunt s'installe à la naissance
- E- La tolérance clinique dépend du débit du shunt

Q31. Parmi les complications des cardiopathies congénitales, laquelle est observé uniquement dans les shunts "droite -gauche"

- A- L'endocardite infectieuse
- B- les accidents thrombo-emboliques
- C- les abcès du cerveau
- D- le syndrome d'EISENMENGERY
- E. Polyglobulie

Q32. Concernant la persistance du canal artériel à gros débit : cocher la réponse juste

- A- il s'agit d'un shunt "droite -gauche"
- B- Il est de découverte fortuite dans l'enfance
- C- Le téléthorax objective une cardiomégalie avec une vascularisation normale
- D- L'ECG révèle un axe droit avec bloc incomplet droit
- E- L'évolution se fait vers le syndrome d'EISENMENGER

Q33. Parmi ces cardiopathies congénitales, laquelle donne une cyanose

- A-communication inter-ventriculaire
- B-communication inter-atriale
- C-Persistance du canal artériel
- D-Tétralogie de Fallot
- E-Coarctation de l'aorte

Q 34. Quelles sont les complications de la thrombolyse: (RJ)

- A. l'échec
- B. Complications thromboembolique
- C. L'hypertension artérielle
- D. Des complications métaboliques
- E. Saignements graves.

Q 35: L'élévation du LDL-cholestérol au-dessus de 55mg/dl. (1,8 mmol/L) après angioplastie pour infarctus du myocarde traduit: (RJ)

- A. Un objectif thérapeutique atteint
- B. Un risque faible de récurrence
- C. Une situation tolérable chez le sujet Agé
- D. Une indication à intensifier le traitement par statine
- E. Ne doit pas être prise en considération dans la prise en charge.

Q 36 : Chez un patient de 45 ans, opéré pour rétrécissement aortique serré, sans contre-indication à l'anticoagulation, quelle prothèse est la plus indiquée ? (RJ)

- A. Prothèse biologique, car moins thrombogène
- B. Prothèse mécanique, pour sa durabilité supérieure
- C. Homogreffe aortique, pour éviter l'anticoagulation
- D. Prothèse biologique, car mieux tolérée hémodynamiquement
- E. L'implantation d'un TAVI

Q 37: Les signes électriques d'une embolie pulmonaire : (RF)

- A. Troubles du rythme supra ventriculaire
- B. Sous décalage du PQ
- C. Bloc de branche droit v
- D. Aspect S1Q3
- E. Des ondes T négatives en v1v2v3t

Q 38:La dissection de l'aorte : (RF)

- A. L'échocardiographie transoesopahgienne est une des meilleures méthodes diagnostiques
- B. Le scanner cardiaque peut faire le diagnostic
- C. Le voile intimal divise la lumière en vrai et faux chenal
- D. Est toujours de sanction chirurgicale même après passage à la chronicité
- E. La gestion de la Pression artérielle est primordiale

Q 39: Quelle est la complication à long terme de la cardiopathie ischémique (RF)

- A. Insuffisance cardiaque
- B. Troubles du rythme ventriculaire graves
- C. Endocardite infectieuse
- D. Récidive.
- E. La survenue d'autres évènements cardiovasculaires graves.

Q40: Quels sont les facteurs de risque cardiovasculaires modifiables: (la ou les RJ)

- A. Le tabagisme
- B. Le sexe
- C. Le diabète
- D. L'âge
- E. L'HTA

Examen Gastroentérologie P1 / 2026

1/ Le carre de MONDOR est constitué de : les RJ

- A/ Douleurs abdominales.
- B/ Niveaux hydro-aériques à l'ASP.
- C/ Arrêt des matières et de gaz.
- D/ Vomissements.
- E/ Météorisme abdominal.

2/ La strangulation dans les occlusions intestinales survient par : Les RJ

- A/ Une bride.
- B/ Un volvulus.
- C/ Une tumeur.
- D/ Un corps étranger intra-luminal.
- E/ Une invagination intestinale.

3/ Dans les occlusions greliques, les niveaux hydro-aériques sont : Les RJ

- A/ Centraux.
- B/ Plus larges que hauts.
- C/ Plus hauts que larges.
- D/ Souvent nombreux.
- E/ Peu nombreux.

4/ Le scanner abdominal avec injection du PDC iode dans les occlusions intestinales aigues a pour objectif : Les RJ

- A/ Étiologique et thérapeutique.
- B/ La confirmation de l'occlusion.
- C/ Donner le siège de l'occlusion.
- D/ Objectiver l'étiologie de l'occlusion.
- E/ Apprécier le suivi évolutif des images radiologiques.

5/ Concernant l'épidémiologie du kyste hydatique, quelle est la réponse fausse ?

- A/ L'agent causal est le *tænia echinococcus granulosus*.
- B/ Le *tænia* possède une tête ou scolex munie de crochets qui s'incruster au niveau des villosités de l'intestin du chien.
- C/ L'homme se contamine en mangeant la viande du mouton.
- D/ Les œufs du *tænia* sont des embryons hexacanthés très résistants.
- E/ Ces œufs éliminés avec les déjections du chien vont être ingérés par les moutons qui feront hôte intermédiaire.

6/ Les mécanismes physiopathologiques impliqués dans la diverticulose colique compliquée : (une ou plusieurs réponses justes)

- A/ Une hyperpression intra-luminale colique.
- B/ Une faiblesse de la musculature au niveau des vasa recta.
- C/ Une inflammation initiale de la muqueuse colique.
- D/ Une altération de la motricité colique.
- E/ Une origine congénitale dans la majorité des cas.

7/ Dans le cancer gastrique, le syndrome obstructif s'exprime par les symptômes suivants :

- A/ Des epigastalgies.
- B/ Des vomissements.
- C/ Une hémorragie digestive.
- D/ Une dysphagie.
- E/ Toutes les réponses sont justes.

8/ Pour le cancer gastrique, en endoscopie, certains diagnostics peuvent se discuter :

Cochez la réponse fausse

- A/ Ulcère duodéal.
- B/ Lymphome.
- C/ Tumeurs carcinoïdes.
- D/ Localisations gastriques d'un autre cancer.
- E/ Tout type histologique malin.

9/ Dans les ulcères hémorragiques de la face postérieure du premier duodénum, le vaisseau le plus souvent responsable du saignement est :

- A/ Artère hépatique moyenne.
- B/ Artère pylorique.
- C/ Artère gastroduodénale.
- D/ Artère pancréatico-duodenale inférieure.
- E/ Aucune artère des artères citées.

10/ En présence d'une hématomèse grave par ulcère duodéal, l'importance de l'hémorragie sera au mieux appréciée par : cochez la réponse juste

- A/ La quantité de sang rejeté.
- B/ L'importance de la quantité de sang nécessaire pour rétablir et maintenir une tension correcte.
- C/ L'agitation du sujet.
- D/ Le choc.
- E/ Toutes les réponses sont justes.

11/ Dans l'ulcère duodéal hémorragique, l'indication d'un traitement chirurgical doit être posée dans plusieurs cas suivants. Lesquels ?

- A/ Hémorragie massive.
- B/ Collapsus mal contrôlé par le traitement médical.
- C/ Récidive de l'hémorragie au cours du traitement médical.
- D/ Hémorragie de moyenne abondance révélant la maladie ulcéreuse.
- E/ Toutes les propositions.

12/ La cholécystite aigue : cochez les réponses fausses

- A/ Impose une intervention d'urgence.
- B/ Est traitée par cathétérisme rétrograde de la papille.
- C/ Est la cause de toutes les douleurs biliaires.
- D/ Est généralement d'origine lithiasique.
- E/ Provoque une défense de l'hypochondre droit.

13/ Une microlithiasie vésiculaire symptomatique peut : Cochez les réponses justes

- A/ Être une indication chirurgicale.
- B/ Être une cause de pancréatite aiguë.
- C/ Être d'origine hémolytique.
- D/ Être parfois méconnue à l'échographie.
- E/ Toutes les réponses sont justes.

14/ Parmi les propositions suivantes, citer celle qui est le plus souvent responsable d'une pancréatite aigue dans notre pays

- A/ Alcool.
- B/ Lithiasie biliaire.
- C/ Obésité.
- D/ Clofibrate.
- E/ Hyperparathyroïdie

15/ Parmi les signes cliniques suivants, quel est le seul permettant au cours d'une cholécystite aigue de suspecter une lithiasie de la voie biliaire principale ?

- A/ Grosse vésicule.
- B/ Fièvre
- C/ Ictère.
- D/ Douleur provoquée de l'hypochondre droit.
- E/ Aucune réponse n'est juste.

16/ Parmi les propositions suivantes, la cholécystite aigue lithiasique est : Citez celle qui est fausse

- A/ Peut être liée à l'enclavement d'un calcul au niveau de l'infundibulum vésiculaire.
- B/ Peut être associée à une lithiasie cholédocienne.
- C/ Survient préférentiellement chez la femme.
- D/ Se manifeste cliniquement par un signe de Murphy qui correspond à une grosse vésicule palpable.
- E/ Complication très fréquente.

17/ Une grosse vésicule peut être palpée lors : cochez les réponses justes

- A/ D'un cancer du pancréas.
- B/ D'un cancer localisé au hile hépatique.
- C/ D'une cholécystite chronique lithiasique sclero-atrophique.
- D/ D'un enclavement calculeux dans le collet vésiculaire.
- E/ Toutes les réponses sont justes.

18/ Cancer de l'œsophage : cocher la réponse fausse

- A/ Tabac et alcool sont 2 facteurs de risque principaux du cancer épidermoïde.
- B/ Reflux gastro-œsophagien et obésité sont 2 facteurs de risque de l'adénocarcinome.
- C/ L'endobrachy-oesophage (EBO) est une lésion précancéreuse de l'adénocarcinome.
- D/ La survie globale du cancer de l'œsophage est aujourd'hui d'environ 40% à 5 ans.
- E/ Est un cancer de mauvais pronostic.

19/ Cancer de l'œsophage : cochez les réponses fausses

A/ La dysphagie élective pour les liquides est le maître symptôme.

B/ Le diagnostic repose sur l'endoscopie avec biopsies.

C/ Le traitement endoscopique curatif est réservé à certaines petites tumeurs superficielles.

D/ La radiochimiothérapie exclusive est indiquée dans les tumeurs localement avancées stade II.

E/ Toutes les réponses sont fausses.

20/ Le carcinome épidermoïde est : RJ

A/ À différenciation glandulaire.

B/ Peut se voir sur toute la hauteur de l'œsophage.

C/ Est rare au niveau de l'œsophage.

D/ Une prolifération méenchymateuse

E/ Se développe sur une métaplasie intestinale.

21/ L'adénocarcinome de l'œsophage : RJ

A/ Est une tumeur bénigne.

B/ Est d'architecture fusocellulaire.

C/ Se développe sur métaplasie malpighienne.

D/ Est de type intestinal le plus souvent.

E/ Est le plus souvent situé au niveau du tiers supérieur de l'œsophage.

22/ L'endobrachyoesophage peut se transformer en : RJ

A/ Carcinome épidermoïde.

B/ Carcinome basocellulaire.

C/ Carcinome sébacé.

D/ Léiomyome.

E/ Adénocarcinome.

23/ Endobrachyœsophage : RF

A/ Est la présence dans le bas œsophage d'une muqueuse de type glandulaire.

B/ Cette muqueuse est le plus souvent de type intestinal.

C/ Peut se transformer en carcinome épidermoïde.

D/ Est dû le plus souvent au reflux gastro-œsophagien.

E/ Est une lésion acquise.

24/ La maladie de Crohn est caractérisée par (RF) :

A/ Un aspect en tuyau d'arrosage.

B/ Une sclerolipomatose.

C/ Des lésions muqueuses continues.

D/ Des ulcérations aphtoïdes et ulcérations en pavés.

E/ Des fissures et fistules.

25/ Chez un patient asymptomatique avec diverticulose colique découverte fortuitement, quelle recommandation initiale est la plus appropriée pour réduire le risque de complications? (Une réponse juste)

- A/ Chirurgie électorale de résection sigmoïdienne.
- B/ Antibiothérapie prophylactique de longue durée.
- C/ Repos strict et régime liquide pendant 7 jours.
- D/ Augmentation progressive des fibres alimentaires et hydratation adéquate.
- E/ Hospitalisation avec hydratation.

26/ La colite ulcéreuse est caractérisée macroscopiquement par : (la réponse juste)

- A/ Un aspect en tuyau d'arrosage.
- B/ Des sténoses.
- C/ Des ulcérations aphtoïdes.
- D/ Des pseudopolypes digitiformes.
- E/ Lésions muqueuses discontinues.

27/ La pancréatite aigue se traduit histologiquement par : la RF

- A/ Remaniements fibreux.
- B/ Congestion vasculaire et thrombose.
- C/ Nécrose épithéliale.
- D/ Lésions de cytotéatonecrose.
- E/ Des remaniements œdémato-inflammatoires.

28/ Les tumeurs bénignes cellulaires du foie, les plus fréquentes sont, sauf une laquelle :

- A/ Hémangiome.
- B/ Hyperplasie nodulaire focale.
- C/ Adénome hépatique.
- D/ Cystadénome.
- E/ Aucune réponse n'est fausse.

29/ Quelle est la tumeur bénigne du foie qui peut se dégénérer : la RJ

- A/ Hémangiome.
- B/ Hyperplasie nodulaire focale.
- C/ Adénome hépatique.
- D/ Kyste biliaire.
- E/ Aucune réponse n'est juste.

30/ Dans les occlusions par obstruction : les réponses justes

- A/ Le début est progressif.
- B/ Les douleurs sont modérées.
- C/ L'existence des signes de souffrance intestinale.
- D/ L'état général est conserve au début.

31/ La prise en charge d'un cancer digestif repose sur : la réponse juste

- A/ La chirurgie.
- B/ L'oncologie médicale.
- C/ La radiothérapie.
- D/ La discussion du dossier en RCP.
- E/ Toutes ces réponses.

32/ Parmi les propositions suivantes laquelle est fausse : (RF)

A/ Le RGO est défini par le passage involontaire et intermittent à travers le cardia d'une partie du contenu gastrique.

B/ Dû à une défaillance anatomique ou fonctionnelle de la barrière anti-reflux.

C/ Le tableau clinique peut se manifester par des signes digestifs typiques ou atypiques extra-digestifs.

D/ Il n'existe pas de complication du reflux gastro-œsophagien.

E/ L'hémorragie digestive constitue une des complications du RGO.

33/ Vous recevez en consultation monsieur M.A âgé de 40 ans, tabagique, obèse avec IMC à 35, adresse par son pneumologue qui le suit depuis 06 mois pour l'apparition d'un asthme.

Dans son histoire de la maladie, on retrouve depuis une année la notion de brûlures retro-sternales ascendantes (pyrosis) et toux nocturne. Quel est votre hypothèse diagnostique ?

La RJ

A/ Hernie hiatale.

B/ Crise d'asthme modérée.

C/ RGO.

D/ Aucune proposition n'est juste.

E/ Toutes les propositions sont justes.

34/ Patient B.N âgée de 55 ans consulte dans le cadre de l'urgence pour douleurs abdominales et une fièvre à 39.5 C évoluant depuis 24 heures. Que devez-vous faire en première intention ? La RJ

A/ Scanner abdominal.

B/ Laparotomie exploratrice.

C/ Abdomen sans préparation (ASP debout).

D/ Interrogatoire minutieux avec un examen clinique complet.

E/ Antalgiques et antipyrétiques.

35/ Examen clinique retrouve une patiente en état général moyen, fébrile à 38C avec une hyperesthésie cutanée, contracture abdominale, météorisme abdominal et un toucher rectal douloureux. L'abdomen sans préparation objective de multiples niveaux hydro-aériques, le scanner abdomino-pelvien retrouve une tumeur du colon gauche occlusive ainsi que du liquide intra-péritonéal de moyenne abondance. D'après les données cliniques et paracliniques, quel diagnostic évoquez-vous ?

A/ Occlusion intestinale sur tumeur colique.

B/ Ascite

C/ Syndrome péritoneo-occlusif.

D/ Toutes les réponses sont justes.

E/ Aucune réponse n'est juste.

36/ Quel est l'élément radiologique qui n'a pas été cité à l'ASP et scanner abdominal ?

A/ Epaissement intestinal.

B/ Pneumopéritoine.

C/ Disparition des ombres du psoas.

D/ Image en double cocarde.

E/ Aucune réponse n'est juste.

37/ Un bilan biologique fait retrouver une hyperleucocytose à 20 000 elts/mm³, un bilan rénal perturbé : créatininémie = 22 / urée = 1.73, troubles ioniques : hypokaliémie (2.02), hyponatrémie (129). Quelles sont les mesures thérapeutiques à entreprendre en première intention ?

- 1) Rééquilibrage hydro-électrolytique.
 - 2) Antibiothérapie à large spectre.
 - 3) Mise en place d'une sonde naso-gastrique.
 - 4) Intubation oro-trachéale.
- A/ (1+2+4) B/ (1+2) C/ (1+2+3) D/ (4) E/ (1+4)

38/ Après des mesures de réanimations intensives, le chirurgien pose l'indication chirurgicale.

Quels sont les principes chirurgicaux lors d'une péritonite aiguë ?

- 1) Prélèvement du liquide pour étude bactériologique.
- 2) Toilette péritonéale abondante.
- 3) Recherche de la cause et son traitement.
- 4) Drainage large.

A/ (1+2+3) B/ (2+3) C/ (1+2+3+4) D/ (1+3) E/ (3+4)

39/ Lors de l'intervention le chirurgien décide de réséquer la tumeur et de rétablir la continuité (suture digestive) avec drainage abdominale. Qu'aurez-vous proposé comme geste chirurgical ? la RJ

- A/ Le même que le chirurgien.
- B/ Une stomie de dérivation.
- C/ Résection + stomie (sans suture digestive).
- D/ Pas de drainage.
- E/ Aucune réponse n'est juste.

40/ A propos du syndrome d'hypertension portale, les manifestations cliniques apparaissent en général lorsque le gradient portosystémique dépasse (choisissez la réponse juste) :

- A/ 5 mmHg.
- B/ 8 mmHg.
- C/ 12 mmHg.
- D/ 15 mmHg.
- E/ 35 mmHg.

41/ Les varices rectales d'HTP résultent d'une communication entre (choisissez la réponse juste) :

- A/ Veine porte et veine azygos.
- B/ Veines hémorroïdales inférieures et veines rénales.
- C/ Système azygos et veine gastrique gauche.
- D/ Veine cave supérieure et veine splénique.
- E/ Veine hémorroïdale supérieure et rectales moyennes et inférieures.

42/ Concernant les mécanismes impliqués dans le syndrome d'HTP, choisissez les réponses justes

A/ Il existe une diminution des résistances vasculaires intrahépatiques, sus ou sous hépatiques.

B/ Il existe une augmentation des résistances vasculaires de la circulation portosystémique.

C/ Il existe une hyperkinésie splanchnique.

D/ Le monoxyde d'azote n'est jamais impliqué.

E/ Toutes les réponses sont justes.

43/ Au cours du syndrome d'HTP, la splénomégalie (choisissez les réponses justes) :

A/ Son volume est corrélé au degré d'HTP.

B/ Est toujours douloureuse.

C/ Peut manquer.

D/ Peut être responsable de thrombopénie.

E/ Toutes les réponses sont justes.

44/ Quel signe Doppler est le plus spécifique d'une hypertension portale avancée (choisissez la réponse juste) ?

A/ Flux hépatopète accéléré.

B/ Flux hépatofuge.

C/ Absence d'ascite.

D/ Réduction du diamètre du tronc porte.

E/ Rétrécissement veineux systématique

45/ Parmi ces propositions concernant les varices gastriques cardio-tuberositaires, laquelle est Juste :

A/ Sont parfois difficiles à diagnostiquer.

B/ Sont présentes dans 90% des HTP.

C/ Ne saignent jamais.

D/ Sont toujours isolées dans l'HTP globale.

E/ Toutes les réponses sont justes.

46/ L'ascite compliquant un syndrome d'HTP est (choisissez les réponses fausses) :

A/ Transsudative si le liquide est infecté.

B/ Toujours transsudative.

C/ Toujours hémorragique.

D/ Parfois associée à un hydrothorax droit.

E/ Indolore.

47/ Selon le consensus BAVENO VII, quel couple de valeurs permet d'exclure une htp cliniquement significative ?

A/ Élasticité ≥ 20 kPa + plaquettes $\leq 150\ 000$.

B/ Élasticité ≤ 15 kPa + plaquettes $\leq 150\ 000$.

C/ Élasticité ≥ 25 kPa + plaquettes $\geq 150\ 000$.

D/ Elasticité ≤ 15 kPa + plaquettes $\geq 150\ 000$.

E/ Elasticité ≥ 15 kPa + plaquettes $\leq 110\ 000$.

48/ Selon le consensus BAVENO VII, les anticoagulants peuvent être prescrits en cas de thrombose porte (choisissez les réponses fausses) :

- A/ Non tumorale datant de moins de 6 mois complète
- B/ Non tumorale datant de plus de 6 mois partielle (< 50%).
- C/ Tumorale datant de moins de 6 mois partielle (>50%).
- D/ Thrombose symptomatique.
- E/ Chez les candidats à la transplantation hépatique.

49/ Selon le consensus BAVENO VII, les anticoagulants oraux directs peuvent être prescrits en cas de thrombose porte (choisissez les réponses justes) :

- A/ Cirrhose Child-Pugh C.
- B/ Thrombose partielle ancienne > 2 ans.
- C/ Cirrhose Child-Pugh A.
- D/ Cirrhose Child-Pugh B avec prudence.
- E/ Toutes les réponses sont justes.

50/ Concernant les manifestations cliniques de l'œsophagite peptique, choisissez la proposition juste

- A/ Plus les symptômes sont intenses, plus les lésions sont sévères.
- B/ Une forte douleur prédit un grade D.
- C/ Les symptômes permettent de prédire la présence d'érosions > 5 mm
- D/ L'absence de symptômes exclut une œsophagite C ou D.
- E/ Il n'existe aucun parallélisme entre symptômes et la gravité des lésions.

51/ Dans la classification de Los Angeles des œsophagites peptiques, le grade C correspond à

- A/ Lésions < 5 mm
- B/ Lésions > 5 mm non confluentes.
- C/ Lésions confluentes entre deux plis mais < 75 % de la circonférence.
- D/ Atteinte > 75 % de la circonférence.
- E/ Métaplasie intestinale associée.

52/ Les biopsies dans l'œsophagite peptique sont systématiques en cas de (choisissez les propositions fausses) :

- A/ Ulcère de l'œsophage.
- B/ RGO simple.
- C/ Suspicion d'endobrachyœsophage.
- D/ Hémorragie digestive.
- E/ Toux chronique avec douleur thoracique.

53/ Quelle complication est la plus typique de l'œsophagite peptique sévère ?

- A/ Dysphonie.
- B/ Sténose œsophagienne.
- C/ Fistule œso-bronchique.
- D/ Diverticule œsophagien.
- E/ Pneumomédiastin spontané.

54/ Au cours des œsophagites, le transit œsogastroduodénal TOGD est utile dans (choisissez la réponse juste) :

- A/ Le diagnostic initial systématique.
- B/ L'œsophagite médicamenteuse.
- C/ L'œsophagite à éosinophiles.
- D/ Le diagnostic de grade A isolé.
- E/ Le bilan de sténose œsophagienne.

55/ Parmi toutes ces hépatites virales, laquelle n'évolue pas vers la cirrhose ?

- A/ Hépatite A.
- B/ Hépatite B.
- C/ Hépatite C.
- D/ Hépatite D.
- E/ Hépatite E.

56/ Au cours de la cholangite biliaire primitive, le bilan immunologique retrouve : (une réponse juste)

- A/ Ac antinucléaires
- B/ Ac anti muscles lisses.
- C/ Ac anti-LKM.
- D/ Ac anti-M2.
- E/ Ac anti-DNA.

57/ Parmi ces signes en rapport avec une hypertension portale, une réponse est fausse, laquelle ?

- A/ Hépatomégalie.
- B/ Splénomégalie.
- C/ Présence de varices œsophagiennes.
- D/ Ascite.
- E/ Ictère.

58/ Parmi ces signes retrouvés au cours de l'insuffisance hépatocellulaire, une réponse est fausse, laquelle ?

- A/ Astérixis
- B/ Erythrose palmaire.
- C/ Angiomes stellaires.
- D/ Ictère.
- E/ Aucune réponse n'est fausse.

59/ Tous ces paramètres font partie de la classification de Child-Pugh sauf un, lequel ?

- A/ Taux d'albumine.
- B/ TP.
- C/ Taux de plaquettes.
- D/ Taux de bilirubine.
- E/ Présence d'ascite.

60/ A partir de quelle quantité, l'ascite devient détectable cliniquement ?

- A/ 2,5 litres.
- B/ 1,5 litres.
- C/ 3 litres.
- D/ 4 litres
- E/ Aucune proposition.

61/ La lithiasie biliaire est définie par : (RJ)

- a/ Les calculs peuvent siéger dans la vésicule biliaire.
- b/ La présence d'un ou plusieurs calculs dans les voies biliaires.
- c/ Dans les voies biliaires intrahépatiques
- d/ Dans la voie biliaire principale (VBP)
- e/ Toutes les réponses sont justes.

62/ Le calcul cholesterique est du : (RF)

- a/ Augmentation de la motricité de la vésicule biliaire.
- b/ Favorisé par les grossesses, obésité.
- c/ Sursaturation de la bile en cholestérol.
- d/ Phénomènes de cristallisation du cholestérol.
- e/ Favorise par l'insulino-resistance et l'amaigrissement rapide.

63/ Les indications de cholecystectomie dans LB asymptomatique

- a/ Drépanocytose.
- b/ Séjour prolongé dans une région avec prise en charge sanitaire facile d'accès.
- c/ Diabète sévère (afin d'éviter d'éventuelles complications infectieuses).
- d/ Vésicule calcifiée ou « porcelaine ».
- e/ Chez ces patients à haut risque.

64/ Parmi les signes physiques dans la cholécystite aigue lithiasique (CAL) (RF) :

- a/ Douleur intense provoquée par la palpation de l'HCD (hypochondre droit) ; qui inhibe l'inspiration profonde : MURPHY +
- b/ Défense pariétale localisée.
- c/ Grosse vésicule palpable (si pyocholécyste).
- d/ T° > 38,5 +/- frissons ; tachycardie ; langue saburrale ;
- e/ Présence d'ictère.

65/ Les signes échographiques dans la CAL (RF) :

- a/ Permet la confirmation du diagnostic de la cholécystite dans 99%.
- b/ Murphy échographique.
- c/ Epaissement de la paroi vésiculaire ≥ 3 mm +++.
- d/ Aspect feuilleté de la paroi.
- e/ Présence de calcul enclavé dans le jabot.

66/ Parmi les complications de la CAL sont (RF) :

- a/ La péritonite biliaire.
- b/ L'hydrocholécyste.
- c/ La cholécystite suppurée.
- d/ Les fistules bilio-digestives.
- e/ La cholécystite gangréneuse.

67/ Dans la cholécystite aigue de gravité modérée (grade 2 TG 2018) (RF)

- a/ Élévation des globules blancs ($> 18\,000/\text{mm}^3$).
- b/ Masse palpable dans l'hypochondre droit.
- c/ Durée des signes clinique de 72 h.
- d/ Péritonite biliaire localisée, abcès perivesiculaire.

e/ Toutes ces réponses sont justes.

68/ Pour le diagnostic de l'angiocholite, il faut au moins un de ces signes (RF)

- a/ A1 : fièvre $> 38^\circ$.
- b/ A2 : CRP élevée, GB < 4000 .
- c/ B1 : ictère.

d/ B2 : dilatation des voies biliaires.

e/ C1 : obstacle visible (exp : calcul).

69/ Le traitement de l'angiocholite (RF)

a/ Le drainage se fait dans les 96h si pancréatite aigue associée.

b/ Antibiothérapie et drainage après.

c/ Soit une sphincterotomie endoscopique (SE), puis cholécystectomie laparoscopique (CL).

d/ Soit une SE + CL en même temps.

e/ Soit drainage chirurgicale.

70/ Parmi les signes de gravite de la pancréatite aigue (RF)

a/ SIRS : ≥ 1 critère.

b/ GB > 12000 ou < 4000 , $T^\circ > 38$ < 36 .

c/ FR > 20 ou $\text{PCO}_2 < 32$ mmHg, FC > 90

d/ Réponse au SIRS 24-48H.

e/ Urée > 170 mmol/L, Score CTSI (classification scanographique).

71/ Le diagnostic d'une hépatite virale aigue B repose sur : (Cochez l'association juste)

1. Antigène HBs positif.
2. Anticorps anti-HBc négatifs.
3. Anticorps anti-HBc positif de type IgM.
4. Anticorps anti-HBc positifs de type IgG
5. Anticorps anti-HBs positifs de type IgM.

A/(1+2) B/(1+3) C/(1+4) D/(3+5) E/(1+5)

72/ Concernant l'hépatite aigue virale A : (Cochez la réponse fausse)

A/ Peut être révélée par un ictère cutanéomuqueux qui peut durer jusqu'à 3 à 4 semaines.

B/ Est diagnostiquée par la présence des IgM anti-VHA.

C/ Est fréquente en milieux défavorisés.

D/ Est transmise par voie sanguine.

E/ Peut se compliquer d'une hépatite fulminante.

73/ Quels sont les principaux facteurs qui peuvent déterminer une hépatite fulminante : (Cochez l'association juste)

1. Un syndrome de cytolyse avec ALAT et ASAT supérieur à 10 fois la normale.
2. Un syndrome de cholestase icterique.
3. Un TP inférieur à 50 %
4. Un TP inférieur à 70 %.
5. Une encéphalopathie hépatique.

A/ (1+3) B/ (1+4) C/ (3+5) D/ (1+5) E/(4+5)

74/ Devant une augmentation des transaminases évoluant depuis plus de 06 mois, quels marqueur(s) sérologique(s) demandez-vous en premier intention : (Cochez l'association juste)

1. Antigène HBs.
2. Anticorps anti-VHC.
3. IgM anti-VHA.
4. Sérologie du virus d'Epstein Barr.
5. Anticorps anti-VHE.

A/ (1+2) B/(1+2+4) C/(4+5) D/(1+3+5) E/(3+4)

75/ Concernant l'infection par le virus de l'hépatite C : (Cochez la réponse fausse)

- A/ Elle est le plus souvent symptomatique.
- B/ L'apparition d'un carcinome hépatocellulaire est rare chez un patient VHC non cirrhotique.
- C/ La transmission est le plus souvent par voie parentérale.
- D/ Est souvent diagnostiquée au stade de l'hépatite chronique.
- E/ L'infection chronique se définit par l'ARN du VHC qui reste positif dans le sang après 6 mois.

76/ Une hernie hiatale par glissement (type I) correspond à :

- A/ Une ascension isolée du fundus gastrique.
- B/ Une ascension du cardia au-dessus du diaphragme.
- C/ Une rotation de l'estomac dans l'abdomen.
- D/ Un déplacement du côlon transverse dans le thorax.
- E/ Une malposition du foie.

77/ Concernant la hernie hiatale par glissement, toutes les propositions suivantes sont exactes SAUF

- A/ Elle représente la forme la plus fréquente.
- B/ La jonction œsogastrique migre au-dessus du diaphragme.
- C/ Elle est fréquemment associée à un reflux gastro-œsophagien.
- D/ Elle expose davantage au risque de strangulation aigue.
- E/ Elle peut être asymptomatique.

78/ La hernie hiatale est définie par : RJ

- A/ La protrusion de l'estomac à travers la paroi abdominale antérieure.
- B/ Le passage d'organes abdominaux à travers l'orifice œsophagien du diaphragme.
- C/ La hernie exclusive du fundus gastrique.
- D/ Une anomalie congénitale toujours symptomatique.
- E/ Une pathologie strictement chirurgicale.

79/ Le principe fondamental du traitement chirurgical de la hernie hiatale est :

A/ La résection gastrique.

B/ La vagotomie tronculaire.

C/ La réduction, la fermeture du hiatus et la fundoplicature.

D/ La mise en place d'une prothèse gastrique.

E/ La gastrostomie de décharge.

80/ Quel symptôme est le plus fréquemment rapporté dans les hernies hiatales par glissement ?

A/ Reflux gastro-œsophagien.

B/ Ictère.

C/ Hémoptysie.

D/ Rectorragie.

E/ Constipation.

Examen Gastroentérologie P2 / 2026

- 1) La péritonite aiguë par perforation d'ulcère : (La RF)
 - A. Complicque plus souvent l'ulcère de la face antérieure du bulbe
 - B. La fièvre est un signe précoce
 - C. Une défense ou contracture abdominale sont fréquemment retrouvées à l'examen clinique
 - D. Des niveaux hydro-aériques peuvent être retrouvés à l'ASP
 - E. Le toucher rectal est douloureux
- 2) Les tumeurs bénignes cellulaires du foie, les plus fréquentes sont, sauf une laquelle :
 - A. Hémangiome
 - B. Hyperplasie nodulaire focale
 - C. Adénome hépatique
 - D. Cystadénome
 - E. Aucune réponse n'est fausse
- 3) Quelle est la tumeur bénigne du foie qui peut se dégénérer : (La RJ)
 - A. Hémangiome
 - B. Hyperplasie nodulaire focale
 - C. Adénome hépatique
 - D. Kyste biliaire
 - E. Aucune réponse n'est juste
- 4) Le carré de MONDOR est constitué de : (Les RJ)
 - A. Douleurs abdominales.
 - B. Niveaux hydro-aériques à l'ASP.
 - C. Arrêt des matières et de gaz.
 - D. Vomissements.
 - E. Météorisme abdominal.
- 5) La strangulation dans les occlusions intestinales survient par : (Les RJ)
 - A. Une bride.
 - B. Un volvulus.
 - C. Une tumeur.
 - D. Un corps étranger intra-luminal.
 - E. Une invagination intestinale.
-) Dans les occlusions greliques, les niveaux hydro-aériques sont : (Les RJ)
 - A. Centraux
 - B. Plus larges que hauts.
 - C. Plus hauts que larges.
 - D. Souvent nombreux.
 - E. Peu nombreux.
- 7) Les mécanismes physiopathologiques impliqués dans la diverticulose colique comprennent: (Les RJ)
 - A. Une hyperpression intra-luminale colique
 - B. Une faiblesse de la musculature au niveau des vasa recta
 - C. Une inflammation initiale de la muqueuse colique
 - D. Une accélération de la motricité colique
 - E. Une origine congénitale dans la majorité des cas

8) Dans le cancer gastrique, le syndrome obstructif s'exprime par les symptômes suivants:RJ

- A. Epigastralgies
- B. Vomissements
- C. Hémorragie digestive
- D. Dysphagie
- E. Toutes les réponses sont justes

9) Cancer de l'œsophage : (La RF)

- A. Tabac et alcool sont 2 facteurs de risque principaux du cancer épidermoïde
- B. Reflux gastro-œsophagien et obésité sont 2 facteurs de risque de l'adénocarcinome
- C. L'endobrachy-œsophage (EBO) est une lésion précancéreuse de l'adénocarcinome
- D. La survie globale du cancer de l'œsophage est aujourd'hui d'environ 40 % à 5 ans
- E. Est un cancer de mauvais pronostic

10) Le carcinome épidermoïde est : (La RJ)

- A. A différenciation glandulaire
- B. Peut se voir sur toute la hauteur de l'œsophage
- C. Est rare au niveau de l'œsophage
- D. Une prolifération mésoenchymateuse
- E. Se développe sur une métaplasie intestinale

11) L'adénocarcinome de l'œsophage : (La RJ)

- A. Est une tumeur bénigne
- B. Est d'architecture fusocellulaire
- C. Se développe sur métaplasie malpighienne
- D. Est de type intestinal le plus souvent
- E. Est le plus souvent situé au niveau du tiers supérieur de l'œsophage

12) L'ascite compliquant un syndrome d'HTP est : (Les RF)

- A. Transsudative si le liquide est infecté.
- B. Toujours transsudative.
- C. Toujours hémorragique.
- D. Parfois associée à un hydrothorax droit.
- E. Indolore.

13) Dans les ulcères hémorragiques de la face postérieure du premier duodénum, le vaisseau le plus souvent responsable du saignement est : (La RJ)

- A. Artère hépatique moyenne
- B. Artère pylorique
- C. Artère gastroduodénale
- D. Artère pancréatico-duodénale inférieure
- E. Aucune artère des artères citées

14) A propos du syndrome d'hypertension portale, les manifestations cliniques apparaissent en général lorsque le gradient portosystémique dépasse : (La RJ)

- A. 5 mmHg
- B. 8 mmHg
- C. 12 mmHg
- D. 15 mmHg
- E. 35 mmHg

15) Quels sont les principaux facteurs qui peuvent déterminer une hépatite fulminante : (Cochez l'association juste)

1. Un syndrome de cytolyse avec ALAT et ASAT supérieur à 10 fois la normale
2. Un syndrome de cholestase ictérique
3. Un TP inférieur à 50 %
4. Un TP inférieur à 70 %
5. Une encéphalopathie hépatique

A. (1+3) B. (1+4) C. (3+5) D. (1+5) E. (4+5)

16) Parmi toutes ces hépatites virales, laquelle n'évolue pas vers la cirrhose ? (La RJ)

- A. Hépatite A
- B. Hépatite B
- C. Hépatite C
- D. Hépatite D
- E. Hépatite E

17) Au cours de la cholangite biliaire primitive, le bilan immunologique retrouve : (La RJ)

- A. Ac antinucléaires
- B. Ac anti muscles lisses
- C. Ac anti-LKM
- D. Ac anti-M2
- E. Ac anti-DNA

18) Au cours du syndrome de l'hypertension portale : (La RJ)

- A. Les varices œsophagiennes asymptomatiques nécessitent un traitement préventif.
- B. La classification de Los Angeles concerne les varices rectales.
- C. Le syndrome de Budd Chiari s'accompagne rarement d'HTP.
- D. Le TIPS ne trouve pas sa place dans la prise en charge.
- E. La thrombose veine porte en est la principale étiologie.

19) À partir de quelle quantité, l'ascite devient détectable cliniquement ? (La RJ)

- A. 2,5 litres
- B. 1,5 litres
- C. 3 litres
- D. 4 litres
- E. Aucune proposition

20) La lithiasse biliaire est définie par : (La RJ)

- A. Les calculs peuvent siéger dans la vésicule biliaire
- B. La présence d'un ou plusieurs calculs dans les voies biliaires
- C. Dans les voies biliaires intrahépatiques.
- D. Dans la voie biliaire principale (VBP)
- E. Toutes les réponses sont justes

21) Dans la cholécystite aiguë de gravité modérée (grade 2 Tokyo GL 2018) : (La RJ)

- A. Élévation des globules blancs ($>18\,000/\text{mm}^3$)
3. Masse palpable dans l'hypochondre droit
- C. Durée des signes cliniques de plus de 72 h
- D. Péritonite biliaire localisée, abcès perivésiculaire
- E. Toutes ces réponses sont justes.

22) Le diagnostic d'une hépatite virale aigue B repose sur : (Cochez l'association juste)

1. Antigène HBs positif.
 2. Anticorps anti-HBc négatifs.
 3. Anticorps anti-HBc positif de type IgM
 4. Anticorps anti-HBc positifs de type IgG.
 5. Anticorps anti-HBs positifs de type IgM.
- A. (1+2) B. (1+3) C. (1+4) D. (3+5) E. (1+5)

23) Une hernie hiatale par glissement (type I) correspond à : (La RJ)

- A. Une ascension isolée du fundus gastrique
- B. Une ascension du cardia au-dessus du diaphragme
- C. Une rotation de l'estomac dans l'abdomen
- D. Un déplacement du côlon transverse dans le thorax
- E. Une malposition du foie

24) Concernant la hernie hiatale par glissement : (La RF)

- A. Elle représente la forme la plus fréquente
- B. La jonction œsogastrique migre au-dessus du diaphragme
- C. Elle est fréquemment associée à un reflux gastro-œsophagien
- D. Elle expose davantage au risque de strangulation aigue
- E. Elle peut être asymptomatique

25) Chez une patiente de 32 ans présentant des douleurs abdominales récurrentes et des troubles du transit depuis plus de 6 mois, sans perte de poids, le diagnostic de syndrome de l'intestin irritable (SII) est évoqué. Selon les critères de Rome IV, lequel des éléments suivants est NECESSAIRE pour poser le diagnostic de SII ? (Cochez l'association juste)

1. Une relation temporelle entre les douleurs et la défécation.
2. La présence de ballonnements ou de distension abdominale.
3. Un début des symptômes lié à un changement de fréquence des selles.
4. Un changement de consistance des selles associée aux douleurs.
5. La présence de douleurs abdominales récurrentes, en moyenne au moins 1 jour/semaine depuis 3 mois.

A. (1+5) B. (2+5) C. (3+5) D. (1+2+3+4+5) E. (3+4+5)

26) Quel est le sous-type de dyspepsie fonctionnelle caractérise principalement par une plénitude postprandiale et une satiété précoce ? (La RJ)

- A. Syndrome de douleur épigastrique (EPS).
- B. Syndrome de détresse postprandiale (PDS),
- C. Syndrome d'intestin irritable mixte (IBS-M).
- D. Syndrome de brûlure épigastrique isolée.
- E. Syndrome dyspeptique mixte

27) Chez un patient atteint de tuberculose intestinale, quel est le mécanisme de contamination le plus fréquent ? (La RJ)

- A. Ingestion d'eau contaminée par Mycobacterium bovis.
- B. Dissémination hématogène à partir d'un foyer pulmonaire primaire ou réactivé.
- C. Transmission oro-fécale directe d'un sujet contagieux.
- D. Propagation par contiguïté depuis une tuberculose génitale.
- E. Inhalation de particules en aérosol contaminées.

- 28) Quelle est la localisation anatomique la plus fréquemment atteinte dans la tuberculose intestinale ? (La RJ)
- A. Le jéjunum.
 - B. Le rectum et le sigmoïde.
 - C. L'iléon terminal et la région iléo-caecale.
 - D. L'estomac et le duodénum.
 - E. L'appendice.
- 29) Tous ces aspects endoscopiques sont habituellement retrouvés au cours de la rectocolite hémorragique sauf un ? (La RF)
- A. Atteinte continue sans espaces de muqueuse saine
 - B. Muqueuse congestive et érosive (aspect granité)
 - C. Ulcérations aphthoïdes
 - D. Atteinte rectale constante
 - E. Les lésions sont ascendantes
- 30) Patient âgée de 45 ans aux antécédents familiaux d'un père décédé suite à un cancer du côlon métastatique, la coloscopie révèle la présence d'une centaine de polypes adénomateux de tailles et de formes différentes tapissant toute la surface colique et au moins 25 polypes rectaux ; il s'agit d'une polypose adénomateuse familiale. Le traitement repose sur : (La RJ)
- A. Colectomie totale avec ileostomie définitive
 - B. Colectomie totale avec anastomose iléo-rectale
 - C. Résection endoscopique des polypes et surveillance endoscopique annuelle
 - D. Coloproctectomie totale avec anastomose ileo-anale
 - E. Colectomie totale avec ileostomie et néo réservoir rectal
- 31) Les éléments suivants sont compatibles avec le diagnostic de maladie cœliaque sauf un, lequel ? (La RF)
- A. HLA DQ2 ou DQ8
 - B. Atrophie villositaire et une hyperplasie des cryptes
 - C. Anticorps anti transglutaminases positifs
 - D. Hyperlymphocytose intraépithéliale
 - E. Anticorps anti-enterocytes positifs
- 32) Un syndrome d'insuffisance hépatocellulaire sévère au cours de la cirrhose est défini par: (La RF)
- A. Encéphalopathie hépatique
 - B. Un ictère cutanéomuqueux
 - C. Un taux des ASAT et des ALAT supérieur à 100 fois la normale
 - D. TP bas non corrigé par le test de Koller
 - E. Un taux d'albumine bas

33) Le kyste hydatique stade IV selon la classification de Gharbi pose un problème de diagnostic différentiel avec : (La RJ)

- A. Kyste biliaire
- B. Tumeur hépatique
- C. Hématome
- D. Lithiase intrahépatique
- E. Nodule de régénération sur foie de cirrhose

34) Le kyste hydatique du foie : (La RF)

- A. Est une parasitose due à *Echinococcus granulosus granulosus*
- B. L'homme est un hôte définitif
- C. Une sérologie hydatique négative n'élimine pas le diagnostic
- D. Le type II de Gharbi correspond à un décollement des membranes
- E. Le traitement repose essentiellement sur la chirurgie

35) L'étranglement herniaire : (La RF)

- A. Est irréductible
- B. La douleur reste le symptôme majeur dans ce cas
- C. L'échographie abdominale est l'examen de première intention
- D. Peut s'accompagner d'une nécrose intestinale
- E. Une prise en charge tardive peut mettre en jeu le pronostic vital

36) La perforation d'un ulcère duodénal : (La RF)

- A. Entraîne une douleur abdominale à début brutal
- B. Peut être provoquée par la prise d'antiinflammatoires
- C. Entraîne une contracture abdominale précoce
- D. Peut révéler la maladie ulcéreuse
- E. Le diagnostic est écarté en cas d'absence de pneumopéritoine

37) Le régime sans gluten dans la maladie cœliaque : (La RF)

- 1. Consiste à l'éviction des céréales pathogènes et leurs dérivés
 - 2. L'avoine est délétère
 - 3. Le régime peut être arrêté après amélioration clinique et biologique
 - 4. Est prescrit en cas de syndrome d'hypersensibilité au gluten non cœliaque
 - 5. La régression de l'atrophie villositaire signe la bonne observance du régime
- A. (1+3+5) B. (1+4+5) C. (2+3+5) D. (2+4+5) E. (3+4+5)

38) La recto-colite hémorragique (RCH) ? (La RF)

- A. Est une maladie inflammatoire chronique du côlon qui évolue par poussées
- B. Est caractérisée par atteinte colique continue
- C. La forme grave est diagnostiquée selon les critères modifiés de Truelove et Witts
- D. Le risque de dégénérescence augmente en fonction de la durée et l'étendue de la maladie
- E. Le traitement de fond repose sur une corticothérapie au long cours

39) La maladie de Crohn : (La RF)

- A. Est une atteinte transmurale
- B. Les lésions endoscopiques sont diffuses à tout le colon
- C. L'atteinte ano-périnéale peut précéder l'atteinte intestinale
- D. Peut être associée à des atteintes extra-digestives articulaires et ophtalmiques
- E. La chirurgie est réservée aux formes compliquées et doit être conservatrice

40) Pour évaluer la gravité d'une pancréatite aiguë : association juste

1. La recherche d'un SIRS est simple et fiable
 2. La lipasémie est corrélée à la gravité de la pancréatite
 3. Un scanner de surveillance hebdomadaire doit être réalisé
 4. Le scanner initial doit être réalisé dès l'admission du patient à la recherche de complications
 5. Le score CTSI (CT Severity Index) doit remplacer le score de BALTHAZAR
- A. (1+2) B. (1+5) C. (2+3) D. (2+4) E. (3+4)

41) Quel est le type de métaplasie retrouvée dans l'œsophage de Barrett : (La RJ)

- A. Pavimenteuse
- B. Glandulaire de type fundique
- C. Glandulaire de type intestinal
- D. Respiratoire de type bronchique
- E. Cartilagineuse ou osseuse

42) La tumeur maligne la plus fréquente de l'œsophage est : (La RJ)

- A. Le carcinome épidermoïde
- B. L'adénocarcinome
- C. Le leiomyosarcome
- D. La tumeur stromale
- E. Le lymphome

43) Les caractéristiques histopathologiques de la cholécystite aiguë sont : (La RF)

- A. Congestion
- B. Exsudat fibrinoleucocytaire
- C. Infiltrat inflammatoire riche en PNN
- D. Fibrose
- E. Lésions ischémiques

44) Parmi ces lésions précancéreuses de la vésicule biliaire et des voies biliaires extra-hépatiques, une seule n'a aucune traduction macroscopique laquelle ? (La RF)

- A. Adénome
- B. Néoplasie biliaire intra-épithéliale (BILIN)
- C. Néoplasie papillaire intracholécystique
- D. Néoplasie kystique mucineuse avec néoplasie intra-épithéliale
- E. Néoplasie papillaire intracanalalaire

45) Concernant la maladie de Crohn, quelle est la proposition juste ? (La RJ)

- A. L'atteinte est limitée au colon et au rectum exclusivement.
- B. Les lésions muqueuses sont continues sans intervalle de muqueuse saine.
- C. La présence de granulomes épitheïoïdes géantocellulaires sans nécrose caséuse est un critère histologique évocateur.
- D. L'inflammation est superficielle, limitée à la muqueuse.
- E. Les fistules et sténoses sont absentes dans la maladie de Crohn.

46) Concernant l'adénocarcinome colorectal, quelle est la proposition juste ?

- A. Il représente moins de 50 % des cancers colorectaux.
- B. Un adénocarcinome bien différencié présente moins de 50 % de structures glandulaires.
- C. Les embolies tumorales et engainements perinerveux sont des facteurs histopronostiques.
- D. Le carcinome mucineux est de bon pronostic.
- E. La classification pTNM utilisée est celle de l'OMS 2010.

47) Parmi ces types histologiques du cancer du pancréas quel est celui qui est le plus fréquent?

- A. Carcinome à cellules acineuses
- B. Adénocarcinome canalaire
- C. Cystadénocarcinome séreux
- D. Cystadénocarcinome mucineux
- E. Tumeur pseudopapillaire et solide

Cas clinique 1 :

Vous recevez pendant la garde un patient âgé de 25 ans sans antécédents pathologiques particuliers en dehors d'une hernie inguinale droite dans l'enfance, pour douleurs abdominales avec vomissements. Il a présenté brutalement la veille des épigastralgies associées à des vomissements.

Cette douleur est exacerbée par la marche. Les gaz sont présents.

À l'examen clinique : T 37.8°C, constantes hémodynamiques stables, à la palpation une sensibilité marquée au niveau de la fosse iliaque droite, une douleur provoquée de la FID lors de la manœuvre de décompression de la FIG ; TR : douleur nette à droite

ASP : aérocolie, FNS : GB : 13 000/mm³, Hb : 13.5 g/dl, CRP : 12, bilan rénal sans anomalie.

48) Une tumeur neuroendocrine du pancréas bien différenciée avec un index mitotique à 23 mitoses/10 HPF et un Ki67 à 25 % est gradée :

- A. Tumeur neuroendocrine (TNE) G2
- B. Tumeur neuroendocrine (TNE) G3
- C. Carcinome neuroendocrine à petites cellules
- D. Carcinome neuroendocrine à grandes cellules
- E. Tumeur neuroendocrine (TNE) G1

49) Les métastases hépatiques : (RJ)

- A. Sont les tumeurs malignes hépatiques les moins fréquentes.
- B. Sont souvent de bon pronostic.
- C. Ne sont jamais révélatrices du cancer primitif.
- D. L'étude immunohistochimique n'a aucun intérêt.
- E. Sont dominées par les cancers digestifs et mammaires.

50) Le carcinome hépatocellulaire se présente sous toutes ces formes sauf une, laquelle :

- A. La forme expansive
- B. La forme micronodulaire
- C. La forme infiltrante
- D. La forme mixte
- E. La forme diffuse

51) Quelle est le diagnostic le plus probable ? (La RJ)

- A. Colique néphrétique
- B. Perforation d'ulcère duodénale ou gastrique
- C. Infection urinaire
- D. Appendicite aigue
- E. Pancréatite

Cas clinique 2 :

Un homme de 54 ans aux antécédents de constipation chronique et de trois épisodes de douleurs intenses avec vomissements l'ayant amené à consulter aux urgences les 8 mois précédents l'épisode actuel, se présente aux urgences pour arrêt complet des matières et des gaz évoluant depuis la veille.

À l'examen clinique l'état général est conservé, le pouls est à 90 bat/min ; la TA à 120/70 mm Hg.

L'examen clinique retrouve un abdomen distendu, tympanique à la percussion. Le toucher rectal met en évidence une ampoule rectale vide.

L'ASP retrouve des niveaux hydro-aériques périphériques plus hauts que larges ; l'échographie a été gênée par les gaz. La TDM a mis en évidence un épaissement tumoral sténose de la jonction recto-sigmoïdienne. L'IRM et le coloscanner n'ont pu être faits.

Deux semaines après sa sortie d'hôpital, le patient revient pour des douleurs pelviennes. Il est fébrile à 40°C. L'exploration radiologique faite dans l'urgence retrouve un abcès du Douglas de quelques millimètres à contenu épais avec des spots d'air.

56) Parmi les éléments anamnestiques suivants, lesquels recherchez-vous dans ce contexte (Cochez l'association juste)

- 1. Antécédents familiaux de cancer colorectal ou de polypes
- 2. Antécédents familiaux de cancer gynécologique
- 3. Antécédent personnel de lithiase vésiculaire
- 4. Notion de traumatisme de l'abdomen
- 5. Notion de rectorragies

A. (1+2+4) B. (1+3+5) C. (1+4+5) D. (2+3+4) E. (1+2+5)

57) Quel examen radiologique demandez-vous en première intention devant ce tableau ? (La RJ)

- A. Abdomen debout sans préparation
- B. Echographie abdomino-pelvienne
- C. TDM abdomino-pelvienne
- D. IRM abdomino-pelvienne
- E. Coloscanner

58) Quelle sera votre conduite à tenir ? (La RJ)

- A. Opérer et faire une résection colo-rectale
- B. Opérer et faire une colostomie d'amont sur baguette
- C. Opérer et faire une caecostomie sur sonde
- D. Surveiller et attendre la résolution spontanée de l'occlusion
- E. Débuter une chimiothérapie neoadjuvante

59) Parmi les actions suivantes, lesquelles allez-vous préconiser a votre patient ? (Cochez l'association juste)

1. Des hémocultures
 2. Une ponction écho ou scannoguidée
 3. Une antibiothérapie probabiliste
 4. Une laparotomie
 5. Une laparoscopie
- A. (1+2+3) B. (1+3+4) C. (1+3+5) D. (2+3+5) E. (2+3+4)

60) Quel test de dépistage préconisez-vous chez les apparentés au premier degré ? (La RJ)

- A. Hémoculture à la recherche de sang dans les selles
- B. Test immunologique à la recherche de sang dans les selles
- C. Coloscopie
- D. Coloscanner
- E. Recto-sigmoïdoscopie

Examen Hémato P2/ 2026

1. Dans le lymphome de Burkitt, quel oncogène est surexprime à la suite de la translocation (8; 14) ?
 - A. BCL2
 - B. Cycline D1
 - C. MYC
 - D. RAS
 - E. BCL6
2. Quel est le phénotype immunohistochimique habituel des cellules de Reed-Sternberg dans le lymphome de Hodgkin classique ?
 - A. CD20+, CD3-
 - B. CD30+, CD15+, PAX5+
 - C. CD3+, CD5+, TDT+
 - D. CD20+, CD15-, PAX5-
 - E. CD30+, CD20-, CD4+
3. Quel est l'aspect macroscopique classique d'un ganglion lymphomateux ?
 - A. Aspect mou liquidien
 - B. Aspect plein blanchâtre en chair de poisson
 - C. Aspect hémorragique
 - D. Aspect graisseux
 - E. Aspect calcifié
4. Les télomères : (RF)
 - A. Sont des séquences dépourvues d'informations génétiques situées à l'extrémité des chromosomes en division
 - B. S'allongent de divis
 - C. Sont allongées grâce à l'activité des télomérases
 - D. Leur allongement par les télomérases est responsable de la survie prolongée des cellules tumorales
 - E. A la fin de leur raccourcissement, la cellule entre en sénescence ou déclenche sa mort programmée par apoptose
5. Les oncogènes ou proto-oncogènes sont des gènes : (RF)
 - A. Qui stimulent la croissance cellulaire
 - B. Actifs en l'absence de toute stimulation physiologique
 - C. La mutation d'un seul allèle est suffisante (gène dominant)
 - D. Qui favorisent la survenue du cancer
 - E. Qui freinent la division cellulaire
6. Les gènes suppresseurs de tumeur ou anti-oncogènes sont des gènes : (RF)
 - A. Qui, lorsqu'ils sont normaux dans la cellule, contribuent à l'élimination des tumeurs
 - B. Qui agissent principalement en phase G1/S
 - C. Qui impliquent une altération des deux allèles (gènes récessifs)
 - D. Qui réparent l'ADN
 - E. Le gène de la protéine P53 et le gène du rétinoblastome Rb en font partie

7. Quel est le mécanisme principal expliquant la majorité des toxicités des chimiothérapies cytotoxiques ? R.J
- A. Activation excessive du système immunitaire
 - B. Inhibition spécifique d'une voie moléculaire tumorale
 - C. Destruction préférentielle des cellules à renouvellement rapide
 - D. Blocage de l'angiogenèse tumorale
 - E. Induction d'une tolérance immunitaire
8. Quelle toxicité est typiquement associée aux agents anti-angiogéniques ? R.J
- A. Alopécie
 - B. Hypertension artérielle
 - C. Mucite
 - D. Hypothyroïdie
 - E. Neuropathie périphérique
9. Quel grade de toxicité correspond à une toxicité sévère nécessitant une prise en charge spécialisée, sans mise en jeu immédiate du pronostic vital ? R.J
- A. Grade 1
 - B. Grade 2
 - C. Grade 3
 - D. Grade 4
 - E. Grade 5
10. La démarche diagnostique d'un cancer : (RF)
- A. Doit commencer par un bon interrogatoire
 - B. Comporte un examen clinique complet et minutieux
 - C. Doit commencer par des examens complémentaires approfondis
 - D. Consiste aussi à rechercher les facteurs de risque
 - E. Doit évaluer l'état général du patient
11. La surveillance d'un patient cancéreux a pour objectif : (RF)
- A. Détecter précocement une récurrence
 - B. Évaluer l'efficacité du traitement
 - C. Prévenir tous les cancers secondaires
 - D. Dépister les toxicités liées aux traitements
 - E. Améliorer la qualité de vie
12. Concernant le suivi biologique : R.J
- 1. La NFS permet de détecter une hématotoxicité
 - 2. Les marqueurs tumoraux suffisent à eux seuls pour diagnostiquer une récurrence
 - 3. La fonction hépatique doit être surveillée sous chimiothérapie
 - 4. L'ionogramme est inutile chez le patient cancéreux
 - 5. La créatinine est importante avant chaque cure de chimiothérapie
- A : 1+2+3 B : 2+3+5 C : 2+4+5 D : 2+3+4 E : 1+3+5

13. Lequel des indicateurs suivants est utilisé dans les études cohortes ?

- A. L'incidence
- B. Le Hazard Ratio
- C. Le risque relatif
- D. La prévalence
- E. L'Odds Ratio

14. La prévalence correspond à :

- A. Le risque de survenue d'une maladie
- B. Le taux de mortalité
- C. Le nombre de nouveaux cas sur une période
- D. Le nombre total de cas à un moment donné
- E. La létalité

15. Cocher la réponse juste

- A. La classification TNM détermine la différenciation tissulaire de la tumeur
- B. pTNM : est une classification clinico-pathologique
- C. Le stade III de la classification TNM définit une tumeur étendue aux organes de voisinage
- D. La lettre T (Tumeur) se réfère toujours à la taille tumorale allant de T0 à T4
- E. Toutes les réponses sont justes

16. Concernant la douleur : (RF)

- A. Motif de consultation exceptionnel en oncologie
- B. Peut-être aiguë ou chronique
- C. D'origine nociceptive ou neuropathique
- D. Le questionnaire DN4 évalue la douleur neuropathique
- E. Peut-être secondaire au traitement oncologique

17. Concernant l'évaluation gériatrique : (RF)

- A. Elle est obligatoire chez un sujet ≥ 70 ans
- B. Toujours nécessaire avant de commencer un traitement oncologique
- C. Le score G8 est un outil de dépistage gériatrique efficace
- D. Un score G8 ≤ 13 nécessitera une consultation gériatrique approfondie
- E. Les patients cancéreux gériatriques sont souvent sous-traités

18. A propos des marqueurs tumoraux : RJ

- 1. Ils sont spécifiques d'un seul type de cancer
- 2. Ils doivent toujours être interprétés avec la clinique
- 3. Ils peuvent augmenter en dehors de toute récurrence
- 4. Ils sont utilisés pour évaluer la réponse au traitement
- 5. Ils remplacent l'imagerie

A : 1+2+3 B : 2+3+4+5 C : 2+4+5 D : 2+3+4 E : 1+3+5

19. Mr M.A, 58 ans, consulte pour une asthénie persistante et un amaigrissement. Antécédents : tabagisme 30 paquets-année, sevré depuis 5 ans ; alcool : consommation régulière estimée à 30 g d'alcool pur par jour pendant 30 ans. Familiaux : mère décédée d'un cancer du sein à 45 ans. Personnels : infection chronique par le virus de l'hépatite C (VHC) connue mais non traitée, suivie par un hépatologue. IMC à 32 kg/m² (obésité). À l'examen clinique, vous notez une légère hépatomégalie ferme. Parmi les facteurs de risque suivants présents chez Mr M.A, lequel est le plus fortement associé au développement d'un carcinome hépatocellulaire ?

- A. L'obésité (IMC à 32 kg/m²)
- B. L'antécédent de tabagisme
- C. L'infection chronique par le virus de l'hépatite C
- D. L'antécédent familial de cancer du sein
- E. La consommation de viande

20. Concernant le rythme de surveillance après traitement curatif : RJ

- 1. Identique pour tous les cancers
- 2. Plus rapproche les deux premières années
- 3. Dépend du stade initial
- 4. Toujours mensuel
- 5. Peut-être annuel après plusieurs années

A : 1+2+3 B : 2+3+4 C : 2+4+5 D : 2+3+5 E : 1+4+5

21. Quelles sont les mesures de prévention primaire parmi celles proposées ?

- 1. Mesures de protection pour des professions exposées à des carcinogènes
- 2. Mesures de protection solaire
- 3. Dépistage de masse organisé de certains cancers
- 4. Interdiction de fumer dans les lieux publics
- 5. Consultation gynécologique avec frottis cervico-vaginal pour le cancer du col de l'utérus

A : 1+2+4+5 B : 1+2+3+4 C : 1+4+5 D : 1+2+4 E : 1+3+4

22. Quelles sont les conditions pour qu'une pathologie soit accessible à un dépistage de masse ?

- A. Pathologie ayant une incidence forte
- B. Phase préclinique longue
- C. Pathologie fréquente et rapidement fatale en l'absence de traitement
- D. Test de dépistage efficace
- E. Test de dépistage valide existant permettant de confirmer la pathologie

A : 1+2+3 B : 2+3+4 C : 1+2+4+5 D : 2+3+4 E : 1+3+5

23. Quels sont les cancers qui bénéficient d'un dépistage de masse organisé ?

- A. Cancer du sein
- B. Mélanome
- C. Cancer du col utérin
- D. Cancer du pancréas
- E. Cancer colorectal

A : 1+3+5 B : 2+3+4+5 C : 2+4+5 D : 2+3+4 E : 1+2+3+5

24. La vaccination est un moyen efficace de prévention primaire dans :

- A. Le cancer colorectal
- B. Le cancer du col de l'utérus
- C. Le cancer du cerveau
- D. Le carcinome hépatocellulaire
- E. Le cancer de l'estomac

A : 1+3 B : 2+3 C : 2+5 D : 3+4 E : 2+4

25. Évaluation de la nutrition : (RJ)

- 1. IMC : masse du corps corporel
- 2. IMC > 25 kg/m² = personne en surpoids
- 3. Un tour d'abdomen >= 90 cm est un facteur nutritionnel
- 4. Une diminution >= 10% est un indice de mauvais pronostic
- 5. L'indice MNA nous permet de faire le diagnostic d'une malnutrition protéino-énergétique

A : 1+3 B : 2+3 C : 4+5 D : 3+4 E : 3+4

26. Le lieu de l'hématopoïèse adulte:

- A. Au niveau de la rate exclusive
- B. Au niveau des os plats : sternum, côtes, vertèbres et bassin
- C. Au niveau du mésoderme
- D. Au niveau médullaire
- E. B + D sont justes

27. La cellule souche hématopoïétique se localise essentiellement :

- 1. Au niveau de la moelle osseuse
- 2. Se retrouve aussi en pourcentage très faible dans la circulation
- 3. Au niveau du sang de cordon
- 4. Au niveau de la rate
- 5. Au niveau des ganglions

A : 1+4+5 B : 1+2+3 C : 1+2+4 D : 1+4+5 E : 2+3+4

28. Les facteurs de croissance de la lignée myéloïde sont principalement :

- A. L'érythropoïétine, pour la différenciation définitive en érythroblastes
- B. La thrombopoïétine favorise la différenciation terminale des plaquettes
- C. L'IL-5 est une cytokine essentielle de la différenciation et l'activation des polynucléaires éosinophiles
- D. A + B sont justes
- E. A + B + C sont justes

29. Le VGM est un indice hématimétrique responsable de :

- A. La taille du GR
- B. La couleur du GR
- C. Sa formule par l'hématocrite x 10 / GR en million
- D. Sa formule est Hémoglobine x 100 / Hématocrite
- E. A + C sont justes

30. Quelle est la formule pour calculer le CCMH :

- A. L'hématocrite et de l'hémoglobine
- B. L'hémoglobine et le taux des GR
- C. Hémoglobine x 100/ Hématocrite
- D. Hémoglobine x 10/ taux GR
- E. A + C sont justes

31. Au cours de la LMC, le gène chimérique BCR-ABL est :

- A. Forme du début de BCR et la fin d'ABL
- B. Forme de la fin de BCR et le début d'ABL
- C. L'ARN chimérique est traduit par une activité tyrosine kinase faible
- D. Une prolifération et augmentation de l'apoptose
- E. A + C + D sont justes

32. Les points de cassure au cours de la LMC sont regroupés entre b1 et b5 sur abl, alors qu'il existe plusieurs régions de cassure sur ber. La région M-ber (Major ber) est majoritairement impliquée dans la LMC:

- A. Le transcript est b3a2 (60% des cas) ou b2a2 (dans 35% des cas)
- B. Le transcript produit la protéine p190
- C. L'ARN chimérique ber/abl est traduit en une protéine de fusion p210
- D. Le transcript produit la protéine p230
- E. A + C sont justes

33. Concernant les masses tumorales / adénopathies : (RF)

- A. Les lymphomes donnent souvent des adénopathies indolores
- B. Les métastases ganglionnaires sont souvent dures et fixées
- C. Les leucémies peuvent donner des polyadenopathies
- D. L'adénopathie tumorale est toujours inflammatoire
- E. La localisation de Troisier évoque un cancer digestif

34. Concernant la phase accélérée de la LMC (OMS 2016) :

- A. Augmentation du taux des leucocytes au-delà de 10 G/L
- B. Présence d'au moins 20% de basophiles dans le sang
- C. Présence d'anomalies cytogénétiques clonales additionnelles au Ph1 (doublement du Ph1, trisomie 8, isochromosome 17q, trisomie 19)
- D. Toutes ces réponses sont justes
- E. B + C sont justes

35. Quelles affections peuvent s'accompagner d'une splénomégalie ? RJ

- A. Anémie hémolytique auto-immune
- B. Leucémie myéloïde chronique
- C. Thrombocytemie essentielle
- D. Lymphomes
- E. Toutes ces réponses sont justes

36. Les inhibiteurs de tyrosine kinases (ITK) de 2^e génération sont indiqués :

- A. En deuxième ligne en cas de résistance ou intolérance
- B. En première ligne en cas de risque intermédiaire ou élevé
- C. En cas de risque pronostic faible
- D. A + B sont justes
- E. B + C sont justes

37. La splénomégalie : (RF)

- 1. Est une maladie à part entière
- 2. Correspond à une augmentation du volume splénique
- 3. Impose toujours une recherche étiologique
- 4. Est toujours symptomatique
- 5. Peut révéler une pathologie grave

A : 1+2 B : 2+3+4 C : 1+4 D : 1+4+5 E : 2+5

38. La réponse optimale sous anti-tyrosine kinases est définie par :

- A. Par une réponse hématologique à 3 mois
- B. Par un transcrit BCR/ABL $\leq 10\%$ à 3 mois
- C. Par un transcrit BCR/ABL $\leq 1\%$ à 12 mois
- D. A + B sont justes
- E. A + B + C sont justes

39. La thrombopénie immunologique (PTI) :

- 1. Est une thrombopénie acquise d'origine auto-immune
- 2. Est due à un déficit de production médullaire isolé
- 3. Se caractérise par une destruction périphérique des plaquettes
- 4. Est secondaire à une maladie sous-jacente dans 80% des cas
- 5. Elle est définie par une thrombopénie isolée < 150 G/L

A : 1+2 B : 1+4 C : 1+3 D : 1+4 E : 2+5

47. Le diagnostic d'aplasie médullaire est confirmé par :

- A. Hémogramme
- B. Frottis
- B. Frottis sanguin
- C. Medullogramme
- D. Cytométrie en flux
- E. Biopsie osteomédullaire

48. Le diagnostic de certitude de Leucémie Lymphoïde Chronique repose sur :

- A. Hyperlymphocytose > 5000 éléments/ul persistante
- B. Lymphocytose médullaire $> 30\%$
- C. Immunophénotypage par cytométrie en flux
- D. Cytogénétique à la recherche d'une translocation (9 ; 22)
- E. Scanner thoraco-abdominal

49. Devant un syndrome hémorragique cutané à type de pétéchie, quels sont les examens à demander en première intention ?

1. Un medullogramme
2. Un bilan d'hémostase
3. Un hémogramme
4. Un frottis sanguin
5. Un dosage des facteurs de la coagulation

A : 1+3+4 B : 1+4+5 C : 1+4+5 D : 1+4+5 E : 2+3+4

50. L'allogreffe est une indication standard dans :

- A. La leucémie myéloïde chronique
- B. Le myélome multiple
- C. L'anémie aplasique sévère
- D. Les syndromes myélodysplasiques à haut risque
- E. Toutes ces réponses sont justes

51. L'hémoglobinurie est surtout observée dans :

- A. Hémolyse extravasculaire
- B. Hémolyse intravasculaire
- C. Hémolyse physiologique
- D. L'anémie ferriprive
- E. Toutes ces réponses sont justes

52. Le principal mécanisme conditionnant l'hémolyse physiologique des globules rouges âgés est :

- A. La perte de la déformabilité membranaire
- B. La diminution de la synthèse de l'hémoglobine
- C. Activation du complément
- D. Augmentation de la perméabilité calcique
- E. Toutes ces réponses sont justes

53. L'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques a pour objectif principal :

- A. De restaurer un système immunitaire défaillant
- B. D'induire un effet greffon contre maladie
- C. De permettre l'administration de chimiothérapies à haute dose
- D. De corriger une anomalie génétique constitutionnelle
- E. Toutes les réponses sont fausses

54. Dans l'évolution sous traitement martial oral, on observe :

1. Crise reticulocytaire entre le 7^e et le 14^e jour
2. Normalisation de l'hémoglobine en deux mois
3. Normalisation de la ferritine en 7 jours
4. Reconstitution des réserves en 6 mois
5. Disparition de la microcytose en 48 heures

A : 2+3+4 B : 1+3+4 C : 2+3+5 D : 1+2+4

55. Lors de l'hémolyse physiologique, l'hémoglobine est transformée en :

- A. Bilirubine conjuguée directement
- B. Bilirubine non conjuguée
- C. Biliverdine conjuguée
- D. Urobiline

E. Toutes ces réponses sont justes

56. Concernant les réserves de fer dans l'organisme :

- A. Elles sont stockées sous forme de ferritine
- B. Elles sont stockées sous forme d'hémosidérine
- C. Elles se situent dans le foie
- D. Elles se situent dans la rate

E. Toutes ces réponses sont justes

57. Une anémie microcytaire hypochrome par carence en fer chez une femme de 30 ans est définie par une

- A. Hb inférieur à 12 g/dl, VGM inférieur à 82 fl, CCMH inférieur à 32%, ferritinémie normale
- B. Hb inférieur à 12 g/dl, VGM inférieur à 80 fl, CCMH inférieur à 32%, ferritinémie < 20 ug/l
- C. Hb inférieur à 10 g/dl, VGM supérieur à 100 fl, CCMH égale à 32%, ferritinémie > 400 ug/l
- D. Hb inférieur à 12 g/dl, VGM inférieur à 82 fl, CCMH inférieur à 32%, fer sérique < 60 ug/dl
- E. Hb inférieur à 10 g/dl, VGM inférieur à 100 fl, CCMH inférieur à 32%, ferritinémie < 30 ug/l

58. Le myélogramme est réalisé dans tous ces cas sauf :

- A. L'aplasie médullaire
- B. Myélome multiple
- C. Les leucémies aiguës lymphoblastiques
- D. L'anémie par carence en fer
- E. La leucémie myéloïde chronique pour une cytogénétique

59. Un sujet de groupe sanguin A Rhésus positif Cc ee Kell positif peut être transfusé par :

- 1. O Rhésus négatif cc ee Kell négatif
- 2. O Rhésus positif Cc ee Kell positif
- 3. O Rhésus positif cc ee Kell positif
- 4. A Rhésus négatif cc ee Kell négatif
- 5. A Rhésus positif Ce ee Kell positif

A : 1+2+3+4 B : 2+3+4 C : 1+5 D : 1+4+5 E : 1+3+4

60. Une anémie macrocytaire peut se voir au cours sauf ?

- 1. Aplasie médullaire
- 2. Carence en fer
- 3. Carence en vitamine B12
- 4. B-thalassémie

A : 1+2 B : 1+3 C : 1+4 D : 3+4 E : 2+4

61. Patiente âgée de 30 ans qui présente une pâleur cutanéomuqueuse, koïlonychie, perlèche, Hb = 9 g/dl, VGM = 69 fl, CCMH = 26%, taux de réticulocytes = 67000/mm³ ; le diagnostic est :

- A. Anémie normocytaire normochrome arégénérative
- B. Anémie microcytaire hypochrome régénérative par hémoglobinopathies
- C. Anémie microcytaire hypochrome arégénérative
- D. Anémie avec signes de sideropenie
- E. C + D sont justes

62. Pour confirmer le diagnostic d'une anémie ferriprive, les bilans suivants sont nécessaires:

- A. Dosage de la ferritine
- B. Dosage des facteurs antipernicieux
- C. Electrophorèse de l'hémoglobine
- D. Bilan inflammatoire
- E. Test thérapeutique au fer à défaut du bilan martial

63. Les signes cliniques de la sideropenie sont : RJ

- 1. Koïlonychie
 - 2. Glossite
 - 3. Ictère
 - 4. Syndrome de PICA
 - 5. Splénomégalie massive
- A : 1+2+3+4 B : 2+3+4 C : 1+4+5 D : 1+2+4 E:1+3+4

64. Le test thérapeutique en fer permet : RJ

- 1. D'affirmer le diagnostic
- 2. D'observer une crise reticulocytaire
- 3. De corriger la moitié du déficit en hémoglobine en 21 jours
- 4. De normaliser la ferritine en 7 jours
- 5. D'éliminer une thalassémie

A : 1+2+3 B : 2+3+4 C : 1+4+5 D : 1+2+4 E :1+3+4

65. Un garçon âgé de 3 ans consulte pour une douleur du genou droit. Dans les antécédents on note des ecchymoses au moindre traumatisme et un frère décédé après une circoncision et cousin paternel suivi pour des hémorragies cutanées. Quel diagnostic évoquez-vous devant ce tableau clinique ?

- A. Une aplasie médullaire
- B. Une hémophilie
- C. Un purpura thrombopénique auto-immun
- D. Une leucémie aigue
- E. Une carence en vitamine B12

66. Quel est l'argument contre le diagnostic ?

- A. Début précoce
- B. Sexe masculin
- C. Antécédents personnels d'hémorragie
- D. Antécédents familiaux : un cousin paternel suivi pour hémorragie
- E. Frère décédé après une circoncision

67. Quel examen demanderez-vous pour confirmer le diagnostic ?

- A. Hémogramme
- B. Medullogramme
- C. TP et TCK
- D. Groupage
- E. Dosage des facteurs de la coagulation

68. La triade d'hémolyse est observée dans toutes ces pathologies sauf ?

- A. Drépanocytose homozygote chez un patient âgé de 18 ans
- B. Une B-thalassémie homozygote
- C. Une anémie hémolytique acquise
- D. Un syndrome drépanocytaire double hétérozygote SC
- E. Un syndrome drépanocytaire double hétérozygote SB

69. Une femme âgée de 65 ans consulte pour des adénopathies cervicales, axillaires et inguinales bilatérales de 02 cm évoluant depuis 07 mois. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A. Leucémie aigue
- B. Maladie d'Hodgkin
- C. Leucémie lymphoïde chronique
- D. Lymphome non hodgkinien de haut grade de malignité
- E. Leucémie myéloïde chronique

70. Quel est l'examen qui confirme votre diagnostic ?

- A. Un medullogramme
- B. Un bilan d'hémostase
- C. Un hémogramme
- D. Un frottis sanguin
- E. Un immunophénotypage par cytométrie en flux

71. Toutes ces complications sont fréquentes dans ce cas sauf ?

- A. Les infections
- B. Les anémies hémolytiques acquises
- C. Transformation en lymphome non hodgkinien
- D. Lésions ostéolytiques
- E. Une hypogammaglobulinémie

72. Une femme âgée de 45 ans consulte pour des adénopathies cervicales et axillaires bilatérales de 05 cm évoluant depuis 05 mois. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A. Leucémie aigue
- B. Leucémie lymphoïde chronique
- C. Les lymphomes
- D. Leucémie myéloïde chronique
- E. Myélome multiple

73. Quelles sont les examens d'orientation à faire ?

1. Biopsie ganglionnaire
2. Hémogramme
3. Cytoponction ganglionnaire
4. Un immunophénotypage par cytométrie en flux
5. IDR a la tuberculine

A : 1+2+3+5 B : 2+3+5 C : 2+4+5 D : 1+2+3 E : 2+3+4

74. Quel est l'examen qui confirme le diagnostic d'un lymphome ?

- A. Cytoponction ganglionnaire
- B. Analyse histologique et immunohistochimie
- C. Immunophénotypage par cytométrie en flux
- D. Analyse histologique
- E. Toutes ces réponses sont justes

75. Dans ce cas le bilan d'extension doit comporter tous ces examens sauf :

- A. Examen ORL
- B. Bilan hépatique
- C. Scanner thoraco-abdominal
- D. Ponction biopsique osseuse
- E. Bilan rénal

76. Un hémophile a épousé une conductrice. Quelle sera l'expression chez les enfants ?

1. Une fille conductrice et une fille saine
2. Un garçon hémophile et un autre sain
3. Une fille conductrice et une fille hémophile
4. Deux garçons sains
5. Deux filles saines

A:1+2 B : 1+4 C: 4+5 D :2+3 E : 2+5

77. Patient âgé de 19 ans consulte pour une fièvre, des adénopathies cervicales de 02 cm et un purpura pétéchiol évoluant depuis 15 jours, font évoquer le diagnostic de :

- A. Hémophilie A
- B. Leucémie lymphoïde chronique
- C. Purpura thrombopénique auto-immun
- D. Leucémie aigue
- E. Lymphome d'Hodgkin

78. Le diagnostic de certitude dans ce cas :

- A. Un hémogramme
- B. Un frottis sanguin
- C. Une cytoponction ganglionnaire
- D. Une ponction biopsique osseuse
- E. Un medullogramme

79. Toutes ces complications se voient dans ce cas sauf :

- A. Une hypercalcémie
- B. Une anémie microcytaire régénérative
- C. Une CIVD
- D. Une septicémie
- E. Une insuffisance rénale

80. Ce patient est transfusé par du culot globulaire. Tous ces gestes sont à faire sauf :

- A. Test de compatibilité au lit du malade
- B. Vérifier le groupage de la poche
- C. Vérifier le groupage du patient
- D. Surveillance de la transfusion pendant seulement les 15 premières minutes
- E. Les sérologies du donneur doivent être négatives

Examen maladies infectieuses - G1/ 2026

1. Chez un patient avec bactériémie à *S. aureus*, quelles affirmations sont exactes ? (Les RJ)
 - A. La dissémination secondaire est rare
 - B. Une endocardite doit être recherchée systématiquement
 - C. Les cathéters sont rarement impliqués
 - D. Les embolies septiques sont fréquents
 - E. Une hémoculture positive unique doit être considérée comme contamination
2. A propos des résistances de *Staphylococcus aureus* : (Les RJ)
 - A. Il est naturellement résistant à la colistine
 - B. La pénicilline G est active dans > 90 % des cas
 - C. La pénicillinase est retrouvée dans > 90 % des souches
 - D. L'amoxicilline est un bon traitement probabiliste
 - E. La résistance à la méticilline est naturelle
3. Concernant le diagnostic étiologique d'une spondylodiscite infectieuse, quelles affirmations sont vraies ? (Les RJ)
 - A. Les hémocultures ne sont pas systématiques
 - B. La ponction-biopsie discolombaire est indiquée si les hémocultures sont négatives
 - C. La recherche d'endocardite infectieuse est systématique si *S. aureus* est isolé aux hémocultures
 - D. L'absence de fièvre élimine l'origine infectieuse
 - E. Les caractéristiques radiologiques à l'IRM suffisent à poser le diagnostic étiologique
4. Concernant l'érythème noueux, quelles affirmations sont correctes ? (Les RJ)
 - A. Nodules sous-cutanés douloureux, rouges ou violacés, surtout sur le tibia
 - B. Les nodules sont toujours symétriques
 - C. Souvent précédé de fièvre et d'arthralgies
 - D. Touchent majoritairement les hommes
 - E. Toujours lié à une infection streptococcique
5. Angine et scarlatine à SGA : quelles propositions sont exactes ? (Les RJ)
 - A. Les céphalosporines sont le traitement de première intention de l'angine à SGA
 - B. La scarlatine doit être traitée par amoxicilline
 - C. Chez l'enfant < 3 ans, le macrolide est le traitement de choix de l'angine fébrile
 - D. En cas d'allergie immédiate aux bêta-lactamines, les macrolides sont une alternative valide
 - E. Un traitement de 15 jours est recommandé pour assurer l'éradication du SGA
6. Concernant la prise en charge de DHBNN typique :
 - A. Ciprofloxacine 1 g x 3/j
 - B. Amoxicilline 50 mg/kg/j
 - C. Antibiothérapie IV obligatoire
 - D. Prolonger le traitement jusqu'à disparition complète des signes cutanés
 - E. Un traitement de 7 jours est largement suffisant

7. Concernant la gangrène de Fournier, quelles propositions sont exactes ?
- A. Toujours monomicrobienne, causée par *Streptococcus pyogenes*
 - B. Diagnostic uniquement sur imagerie (TDM/IRM)
 - C. Polymicrobienne : aérobies + anaérobies
 - D. Porte d'entrée fréquente : lésion péri-anale ou post-chirurgie urologique/gynécologique
 - E. Les lésions ne s'étendent jamais à l'abdomen ou aux cuisses
8. Quels éléments orientent le plus vers une fièvre boutonneuse méditerranéenne (FBM) ?
- A. Exposition récente à des eaux douces stagnantes, notamment
 - B. Survenue du tableau fébrile en période estivale
 - C. Activité agricole ou travaux d'égout
 - D. Contact étroit avec un chien
 - E. Voyage récent en zone tropicale humide
9. Leptospirose ictero-hémorragique (LIH) : quelles anomalies biologiques sont fréquemment observées ?
- A. Thrombopénie marquée
 - B. Cytolyse hépatique majeure avec transaminases >10 N
 - C. Insuffisance rénale aiguë avec élévation de la créatinine $\pm$ hypokaliémie initiale
 - D. Hypoglycémie constante au LCS
 - E. Lymphopénie marquée
10. Un patient de Boufarik se présente en janvier avec fièvre, céphalées, myalgies et hyperhémie conjonctivale depuis 3 jours. Comment orienter le diagnostic entre leptospirose et FBM ? (1 RJ)
- A. À cette phase précoce, on ne peut pas distinguer les deux pathologies
 - B. On demande une sérologie ELISA pour leptospirose et IFI pour FBM pour faire la distinction
 - C. C'est forcément une FBM, on recherche la tache noire
 - D. C'est forcément une leptospirose, on peut initier un traitement empirique par amoxicilline
 - E. La profession du patient suffit pour faire la différence
11. Chez un patient présentant une méningite à cocci à Gram positif, sans signe de gravité ni facteur de PSDP. Quelle(s) proposition(s) sont correcte(s) ? (Les RJ)
- A. Le traitement probabiliste repose sur céfotaxime ou ceftriaxone
 - B. La vancomycine doit être associée d'emblée
 - C. La durée du traitement est de 10 à 14 jours
 - D. L'amoxicilline est le traitement de référence
 - E. La rifampicine seule est suffisante
12. Concernant la prévention de la méningite à *Streptococcus pneumoniae* : (Les RJ)
- A. Une chimioprophylaxie antibiotique est indiquée pour les sujets contacts proches
 - B. La vaccination antipneumococcique est recommandée chez les sujets à risque
 - C. Prise en charge de la porte d'entrée infectieuse
 - D. Un isolement respiratoire du patient est recommandé pendant 24 heures
 - E. L'infection confère une immunité durable rendant la vaccination inutile

13. Un adulte est admis aux urgences pour fièvre élevée, altération rapide de la conscience, hypotension artérielle et purpura extensif évocateur d'un purpura fulminants. (Les RJ)
- A. Devant les troubles neurologiques, un scanner cérébral est prioritaire avant toute autre prise en charge
 - B. La ponction lombaire est prioritaire et doit être réalisée immédiatement avant toute antibiothérapie
 - C. Une céphalosporine de 3e génération par voie intraveineuse doit être débutée immédiatement
 - D. L'antibiothérapie ne doit être administrée qu'en cas d'aspect purulent du LCS
 - E. Un remplissage vasculaire par cristalloïdes est indiqué d'emblée
14. Concernant les caractéristiques de la méningite à *Listeria monocytogenes*, quelles affirmations sont exactes ? (Les RJ)
- A. Le LCR est toujours franchement purulent avec hyperleucocytose à prédominance de polynucléaires
 - B. Le traitement de référence repose sur l'association céfotaxime + gentamicine
 - C. Elle touche préférentiellement l'enfant < 5 ans
 - D. L'infection gagne le SNC par voie hématogène après ingestion d'aliments contaminés
 - E. La durée du traitement est plus longue que celle des autres méningites bactériennes
15. Dans le traitement probabiliste d'une encéphalite avec LCS clair, pourquoi associe-t-on aciclovir + amoxicilline ? (Les RJ)
- A. Aciclovir contre les entérovirus
 - B. Amoxicilline contre le pneumocoque
 - C. Aciclovir contre Herpès simplex virus (HSV)
 - D. Aciclovir contre le virus West Nile
 - E. Amoxicilline contre *Listeria monocytogenes*
16. Parmi les examens suivants, lesquels font partie du bilan de première ligne d'une encéphalite à liquide clair ? (Les RJ)
- A. Sérologie *Leptospires*
 - B. PCR : HSV, VZV, entérovirus
 - C. Scanner cérébral sans injection
 - D. Hémocultures
 - E. Sérologie auto-immune (anticorps anti-NMDA, anti-LGI1 ...)
17. VIH/SIDA : Concernant la phase chronique asymptomatique : (Les RJ)
- A. Elle est biologiquement inactive
 - B. La charge virale est nulle
 - C. Les CD4 sont souvent > 500/mm³
 - D. Le risque de transmission persiste
 - E. Sa durée médiane est inférieure à 1 an
18. VIH/SIDA : Concernant le traitement antirétroviral (ARV) : (Les RJ)
- A. Il doit être initié si le taux de CD4 < 500/mm³
 - B. Une bithérapie est recommandée en première ligne à vie
 - C. L'objectif est une charge virale < 50 copies/mL en 6 mois
 - D. Le traitement peut être arrêté si la charge virale devient indétectable
 - E. Le traitement est initié précocement quel que soit le taux de CD4

19. Concernant la pneumocystose chez le patient infecté par le VIH, quelles propositions sont correctes ? (Les RJ)

- A. Elle survient classiquement chez les patients au stade chronique symptomatique
- B. Elle se manifeste le plus souvent par une dyspnée progressive fébrile
- C. Le traitement de première intention repose sur l'amoxicilline
- D. La prophylaxie primaire est recommandée chez les patients avec $CD4 < 200/mm^3$
- E. La radiographie thoracique est habituellement normale

20. À propos du diagnostic du VIH en phase très précoce : (Les RJ)

- A. L'ELISA 4e génération détecte l'antigène p24 viral
- B. L'antigène p24 apparaît avant les anticorps
- C. Le Western-Blot est le test de dépistage de référence
- D. La PCR VIH est utile en cas de primo-infection suspectée
- E. Un TROD négatif élimine formellement une primo-infection

21. Interprétation des hémocultures : quelles situations évoquent une contamination ? (Les RJ)

- A. Un seul flacon positif à SCN, sans signes cliniques de sepsis
- B. 2 flacons positifs à SCN provenant de 2 séries différentes
- C. Streptococcus spp isolé dans un seul flacon
- D. Corynebacterium spp isolé dans un seul flacon
- E. Staphylococcus aureus isolé dans un seul flacon

22. Bactériémie communautaire à SCN sans facteur de risque : quelle antibiothérapie probabiliste est recommandée ? (1 RJ)

- A. Cefotaxime IV
- B. Amoxicilline IV
- C. Céfazoline IV
- D. Imipénème IV
- E. Amikacine IV en monothérapie

23. Concernant la diffusion des antibiotiques, quelles affirmations sont correctes ? (Les RJ)

- A. Les aminosides ont une bonne diffusion osseuse
- B. Les fluoroquinolones diffusent bien dans la prostate
- C. La rifampicine est active sur les biofilms
- D. Les macrolides diffusent bien dans le LCS
- E. Les beta-lactamines sont efficaces sur les bactéries intracellulaires

24. Définition du choc septique (Les RJ)

- A. Fréquence respiratoire $\geq 22/min$
- B. Hypotension persistante nécessitant vasopresseurs pour maintenir PAM ≥ 65 mmHg
- C. PAS ≤ 100 mmHg
- D. Score de Glasgow $\leq 12/15$
- E. Lactatémie > 2 mmol/L

25. Facteurs expliquant la grande variabilité de la période d'incubation de la rage (15 jours à 1 an) ? (Les RJ)
- A. Statut immunitaire de la victime
 - B. Temps nécessaire à la migration neurotrope le long des nerfs périphériques vers le SNC
 - C. Type d'animal mordeur
 - D. Gravité de la plaie (profondeur, richesse en innervation)
 - E. Localisation de la morsure
26. Un patient a déjà reçu une vaccination antirabique complète il y a 6 mois. Il subit une nouvelle exposition de catégorie II. Conduite à tenir ? (1 RJ)
- A. Sérothérapie (Ig) toujours indiquée
 - B. Sérothérapie (Ig) non indiquée
 - C. Rappel vaccinal simple : 2 injections J0 et J3
 - D. Même protocole que le sujet non vaccine
 - E. Rappel inutile si vaccination complète < 3 ans
27. Dans le tétanos généralisé, tous ces caractères correspondent aux contractures généralisées sauf un, lequel ? (1 RF)
- A. Inoculable
 - B. Indolores
 - C. Symétriques
 - D. Permanentes
 - E. Des spasmes peuvent survenir à l'occasion d'un stimulus sonore
28. Concernant le tétanos : (1 RJ)
- A. C'est une maladie contagieuse
 - B. Toujours fébrile
 - C. Son traitement nécessite une antibiothérapie essentiellement
 - D. Les nouveau-nés sont épargnés
 - E. Des formes localisées peuvent se rencontrer
29. Femme enceinte de 30 SA présente un accès palustre à *P. falciparum* (parasitémie 2,8 %). Traitement indiqué ? (1 RJ)
- A. Artemether-lumefantrine per os
 - B. Quinine per os
 - C. Artésunate per os
 - D. Artésunate injectable
 - E. Clindamycine IV en monothérapie
30. Un voyage est prévu en Tanzanie (zone C) chez une femme enceinte. Quelle chimioprophylaxie est recommandée ? (1 RJ)
- A. Chloroquine (Nivaquine)
 - B. Proguanil seul
 - C. Primaquine
 - D. Doxycycline ou méfloquine
 - E. Méfloquine ou atovaquone/proguanil

31. Fièvre typhoïde : première semaine (phase septicémique) - 1 réponse FAUSSE

- A. Les hémocultures sont souvent positives à cette période
- B. La coproculture se positive le plus souvent secondairement
- C. Le sérodiagnostic de Widal peut être négatif à ce stade
- D. Une hyperleucocytose franche à polynucléose est habituelle
- E. Une constipation est fréquemment décrite

32. Concernant le choléra, quelle affirmation est fausse ? - 1 réponse FAUSSE

- A. Il se manifeste par une diarrhée aqueuse abondante sans fièvre
- B. La symptomatologie est liée à une toxine agissant sur l'AMPc des entérocytes
- C. La déshydratation peut être rapide et sévère
- D. La présence de sang et de glaires dans les selles est caractéristique du choléra
- E. La prise en charge initiale repose sur une réhydratation rapide et adaptée

33. Concernant le diagnostic de la diphtérie : (Les RJ)

- A. Prélèvement pharyngé avec culture sur milieu tellurite
- B. La sérologie diphtérique est le standard pour le diagnostic en urgence
- C. Le test de toxine (Elek ou PCR) confirme le pouvoir toxigène
- D. L'hémoculture isole systématiquement la bactérie
- E. La coloration Gram positive seule suffit pour confirmer le diagnostic

34. Quelle est la complication à redouter dans la diphtérie entre le 8ème et 15ème jour après l'infection ? (1 RJ)

- A. Insuffisance rénale
- B. Paralysie des membres inférieurs
- C. Myocardite
- D. Thrombose veineuse profonde
- E. Infection pulmonaire

35. Chez un patient suspect de MNI, quel examen biologique est le meilleur indicateur d'infection récente à EBV ? (1 RJ)

- A. Numération sanguine normale
- B. Lymphocytose avec atypies modérées
- C. Sérologie EBV : IgM anti-VCA
- D. Sérologie EBV : IgG anti-EBNA
- E. Hyperleucocytose avec neutrophilie

36. La rubéole est : Les réponses FAUSSES

- A. Une maladie virale éruptive, endémo-épidémique
- B. Due à un Herpesvirus
- C. Bénigne de la deuxième enfance
- D. Non immunisante
- E. Inapparente ou éruptive

37. Quelle est la méthode qui permet de poser le diagnostic de varicelle ? (1 RJ)

- A. Sérologie ELISA
- B. PCR à partir des cellules vésiculaires
- C. L'isolement du virus par culture cellulaire
- D. Immunofluorescence directe
- E. Arguments cliniques

38. Un éleveur de vaches consulte pour fièvre intermittente depuis 20 jours, sueurs profuses et arthralgies. Quel examen biologique permet le mieux de confirmer le diagnostic ? (Les RJ)

- A. Hémoculture
- B. Sérologie Widal et Felix
- C. Sérologie leptospirose (ELISA)
- D. Coproculture
- E. Sérologie Wright

39. Enfant 6 ans : fièvre 38,5 C, éruption maculopapuleuse rosée débutant sur le visage et s'étendant au tronc et aux membres, adénopathies retroauriculaires, pas de toux ni conjonctivite. Diagnostic le plus probable ? (1 RJ)

- A. Rougeole
- B. Rubéole
- C. Varicelle
- D. Scarlatine
- E. Mononucléose

40. Un médecin se pique avec une aiguille creuse sur un patient toxicomane, statut viral inconnu. Quelles mesures doivent être prises immédiatement ? Les réponses FAUSSES

- A. Laver abondamment la plaie à l'eau et au savon
- B. Faire saigner rapidement la plaie
- C. Contacter rapidement un centre d'infectiologie
- D. Attendre les résultats des sérologies pour décider de la prophylaxie VIH
- E. Vérifier le statut sérologique et vaccinal du soignant

Examen Maladies Infectieuses G3/ 2026

1. Antibiotiques de première intention en cas d'impétigo étendu chez l'enfant (Les RJ)
 - A. Pristinamycine per os
 - B. Érythromycine per os
 - C. Amoxicilline + acide clavulanique per os
 - D. Métronidazole per os
 - E. Amoxicilline seule per os
2. Quels sont les germes les plus fréquemment responsables des infections sur matériel prothétique ? (Les RJ)
 - A. Staphylococcus aureus
 - B. Escherichia coli
 - C. Pseudomonas aeruginosa
 - D. Staphylococcus epidermidis
 - E. Enterococcus faecalis
3. En cas de bactériémie à Staphylococcus aureus, concernant l'endocardite infectieuse : (Les RJ)
 - A. Recherche systématique seulement chez le patient avec antécédent de valvulopathie.
 - B. Sa recherche doit être systématique pour tous les patients.
 - C. Environ 10 % des bactériémies communautaires s'accompagnent d'endocardite.
 - D. Elle ne survient que chez les toxicomanes IV.
 - E. Elle ne survient que chez les porteurs de prothèses valvulaires.
4. Concernant les DHBNN (dermohypodermes non nécrosantes) : (Les RJ)
 - A. Toujours polymicrobiennes.
 - B. Streptococcus pyogènes (groupe A) fréquent.
 - C. Staphylococcus aureus jamais implique.
 - D. Prélèvement cutané obligatoire.
 - E. Germes anaérobies souvent présents.
5. Concernant l'érysipèle typique du membre inférieur : (Les RJ)
 - A. Bilans biologiques et hémocultures toujours nécessaires pour poser le diagnostic.
 - B. L'examen clinique permet le plus souvent le diagnostic.
 - C. L'érysipèle survient uniquement chez les patients obèses.
 - D. Une atteinte bilatérale est typique.
 - E. Le traitement repose essentiellement sur des antibiotiques adaptés aux streptocoques.
6. Quelles sont les caractéristiques définissant une infection invasive sévère à Streptococcus A (SGA) ? (Les RJ)
 - A. Impétigo bulleux
 - B. Bactériémie
 - C. Vulvovaginite
 - D. Endométrite du post-partum
 - E. Erysipèle

7. Quelles sont les caractéristiques cliniques spécifiques de la scarlatine (toxino-infection à SGA) ? (Les RJ)

A. L'incubation est longue (plus de 15 jours).

B. Durant la phase d'état, l'exanthème est un érythème diffus en nappe avec sensation « papier sablé » au toucher.

C. L'exanthème scarlatin respecte la région péri-buccale et s'efface à la vitro-pression

D. L'énanthème : langue passe du rouge framboise au début, à blanchâtre après le 5

E. La desquamation commence précocement (dès le 3e jour).

8. Quelles sont les particularités de la méningite à *Streptococcus pneumoniae* (Les RJ)

A. La porte d'entrée est le plus souvent pulmonaire.

B. C'est l'étiologie de méningite la plus sévère avec la plus forte mortalité.

C. Une antibioprophylaxie des contacts est indiquée.

D. Elle survient préférentiellement chez le sujet jeune et adolescent.

E. L'asplénie constitue un facteur de risque.

9. Chez un sujet de 70 ans diabétique, admis pour une méningite purulente, quelle antibiothérapie probabiliste doit être instaurée ? (1RJ)

A. Ceftriaxone seule

B. Ceftriaxone + Vancomycine

C. Ceftriaxone + Amoxicilline

D. Amoxicilline + Gentamicine

E. Cefotaxime + Amoxicilline

10. Une épidémie de méningite à LCS clair survient en été, touchant surtout enfants et jeunes adultes. Quels agents suspectez-vous ? (1RJ)

A. Entérovirus (Coxsackie, Echovirus)

B. *Haemophilus influenzae*

C. *Neisseria meningitidis*

D. *Streptococcus pneumoniae*

E. *Listeria monocytogenes*

11. Patient de 41 ans, diabétique, présente une méningite à LCS clair, lymphocytaire, normoglycorachique. Quelles conclusions ? (Les RJ)

A. Une origine virale bénigne peut être retenue sans explorations.

B. La normoglycorachie élimine une cause bactérienne.

C. Une tuberculose neuro-méningée ne peut être éliminée.

D. Une méningite à *Listeria monocytogenes* ne peut être éliminée.

E. Il est nécessaire d'orienter l'enquête étiologique par un interrogatoire ciblé (terrain, expositions, contagé).

12. Concernant la durée du traitement selon le germe, quelles affirmations sont exactes ? (Les RJ)

A. *Neisseria meningitidis* -> 7 jours

B. *Streptococcus pneumoniae* -> 10 à 14 jours

C. *Listeria monocytogenes* -> 10 jours

D. *Haemophilus influenzae* -> 6 semaines

E. LCS est négatif -> 30 jours

13. Concernant les Bêta-Lactamases à Spectre Elargi (BLSE), quelle(s) affirmation(s) est (sont) juste(s) ? (Les RJ)

- A. Elles sont naturellement produites par toutes les souches d'*Escherichia coli*.
- B. Elles hydrolysent les céphalosporines de 3^e génération (C3G).
- C. Elles sont inhibées par l'acide clavulanique et le tazobactam.
- D. Leur gène de résistance est exclusivement chromosomique.
- E. Elles confèrent une résistance aux carbapénèmes.

14. Dans la première heure de la prise en charge du sepsis : (Les RJ)

- A. Débuter une antibiothérapie IV à large spectre.
- B. Réaliser un remplissage vasculaire par cristalloïdes 30 mL/kg.
- C. Administrer systématiquement des corticoïdes d'emblée.
- D. Attendre les résultats de culture avant traitement.
- E. Utiliser un diurétique pour corriger l'oligurie.

15. Quel est le moment idéal pour réaliser un prélèvement d'hémocultures ? (Les RJ)

- A. Uniquement lorsque la fièvre dépasse 39°C.
- B. Dès l'apparition de frissons ou d'une ascension thermique.
- C. Systématiquement 2 heures après la prise d'un antipyrétique.
- D. En cas d'hypothermie (< 36°C).
- E. Toujours après avoir débuté une antibiothérapie probabiliste.

16. Une hémoculture positive est interprétée comme une vraie bactériémie si : (Les RJ)

- A. Plusieurs flacons sont positifs pour le même germe.
- B. Le délai de positivité est > 72 h.
- C. Le germe est typiquement pathogène (*S. aureus*, BGN).
- D. L'absence de syndrome infectieux est un argument.
- E. Le germe est un contaminant cutané.

17. Lorsqu'une candidémie est confirmée : (Les RJ)

- A. Une seule hémoculture positive suffit pour débiter le traitement.
- B. L'échocardiographie et le fond d'œil sont systématiques.
- C. L'antifongique de choix est une pénicilline.
- D. Le cathéter doit être conservé.
- E. On arrête le traitement dès l'apyrexie.

18. Concernant la transmission du VIH : (Les RJ)

- A. Le risque femme -> homme est supérieur.
- B. Le rapport anal réceptif est à haut risque.
- C. Les IST augmentent le risque
- D. L'allaitement est sans risque.
- E. La salive transmet fréquemment le VIH.

19. Chez un patient consultant 12 jours après un rapport à risque : (Les RJ)

- A. Une sérologie VIH négative élimine le diagnostic.
- B. L'antigène p24 peut être détectable.
- C. La charge virale peut dépasser 10⁶ copies/mL.
- D. Le Western-Blot est l'examen de choix.
- E. Le patient n'est pas contagieux à ce stade.

20. VIH/SIDA : Toxoplasmose cérébrale (Les RJ)

- A. Une sérologie toxoplasmique négative élimine le diagnostic.
- B. L'IRM montre typiquement des lésions en cocarde.
- C. Le diagnostic est toujours histologique.
- D. L'amélioration sous traitement est un argument diagnostique.
- E. Le traitement repose sur amphotéricine B.

21. SIDA : La prophylaxie primaire est indiquée : (Les RJ)

- A. Contre la pneumocystose si $CD4 < 200/mm^3$.
- B. Contre la toxoplasmose si IgG négative.
- C. Par cotrimoxazole.
- D. À vie même si les CD4 remontent.
- E. Uniquement après une infection opportuniste.

22. Un syndrome gastroentéritique fébrile survenant 48 h après ingestion de volaille insuffisamment cuite oriente vers : (1RJ)

- A. Campylobacter jejuni
- B. Salmonella enteritidis
- C. Staphylococcus aureus
- D. Clostridium botulinum
- E. Bacillus cereus

23. Concernant le syndrome dysentérique : (Les RJ)

- A. Il est dû à un mécanisme invasif.
- B. Les selles sont glaireuses et sanglantes.
- C. La fièvre est absente.
- D. Shigella est un agent fréquent.
- E. Il n'expose pas à des complications.

24. FBM (Fièvre Boutonneuse Méditerranéenne) : Concernant la chronologie : (Les RJ)

- A. L'éruption précède la fièvre.
- B. L'éruption apparaît en moyenne à J4.
- C. L'incubation est en moyenne de 6 jours.
- D. La fièvre disparaît spontanément en 48 h.
- E. Les céphalées sont tardives.

25. Chez quel patient doit-on toujours évoquer la leptospirose

- A. Adulte ayant nagé dans une rivière.
- B. Patient avec notion de contact avec les chiens.
- C. Travailleurs agricoles.
- D. Consommation de lait cru.
- E. Pique de tique.

27. Quels examens permettent de confirmer la rage humaine ?

- A. RT-PCR sur follicules pileux, salive, LCR, urine (pré-mortem).
- B. Immunofluorescence directe sur biopsie cérébrale (post-mortem).
- C. Sérologie anti-rabique.
- D. IRM cérébrale.
- E. Hémoculture.

28. Risque rabique : Prophylaxie Post-Exposition (PPE) : (Les RJ)

- A. Le protocole « Zagreb » comporte 4 injections selon le schéma 2-1-1.
- B. Le protocole « Essen » comporte 5 injections aux jours 0, 3, 7, 14 et 21.
- C. La voie intradermique n'est pas recommandée.
- D. Une personne correctement vaccinée reçoit un rappel uniquement à J0 et J3.
- E. En cas de réexposition < 3 mois après une PPE complète, une nouvelle PPE complète est indiquée.

29. Zona : Quelles affirmations sont correctes ? (Les RJ)

- A. Le diagnostic est clinique, basé sur la distribution dermatologique.
- B. Une sérologie antivirale est nécessaire pour confirmer le diagnostic.
- C. Le zona peut récidiver surtout chez les immunodéprimés.
- D. Le diagnostic repose sur la culture du virus.
- E. La fièvre est constante et nécessaire pour poser le diagnostic.

30. Brucellose aigue septicémique : Traitement de première intention chez l'adulte selon les recommandations ? (Les RJ)

- A. Doxycycline 100 mg x 2/j pdt 6 semaines.
- B. Rifampicine 900 mg/j pdt 6 semaines.
- C. Amoxicilline seule 1 g x 3/j x 2 semaines.
- D. Cotrimoxazole per os (TMP 320 mg / SMX 1600 mg) pdt 2 mois.
- E. Gentamicine en IM : 80 mg 2 fois/j pdt 7 à 14 jours.

31. Quels signes peuvent orienter vers une typhoïde chez un adulte ? (Les RJ)

- A. Fièvre en plateau prolongée.
- B. Diarrhée sanglante massive dès le début.
- C. Roséoles sur thorax/abdomen.
- D. Vomissements sévères systématiques.
- E. Polyarthrite migratrice isolée.

32. Quelles sont les complications graves les plus fréquentes à redouter lors d'une fièvre typhoïde ?

- A. Pneumonie bactérienne.
- B. Insuffisance rénale aigue.
- C. Péritonite.
- D. Hépatite.
- E. Hémorragie gastro-intestinale.

33. Devant une angine à fausses membranes, quelle est la conduite à tenir ? (Les RJ)

- A. Débuter immédiatement la sérothérapie antidiptérique.
- B. Réaliser des prélèvements puis attendre les résultats avant de traiter.
- C. Débuter une antibiothérapie (pénicilline ou macrolide).
- D. Administrer une vaccination immédiate en urgence.
- E. Faire un test MNI d'abord pour éliminer une mononucléose.

34. Parmi les propositions suivantes concernant le paludisme, indiquer celle(s) se rapportant à *Plasmodium falciparum* : (Les RJ)

- A. Le moustique tigre (*Aedes*) est le vecteur principal.
- B. La phase d'incubation est de 7 jours minimum.
- C. Le diagnostic d'urgence est sérologique.
- D. Les jeunes enfants sont particulièrement exposés aux accès graves.
- E. Le traitement fait appel au métronidazole.

35. Un "accès pernicieux" (paludisme grave) à *P. falciparum* est défini par la présence d'au moins un critère de gravité parmi les suivants, SAUF un. Lequel ? (1RF)

- A. Troubles de la conscience ou coma (Score de Glasgow < 11).
- B. Anémie profonde (Hémoglobine < 7 g/dL).
- C. Œdème lésionnel du poumon.
- D. Une fièvre supérieure à 41°C.
- E. Insuffisance rénale aiguë (créatinine > 265 µmol/L).

36. Mécanisme d'action physiopathologique de la toxine tétanique (tétanospasmine) (1RJ)

- A. Destruction directe et irréversible des motoneurones alpha.
- B. Bloque la recapture de dopamine et sérotonine.
- C. Migre par transport rétrograde et bloque la libération de GABA et glycine.
- D. Se lie aux récepteurs post-synaptiques d'acétylcholine causant une paralysie flasque.
- E. Provoque une démyélinisation des fibres périphériques.

37. Facteurs de mauvais pronostic du tétanos (1RF)

- A. Incubation < 7 jours
- B. Invasion < 2 jours
- C. Nouveau-né ou sujet âgé > 70 ans
- D. Existence d'un trismus
- E. Paroxysme

38. Concernant la prise en charge du tétanos, laquelle est fausse ? (1RF)

- A. Administration d'immunoglobulines antitétaniques spécifiques.
- B. Antibiothérapie par métronidazole.
- C. Soins locaux avec débridement de la porte d'entrée.
- D. Corticothérapie à forte dose pour contrôler les spasmes.
- E. Réanimation et sédation en cas de formes sévères.

39. Concernant les signes cliniques de la rubéole : (Les RJ)

- A. La fièvre disparaît dès l'apparition de l'éruption.
- B. L'éruption de la rubéole est scarlatiniforme.
- C. Elle est prurigineuse.
- D. Un catarrhe marque est habituel.
- E. L'état général est souvent bien conservé.

40. Une femme de ménage se pique avec une aiguille abandonnée. Elle consulte immédiatement. Quelles affirmations sont vraies ? (Les RJ)

- A. Rincer abondamment à l'eau puis désinfecter (Bétadine® ou Dakin®).
- B. Risque de transmission du VHB est faible.
- C. Instaurer systématiquement une prophylaxie antirétrovirale dans les 4 h.
- D. Prophylaxie antirétrovirale au plus tard dans les 4 jours.
- E. Pas d'indication de prophylaxie antirétrovirale car le risque est faible.

Examen neurologie q1 / 2026

Cas clinique 01 :

Patiente âgée de 66 ans, aux antécédents de néoplasie du sein, hypertendue sous diurétique et inhibiteur calcique, également diabétique sous insulinothérapie, consulte aux urgences à 16h pour une faiblesse musculaire de l'hémicorps gauche d'installation brutale ayant entraîné une chute de sa hauteur à 10h du matin. À l'interrogatoire : patiente consciente, coopérant, ouvre les yeux spontanément, réponse verbale ralentie et confuse, réponse motrice bien orientée à la stimulation douloureuse.

Examen des paires crâniennes : paralysie faciale intéressant l'étage inférieur gauche.

Examen des voies longues : hémiparésie gauche.

Examen somatique : ecchymose du pied droit, sans autre cause connue.

1. Concernant l'état de conscience de cette patiente, elle est scorée à l'échelle de Glasgow a:

- a) 15/15
- b) 14/15
- c) 13/15
- d) 12/15
- e) 11/15

2. Concernant le déficit moteur qu'elle a présenté :

- a) C'est une hémiparésie partielle
- b) C'est une hémiparésie totale
- c) C'est un syndrome alterne
- d) C'est une hémiparésie non proportionnelle
- e) Toutes les réponses sont fausses

3. Cette patiente a été bien orientée par le médecin de famille, qui a suspecté un accident vasculaire cérébral. Sur quel critère a-t-il suspecté ce tableau clinique ?

- a) Le mode d'installation des symptômes
- b) L'évolution du tableau clinique
- c) La notion de chute
- d) La notion d'insulinothérapie
- e) La notion de néoplasie

4. Quel est l'examen complémentaire de première intention dans ce tableau clinique ?

- a) Une IRM cérébrale
- b) Une IRM cérébro-médullaire
- c) Une TDM cérébrale sans injection
- d) Une TDM cérébro-médullaire sans injection
- e) Une TDM cérébrale avec injection de produit de contraste

5. Le résultat de l'examen complémentaire demandé est sans anomalie en dehors d'une atrophie corticale. Quel est votre diagnostic ?

- a) Un accident vasculaire cérébral hémorragique
- b) Un accident vasculaire cérébral ischémique
- c) Une thrombose veineuse cérébrale
- d) Pas d'atteinte du système nerveux central
- e) Les informations sont insuffisantes, demander un autre examen complémentaire

Cas clinique 02 :

Un homme âgé de 62 ans, diabétique sous insulinothérapie et hypertendu, consulte pour une faiblesse musculaire des 4 membres d'évolution ascendante. Il signale des troubles sensitifs, des paresthésies à type de fourmillements aux membres inférieurs. L'examen clinique et paraclinique est en faveur d'une polyradiculonevrite aigue.

1. Concernant cette affection, laquelle est juste ?

- a) C'est une urgence diagnostique et thérapeutique qui touche le système nerveux central
- b) C'est une urgence diagnostique et thérapeutique qui touche le système nerveux périphérique
- c) Elle touche les racines des nerfs crâniens et spinaux uniquement
- d) Elle touche le système nerveux central et/ou périphérique
- e) Toutes les réponses sont fausses

2. Concernant l'examen clinique de ce patient, les réflexes ostéotendineux sont :

- a) Présents
- b) Vifs et polycinétiques
- c) Pendulaires
- d) Vifs mais asymétriques
- e) Abolis

3. Quel est l'examen complémentaire de première intention ?

- a) Électroencéphalographie
- b) Électroneuromyogramme
- c) IRM cérébrale
- d) IRM cérébro-médullaire
- e) IRM cérébrale et EEG

4. Ce patient a été hospitalisé pour complément d'exploration et prise en charge. Quel est cet examen ?

- a) Bilan inflammatoire (VS & CRP)
- b) Ponction lombaire à la recherche d'éléments dans le LCR supérieurs à 100/mm³
- c) Ponction lombaire à la recherche d'éléments dans le LCR inférieurs à 10/mm³
- d) Biopsie nerveuse
- e) Biopsie musculaire

5. Quelle est la complication la plus redoutable dans cette affection ?

- a) Troubles visuels
- b) Paralysie faciale
- c) Troubles respiratoires
- d) Insuffisance rénale
- e) Atrophie musculaire

Questions indépendantes

11. Quelle est l'étape capitale dans l'examen neurologique ? (réponses justes)

- a) L'examen proprement dit
- b) Le regroupement syndromique
- c) La localisation topographique
- d) La nature de la lésion
- e) L'examen somatique

12. Pourquoi cette étape est-elle importante ? (réponses justes)

- a) Pour orienter le diagnostic
- b) Pour orienter le pronostic
- c) Pour orienter les examens complémentaires
- d) Pour orienter la thérapeutique
- e) Pour orienter l'évolution clinique

13. Un patient qui a une démarche talonnante avec trouble de la préhension aveugle présente : (réponses justes)

- a) Une atteinte cordonale postérieure
- b) Une atteinte neurogène périphérique
- c) Une atteinte cérébelleuse
- d) Une atteinte myogène
- e) Une atteinte extrapyramidale

14. Le maître symptôme de la maladie de Parkinson est : (réponses justes)

- a) La rigidité extrapyramidale
- b) Le tremblement de repos unilatéral
- c) La lenteur des mouvements
- d) La paralysie verticale de l'oculomotricité, surtout vers le bas
- e) Une démarche ébrieuse

15. La toxoplasmose cérébrale est : (réponses fausses)

- a) Due au parasite *Toxoplasma gondii*
- b) Le diagnostic est basé sur un faisceau d'arguments clinique, radiologique et sérologique
- c) Le plus souvent, le diagnostic différentiel se pose avec le lymphome cérébral primitif
- d) Le diagnostic est seulement clinique

16. Lors de l'examen du nerf optique, on explore : (réponses fausses)

- a) Le champ visuel
- b) L'acuité visuelle
- c) La papille
- d) La rétine
- e) Toutes ces réponses sont justes

17. Les céphalées migraineuses sont caractérisées par : (1 réponse fausse)

- a) Des hémicrâniées à bascule
- b) Le plus souvent pulsatiles, accompagnées de vomissements, photophobie et phonophobie
- c) Elles sont secondaires à un accident vasculaire cérébral ischémique
- d) L'examen neurologique est toujours normal
- e) L'accès migraineux dure entre 4 et 72 heures

18. La myopathie de Duchenne se manifeste par : (1 réponse fausse)

- a) Déficit moteur proximal
- b) Abolition des ROT
- c) Abolition de la contraction idiomusculaire
- d) Signe de Gowers
- e) Pseudo-hypertrophie des mollets

19. La forme commune de SLA associe : (1 réponse fausse)

- a) Des fasciculations
- b) Vivacité des réflexes ostéotendineux
- c) Des troubles sensitifs objectifs
- d) Une amyotrophie à début brachial
- e) Une atteinte des noyaux bulbaires

20. Dans le syndrome de Wallenberg, cochez la réponse fausse :

- a) Le patient présente un vertige rotatoire avec vomissements
- b) C'est un syndrome sensitif alterne
- c) L'hémiplégie est facio-brachio-crurale non proportionnelle
- d) C'est le syndrome de la fossette latérale du bulbe
- e) Le mode d'installation est brutal

21. Le syndrome de Weber : (1 réponse juste)

- a) Évoque une lésion protubérantielle
- b) Atteinte du III homolatérale à la lésion
- c) Hémiplégie homolatérale à la lésion
- d) Syndrome alterne sensitif

22. Ces symptômes évoquent une lésion médullaire, sauf un :

- a) Syndrome cordonal postérieur
- b) Paraparésie
- c) Troubles sphinctériens
- d) Crises d'épilepsie

23. La méningo-encéphalite herpétique : (réponse fausse)

- a) Le diagnostic de certitude repose sur la PCR de l'HSV dans le LCR
- b) Il faut attendre la preuve biologique pour commencer le traitement antiviral
- c) Lésion necrotico-hémorragique des lobes temporaux à l'imagerie
- d) L'EEG objective une activité périodique

24. L'étude du LCR en cas de tuberculose du SNC retrouve : (réponse fausse)

- a) Méningite lymphocytaire
- b) Hypochlorurachie
- c) Hyperproteinorachie
- d) Hyperglycorachie

25. L'hémorragie méningée spontanée grade III selon le grading de la WFNS est : (1 réponse juste)

- a) Patient score a 15 au Glasgow avec déficit moteur
- b) Patient scoré à 13-14 au Glasgow avec déficit neurologique
- c) Patient score a 13-14 au Glasgow sans déficit neurologique
- d) Patient score à 12 au Glasgow associe à un déficit neurologique

26. L'étiologie d'un saignement spontané dans les espaces sous-arachnoïdiens peut être causé par : (1 réponse fausse)

- a) Un traumatisme crano-encéphalique ancien remontant à l'enfance
- b) Un saignement d'une métastase cérébrale
- c) Une maladie de Moya Moya
- d) Une rupture d'un anévrisme artériel intracrânien

27. Les complications neurologiques majeures de l'hémorragie méningée par rupture d'un anévrisme artériel intracrânien sont : (1 réponse juste)

- a) Crise d'épilepsie, déshydratation, ischémie cérébrale
- b) Récidive hémorragique, vasospasme, hydrocéphalie
- c) Œdème pulmonaire aigu, fièvre à 40°, perturbation du bilan hépatique
- d) Trouble ionique, perturbation de la glycémie, trouble du rythme cardiaque

28. Les options thérapeutiques du traitement d'un anévrisme artériel rompu : (1 réponse juste)

- a) Traitement médical
- b) Abstention thérapeutique
- c) Traitement microchirurgical ou traitement endovasculaire
- d) Radiochirurgie

29. Dans quel cas l'HIC est-elle le plus souvent retrouvée ? (1 réponse juste)

- a) Scaphocephalie
- b) Plagiocephalie
- c) Oxycéphalie
- d) Trigonocephalie

30. Chez une fillette de 14 mois, vous constatez une asymétrie faciale, une exophtalmie et une syndactylie osseuse. À quoi pensez-vous ? (1 réponse juste)

- a) Syndrome de Crouzon
- b) Syndrome de Marfan
- c) Syndrome de Pfeiffer
- d) Syndrome d'Apert

31. En cas de craniosténose, quels examens demandez-vous pour étayer le diagnostic ? (1 réponse fausse)

- a) Radiographie du crane
- b) EMG
- c) Fond d'œil
- d) TDM cérébrale en 3D

32. Quel est l'âge idéal pour opérer une craniosténose ? (1 réponse juste)

- a) À la naissance
- b) Après 2 ans
- c) Entre 6 mois et 18 mois
- d) En anténatal

33. Dans la méningocèle, le sac herniaire est composé de : (réponses justes)

- a) Méninges et éléments nerveux
- b) Méninges et LCR
- c) Moelle épinière
- d) Queue de cheval
- e) Toutes les reponses sont fausses

34. La myéломéningocèle est caractérisée par : (réponses justes)

- a) Ne contient pas d'éléments nerveux
- b) Un sac qui ne contient que du LCR
- c) Absence de troubles neurologiques
- d) Absence d'hydrocéphalie le plus souvent
- e) Absence de fermeture cutanée

35. La myéломéningocèle : (réponses fausses)

- a) Peut être diagnostiquée avant la naissance
- b) Est due à la déhiscence de l'arc postérieur d'une vertèbre
- c) Est souvent associée a une hydrocéphalie communicante
- d) Expose au risque de méningite si elle est rompue
- e) La prévention est basée sur l'administration d'acide folique au premier trimestre de la grossesse

36. Intérêt du segment vertébral moyen : (réponses justes)

- a) Pour connaître l'anatomie du rachis cervical
- b) Pour mieux comprendre la statique rachidienne
- c) Pour permettre la classification des lésions post-traumatiques
- d) Pour une bonne conduite thérapeutique

A (a+b) B (c+d) C (a+c) D (b+d)

38. L'aspect radiologique en marche d'escalier est caractéristique de : (1 réponse juste)

- a) Fracture du mur postérieur
- b) Luxation uni-articulaire
- c) Entorse grave
- d) Luxation bi-articulaire
- e) Toutes ces réponses

39. L'apophyse odontoïde est formée de : (réponses justes)

- a) Corps
- b) Col
- c) Arc antérieur
- d) Base
- e) Protubérance
- f) Apex

A (a+b+c) B (a+d+e) C (b+e+f) D (a+f+c) E (b+d+f)

40. L'instabilité rachidienne est : (réponses justes)

- a) Atteinte de la colonne vertébrale postérieure
- b) Perte de la cohésion entre les différentes structures intracanalaires
- c) Perte de la cohésion entre les structures ostéo-disco-ligamentaires
- d) Atteinte du segment mobile rachidien
- e) Lésion évolutive

A (a+b+c) B (a+c+d) C (c+d+e) D (b+d+e) E (a+c+e)

Examen Neuro G2 / 2026

1) Au cours de la maladie d'Alzheimer, le défaut de mémorisation réside dans ?

- a. Encodages
- b. Stockage
- c. Récupération
- d. Toutes les réponses sont justes
- e. Toutes les réponses sont fausses

2) Le diagnostic de certitude dans la maladie d'Alzheimer repose sur :

- a. Les signes cliniques
- b. L'interrogatoire
- c. L'IRM cérébrale
- d. La ponction lombaire
- e.) L'examen anatomopathologique

3) Le syndrome occipital associe tous ces signes sauf un :

- a. Epilepsie d'allure visuelle
- b. Cécité
- c. Hémianopsie latérale homonyme
- d. Atteinte du nerf optique
- e. Troubles mnésiques

4) Le syndrome frontal associe tous ces signes sauf un :

- a. Troubles moteurs
- b. Aphasie sensitive de Wernicke
- c. Apraxie d'habillage
- d. Troubles de la mémoire
- e. Indifférence affective

5) Choisir la réponse correcte:

- a. Les céphalées primaires sont les plus rares parmi toutes les céphalées et les algies faciales.
- b. Les céphalées aiguës sont toujours secondaires à une urgence neurologique.
- c. La douleur en rapport avec une céphalée de type migraine est unilatérale ou à bascule, mais jamais bilatérale.
- d. La douleur en rapport avec une névralgie faciale essentielle est unilatérale ou à bascule, mais jamais bilatérale.
- e. L'absence d'un fond douloureux permanent entre les accès des céphalées une grande valeur sémiologique.

6) Parmi ces critères d'alerte face à des céphalées, quelle est la réponse fausse

- a. La présence de fièvre sans d'autres signes neurologiques
- b. L'Age du patient
- c. La présence d'anomalies au fond d'œil
- d. La début brutal
- e. L'association à des anomalies de l'examen neurologique

7) Le scanner cérébral dans l'AVC ischémique (Réponse Juste)

- a. Est l'examen de choix pour le diagnostic
- b. Est l'examen de première intention.
- c. Est toujours normal les premières heures
- d. N'a pas d'intérêt en cas d'indication de thrombolyse.
- e. Il permet d'éliminer d'autres diagnostics.

5) En cas de tableau clinique évoquant un accident vasculaire cérébral (AVC), parmi les éléments suivants par quoi allez-vous commencer ?

- a. Faire un ECG
- b. Faire un scanner cérébral.
- c. Demander aux parents l'horaire de survenue du déficit rapporté
- d. Prendre la pression artérielle
- e. Faire une IRM cérébrale

9) Devant un jeune patient qui présente des troubles de l'équilibre et de la marche évoluent progressivement, issu d'un mariage consanguin avec des cas similaires dans la famille : quelle est l'hypothèse diagnostique la plus probable chez lui :

- a. Maladie du Huntington
- b. Atrophie multi systématisée.
- c. Sclérose latérale amyotrophique
- d. Ataxie autosomique récessive
- e. Maladie de pompe

10). Parmi les propositions suivantes concernant les mouvements anormaux, quelle est la réponse juste :

- a. Les myoclonies sont toujours d'origine corticale
- b. La dystonie provoque des postures normales non gênantes.
- c. Les mouvements choréiques sont stéréotypés et répétitifs.
- d. Les dyskinésies sont toujours proximales,
- e. Les mouvements anormaux peuvent être hypokinétiques ou hyperkinétiques.

11) À quel âge apparaissent généralement les premiers symptômes de la myopathie de Duchenne ?

- a. À la naissance
- b. Entre 2 et 5 ans
- c. Entre 10 et 15 ans
- d. A l'âge adulte
- e. Début variable entre 1 et 7 ans.

12) Parmi les éléments suivants, lequel est le signe cutané spécifique de la dermatomyosite:

- a. Un érythème malaire (en "masque de loup").
- b. Des nodules sous-cutanés.
- c. Un rash héliotrope (coloration violacée des paupières).
- d. Un psoriasis des coudes et des genoux.
- e. Toutes les réponses sont justes.

13) A propos de l'hémorragie méningée, quelle est la proposition juste :

- a. L' hypertension artérielle est une étiologie.
- b. Hypertension artérielle est un facteur de risque.
- c. Le début est souvent subaiguë, parfois aiguë.
- d. Est une affection fréquente parmi les accidents vasculaires cérébraux.
- e. Elle est de bon pronostic.

14) La myéloméningocèle: (RF)

- a. Est une malformation congénitale en rapport avec un défaut de fermeture du tube neural
- b. s'accompagne toujours d'une hydrocéphalie
- c. S'accompagne toujours de troubles neurologiques.
- d. siège en région dorso-lombaire
- e. Nécessite un traitement chirurgical

15) Le syndrome de Guillain Barre est caractérisé par (RJ) :

- a. Une évolution en quatre phases.
- b. Une évolution descendante du déficit moteur et / ou sensitif.
- c. Une nette prédominance féminine.
- d. Nodo et para-nodopathes sont les formes les plus rapides.
- e. Toutes les réponses sont justes

16) la sclérose en plaque (SEP) est caractérisée par (RJ) :

- a. Quatre formes évolutives,
- b. Elle est sans prédominance d'âge
- c. La neuromyéélite optique est reconnue actuellement en tant qu'une des formes cliniques de la SEP
- d. Son traitement repose sur des immunosuppresseurs.
- e. Trois voles thérapeutiques sont indissociables pour sa prise en charge : traitement de la poussée, traitement symptomatique et le traitement de fond.

17) La tuberculose du système nerveux central (RF):

- a. Responsable d'une atteinte aiguë et disséminée,
- b. Son évolution peut être sub-aiguë et localisée.
- c. Caractérisée par un mauvais pronostic fonctionnel et vital.
- d. Sa prise en charge se fait selon le PNAT (programme national anti-tuberculeux).
- e. Est une affection très rare en Algérie actuellement

Cas clinique :

Un patient âgé de 60 ans est adressé en consultation de neurologie pour prise en charge d'un tremblement de repos du membre supérieur gauche en distal évoluant depuis une année progressivement vers l'aggravation.

L'examen neurologique retrouve un tremblement de repos unilatéral du membre supérieur gauche, une rigidité prédominant sur l'hémicorps gauche et une diminution du ballant du membre supérieur gauche à la marche.

18) Q1) Quel est votre diagnostic ? :

- a. Syndrome parkinsonien de début asymétrique.
- b. Syndrome de Westphal
- c. Maladie de Wilson.
- d. Démence à corps de Lewy
- e. Paralyse supra nucléaire progressive.

19) Q2) Pour confirmer le diagnostic de maladie de Parkinson vous faites :

- a. Un test à la L-Dopa.
- b. Une imagerie cérébrale notamment l'IRM cérébrale.
- c. Un electro-neuro-myogramme (ENMG)
- d. Un electro-encephalogramme (EEG)
- e. Une ponction lombaire (PL).

20) Q3) Quel est la forme clinique de la maladie de Parkinson (RJ):

- a. Maladie de Parkinson forme akinéto rigide.
- b. Maladie de Parkinson avec camptocormie.
- c. Maladie de Parkinson avec attitude guindée.
- d. Maladie de Parkinson forme trémo-akinéto-rigide
- e. Syndrome parkinsonien avec retro pulsion et chutes fréquentes.

21) Q4) Dans la maladie de Parkinson, quel est le symptôme le plus fréquent qui amène le malade à consulter ? (RJ)

- a. Le tremblement de repos unilatéral en distal.
- b. La lenteur des mouvements
- c. La rigidité plastique
- d. Les chutes fréquentes
- e. Les troubles oculomoteurs.

22) Q5) Quel est le maître symptôme de la maladie de Parkinson ? (RJ)

- a. La lenteur des mouvements.
- b. Un tremblement de repos unilatéral en distal, sans bilatéralisation.
- c. Le tremblement essentiel
- d. Le tremblement intentionnel
- e. Les troubles de la marche.

23) Devant une compression médullaire : (RJ)

- a. Des troubles sensitifs atteignant les mamelons indiquent une atteinte de niveau D1
- b. Elle impose la réalisation en urgence d'une IRM médullaire.
- c. Elle impose une ostéosynthèse en urgence.
- d. Le syndrome du cône terminal donne une atteinte médullaire isolée.
- e. Les troubles sphinctériens sont au premier plan.

24). Le syndrome syringomyelique : (Réponse Fausse)

- a. Se manifeste par un syndrome pyramidal en sous lésionnel
- b. l'imagerie montre une cavité centromédullaire de nature liquidienne.
- c. Se manifeste par des troubles de la sensibilité cordonal postérieur.
- d. Peut entraîner une amyotrophie.)
- e. chez l'enfant faut rechercher une malformation de Chiari.

25) Parmi les signes d'appel des tumeurs cérébrales sont, de manière didactique, regroupés en trois grands syndromes. (RJ)

- a. Syndrome endocrinien (hypothalamo-hypophysaire)
- b. Syndrome d'hypertension intracrânienne
- c. Syndrome neurologique topographique
- d. Syndrome opto-chiasmatique
- e. Toutes les réponses sont justes.

26) Le craniopharyngiome est une tumeur bénigne, d'origine embryonnaire, les circonstances de découverte (RJ)

- a. Syndrome dysmorphique lié à une hypersécrétion de GH
- b. Diabète Insulino-dépendant.
- c. Syndrome opto-chiasmatique
- d. Trouble de la croissance avec retard staturo-pondérale
- e. Les réponses b c et d sont justes

27) Les caractéristiques de la trigonocéphalie sont : (RJ)

- a. Bourrelet médian occipital palpable
- b. Front élargi
- c. Aspect triangulaire du front
- d. Hypertélorisme

25) Concernant le traitement des craniosténoses, quelle proposition est correcte ?

- a. La strip-craniectomie endoscopique est préférentiellement indiquée après l'âge de 3 ans.
- b. Le remodelage avec volets osseux libres permet une expansion crânienne plus large que la craniotomie linéaire.
- c. la chirurgie est réalisée idéalement entre 2 et 3 ans pour la majorité des craniosténoses simples,
- d. Le traitement médical seul est recommandé en cas d'hypertension intra crânienne avérée.

29) Le syndrome cérébelleux comporte tous ces signes sauf (RF) :

- a. Dysmétrie
- b. Hypotonie
- c. Exagération des réflexes de posture
- d. Ataxie
- e. Troubles de l'élocution.

30) L'hydrocéphalie à pression normale se caractérise par : (RJ)

- a. Ataxie
- b. Céphalées avec œdème papillaire au FO
- c. Trouble de la marche
- d. Troubles secondaires à l'atteinte des voies longues.
- e. C, D sont justes.

31) L'hématome sous dural est une collection du sang : RJ

- a. Entre le crane et la dure mère
- b. Entre la dure mère et l'arachnoïde
- c. Entre l'arachnoïde et la pie mère
- d. Entre la pie mère et le cortex
- e. Est un hématome qui est toujours aigu

32) Au cours d'une hypertension intracrânienne (HIC), la phase de compensation

- a. Une réduction du volume veineux extracranien
- b. Une réduction du volume des ventricules
- c. Une diminution des résistances vasculaires intracrâniennes
- d. Une augmentation de la pression artérielle moyenne
- e. Réponses A et B

33) On doit rechercher une lésion du rachis cervical face à toutes ces situations

- a. D'un polytraumatisme
- b. D'une fracture du massif facial.
- c. Fracture osseuse de jambe
- d. Des troubles respiratoires
- e. D'un traumatisme crânien

34) Les malformations cervico-occipitales peuvent occasionner: (RF)

- a. Un syndrome pyramidal
- b. Un syndrome cérébelleux
- c. Des vertiges
- d. Une ophtalmoplégie internucléaire
- e. Des troubles de la déglutition.

35). Les signes cutanés d'une dysraphie sont : (RJ)

- a. Un lipome lombosacré
- b. Un angiome
- c. Une atrophie cutanée
- d. Une touffe de cheveux
- e. Toutes ces réponses sont justes

36). Les traumatismes du rachis cervical : (RF)

- a. Prédomine chez les hommes
- b. Les accidents de la circulation sont les étiologies les plus fréquentes
- c. Le traitement est exclusivement chirurgical
- d. Les mécanismes sont variables
- e. Le ramassage du blessé nécessite l'immobilisation du cou

37) Le score de GLASGOW (RF)

- a. Il est grave si le patient est scoré à 1
- b. Appréciation de l'ouverture des yeux
- c. Appréciation de la réponse verbale
- d. Appréciation par la réponse motrice
- e. est l'échelle utilisée pour l'appréciation de l'état de conscience chez un malade polytraumatisé

38) Les tumeurs de la fosse cérébrale postérieure constituent une urgence diagnostique et thérapeutique chez l'enfant : (RJ)

- a. Le médulloblastome représente la tumeur la plus fréquente
- b. Le tableau clinique est dominé par un syndrome d'HIC associé à un syndrome cérébelleux statique
- c. Atteinte de nerfs oculomoteurs : IV et VI
- d. Un syndrome pyramidal
- e. Toutes ces réponses sont justes

39) Le signe non évocateur de crise d'épilepsie devant une perte de connaissance

- a. Perte d'urine
- b. Morsure latéral de la langue
- c. Secousses toniques
- d. Secondaire à une décharge corticale
- e. Déviation de la tête et des yeux

40) L'absence est définie par : (RF)

- a. Une rupture de contact de quelques secondes
- b. Un début et fin brusques
- c. Un tracé électroencéphalographie caractéristique
- d. Dite petit mal.
- e. Une diversité des formes cliniques.

Examen Neurologie G3 / 2026

1) Chez un patient suspect de myasthénie gravé l'élément le plus spécifique du diagnostic est:

- A. Une fatigabilité musculaire à l'examen clinique
- B. Un ptosis fluctuant aggravé à l'effort
- C. La présence d'anticorps anti-récepteurs de l'acétylcholine
- D. Une amélioration transitoire après repos
- E. Une atteinte prédominante des muscles oculaires

2). Concernant la myosite à inclusions, quelle affirmation est correcte ?

- A. Elle touche principalement l'enfant
- B. Elle répond très bien à la corticothérapie
- C. La faiblesse musculaire est uniquement proximale
- D. Elle est associée à un risque élevé de néoplasie
- E. Elle associe une atteinte proximale et distale, souvent asymétrique

3) Le syndrome de Pancoast Tobias correspond à: la ou les réponses justes (RJ)

- A. Une atteinte inflammatoire aiguë du plexus brachial
- B. Une atteinte dégénérative chronique du plexus brachial
- C. Une atteinte traumatique du plexus cervical
- D. Une atteinte compressive du plexus brachial par une tumeur de l'apex pulmonaire
- E. Associe un syndrome de Claude Bernard Horner

4) La neuropathie sensitive se caractérise principalement par une ou plusieurs réponses justes:

- A. Une atteinte des motoneurones périphérique
- B. Une atteinte des corps cellulaires des neurones sensitifs
- C. Une atteinte des plaques neuromusculaires
- D. Une atteinte des fibres musculaires.
- E. Est synonyme d'une ganglionopathie

5) Pour établir rétrospectivement le diagnostic de crise tonico-clonique généralisée, quel (s) est (sont) les éléments qui éliminent une syncope:

- A. Une morsure latérale de langue
- B. Une perte d'urine
- C. Une phase confusionnelle post-critique
- D. Une perte de connaissance de durée brève
- E. Des nausées

6) Parmi les propositions suivantes, quelle (s) est ou sont celles qui plaident en faveur d'une épilepsie généralisée idiopathique :

- A. Une imagerie normale
- B. Des anomalies paroxystiques bilatérales et synchrones à l'EEG
- C. Un retard du développement psycho-moteur
- D. Une trace EEG de fond normal
- E. L'examen neurologique retrouve des signes de focalisation

7) Parmi les éléments suivants lequel est le plus évocateur d'un infarctus cérébral en phase aiguë

- A. Déficit moteur rapidement progressif des 4 membres
- B. Apparition brutale d'un déficit moteur ou sensitif
- C. Céphalées aiguës en coup de tonnerre
- D. Une confusion mentale
- E. Tremblements de repos

8) Quel traitement doit être initié en urgence chez un patient avec un infarctus cérébral ischémique sans contre-indications et dans les délais recommandés ?

- A. Thrombolyse intraveineuse par rt-PA
- B. Aspirine 500 mg IV
- C. Héparinothérapie à dose curative
- D. Corticothérapie à forte dose
- E. Bêtabloquant IV

9) Complications des tumeurs intracrâniennes :(RF)

- A. En cas d'engagement temporal, on observe un syndrome pyramidal homolatéral à la lésion
- B. Le Traitement en urgence de l'hydrocéphalie est la dérivation ventriculo péritonéale
- C. Le Traitement de l'hydrocéphalie non communicante est la ventriculo cisternostomie
- D. Un opisthotonos douloureux vous oriente vers un engagement cérébelleux
- E. Un syndrome associant hémiparésie ; paralysie des nerfs crâniens et céphalées vous oriente vers un engagement mésencéphalique ou protubérantielle.

10) Bilan paraclinique d'un syndrome de masse cérébrale: réponse (s) fausse (s)

- A, Ophtalmoscopie
- B. IRM cérébrale
- C. PL systématique
- D. TDM Cérébrale
- E. Examen anatomopathologique de la lésion (après biopsie ou exérèse chirurgicale)

Cas clinique :

Une patiente de 32 ans consulte pour une baisse de l'acuité visuelle de l'œil droit, installée il y a 3 jours, associée à des douleurs notamment lors des mouvements oculaires.

- L'interrogatoire vous apprend qu'elle avait présente il y a un an; une faiblesse musculaire du membre inférieur gauche la gênant à la marche mais devant son amélioration spontanée elle n'a pas consulté un médecin.
- L'examen neurologique retrouve un bon état général, une baisse de l'acuité visuelle cotée à 4/10 à droite, le reste de l'examen retrouve aux membres inférieurs : un discret déficit moteur à droite, des réflexes tendineux vifs et diffusés, un signe de Babinski à droite, une diminution marquée de la pallesthésie aux membres inférieurs et une urgurie.

11) L'atteinte visuelle évoque : (RJ)

- A. Une myasthénie
- B. Une ophtalmoplégie inter nucléaire antérieure droite
- C. Une névrite optique retro bulbaire droite
- D. Une uvéite
- E. Une migraine ophtalmique

12) L'examen des voies longues retrouve : (déterminez la ou les réponses justes)

- A. Un syndrome pyramidal
- B. Un syndrome cérébelleux
- C. Un syndrome cordonal postérieur aux membres inférieurs
- D. Une impériosité mictionnelle
- E. Un syndrome extra pyramidal

3) Vous demandez quel examen(s) complémentaire(s) ? (RJ)

- A. IRM cérébrale
- B. EEG
- C. Ponction lombaire
- D. ENMG
- E. IRM médullaire

- L'IRM cérébrale retrouve un hyper signal en 12 du nerf optique droit avec des lésions demyélinisantes de la substance blanche en periventriculaire et une lésion médullaire dorsale sans prise de contraste.
- L'étude du LCR retrouve des bandes oligoclonales dans le LCR

14) Quel serait le diagnostic le plus probable ? (RJ)

- A. Sclérose en plaques forme primaire progressive
- B. Sclérose en plaques forme rémittente récurrente
- C. neuropathie optique idiopathique
- D. Une neuromyélite optique de Devic
- E. Une EMAD

15) Le système limbique est très important dans :

- A. La régulation du comportement.
- B. La production des émotions
- C. La mémoire
- D. La pallesthesie
- E. La praxie.

16) La compression médullaire peut siéger : la ou les réponses justes

- A Au niveau cervical
- B Au niveau thoracique
- C. Au niveau lombaire au-dessus de L1
- D. Au niveau de la moelle allongée
- E. A la queue de cheval

17) L'exploration du liquide céphalo-rachidien, à l'état normale, retrouve:

- A. Une pression inférieure ou égale à 20 mmH2O.
- B. Protéinorachie inférieure ou égale à 0,4 g/l
- C. Protéinorachie inférieure ou égale à 0,4 mg/l
- D. Une pression inférieure ou égale à 20 cmH2O.
- E. Absence totale d'éléments cellulaires

18) La névralgies essentielle du trijumeau: la ou les réponses justes

- A. Est plus fréquente que la névralgie secondaire du trijumeau.
- B. Survient chez les sujets très âgés de sexe masculin.
- C. présente une douleur à bascule
- D. atteint plus fréquemment la branche ophtalmique.
- E. Plus fréquente chez la femme après 50 ans.

19- Le syndrome cérébelleux comporte la ou les signes suivants: (RF)

- A. Dysmétrie
- B. Hypotonie
- C. Exagération des réflexes ostéotendineux
- D. Nystagmus
- E. Troubles du langage

20 - Le syndrome parkinsonien comporte tous ces signes sauf (RF) :

- A. Tremblement de repos
- B. Apraxie de l'habillage précoce
- C. Akinésie
- D. Réflexe nasopalpebral inépuisable
- E. Signe de l'oreiller psychique

21). L'hydrocéphalie a pression normale se caractérise par : (la ou les réponses justes,)

- A.) Ataxie
- B. Céphalées
- C. Eclipses visuelles
- D. Troubles des fonctions supérieures
- E. Œdème papillaire au FO

22 - La maladie de Charcot-Marie-Tooth est : (RF)

- A- Une maladie génétique
- B- Le début remonte à l'enfance
- C- L'étude de l'électroneuromyogramme a un grand intérêt
- D- L'évolution est progressive
- E- la corticothérapie améliore le pronostic fonctionnel.

23) Le syndrome cordonal postérieur se manifeste par (RF)

- A. Une ataxie aggravée par la fermeture des yeux
- B. Un signe de Lhermitte
- C. Une Marche talonnante
- D. Une atteinte de la voie extra-lemniscale
- E. Une apallésie testée au diapason

24- Le Syndrome frontal se manifeste par tous ces signes sauf :

- A. Troubles de la marche
- B. Absence des réflexes archaïques
- C. Des troubles psychos comportementales
- D. Une Euphorie
- E. Comportement d'urination

25- L'Hématome sous-dural est une collection de sang siégeant: (RJ)

- A. Entre la tablette interne et la dure-mère.
- B. Entre la dure-mère et l'arachnoïde.
- C. Entre l'arachnoïde et la pie-mère.
- D. Entre la pie-mère et le cortex.
- E. Est un hématome qui est toujours aigu.

26) La neuropathie diabétique : (RF)

- A. Est une complication fréquente
- B. Est une atteinte des troncs nerveux
- C. L'examen electroneurophysiologique permet le diagnostic
- D. Les nerfs oculomoteurs sont rarement atteints,
- E. L'équilibre du diabète a un effet bénéfique

27) L'oxycéphalie est la craniosténose : (RF)

- A. La plus fréquente en Afrique du nord
- B. Peut se compliquer de troubles visuels
- C. Due à la fermeture des sutures coronale
- D. Entraîne une microcranie
- E. Entraîne souvent un retard intellectuel

28) Le syndrome de parinaud : (RJ)

- A. Est dû à une atteinte au niveau de la lame tectale du mésencéphale
- B. Souvent secondaire à une lésion de la région pinéale
- C. Se caractérise par une atteinte de la verticalité du regard
- D. Se caractérise par une paralysie de la convergence
- E. Les propositions a, b, et c sont justes

29) Le syndrome occipital associe tous ces signes : (la ou les réponses fausses)

- A. Epilepsie d'allure visuelle
- B. Cécité
- C. Hémianopsie latérale homonyme
- D. Atteinte du nerf optique
- E. Troubles mnésiques

30) Le syndrome de Wallenberg associé tous ces signes : (la ou les réponses fausses)

- A. Hypoesthésies de l'hémiface
- B. Tetraparesie spastique
- C. Syndrome cérébelleux
- D. Troubles sensitifs
- E. Vertiges

31) Concernant le traitement des craniosténoses, quelle(s) proposition(s) est/sont correcte(s)

- A. La strip-craniectomie endoscopique est préférentiellement indiquée après l'âge de 3 ans.
- B. Le remodelage avec volets osseux libres permet une expansion crânienne plus large que la craniotomie linéaire.
- C. la chirurgie est réalisée idéalement entre 6-9 mois pour la majorité des craniosténoses simples.
- D. Le traitement médical seul est recommandé en cas d'hypertension intracrânienne avérée.
- E. toutes ces réponses sont justes

32) La maladie de Friedrich est caractérisée par : RF

- A. Les signes évoquant une atteinte cérébelleuse sont inconstants
- B. Le syndrome neurogène périphérique a prédominance motrice
- C. Une atteinte extraneurologique
- D. L'âge de début est souvent tardif
- E. Mutation d'une protéine mitochondriale.

33) Quelle association clinique est caractéristique du syndrome de Millard-Gubler(RJ) :

- A-Paralysie faciale périphérique homolatérale et une hémiparésie contralatérale
- B- paralysie du nerf oculomoteur commun homolatérale et une hémiparésie contralatérale
- C-paralysie faciale centrale homolatérale et une hémiparésie contralatérale
- D-Paralysie du nerf abducens homolatérale et une hémiparésie contralatérale
- E- Une ataxie cérébelleuse homolatérale et une hémiparésie contralatérale

34) La symptomatologie motrice de la maladie de Parkinson comprend : (RF)

- A. Lenteur des mouvements, rigidité extrapyramidale, tremblement de repos distal de début asymétrique.
- B. hypertonie spastique.
- C. démarche festinant avec attitude voûtée en avant.
- D. la symptomatologie motrice est dopa résistante.
- E. Hypotonie plastique.

35) L'anomalie génétique de la maladie de Parkinson dans les formes autosomiques dominantes dans la population maghrébine est :

- A. Mutation dans le gène alpha synucléine
- B. Mutation R258Q dans le gène SYNJ1
- C. Une délétion télomérique
- D. Une délétion centromérique
- E. Mutation G2019S du gène leucine rich-repeat kinase2 (LRRK2)

36) Le syndrome syringomyélique : la ou les réponses fausses

- A. Se manifeste par un syndrome pyramidal en lésionnel.
- B. L'imagerie montre une cavité centromédullaire de nature liquidienne.
- C. Se manifeste par des troubles de la sensibilité cordonal postérieur.
- D. Peut entraîner une amyotrophie.
- E. chez l'enfant faut rechercher une malformation de Chiari.

37) En pratique courante, le diagnostic de la maladie d'Alzheimer repose sur les signes suivants : réponse (s) juste(s):

- A. Les signes cliniques
- B. les tests neuropsychologiques
- C. L'IRM cérébrale
- D. La ponction lombaire.
- E. L'examen anatomopathologique

38) Le syndrome frontal associe tous ces signes sauf : réponse (s) fausse (s)

- A. Troubles de comportement
- B. Apraxie d'habillage
- C. Troubles dysexecutifs.
- D. Indifférence affective
- E. Aphasie sensitive

39) Les signes évocateur d'une hydrocéphalie chez un nourrisson est (RF)

- A. augmentation du périmètre crânien
- B. paralysie VI
- C. hypotonie axiale
- D. vomissements
- E. œdème au FO

40) La malformation de Dandy- Walker est:

- A. une agénésie du lobe occipital
- B. une agénésie du corps calleux
- C. une agénésie vermienne
- D. Peut être associée à un angiome facial et/ ou une fente palatine
- E. est toujours associée à angiome facial et une fente palatine.

Examen Neuro G 4/ 2026Cas clinique :

Femme âgée de 42 ans est amenée aux urgences. Elle a présenté un épisode de céphalées brutales évoluant depuis le matin même, alors qu'elle faisait son ménage. Vous retrouvez lors de votre examen clinique une patiente consciente mais désorientée. Elle répond correctement à vos questions, n'ouvre les yeux que lorsque vous faites du bruit, et serre les deux mains sur la table.

L'examen retrouve des pupilles intermédiaires, égales et réactives, il n'y a pas de troubles oculomoteurs. Ses céphalées persistent et sont accompagnées de vomissements. Vous retrouvez également une nuque raide chez cette patiente apyrétique.

1. Quel(s) diagnostic(s) suspectez-vous ? (la ou les réponses justes)

- A. Méningite
- B. Hémorragie méningée
- C. Engagement temporal
- D. Hématome extradural
- E. Rupture d'anévrisme

2. Quel est son score de Glasgow ? (réponses justes)

- A. 7/15
- B. 3/15
- C. 13/15
- D. 10/15
- E. 15/15

3. Pour affiner l'examen clinique, quels sont les signes à rechercher ? (réponses justes)

- A. Signe de Kernig
- B. Signe de Babinski bilatéral
- C. Hypoacousie
- D. Anomalies au fond d'œil
- E. Convulsions

4. Quel(s) examen(s) paraclinique(s) va/vent confirmer votre diagnostic clinique ? (la ou les réponses justes)

- A. L'EEG
- B. L'angiographie cérébrale
- C. Le scanner cérébral sans injection de produit de contraste
- D. L'IRM cérébrale
- E. L'examen à l'ophtalmoscope

5. 12 heures après son admission, la patiente présente une majoration des troubles de la conscience.

Que redoutons-nous comme complications majeures ? (la ou les réponses justes) :

- A. Vasospasme
- B. Hydrocéphalie aiguë
- C. Hypotension cérébrale
- D. Abscès cérébral
- E. Troubles métaboliques

6. Au cours de la sclérose en plaques : (la ou les réponses justes)
- A. Les anomalies des potentiels évoqués visuels sont habituelles
 - B. Il existe souvent une sécrétion intrathécale d'immunoglobulines
 - C. La protéinorachie est en règle supérieure à 1 g/l
 - D. Il existe une lymphocytose du LCR en règle supérieure à 100 éléments par mm³
 - E. L'imagerie par résonance magnétique du cerveau est souvent normale
7. Une femme de 30 ans consulte pour des dysesthésies apparues il y a un mois au niveau de l'hémicorps droit. A l'examen, on retrouve des troubles de la sensibilité lemniscale hémicorporels droits et un syndrome quadripyrimal. La sclérose en plaques est un diagnostic possible. Toutes les propositions suivantes sont compatibles avec cette hypothèse sauf :
- A. Aucun antécédent neurologique
 - B. Existence de troubles sphinctériens
 - C. Les potentiels évoqués visuels sont normaux
 - D. Protéinorachie à 1,20 g/l
 - E. Aspect normal du nerf optique au fond d'œil et à l'IRM
8. Le traitement par corticoïdes de la sclérose en plaques : (la ou les réponses justes)
- A. Doit être continu en permanence
 - B. Doit être réservé aux poussées
 - C. Ne doit jamais être mis en œuvre
 - D. Est capable de prévenir les récurrences
 - E. Peut comporter des doses massives de manière transitoire
9. À propos de la sclérose en plaques, il est généralement admis que : (la ou les réponses justes)
- A. La maladie est rare dans les zones subtropicales
 - B. Il existe une corrélation entre l'incidence de la maladie et les antigènes du système d'histocompatibilité
 - C. Une lymphocytose modérée sans élévation de la Protéinorachie est évocatrice
 - D. La première poussée ne survient habituellement pas après l'âge de 50 ans
 - E. Les troubles de l'oculomotricité sont exceptionnels
10. Le syndrome parkinsonien comporte (la ou les réponses justes) :
- A. Un ralentissement des gestes alternes rapides
 - B. Un tremblement de la tête
 - C. Une hypertonie plastique
 - D. Une micrographie
 - E. Une voix scandée et explosive
11. Le syndrome combiné de la moelle se manifeste par (la ou les réponses fausses) :
- A. Une ataxie aggravée par la fermeture des yeux
 - B. Une démarcation latérale
 - C. Une démarcation frontale
 - D. Une atteinte de la voie extralemniscale
 - E. Un syndrome extrapyramidal

12. Le syndrome cérébelleux : (réponses justes)

- A. Toujours stato-cinetique
- B. Une dysmétrie aggravée à la fermeture des yeux
- C. Le signe de Romberg à la station debout est caractéristique
- D. Un réflexe rotulien pendulaire
- E. Un vertige rotatoire peut être le maître symptôme

13. Le système limbique comporte plusieurs éléments comme : (RJ)

- A. La glande pinéale
- B. L'hippocampe
- C. L'hypothalamus
- D. L'hypophyse
- E. Le corps calleux

14. Le système limbique a un rôle dans : (RJ)

- A. La régulation de l'homéostasie
- B. La régulation du comportement
- C. Les émotions
- D. La mémoire
- E. L'équilibre

15. La névralgie essentielle du trijumeau présente toutes ces caractéristiques sauf :

- A. Prédominance masculine
- B. Age supérieur à 50 ans
- C. Douleur de type décharge électrique brève très intense
- D. Durée : quelques secondes
- E. Territoire : V1

16. Concernant les craniosténoses : (RJ)

- A. Elles correspondent à une fermeture tardive des sutures
- B. Elles peuvent être responsables d'hypertension intracrânienne
- C. Elles sont toujours syndromiques
- D. Elles entraînent une déformation crânienne
- E. L'IRM est meilleure que le scanner pour l'étude osseuse

17. Concernant la trigonocéphalie : (réponses justes)

- A. Elle touche la suture métopique
- B. Le front est triangulaire
- C. La fontanelle antérieure est fermée précocement
- D. Il existe un bourrelet médian palpable
- E. Elle donne un hypertélorisme constant

18. Le syndrome frontal se manifeste par tous ces signes sauf :

- A. Troubles de la marche
- B. Absence des réflexes archaïques
- C. Troubles psycho-comportementaux
- D. Euphorie
- E. Comportement d'urination

19. La migraine de l'enfant est caractérisée par : (RF)

- A. Une localisation le plus souvent bilatérale
- B. Une durée des crises plus longues que chez l'adulte
- C. Une pâleur inaugurale
- D. Des troubles digestifs souvent au premier plan
- E. Un caractère souvent pulsatile

20. À propos de l'épilepsie myoclonique juvénile : (réponses justes)

- A. Débute à un âge tardif
- B. Est une épilepsie symptomatique
- C. Est une épilepsie pharmacorésistante
- D. Caractérisée par l'existence de myoclonies
- E. Caractérisée par l'existence de crises généralisées tonico-cloniques

21. À propos du syndrome de West : (réponses justes)

- A. Caractérisé par la survenue de spasmes infantiles
- B. Est une épilepsie bénigne
- C. Caractérisé par une régression psychomotrice
- D. Se manifeste à partir de l'âge de 5 ans
- E. Est classée parmi les épilepsies partielles

22. À propos du diagnostic des crises d'épilepsie : (réponses justes)

- A. L'EEG est toujours pathologique même en dehors des crises
- B. Les syncopes représentent un diagnostic différentiel
- C. L'examen neurologique peut être normal
- D. Les crises d'épilepsie sont toujours synonymes d'une maladie épileptique
- E. L'interrogatoire est une étape clé du diagnostic

23. La myasthénie : (réponses justes)

- A. Est une maladie auto-immune de la jonction neuromusculaire
- B. Les réflexes ostéo-tendineux sont abolis précocement, et la faiblesse musculaire s'améliore après effort
- C. Le test au glaçon (ice pack test) améliore le ptosis myasthenique
- D. A+C
- E. A+B+C

24. La dystrophie musculaire de Duchenne : (réponses justes)

- A. C'est une maladie génétique liée à l'X
- B. Elle touche principalement les filles
- C. L'évolution de la maladie se fait vers la perte de la marche entre 10 et 12 ans
- D. A+B
- E. A+C

25. Parmi les caractéristiques de l'algie vasculaire de la face, quelle(s) est/sont la ou les réponses fausses :

- A. Durée : 15 min à 30 heures
- B. Douleur périorbitaire à type d'arrachement, de broyement de l'œil
- C. Unilatérale, toujours du même côté
- D. Signes vasomoteurs associés
- E. Caractère pulsatile

26. Le syndrome de l'artère sylvienne totale associe : (RF)

- A. Un déficit sensitivomoteur massif
- B. Une aphasie par lésion de l'hémisphère dominant
- C. Une hémiplégie proportionnelle controlatérale
- D. Une déviation conjuguée de la tête et des yeux controlatérale à la lésion
- E. Des troubles de la conscience

27. Chez un enfant de 5 ans dont le tableau clinique évoque une hypertension intracrânienne, on retient en faveur de ce diagnostic sur la radiographie simple du crâne de profil : (réponses justes)

- A. Une disjonction des sutures
- B. Un épaississement de la voûte crânienne
- C. Une déminéralisation du dos de la selle turcique
- D. Une table interne de la voûte crânienne lisse et sans relief
- E. Une dilatation du trou occipital

28. La maladie d'Alzheimer : (RF)

- A. L'apolipoprotéine E est un facteur protecteur
- B. Est une cause fréquente de démence
- C. Se caractérise par des lésions neuropathologiques (plaques séniles, dégénérescences neurofibrillaires)
- D. A une prévalence qui augmente avec l'âge
- E. Est d'étiologie inconnue

29. Un hématome sous-dural chronique hémisphérique droit peut se manifester par :

- A. Des troubles confusionnels
- B. Une obnubilation
- C. Un déficit moteur controlatéral
- D. Une hémianopsie latérale homonyme droite
- E. Des céphalées

30. L'hématome sous-dural post-traumatique se rencontre avec une fréquence particulière en cas de : (RJ)

- A. Éthylisme chronique
- B. Traitement par anticoagulants
- C. Traitement par antiagrégants plaquettaires
- D. Diabète
- E. Age avance

31. En faveur d'un ramollissement sylvien superficiel gauche chez un droitier, on retient : (réponses justes)

- A. La topographie brachio-faciale du déficit droit
- B. L'association du déficit à des troubles de la sensibilité de l'hémicorps droit
- C. Une héli-asomatognosie
- D. Une hémianopsie latérale homonyme gauche
- E. Un signe de Babinski droit

32. L'hydrocéphalie à pression normale (hydrocéphalie chronique de l'adulte) se caractérise par : (réponses justes)
- A. Troubles du comportement urinaire
 - B. Céphalées avec troubles de la déglutition
 - C. Troubles de la marche
 - D. Troubles des fonctions supérieures
 - E. Les réponses A, C et D sont justes
33. Le syndrome de Wallenberg : (RJ)
- A. Est un infarctus cérébral de l'artère sylvienne associant vertige violent, nystagmus et troubles bulbaires
 - B. Est un AVC du tronc cérébral de pronostic réserve nécessitant une prise en charge en unité de soins intensifs
 - C. Est un infarctus cérébral par occlusion de l'artère de la fossette latérale du bulbe
 - D. Se manifeste par une hémiplégie, hémianesthésie controlatérale avec aphasie de Broca
 - E. Toutes ces propositions sont justes
34. L'encéphalite herpétique est : (réponses justes)
- A. Nécrosante
 - B. Hémorragique
 - C. Symétrique
 - D. Intéresse surtout les régions temporales
 - E. La plus fréquente des encéphalites aiguës
35. La myéloméningocèle : (RF)
- A. Est une malformation congénitale en rapport avec un défaut de fermeture du tube neural
 - B. S'accompagne toujours d'une hydrocéphalie
 - C. S'accompagne toujours de troubles neurologiques
 - D. Siège en région dorsolombaire
 - E. Nécessite un traitement chirurgical
36. Dans la maladie de Friedreich (RF)
- A. Le début de l'affection se fait en général à l'adolescence
 - B. On retrouve généralement une neuropathie motrice
 - C. La cardiomyopathie est fréquente
 - D. L'évolution se fait progressivement vers l'aggravation
 - E. Le gène incriminé est localisé en ** 9q13 ** et code pour la frataxine
37. Le méningiome (RJ)
- A. Est envahissant
 - B. Est à prédominance masculine
 - C. Se développe à partir de l'ectoblaste
 - D. Ne refoule pas le parenchyme cérébral
 - E. Se développe à partir des cellules arachnoïdiennes

38. La polyradiculonévrite aiguë (RF)

- A. Atteint l'ensemble du système nerveux périphérique
- B. Est habituellement symétrique
- C. Est caractérisée par une dissociation cyto-albuminorachique
- D. Le substratum anatomique est une démyélinisation segmentaire
- E. La nature inflammatoire est confirmée par la présence d'un infiltrat inflammatoire

39. La migraine commune sans aura est définie par (RF)

- A. Crises de céphalées durant de ** 4 à 72 heures **
- B. Céphalées pulsatiles, bilatérales
- C. Céphalées aggravées par les activités physiques de routine telles que la montée ou la descente d'escaliers
- D. Les céphalées sont accompagnées de nausées et/ou vomissements
- E. L'examen clinique doit être normal entre les crises

40. Au cours d'une hypertension intracrânienne, la phase de compensation est assurée par (RJ)

- A. Une réduction du volume veineux intracrânien
- B. Une réduction du volume des ventricules
- C. Une diminution des résistances vasculaires intracrâniennes
- D. Une augmentation de la pression artérielle moyenne
- E. Une sécrétion inappropriée d'ADH

Examen Neuro G5 / 2026

1) Parmi les pathologies suivantes, lesquelles touchent le motoneurone alpha :

- A. La Sclérose latérale amyotrophique
- B. La poliomyélite antérieure aiguë
- C. Le syndrome de Guillain-Barré
- D. L'amyotrophie spinale (SMA)
- E. La sclérose en plaques

2) quelles sont les deux étiologies à rechercher en priorité devant une neuropathie sensitive :

- A. Une pathologie d'origine paranéoplasique
- B. Un diabète type 1 mal équilibré
- C. Un syndrome de Gougerot -Sjögren primitif
- D. Une carence sévère en vitamine B12
- E. Une intoxication chronique à l'alcool.

3) Concernant les polyneuropathies longueur-dépendantes :

- A. Elles touchent d'abord les fibres nerveuses les plus longues
- B. L'atteinte débute souvent aux membres inférieurs
- C. Elles donnent une atteinte proximale d'emblée
- D. L'atteinte est souvent symétrique
- E. Elles réalisent une distribution "chaussettes-gants"

4) L'accident vasculaire cérébral peut être :

- A. Un accident vasculaire cérébral ischémique.
- B. Un accident vasculaire hémorragique
- C. Une hémorragie méningée
- D. Une thrombose veineuse cérébrale.
- E. Un traumatisme crânien.

5) Le tremblement:

- A. De repos est un tremblement essentiel.
- B. D'attitude est un tremblement parkinsonien
- C. D'action est un tremblement d'origine cérébelleux
- D. Est toujours bilatéral.
- E. Peut être sans valeur sémiologique sans valeurs sémiologiques

6) L'atteinte de la voie pyramidale se manifeste par :

- A. Une hypotonie en phase aiguë et une hypertonie en phase chronique.
- B. L'hypertonie est de type spastique.
- C. L'hypertonie est de type plastique.
- D. Déficit moteur.
- E. Déficit sensitif.

7) L'étude de la marche peut contribuer au diagnostic syndromique d'un malade présentant une maladie neurologique:

- A. La démarche à petit pas peut être en rapport avec une maladie de parkinson.
- B. Un steppage uni ou bilatéral peut être en rapport avec une atteinte médullaire.
- C. Un steppage bilatéral est secondaire à une atteinte neurogène périphérique.
- D. Une marche avec fauchage unilatéral est secondaire à une hémiplégie spastique
- E. Le syndrome myogène est responsable d'une démarche dandinante avec une bascule du bassin vers le côté d'appui à chaque pas.

8) Le syndrome cérébelleux comporte :

- A. Des troubles statiques
- B. Des troubles cinétiques, recherchés à l'examen clinique les yeux ouverts.
- C. Des troubles cinétiques, recherchés à l'examen clinique les yeux fermés
- D. Des troubles de la mémoire.
- E. Des troubles du langage de type dysarthrie.

9) Les signes évocateurs d'une hydrocéphalie chez un nourrisson sont (RF)

- A. augmentation du périmètre crânien
- B. paralysie du VI
- C. hypotonie axiale
- D. vomissements
- E. Un œdème papillaire au Fond d'œil (FO).

10) Les céphalées essentielles sont de loin les plus fréquentes :

- A) Les migraines avec aura sont plus fréquentes que les migraines sans aura.
- B) L'aura ophtalmique est fréquente chez les enfants.
- C) Le diagnostic nécessite toujours des explorations paracliniques.
- D) Le diagnostic nécessite toujours des critères diagnostiques.
- E) Le traitement de fond et le traitement de la crise sont indiqués pour tous les cas.

11) Concernant la maladie de Parkinson :

- A. C'est une maladie neurodégénérative
- B. Elle débute souvent de manière asymétrique
- C. Les signes non moteurs peuvent précéder les signes moteurs
- D. Le diagnostic est avant tout clinique
- E. L'évolution est généralement chronique et progressive

12) Concernant les complications du traitement dopaminergique :

- A. Les dyskinésies peuvent apparaître après plusieurs années
- B. Les fluctuations motrices peuvent survenir
- C. Les agonistes dopaminergiques peuvent entraîner des troubles du contrôle des impulsions
- D. La L-Dopa provoque une guérison définitive
- E. Des hallucinations peuvent apparaître sous traitement

13) Concernant la prise en charge thérapeutique de la maladie de Parkinson :

- A. La L-Dopa reste le traitement symptomatique le plus efficace
- B. Les agonistes dopaminergiques peuvent être utilisés
- C. La rééducation motrice n'a pas un intérêt
- D. Les antipsychotiques classiques sont recommandés de première intention
- E. La prise en charge doit inclure les symptômes non moteurs

14) Parmi les éléments orientant vers un syndrome parkinsonien atypique :

- A. Chutes précoces
- B. Mauvaise réponse à la L-Dopa
- C. Dysautonomie sévère précoce
- D. Tremblement de repos asymétrique
- E. Paralysie verticale du regard

15) A propos les critères diagnostiques de la maladie de Parkinson idiopathique :

- A. La bradykinésie est un critère essentiel
- B. Le diagnostic est uniquement radiologique
- C. Une asymétrie des signes est évocatrice
- D. Une bonne réponse à la L-Dopa est en faveur du diagnostic
- E. Les signes cérébelleux précoces orientent vers une forme idiopathique

16) Le syndrome de Brown- squared regroupe

- A) Un syndrome pyramidal déficitaire et/ ou réflexe des quatre membres ou des deux membres inférieurs.
- B) Un syndrome lemniscal homolatéral.
- C) Un syndrome spinothalamique homolatéral
- D) Une atteinte des paires crâniennes.
- E) Des signes d'atteinte cérébelleuse.

17) La crise cholinergique caractérisée par :

- A) Elle est due à un déficit en anticholinesthésiques.
- B) Mydriase
- C) Majoration du déficit moteur et de la détresse respiratoire
- D) Nausées, douleurs abdominales et diarrhées
- E) Bradycardie.

18) Dans la maladie d'Alzheimer, on observe :

- A) Des troubles de la mémoire
- B) Des troubles du langage oral et écrit
- C) Des troubles praxiques.
- D) Des troubles gnosiques.
- E) Troubles des fonctions exécutives

19) La thrombose veineuse cérébrale est une affection souvent curable sans séquelles à condition d'un diagnostic et une prise en charge précoces, plusieurs étiologies peuvent être mises en évidence

- A) Période post opératoire, post- partum.
- B) Troubles de l'hémostase congénitale ou acquise.
- C) Infection à type de septicémie ou endocardite.
- D) Maladies inflammatoires.
- E) L'hypertension artérielle mal contrôlée.

24) La myasthénie:

A- Est une maladie auto-immune de la jonction neuromusculaire

B- Les réflexes ostéo-tendineux sont abolis précocement, et la faiblesse musculaire s'améliore après effort

C- Le test au glaçon (ice pack test) améliore le ptosis myasthenique..

D.A+C

B.A-B+C

25) La dystrophie musculaire de Duchenne:

A- C'est une maladie génétique liée à l'X

B- Elle touche principalement les filles.

C- L'évolution de la maladie se fait vers la perte de la marche entre 10-12 ans.

D-A-B

E-A+C

26) A propos des épilepsies généralisées idiopathiques, quelle est la proposition fautive :

A. Antécédents familiaux d'épilepsie

B. Des anomalies épileptiques bilatérales et synchrones à l'BEG

C. Un développement psycho-moteur normal

D. Un tracé EEG de fond normal

E. Un examen neurologique pathologique

27) Quel élément n'oriente pas vers le diagnostic d'une crise d'épilepsie

A. Un début paroxystique

B. Une confusion post critique

C. Une durée de plusieurs heures

D. Une morsure latérale de la langue

E. Des automatisme oroalimentaires

28) Une crise de type absence est définie par : cochez la réponse juste

A. Une projection au sol

B. Une rupture du contact d'une vingtaine de minutes

C. Une suspension très brève de la conscience

D. Une suspension de la conscience avec automatismes gestuels et perte d'urines

E. Toutes ces réponses sont justes

29) Concernant la trigonocéphalie :

A. Elle touche la suture métopique

B. Le front est triangulaire

C. La fontanelle antérieure est fermée précocement

D. Il existe un bourrelet médian palpable

E. Elle donne un hypertélorisme constant

30) Concernant le traitement des craniosténoses:

A Il est toujours médical

B. La chirurgie est le traitement principal

C. la chirurgie doit être réalisée idéalement avant un an

D. la chirurgie permet de prévenir les complications neurologiques

E. Elle doit être réalisée idéalement avant deux ans.

31) Le diagnostic positif de SEP repose sur 4 éléments sauf un lequel ?:

- A. Dissémination spatiale
- B. Dissémination temporelle
- C. Inflammation du SNC
- D. Absence de diagnostic différentiel
- E. Elévation du taux d'homocystéine

32) la névralgie essentielle du trijumeau présente toutes ces caractéristiques sauf une ?

- A. Prédominance féminine
- B. Age supérieur à 50 ans
- C. Douleur de type de décharge électrique brève très intense
- D. Durée : quelques secondes
- E. Territoire : VI

33) Le syndrome de l'artère sylvienne totale associe : (RF)

- A. Un déficit sensitivo-moteur massif
- B. Une aphasie par lésion de l'hémisphère dominant
- C. Une hémiparésie proportionnelle contralatérale
- D. Une déviation conjuguée de la tête et des yeux contralatérale à la lésion
- E. Des troubles de la conscience

34). Les complications de l'hémorragie sous arachnoïdienne post anévrysmale sont : (RF)

- A. Un vasospasme visible uniquement à l'angiographie
- B. Une hydrocéphalie chronique
- C. Une hydrocéphalie aigue
- D. Un re-saignement
- E. Réponses C et D

35) Le méningiome :

- A. Est envahissant
- B. Est à prédominance masculine
- C. Se développe à partir de l'ostéoblaste
- D. Ne refoule pas le parenchyme cérébral
- E. Se développe à partir des cellules arachnoïdiennes

36) L'adénome hypophysaire

- A. Est toujours malin
- B. S'accompagne d'une déviation de la ligne médiane
- C. Se développe à partir du mésencéphale
- D. A l'origine de troubles visuels
- E. Est un processus dont le bilan hormonal est normal

37). La migraine commune sans aura est définie par : (RF)

- A. Crises de céphalées durant de 4 à 72 heures
- B. Œdème papillaire bilatérale.
- C. Céphalées aggravées par les activités physiques de routine, telle que la montée ou la descente d'escaliers.
- D. Les céphalées sont accompagnées de nausées et/ou vomissements
- E. L'examen clinique doit être normal entre les crises.

38) La maladie d'Alzheimer : (RF)

- A. L'apoprotéine E est un facteur protecteur
- B. Est une cause fréquente de démence
- C. Se caractérise par des lésions neuropathologiques caractéristiques
- D. A une prévalence qui augmente avec l'âge
- E. Est d'étiologie inconnue

39) L'Hématome sous-dural est une collection de sang siégeant :

- A. Entre la tablette interne et la dure-mère.
- B. Entre la dure-mère et l'arachnoïde.
- C. Entre l'arachnoïde et la pie-mère.
- D. Entre la pie-mère et le cortex.
- E. Est un hématome qui est toujours aigu.

40) Le syndrome de DANDY WALKER se caractérise par: (RF)

- A. Une macrocranie.
- B. Un regard en coucher de soleil.
- C. Une impression basilaire.
- D. Une hydrocéphalie tétra-ventriculaire.
- E. Une agénésie vermienne.

Examen Gygy G3 / 2026

1-Les suites de couches caractérisées par : réponse fausse

A- Un retour progressif a la normal de l'organisme maternel

B- Période s'étendant de l'accouchement au retour de couches

C- Mise en route de l'allaitement

D- L'allaitement maternelle lorsqu' il est bien conduit peut-être utiliser comme méthode contraceptif les 6 premiers mois

E- Les complications sont rares après les 3semaines du post partum

2-quel est l'examen qui permet de poser le diagnostic du placenta praevia :

A- L'échographie sus pubienne

B- L'échographie endovaginale

C- L'amnioscopie

D- Le toucher vaginale combiner au palper abdominale

E- L'examen clinique et le palper utérin

3-Quelle est la principale étiologie des avortements précoces spontanés :

A- Les infections

B- Maladie métaboliques tel que le diabète déséquilibre

C- Les aberrations chromosomiques

D- La béance cervico isthmique

E- L'hypothyroïdie

4-Les complications des avortements : Réponse fausse

A- Infectieuses

B- Perforation utérine

C- Stérilité par synéchie

D- Béance cervico isthmique

E- Choc vagale

5-parmis les étiologies suivantes laque n'est pas responsable des avortements :

A- Synéchies utérines

B- Cloison utérine

C- Utérus hypoplasique

D- Fibrome utérin

E- Béance cervico isthmique

6-Parmis les étiologies suivantes laquelle n'ai pas partie des étiologies de la menace d'accouchement prématuré :

A- Infection urinaire

B- Traumatisme abdominal

C- Hydramnios

D- Grossesses multiples

E- Thrombose pelvienne

7-Parmis les signes suivants un seul ne définit pas l'HRP :

- A- Hémorragie faites de sangs noirâtres
- B- Hémorragie faite de sang rouge vif
- C- BCF lointains ou parfois absents
- D- Segment inferieur dur avec un col comme cercle par fil de fer
- E- Douleurs abdominales intense

8-Quels sont les complications de l'HRP : Réponse fausse)

- A- Trouble de l'hémostase
- B- Souffrance foétale voir une mort foétale in utero
- C- Accouchement prématuré
- D- Décès maternel
- E- Une prééclampsie

9-Quels sont les facteurs de risque d'un diabète gestationnel : Réponse fausse

- A- IMC sup a 25
- B- Age supérieur à 35ans
- C- ATCDS de diabète gestationnel ou de macrosomie
- D- ATCDS familiaux de 1 er degrés de diabète type 2
- E- ATCDS d'hydramnios

10-Les complications d'un nouveau-né de mère avec un diabète déséquilibré : Réponse fausse

- A- Une détresse respiratoire surtout si naissance avant 39semaines
- B- Une hypoglycémie néo natale
- C- Une hyperbilirubinémie
- D- Une polyglobulie
- E- Une hypercalcémie

11-La souffrance foétale chronique : cocher la réponse juste

- A- Se traduit cliniquement par un RCIU
- B- Etiologies multiples
- C- L'origine peut infectieuse
- D- L'origine peut être génétique
- E- Toutes ces réponses sont justes

12- Au cours du cycle menstruel, le pic de LH provoque : Réponse juste

- A- Les règles
- B- La croissance folliculaire
- C- L'ovulation
- D- La fin des règles
- E- La sécrétion de l'estradiol

13-présentation du sommet : Réponse fausse

- A- Nécessite une tête bien fléchie
- B- Le repère de la présentation est l'occiput facilement reconnu par la grande fontanelle
- C- Est la présentation la plus eutocique
- D- La plus fréquente des présentations
- E- Les variétés antérieures sont les plus fréquentes

14-La présentation de la face : Réponse fausse

A- Le repère de la présentation est le menton

B- Déflexion totale de la présentation

C- Présentation eutocique dans ses variétés antérieures

D- Lors des variétés postérieures on peut tenter une expulsion instrumentale pour terminer l'accouchement

E- Est plus fréquente que la présentions du front

15-Le diagnostic de certitude de la grossesse extra utérine avant sa rupture se fait par :

A- L'échographie pelvienne

B- La colposcopie

C- L'hystéroscopie

D- Un taux de BHCG fortement positif

E- La coelioscopie

16-Quelle indication la plus adapté pour une patiente âgée de 50 ans aux antécédents de diabète et d'hypertension artérielle présentant un gros utérus fibromateux avec ménorragies

A Traitements par œstrogènes

B- Une polomyomectomie

C- Une hystérectomie sans conservation des ovaires

D- Une hystérectomie avec conservation des ovaires

E- Traitement par progestatif

17-parmis ls fibrome suivant qui nécessite le plus un traitement chirurgical : réponse juste

A- Fibrome sous séreux

B- Fibrome intra cavitaire

C- Fibrome mural

D- Fibrome du ligament large

E- Fibrome de l'isthme

18-quel est la particularité des tératomes ovariens : Réponse juste

A- La torsion

B- Le risque de dégénérescence est marqué

C- Le volume ne dépasse pas les 10cm

D- La rupture du kyste est très fréquente

E- Sont tous les temps bilatéraux

19-Quelles sont les signes de gravité de la prééclampsie : Réponse fausse

A- Douleur épigastrique en barre

B- Elévation des transaminases

C- Augmentation de l'urée

D- Augmentation de la créatinémie

E- Une oligurie

20-Lors de la séroconversion toxoplasmique : Réponse fausse

A- La transmission est beaucoup plus importante au 1er trimestre

B- Le risque malformatif est réduit vers le 3eme trimestre

C- La transmission durant le 1 er trimestre est faible

D- Le dépistage est obligatoire dès le début de la grossesse

E- En cas de séroconversion le traitement sera poursuivi jusqu'à la fin de la grossesse

21- Le prolapsus : RF

A- Est une pathologie fréquente qui touche entre 30 et 50 % des femmes

B- Le traumatisme obstétrical est l'une des causes principales

C- Son diagnostic est clinique avec sensation de boule dans le vagin responsable de pesanteur pelvienne

D- Tous les organes pelviens peuvent être concernés (vessie, utérus et rectum)

E- L'échographie pelvienne est indispensable au diagnostic

22-L'allo-immunisation : réponse fausse

A- Elle est secondaire au passage d'hématies fœtales dans la circulation maternelle

B- Les anticorps maternels sont de type IGM

C- Le risque est celui de l'ictère néonatal

D- Elle survient lorsque la mère est de rhésus négatif et le fœtus est de rhésus positif

E- Les complications sont l'anémie fœtale et la mort fœtale

23-Le mécanisme physiopathologique de l'iso-immunisation rhésus :

A- Passage des plaquettes fœtales dans la circulation maternelle

B- Passage des globules blanc fœtales dans la circulation maternelle

C- Passage des globules rouges maternelles dans la circulation fœtale

D- Passage des globules rouges fœtales dans la circulation maternelle

E- Aucune de ces réponses

24-L'incompatibilité fœto-maternelle :

1- Survient toujours lors de la première grossesse

2- Survient chez une mère rhésus positif porteuse d'un fœtus rhésus négatif

3- Elle est liée au passage transplacentaire d'immunoglobulines IgG

4- Elle peut être détecté par un test de Coombs direct chez le nouveau-né

5- Peut-être prévenue par une injection immunoglobuline anti-D

A (1-2) B (2-3-5) C (1-3-5) D (1-2-3) E (1-2-3-4-5)

Vous recevez une patiente âgée de 53ans ménopausée à l'âge de 35ans, pour une augmentation du volume abdominale orientée par son gastro-entérologue suite à la découverte d'une masse ovarienne

25-quel diagnostic vous allez poser :

A- Une métastase d'un cancer digestif

B- Une tumeur ovarienne

C- Une carcinose péritonéale

D- On ne peut pas se prononcer car on pas beaucoup d'éléments

E- Des kystes péritonéaux

Lors de votre interrogatoire vous noter que la patiente est une nulligeste nullipare, ayant bénéficiée un parcours de procréation médicalement assisté, prise de traitement hormonal substitutif et on note que dans sa famille plusieurs type de cancer tel que : cancer de l'angle colique gauche chez son frère et cancer de l'endomètre chez sa sœur

26-quels sont les facteurs de risques qu'on note dans notre interrogatoire : RF

- A- La nulliparité
- B- Parcours de procréation médicalement assisté
- C- Prise de traitement hormonal substitutif
- D- Notion de cancer dans la famille
- E- Aucune de ces réponses

27-quels examens complémentaires vous allez demander :

- 1- Une IRM pelvienne
 - 2- Un scanner thoraco abdominopelvien
 - 3- Un dosage de CA125
 - 4- Un scanner cérébral
 - 5- Une scintigraphie osseuse
- A (1-2-3) B (2-3-4) C (1-3-5) D (1-2-3-4-5) E (1-3)

28-la stratégie de prise charge que vous allez entreprendre est : réponse juste

- A- Un traitement chirurgical
- B- Une radio-chimiothérapie en fonction de type histologique et la classification FIGO
- C- Une enquête familiale à la recherche d'un syndrome de LYNCH
- D- Toutes ses propositions sont juste
- E- Aucune de ces réponses

29-Devant une aménorrhée primaire, quel est l'examen complémentaire de base pratique-il de demander

- A- Une courbe de température
- B- Une échographie pelvienne.
- C- Une échographie surrénalienne.
- D- Un dosage sanguin de FSH.
- E- Une radiographie de la main

30- vous êtes de garde et vous recevez une patiente une 3eme geste avec deux accouchements vois basse a 28SA de groupage A Rh négatif qui n'a pas perçue les mouvements actifs fœtaux depuis deux jours avec quelque douleurs pelvienne ; le diagnostic le plus probable est :

- A- Une menace d'accouchement prématuré
- B- Une mort fœtale
- C- Un accouchement prématuré
- D- Une mort in utero suite à un HRP
- E- Aucune de ses réponses

Lors de votre examen clinique vous remarquez que la hauteur utérine est augmentée par rapport à l'âge gestationnel ; les BCF ne sont pas perçus le toucher vaginal retrouve un col long fermé Vous décidez de faire une échographie :

- Pas de visualisation de l'activité cardiaque
- Un excès de liquide amniotique
- un hydrops fœtal

31-Le diagnostic le plus probable de cette mort in utero est :

- A- Un diabète déséquilibré qui était méconnu
- B- Une malformation fœtale très probable
- C- Une infection à parvovirus B19
- D- Une allo-immunisation fœtaux maternelle
- E- Aucune de ses réponses

Lorsque vous poussez votre démarche étiologique la patiente vous rapporte que le dernier accouchement la patiente n'a pas bénéficié de son anti-D avant sa sortie de la maternité

32-Donc le diagnostic le plus probable est : réponse juste

- A- On ne peut pas se prononcer sur le diagnostic avant de faire le taux de RAI
- B- Le diagnostic de iso-immunisation est retenue vu le contexte
- C- Il ne peut être retenu qu'après confirmation du groupage du fœtus A_h7
- D- Ne peut être retenue qu'après une étude anapath du placenta
- E- Aucune de ses réponses

33- Parmi les examens suivants, lequel est recommandé pour diagnostiquer une menace d'accouchement prématuré ? MAP

- A- Échographie obstétricale de contrôle systématique
- B- Mesure de la longueur du col utérin par échographie
- C- Analyse des gaz du sang fœtal
- D- Bilan microbiologique de toutes les pertes vaginales
- E- Bilan hormonal incluant la prolactine

34-Le premier diagnostic à éliminer en cas d'aménorrhée secondaire :

- A- Une synéchie utérine
- B- Une aménorrhée post pilule
- C- Une grossesse évolutive
- D- Un diabète déséquilibré
- E- Une dysthyroïdie

35- Vous recevez un couple pour désir de grossesse mari âgé de 42 ans et femme âgée de 36ans qui sont mariés depuis 18mois, quel sera votre attitude pratique : réponse fausse

- A- Abstention pour le moment car selon la définition de l'OMS l'infertilité est évoquée au-delà de 2ans de rapport sexuel non protégé
- B- Il faut explorer au-delà de 6mois de mariage
- C- Commencer par une courbe de température pour vérifier l'ovulation
- D- Une échographie et un bilan hormonal pour la femme
- E- Un spermogramme pour le mari

Patiente âgée de 28ans G3P2 groupage A rhésus négatif qui se présente aux urgences obstétricales pour syndrome douloureux pelvien dans un contexte apyrétique sur une aménorrhée de 32semaines

Dans ses antécédents on note la notion de deux accouchements prématuré a 33semaines les deux enfants sont vivants

L'examen clinique retrouve un utérus ovoïde a grand axe longitudinal, la hauteur utérine correspond à l'âge gestationnel, mouvements actifs présent et les bruits du cœur fœtal présent et réguliers

Le toucher vaginal : retrouve un col très court médian souple ouvert à deux doigts

La poche des eaux est bombante

Aucune présentation n'est perçue

Echographie fœtal retrouve une grossesse monofoetal évolutive présentation podalique

Biométrie conforme à l'âge gestationnel, longueur du col est à 19mm

36-quel est le diagnostic le plus probable devant ce tableau clinique :

A- un hématome retroplacentaire

B- une colique nephretique

C- un début de travail

D- une menace d'accouchement prématuré

E-Aucune de ces réponses

37- quel type de prématurité :

A- très grande prématurité

B- prématurité moyenne

C-grande prématurité

D- enfant non viable

E- Aucune de ces réponses n'est juste

38- quelle est l'étiologie la plus probable dans ce cas

A-infectieuse

B-malformation utérine

C-béance cervico-ischémique

D-traumatisme cervical

E-Aucune de ces réponses

39-parmis les propositions suivantes de la prise en charge quel est celui qui n'est pas indiqué :

A-traitement antibiotique

B- tocolytiques

C- anti D

D- cerclage utérin à chaud

E-Toutes ces propositions sont correctes

40-quel est le traitement le plus approprié qui aurait dû être proposé à cette patiente :

A-traitement antibiotique dès le début de la grossesse

B-traitement antibiotiques

C-traitement anticoagulant

D- un cerclage du col utérin

E-un traitement anti coagulant et de l'aspirine

La patiente est arrivée à terme et admise en salle de naissance pour son accouchement à 4cm, 3H après la sage-femme vous appelle pour anomalie détectée lors du dernier examen obstétrical ; lors de votre examen vous trouvez : un col effacé et dilaté à 8CM, la poche des eaux est rompue le liquide amniotique est clair, présentation on perçoit la racine du nez sans perception de la bouche ni le menton :

41-quelle est le type de la présentation :

A- c'est une présentation sommet qui a mal tourné

B- c'est une présentation du front

C- c'est une présentation type bregma

D- c'est une présentation du siège

E-Il faut attendre un peu pour pouvoir avoir un bon diagnostic

42-l'accouchement sera terminé par :

A- la pratique d'une césarienne en urgence car la voie basse est impossible et il y a un risque d'enclavement

B- la pratique d'une version par manœuvre interne pourrait transformer la présentation en sommet et terminer l'accouchement

C- l'accouchement par voie basse peut être terminé

D- aucune de ses réponses n'est juste

E-Aucune de ces réponses

43-L'endométriose : réponse fautive

A- Touche la femme jeune

B- La localisation peut être génitale ou extra génitale

C- L'hystéroscopie permet de visualiser les lésions

D- Le diagnostic de certitude repose sur la coelioscopie

E- Induire une ménopause chimique permet de ralentir l'évolution

44- Parmi les 5 infections ci-dessous, indiquer celle(s) qui fait (font) courir un danger pour la grossesse ou le fœtus :

A- Herpès génital!

B- Cytomégalovirus

C- Toxoplasmose

D- Listeria

E- Toutes les réponses sont justes

45-La contraception d'urgence : Réponse juste

A- Utilisée en cas de rapport non protégé

B- Peut interrompre une grossesse débutante

C- Est utilisée comme contraception principale

D- Ne doit pas contenir un progestatif

E- Est une pilule oestroprogestative

46-Quel est l'image échographique de la mole hydatiforme :

A- Aspect d'un pseudo sac

B- Sac intra utérin sans visualisation d'embryon

C- Image latéro-utérine visible

D- Embryon visible sans activité cardiaque

E- Aspect de floconneux de tempêtes de neiges

47- parmi les complications de l'IGH: réponse fausse

- A- Infertilité
- B- Synéchie utérine
- C- Douleur pelvienne chronique
- D- Grossesse extra utérine
- E- Meno métrorragies

48-Concernant les lésions précancéreuses malpighienne du col utérin :

- A. Elles correspondent à une prolifération tumorale invasive.
- B. Elles sont caractérisées entre autres par une anomalie de maturation de l'épithélium malpighien et de différenciation cellulaire.
- C. Elles n'entraînent aucune anomalie nucléaire
- D. Elles sont toujours associées à une nécrose tumorale.
- E. Elles ne présentent pas d'activité mitotique.

49-À propos des lésions intra-épithéliales : (RF)

- A. Elles peuvent évoluer vers un cancer.
- B. Elles respectent la membrane basale.
- C. Elles sont toujours irréversibles.
- D. Elles peuvent être de bas ou de haut grade.
- E. Elles précèdent le cancer invasif.

50-Concernant les tumeurs malignes du col utérin, quelle est la proposition juste ?

- A. Les tumeurs malignes du col sont majoritairement des sarcomes.
- B. Le carcinome épidermoïde représente moins de 50 % des cas.
- C. L'adénocarcinome se développe à partir de l'épithélium malpighien exo cervical.
- D. Les tumeurs secondaires du col utérin sont fréquentes.
- E. Le carcinome épidermoïde est le type histologique le plus fréquent.

51- l'hyperplasie atypique de l'endomètre, laquelle des affirmations suivantes est correcte

- A. Les noyaux sont petits, réguliers et sans nucléoles.
- B. L'épithélium garde parfaitement sa polarité.
- C. Le nombre de glandes est inférieur au chorion.
- D. Les mitoses sont rares et absentes dans les zones atypiques.
- E. Il existe une perte partielle ou totale de la polarité cellulaire et nucléaire.

52-La biopsie de l'endomètre d'une femme ménopausée objective : (RF)

- A. Une muqueuse peu épaisse.
- B. Des glandes rectilignes, petites de taille à lumière étroite.
- C. Un chorion cytogène très peu cellulaire.
- D. Absence de mitoses.
- E. Un épithélium cubique pseudo stratifié

53-Dans les tumeurs séreuses borderline de l'ovaire on peut retrouver : (RF)

- A. Une pluri stratification du revêtement épithélial.
- B. Des mitoses en nombre augmenté mais modéré.
- C. Une invasion du stroma.
- D. Des atypies cytonucléaires modérées.
- E. Calcosphérites dans 50% des cas.

54-Dans les tumeurs Krukenberg quelle est l'origine à rechercher en priorité : (RJ)

- A. Colique.
- B. Mammaire.
- C. Gastrique.
- D. Utérine
- E. Pancréatique.

55-Lequel des types suivants représente le groupe le plus fréquent (environ 70% des cas) des carcinomes mammaires : (RJ)

- A. Carcinome lobulaire invasif
- B. Carcinome canalaire infiltrant de type non spécifique.
- C. Carcinome papillaire intra kystique.
- D. Carcinome médullaire.
- E. Carcinome tubuleux

56-dans un compte rendu anatomopathologique, le grade histologique de Scarff Bloom et Richardson est un facteur pronostique majeur. A quel type de lésion s'applique-t-il? (RJ)

- A. Aux carcinomes in situ uniquement.
- B. Aux hyperplasies lobulaires atypiques
- C. A tous les carcinomes infiltrants.
- D. Aux fibroadénomes.
- E. Aux mastites granulomateuses.

57-Parmi les propositions suivantes laquelle correspond à la définition ou à une caractéristique du carcinome lobulaire invasif ? (RJ)

- A. Il représente 70% du cancer du sein et se manifeste par une tumeur palpable, bilatérale dans 7% des cas.
- B. Il est souvent associé à une mutation de HER2 et à un mauvais pronostic.
- C. Il se caractérise histologiquement par des cellules en file indienne et parfois des vacuoles intra cytoplasmiques en bague à chaton.
- D. Il s'agit d'une lésion bénigne fréquente de la femme jeune à double composante conjonctive et épithéliale.
- E. Elle correspond à une prolifération in situ des canaux galactophores sans infiltration du stroma.

58-Laquelle des propositions suivantes correspondent au choriocarcinome : (RJ)

- A. Villosités chorales volumineuses et hydropiques.
- B. Villosités molaires sans fœtus envahissant le myomètre.
- C. Absence de villosités chorales avec proliférations trophoblastiques atypiques
- D. Envahissement myométrial par un trophoblaste hyperplasique.
- E. Villosités molaires avec hyperplasie trophoblastique.

59-Le placenta hémochorial est défini comme : (RJ)

- A. Le sang maternel est séparé du sang fœtal par deux couches cellulaires.
- B. Le sang maternel est en contact direct avec l'endothélium des vaisseaux fœtaux.
- C. Le sang maternel est en contact direct avec le trophoblaste.
- D. Le sang fœtal circule librement dans les espaces intervilleux.
- E. Il existe une barrière placentaire épaisse sans contact avec le sang maternel.

60-Quelle proposition est juste ?

- A. Des villosités volumineuses hydropiques, avasculaires se voient dans la mole complète.
- B. L'insertion vélamenteuse du cordon expose surtout à une infection ascendante.
- C. Les touffes trophoblastiques inter villositaires sont retrouvés dans la molle partielle.
- D. La molle partielle n'évolue jamais vers l'invasion.
- E. La chorioamniotite est due à une infection hématogène.

Partie pratique :

61-Le bassin obstétrical est représenté par sa partie supérieure : Réponse fausse

- A- Détroit supérieur
- B- Plan de l'engagement de la présentation
- C- Latéralement par les lignes innominées
- D- Plan du dégagement
- E- Limite en avant par les bords supérieurs de la symphyse pubienne

62-La délivrance normale nécessite : réponse fausse

- A- De bonne contraction utérine
- B- Un respect de la physiologie de la délivrance
- C- Bilan d'hémostase correct
- D- Les contractions doivent être normaliser par une perfusion de syntocinon
- V E- Un utérus normal

63-Pendant l'accouchement : réponse juste

- A- Les variétés antérieures : OIGA et OIDA font une rotation laborieuse de 135 degrés
- B- La rotation de la tête fœtale n'est pas obligatoire
- C- La décente et la rotation de la tête se fait avant l'engagement
- D- La variété OIDP est la moins fréquente
- E- Les variétés postérieures sont les plus fréquentes

64-Pour un accouchement normal : réponse fausse

- A- Une tête fœtale bien fléchie
- B- Un bassin maternelle compatible avec les biométries fœtales
- C- De bonnes contractions normales et régulières
- D- Un décollement placentaire avant le dégagement de la tête fœtale
- E- Un rythme cardiaque fœtale normal entre 120 et 160 btm/mn

65-Parmi les signes suivants, quel est le signe qui est rattaché à un cancer du sein :

- A- Mastodynies
- B- Augmentation du volume du sein
- C- Rougeur cutanée
- D- Écoulement mamelonnaire
- E- Rétraction du mamelon d'apparition récente

66-Madame D vous consulte pour une tumeur du sein, quels sont parmi ces signes qui sont à haut risque de cancer du sein : réponse fausse

- A- Elle a eu ses règles à 16 ans Puberte Parshp
- B- Elle a été déjà opérée d'une masthopathie
- C- Elle a 51 ans
- D- Elle a des antécédents familiaux de cancer du sein
- E- Notion de radiothérapie pour lymphome hodgkinien à l'âge de 19ans

67- L'examen du délivre : Réponse fausse

A- Est systématique après un accouchement

B- L'existence d'un petit côté des membranes mois 10cm peut témoigner d'une insertion basse du placenta

C- Son examen permet de nous expliquer certaine souffrance fœtale au cours du travail

D- Toutes les réponses sont justes

E- Seule les réponses b et c sont justes

68- La délivrance artificielle : Réponse juste

A- N'est pas systématique après un accouchement.

B- Indispensable en cas d'hémorragie de la délivrance.

C- Se fait sou respect rigoureux de l'asepsie.

D- Sous couverture d'antibiotique.

E- Toutes ces réponses sont justes

69- L'examen du délivre : Réponse juste

1- N'est pas systématique pour toutes les naissances.

2- On peut retrouver des anomalies de forme et d'insertion

3- Parmi les tumeurs placentaires on peut retrouver le chorioangiome

4- Le syndrome de l'artère ombilicale unique peut être associé des malformations cérébrales et gastro-duodenale

A (1-2-4) B (2-3) C (0-8-4) D (1-4) E (1-2-3-4)

70- En hystérosalpingographie quel est la proposition la plus fausse :

A- Est un examen radiologique réaliser par le gynécologue spécialiste de l'infertilité

B- Se fait durant une période bien précise entre le 7eme et le 11eme jour du cycle

C- Sa principale indication actuellement est l'infertilité d'origine tubaire

D- La complication la plus redoutable est l'infection

E- Est parmi les explorations de 1ere intention en infertilité

71- L'échographie du 1 er trimestre : Réponse la plus fausse

A- Est une échographie de datation

B- Il faut calculer la longueur cranio caudale est la clarté nucale

C- La clarté nucale peut-être calcule à n'importe quelle date du 1 er trimestre

D- Permet de nous situer la grossesse intra ou extra utérine

E- Importante pour les grossesses multiples pour définir la chorionicité

72- L'échographie du 2eme du trimestre principal intérêt :

A- Localisation placentaire

B- Quantifier le liquide amniotique afin de dépister un diabète méconnu

C- Etude morphologie des organes du fœtus

D- La croissance fœtale

E- Faire le doppler ombilical a la recherche d'une anomalie de ce dernier

73- Concernant le curetage utérin évacuateur, quelle affirmation est correcte ?

A- Il est toujours réalisé à l'aveugle sans contrôle

B- Il est indiqué en première intention dans toutes les fausses couches

C- Il expose à un risque de synéchies utérines

D- Il ne nécessite jamais d'antibioprofylaxie

E- Il est contre-indiqué après 12 SA

74- Parmi les complications suivantes du curetage, laquelle est la plus spécifique ?

- A- Hémorragie
- B- Infection
- C- Perforation utérine
- D- Synéchies intra-utérines (syndrome d'Asherman)
- E- Douleurs pelviennes

75- Concernant la perforation utérine lors d'un curetage, quelle est la conduite à tenir la plus appropriée ?

- A- Continuer le geste immédiatement
- B- Arrêter le geste et surveiller laparoscopie
- C- Prescrire uniquement des antalgiques
- D- Faire une hystérectomie d'emblée
- E- Administrer des ocytociques uniquement

76- Concernant le curage bidigital utérin, quelle affirmation est correcte ?

- A- Il se fait exclusivement sous anesthésie générale
- B- il consiste en une évacuation instrumentale uniquement
- C- Il permet une évacuation utérine par voie manuelle
- D- Il est indiqué uniquement au 1er trimestre
- E- Il est dépourvu de risque infectieux

77- Quel élément doit être systématiquement vérifié après un curage bidigital ?

- A- Groupe sanguin uniquement
- B- Vacuité utérine
- C- Taille des ovaires
- D- Longueur cervicale
- E- Etat hémodynamique

78- La manœuvre de McRoberts est indiquée dans :

- A- Hémorragie du post-partum
- B- Dystocie des épaules
- C- Présentation du siège
- D- Procidence du cordon
- E- Rupture utérine

79- Quelle est la première manœuvre à réaliser devant une dystocie des épaules ?

- A- Woods
- B- Jacquemier
- C- McRoberts
- D- Rubin
- E- Césarienne

80- Concernant l'échographie endovaginale, quelle affirmation est correcte ?

- A- Elle nécessite une vessie pleine
- B- Elle est moins précise que la voie abdominale
- C- Elle permet une meilleure résolution des structures pelviennes
- D- Elle est contre-indiquée chez toute femme vierge
- E- Elle ne visualise pas l'endomètre

Examen Pédiatrie G4 / 2026

1. Un nourrisson présentant les acquisitions suivantes : transfert d'un objet d'une main à l'autre, tient debout, s'oriente à l'appel de son prénom, babille. Son âge est :
A. 4 mois B. 6 mois C. 8 mois D. 10 mois E. 12 mois
2. Quelle est la ration quotidienne de lait pour un nourrisson âgé de 3 mois pesant 5 kg ?
A. 250 ml B. 500 ml C. 750 ml D. 1000 ml E. 1250 ml
3. Concernant l'allaitement maternel :
A. Aliment le plus adapté au nourrisson
B. Ne nécessite aucune supplémentation vitaminique
C. Protège contre les infections
D. Nécessite une supplémentation en vitamine K
E. Nécessite une supplémentation en vitamine D
4. Anis, âgé de 3 ans, souffre d'une cardiopathie congénitale. A l'auscultation cardiaque, souffle mésosystolique 4/6 au 2 espace intercostal gauche avec clic protosystolique. Ceci est en faveur de :
A. Sténose valvulaire aortique serrée
B. Maladie valvulaire aortique à sténose prédominante
C. Sténose valvulaire pulmonaire serrée
D. Maladie valvulaire pulmonaire à régurgitation prédominante
E. Sténose supravalvulaire pulmonaire serrée
5. Concernant la prise en charge des infections néonatales bactériennes précoces (INBP), quelle est l'association juste:
 1. Une CRP normale n'élimine pas une infection dans les premières heures de vie
 2. Une antibiothérapie doit être débutée sans attendre les résultats des prélèvements en cas de signes cliniques évocateurs
 3. La surveillance clinique seule est suffisante pour tous les nouveau-nés symptomatiques exposés à un risque d'INBP
 4. L'amoxicilline + gentamicine est l'association de référence en première intention
 5. Le principal germe en cause est le streptocoque du groupe B
 6. L'affirmation de l'arrêt circulatoire chez l'enfant est basée sur
A. Absence de pouls carotidien ou brachial
B. Présence d'une saturation en oxygène basse
C. Absence de bruits du cœur à l'auscultation
D. Mydriase bilatérale
E. Tension artérielle basse
7. Au cours d'une méningite bactérienne, le LCR montre le plus souvent :
A. Aspect trouble
B. Hyperprotéinorachie
C. Hypoglycorachie
D. Prédominance lymphocytaire
E. Hypercellularité à polynucléaires neutrophiles

8. Profil clinique le plus proche de la maladie de Still (forme systémique de l'AJI) :

- A. Fièvre en plateau depuis 6 jours avec conjonctivite et œdème des extrémités
- B. Fièvre avec arthrite aiguë du genou
- C. Fièvre avec éruption vésiculaire des mains et pieds
- D. Fièvre depuis 15 jours avec rash fugace aux pics fébriles et arthrites
- E. Fièvre avec sueurs nocturnes et céphalées

9. Nourrisson de 8 mois pour crise convulsive fébrile de 15 minutes. Examen neurologique post-critique : hypotonie. Premier examen à réaliser :

- A. TDM cérébrale
- B. Ponction lombaire
- C. Hémoculture
- D. EEG
- E. NFS, CRP

10. L'ictère précoce se voit dans toutes les situations suivantes sauf :

- A. Déficit en G6PD
- B. Incompatibilité Rhésus
- C. Incompatibilité ABO
- D. Maladie de Minkowski-Chauffard
- E. Hypothyroïdie congénitale

11. Le pied bot varus équin est :

- A. Déformation souple
- B. Pathologie acquise
- C. Simple supination
- D. Malformation rigide tridimensionnelle
- E. Toujours associée à une paralysie

12. Enfant de 3 ans et demi avec douleurs abdominales, masse abdominale et ascite.

Diagnostic le plus probable :

- A. Néphroblastome
- B. Neuroblastome
- C. Lymphome non hodgkinien
- D. Hépatoblastome
- E. Lymphome hodgkinien

13. Nouveau-né de faible poids de naissance si poids :

- A. 2400 g B. 2500 g C. 2600 g D. 2800 g E. 3000 g

14. Prématuré avec SDR, radio : fin granité bilatéral + bronchogramme aérien. Diagnostic :

- A. Tachypnée transitoire
- B. Maladie des membranes hyalines type II
- C. Maladie des membranes hyalines type IV
- D. Inhalation de liquide amniotique
- E. Atrésie de l'œsophage

15. L'hypothyroïdie congénitale : réponse fausse :

- A. Ictère prolongé
- B. Macroglossie
- C. Petit poids de naissance
- D. Fontanelle large
- E. Hernie ombilicale

16. Nourrisson de 2 mois avec vomissements, déshydratation et ambiguïté sexuelle.

Diagnostic :

- A. Hypothyroïdie congénitale
- B. Hyperplasie congénitale des surrénales
- C. Trisomie 21
- D. Maladie de Hirschsprung
- E. Phénylcétonurie

17. Selon le PEV algérien, enfant de 7 ans :

- A. 4 doses VPO
- B. 4 doses VPI
- C. 4 doses hexavalent
- D. 4 doses antipneumococcique
- E. Toutes fausses

18. Obésité commune : réponse fausse :

- A. Epidémie mondiale
- B. Plus fréquente dans pays riches
- C. Gènes modulés par environnement
- D. Peut toucher <5 ans
- E. Définie par IMC >+2 DS

19. Hypoglycémie chez diabétique sous insuline :

- A. Sueurs
- B. Palpitations
- C. Faim douloureuse
- D. Obnubilation
- E. Agitation

20. APLV : toutes exactes sauf :

- A. Amélioration sous éviction
- B. Rechute à réintroduction
- C. Malabsorption possible
- D. Atrophie villositaire partielle
- E. Régime à vie

21. Traitement cystite :

- A. Amoxicilline-acide clavulanique
- B. TMP-SMX
- C. Cefaclor
- D. Cefixime
- E. Cefalexine

22. Rachitisme carentiel :

- A. Retard marche
- B. Convulsions
- C. Chapelet costal
- D. Fermeture précoce fontanelle
- E. Déformation membres

23. Nourrisson 6 mois, pleurs, sang dans selles :

- A. Invagination intestinale aigue
- B. Appendicite
- C. RGO
- D. Méningite
- E. Parasitose

24. Diarrhée aiguë virale :

- A. Atteinte ORL
- B. Déshydratation sévère
- C. Convulsions + glairo-sanglante
- D. A + B
- E. Toutes

25. Crise d'asthme avec DEP = 60 % :

- A. Légère
- B. Modérée
- C. Sévère
- D. Asthme aigu grave
- E. Aucune

26. GNA post-streptococcique : non indiqué :

- A. Albumine IV
- B. Hypotenseurs
- C. Furosémide
- D. Restriction hydrique
- E. Benzathine pénicilline

27. Nourrisson 4 mois, bronchiolite :

- A. Hospitalisation + salbutamol
- B. Hospitalisation + corticoïdes IV
- C. Oxygène + kiné
- D. Désobstruction + hydratation
- E. Antibiothérapie

28. Retard statural :

- A. <97e percentile
- B. <- 2 DS
- C. <3e percentile
- D. - 3 DS
- E. Vitesse ralentie

29. Transfusion NN AB Rh+ mère inconnue :

- A. A Rh+
- B. A Rh-
- C. AB Rh+
- D. O Rh+
- E. O Rh-

30. Protéinurie glomérulaire :

- A. Réduction néphronique
- B. Protéine Tamm-Horsfall
- C. Importante
- D. HTA + œdèmes
- E. IRA

31. Syndrome néphrotique idiopathique

- A. Œdèmes par hypoalbuminémie
- B. IRA initiale
- C. Rechutes fréquentes
- D. Toujours corticoïdes
- E. Vaccins contre-indiqués

32. Choc septique :

- A. Fièvre
- B. Oligurie
- C. Turgescence jugulaire
- D. Pouls bondissants
- E. PA différentielle augmentée

33. Fille 11 ans, retard statural, cou palmé :

- A. Déficit GH
- B. Hypothyroïdie
- C. Turner
- D. Retard constitutionnel
- E. Noonan

34. Examen confirmatif :

- A. GH
- B. IRM hypophysaire
- C. Caryotype
- D. TSH FT4
- E. Echo abdominale

35. Enfant 5 ans, purpura post-viroses :

- A. PTI
- B. Hémophilie A
- C. CIVD
- D. Glanzmann
- E. Bernard-Soulier

36. BRUE :

- A. > 5 min
- B. Examen anormal
- C. < 1 min retour normal
- D. Pendant biberon
- E. Réceptivité exclue

37. Torsion testiculaire typique :

- A. Fréquente nourrisson
- B. Douleur brutale nocturne
- C. Réflexe crémastérien présent
- D. Doppler indispensable
- E. AINS en 1ère intention

38. Biopsie rénale GNA :

- A. Anurie >24h
- B. C3 >4 semaines
- C. IRA >7j
- D. Hématurie 1 an
- E. Protéinurie persistante

39. Nourrisson diarrhée aigüe, Na=128 :

- A. Modérée hypoNa
- B. Modérée isoNa
- C. Sévère isoNa
- D. Sévère hypoNa
- E. Choc débutant

40. Quantité à perfuser 2 premières heures :

- A. 100 ml B. 200 ml C. 300 ml D. 400 ml E. 500 ml

Examen Psychiatrie G1 / 2026

1. Parmi les propositions suivantes, quelle est celle qui répond le mieux à l'exploration clinique des idées suicidaires chez un patient avec quelques symptômes dépressifs

- A. Evoquer directement les idées suicidaires avec un patient comporte un risque majeur d'indication ou de suggestion du passage à l'acte.
- B. Si le sujet n'est pas abordé spontanément par le patient, le clinicien ne doit pas poser de question directe sur le suicide pour éviter d'aggraver l'anxiété.
- C. Questionner explicitement le patient sur ses intentions suicidaires permet de libérer la parole, de diminuer l'anxiété et d'amorcer l'évaluation du risque.
- D. Seuls les psychiatres formés sont habilités à explorer la présence des idées suicidaires
- E. Un patient qui exprime clairement ses idées suicidaires cherche uniquement à manipuler et ne passera pas à l'acte.

2. Dans le trouble bipolaire type 1, la prescription d'un antidépresseur obéit à une règle clinique Indiquez laquelle :

- A. Il est strictement interdit d'en prescrire même si le patient présente une dépression sévère
- B. Il peut être prescrit seul mais uniquement pour une durée ne dépassant pas les sept (07) jours.
- C. Il ne doit jamais être prescrit seul, Il doit être associé à un thymorégulateur avec une durée limitée.
- D. Utiliser un inhibiteur de la recapture de la sérotonine pour éviter le virage maniaque.
- E. Privilégier les tricycliques car ils sont moins dangereux.

3. Les facteurs étiologiques impliqués dans l'étiologie de l'autisme sont : (Cocher la réponse fausse)

- A. La prématurité
- B. La génétique
- C. exposition à certains médicaments ou toxines
- D. La vaccination
- E. L'âge parental avancé

Cas clinique :

G. Ilyes, âgé de 37 ans, déjà suivi en psychiatrie et recevant un médicament antipsychotique associé à un thymorégulateur, est ramené le soir aux urgences psychiatriques de l'hôpital Frantz Fanon de Blida par ses frères après une bagarre avec ses voisins.

À l'examen, vous retrouvez :

- Un patient vêtu d'un pyjama à fleur de couleur orange, lunettes de soleil et casquette.
- Un contact très facile.
- Une parole rapide, passant d'un sujet à l'autre avec jeux de mots incessants et une humeur joyeuse.
- Le malade se bagarre avec les infirmiers et affirme ne pas avoir dormi depuis 4 jours sans ressentir la moindre fatigue. Il ajoute qu'il a dépensé toutes ses économies dans l'achat de 20 trottinettes électriques pour les offrir aux pauvres de la wilaya de Blida.

Quel on le diagnostic le plus probable devant ce tableau : Cochez la proposition juste

A. Trouble psychotique bref

B. Une schizophrénie.

C. Un épisode dépressif

D. Un épisode maniaque

E. Un trouble anxieux généralisé

5. Quel signe ou symptôme ne fait pas partie des arguments sémiologiques de ce diagnostic : (Cocher la proposition juste)

A. Réduction du besoin de sommeil.

B. Une Obsession vestimentaire

C. Une présentation extravagante

D. Des dépenses excessives.

A. Une logorrhée.

6. Votre stratégie thérapeutique dans cet accès fera appel : (Cocher la proposition juste)

A. Aux antidépresseurs.

B. Au phénobarbital.

C. Aux antipsychotiques.

D. A des séances de relaxation.

E. Toutes les réponses sont justes.

7. En cas de prescription médicamenteuse, quelle classe thérapeutique est recommandée en première intention pour traiter les symptômes du trouble de stress post traumatique ? (Cocher la proposition juste)

A. Les benzodiazépines au long cours.

B. Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS).

C. Les antipsychotiques de première génération.

D. Les stabilisateurs de l'humeur (Thymorégulateurs).

E. Les hypnotiques.

8. Quelle est la prise en charge psychothérapeutique de première intention recommandée pour le trouble de stress post traumatique ? (Cocher la proposition juste)

A. La cure analytique (psychanalyse pure).

B. La thérapie de soutien non directive.

C. L'EMDR (Intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires) ou les TCC centrées sur le trauma.

D. La cure de sommeil.

E. L'isolement complet du patient pour éviter toute stimulation.

9. Quelle est la durée minimale des symptômes requise pour différencier un Trouble de Stress Post Traumatique d'un Trouble de Stress Aigu ? (Cocher la proposition juste)

A. Plus de 48 heures.

B. Plus de 2 semaines.

C. Plus de 1 mois,

D. Plus de 3 mois.

E. Deux mois,

10. La clinique du trouble de conversion se caractérise par tous ces éléments sauf un, indique lequel

A. Absence d'atteinte organique

B. Symptômes pseudo-neurologiques (paralysie)

C. Un délire de grandeur

D. Evolution fluctuante

E. Notion d'un conteste déclencheur (conflit ou stress)

11. Dans le trouble dépressif : (Cocher la proposition fausse)

A. L'alliance thérapeutique est la base d'une bonne prise en charge.

B. La psychothérapie peut être associée au traitement médicamenteux.

C. Les antidépresseurs ISRS sont indiqués en dernière intention.

D. Les comportements suicidaires peuvent survenir à tout moment dans l'évolution de l'épisode dépressif.

E. Le sexe masculin, le fait d'être célibataire et l'isolement augmentent le risque suicidaire.

12. Le trouble délirant : (Cocher la proposition fausse)

A. Diffère de la schizophrénie par l'absence de syndrome de désorganisation.

B. Débute en général à l'âge adulte moyen ou tardif, entre 35 et 45 ans.

C. Présente une prédominance féminine dans sa forme de délire de jalousie.

D. N'affecte pas le fonctionnement psychosocial ou du moins ce dernier n'est pas altéré d'une façon marquée.

E. Justifie une hospitalisation, au besoin sous contrainte, en cas de danger imminent pour le patient ou pour autrui.

13. Le délire paranoïaque : (Cocher la proposition fausse)

A. Repose sur un mécanisme généralement hallucinatoire.

B. Est un délire bien systématisé.

C. Peut entraîner l'adhésion d'autrui.

D. Comporte généralement un thème unique.

E. Entraîne l'adhésion totale du malade à son idée délirante.

14. Toutes ces causes peuvent induire un tableau confusionnel sauf une. Indiquez laquelle :

- A. Une tumeur cérébrale.
- B. Une brucellose cérébrale.
- C. Une méningite
- D. Une migraine chronique.
- E. Une hémorragie méningée.

15. La loi n° 18-11 du 2 juillet 2018 relative à la santé a introduit une nouveauté textuelle majeure concernant la protection des malades mentaux hospitalisés sans leur consentement. De quoi s'agit-il ? (Cochez la réponse juste)

- A. L'abolition complète du régime de la tutelle pour les majeurs incapables.
- B. La possibilité pour le magistrat de nommer un curateur pour le malade hospitalisé sans son consentement et sans autre mesure de protection.
- C. L'obligation d'obtenir l'accord écrit du Conseil de l'Ordre des médecins avant toute hospitalisation sous contrainte.
- D. Le transfert exclusif de la gestion des biens du malade au Directeur de la Santé et de la Population (DSP) de la wilaya.
- E. La création d'une commission médicale préfectorale statuant automatiquement sur la saisie des biens.

16. En droit algérien, la tutelle est l'unique mesure de protection des majeurs incapables prévue par les Codes civils et de la famille. Quelle est sa caractéristique principale concernant son application dans le temps ? (Cochez la réponse juste)

- A. Elle est strictement limitée à une durée de 6 mois renouvelable une seule fois.
- B. Elle s'exerce de façon continue, subsistant même lors des intervalles lucides, de guérison ou de stabilisation temporaire du malade.
- C. Elle s'annule automatiquement et sans formalité dès que le psychiatre note une amélioration clinique.
- D. Elle ne concerne que les actes de disposition (vente) et laisse le malade gérer ses comptes courants (achats, chèques).
- E. Elle s'applique uniquement pendant les périodes d'hospitalisation effective du patient.

17. Le syndrome confusionnel se caractérise principalement par ? (Cochez la réponse juste)

- A. Fluctuation de la conscience.
- B. Vertiges.
- C. Migraines.
- D. Hypotensions.
- E. Toutes les réponses sont justes.

18. Concernant les principes généraux et le triptyque constitutif de l'expertise psychiatrique, indiquez la proposition fausse :

- A. L'expertise psychiatrique est un dispositif d'aide à la décision qui concourt à la recherche de faits techniques ou scientifiques.
- B. L'expertise requiert obligatoirement la conjonction de trois éléments : une mission diligentée, la réalisation de celle-ci et un rapport.
- C. L'avis rendu par l'expert ou le collège d'experts lie juridiquement le juge, qui est obligé de suivre ses conclusions cliniques pour rendre son verdict.
- D. L'expertise peut être confiée conjointement à plusieurs experts, constituant ainsi un collège d'experts
- E. L'expert est défini textuellement comme un "homme de l'art" reconnu apte à mener la mission à son terme.

19. Quelle est l'évolution médico-légale ou clinique la plus redoutée et typique dans le délire de revendication (inventeurs méconnus, quérulents processifs) ? (Cocher la proposition juste)

- A. Le suicide altruiste.
- B. Le passage à l'acte hétéro-agressif ciblé (procureurs, experts, médecins) par sentiment de justice non rendue
- C. L'évolution rapide vers un état démentiel.
- D. La guérison spontanée après gain de cause juridique.
- E. La transformation du délire en un tableau de schizophrénie désorganisée.

20. Dans le trouble délirant : (Cocher la proposition fausse)

- 1 A. La prise en charge se fait uniquement en intra hospitalier.
- B. La mauvaise observance thérapeutique est fréquente en raison du manque d'insight (conscience du trouble).
- C. Les antidépresseurs peuvent être indiqués en cas de décompensation dépressive.
- D. Le délire érotomane est plus fréquent chez les femmes.
- E. Les délires d'interprétation sont peu sensibles au traitement pharmacologique.

21. Quelle est la durée minimale requise par les critères diagnostiques du DSM-5 pour affirmer le diagnostic de Trouble délirant ?

- A. 1 semaine.
- B. 1 mois.
- C. 3 mois.
- D. 6 mois.
- E. 1 an.

22. Les objectifs des soins en santé mentale sont ? (Cocher la réponse fausse)

- A. Prévenir les troubles.
- B. Diagnostiquer les troubles.
- C. Traiter les troubles.
- D. Classer les troubles.
- E. La réhabilitation.

23. Selon la classification des modalités de consommation proposée en 1990 par Aviel Goodman. Quelle catégorie regroupe spécifiquement l'usage à risque, l'usage nocif et l'usage avec dépendance ?

- A. L'usage simple,
- B. L'usage nocif exclusivement.
- C. Le mésusage.
- D. La pharmacodépendance.
- E. L'abstinence.

24. Sur le plan neurobiologique, quelle structure cérébrale est explicitement identifiée comme le lieu majeur de la libération de dopamine (neurotransmetteur du plaisir) au sein du circuit de la récompense ?

- A. Le cortex préfrontal.
- B. L'aire tegmentale ventrale (ATV) uniquement.
- C. Le cervelet.
- D. Le noyau accumbens.
- E. La moelle épinière.

25. Quelle est la durée maximale d'un épisode pour poser le diagnostic de Trouble psychotique bref selon le DSM (Cocher la réponse juste)

- A. 24 heures.
- B. 1 mois.
- C. 3 mois.
- D. 6 mois.
- E. 12 mois.

26. D'après les critères diagnostiques du Trouble de l'Usage de Substance (TUS) selon le DSM-5. quel score de critères validés (sur une période continue de 12 mois) définit une intensité qualifiée de modérée ? (Cocher la réponse juste)

- A. Score < 2
- B. Score de 2 à 3
- C. Score de 4 à 5
- D. Score ≥ 6
- E. Score de 1 à 11

27. Sur le plan sémiologique, comment qualifie-t-on le délire fréquemment associé à la confusion mentale, caractérisé par des hallucinations visuelles riches et vécues comme un rêve éveillé ? (Cocher la proposition juste)

- A. Un délire paranoïaque systématisé.
- B. Un délire de revendication.
- C. Un délire onirique.
- D. Une intuition délirante isolée.
- E. Un délire mélancolique de ruine.

28. Parmi les propositions suivantes se rapportant à la psychiatrie, indiquez celle qui est juste:

- A. Elle comporte trois sous-spécialités : la pédopsychiatrie, la psychiatrie de l'adulte et la psycho-gériatrie
- B. Elle comprend trois approches liées : le modèle biologique, le modèle psychologique et le modèle social.
- C. Elle est basée sur deux classifications : DSM-5 et CIM-11
- D. C'est une spécialité médicale qui s'occupe de la santé mentale et les troubles mentaux.
- E. Toutes les propositions sont justes.

29. Parmi les troubles mentaux il y a : (Cocher la réponse fausse)

- A. Trouble déficitaire de l'attention/hyperactivité.
- B. Les troubles de l'équilibre idéique.
- C. Les troubles anxieux.
- D. Les troubles de l'humeur.
- E. Les troubles psychotiques.

30. Parmi les médicaments suivants le seul à avoir l'AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) dans l'indication de l'éjaculation précoce est ? (Cocher la réponse juste)

- A. La paroxétine à 20 mg/j.
- B. La clomipramine à 10 mg/j.
- C. La dapoxétine (Priligy).
- D. La crème de lidocaïne 5%
- E. La cimétidine à la demande.

31. À partir de quel seuil d'échec d'érection parle-t-on de trouble de l'excitation/érection lors des tentatives ?

- A. Quand l'échec est supérieur à 10% des tentatives,
- B. Quand l'échec est supérieur à 25% des tentatives.
- C. Quand l'échec est supérieur à 50% des tentatives
- D. Quand l'échec est systématique et atteint 100% des tentatives.
- E. Quand l'échec survient uniquement lors du premier rapport sexuel

32. Dans la prise en charge thérapeutique du vaginisme en l'absence de lésion organique, quelle méthode d'auto-introduction progressivement recommandée ? (Cocher la réponse juste)

- A. L'utilisation à la demande de crème de lidocaïne 5 %
- B. L'utilisation de bougies de Hégar de calibre croissant associée à des exercices de contraction/relâchement.
- C. La prescription quotidienne d'antidépresseurs de type ISRS
- D. La réalisation d'une coéloscopie diagnostique et thérapeutique précoce.
- E. Une cure d'hydrothérapie exclusive associée à une thérapie de groupe.

33. Parmi les propositions suivantes indiquez celle qui est fausse :

- A. L'insomnie fait partie des motifs de consultation les plus fréquents en médecine générale.
- B. Le cycle de sommeil est régulé par deux hormones : la mélatonine et le cortisol.
- C. Les parasomnies sont caractérisés par des-hallucinations durant le sommeil.
- D. L'insomnie d'endormissement est fréquemment retrouvée chez les patients présentant un trouble anxieux.
- E. L'insomnie matinale est fréquemment retrouvée chez les patients présentant une dépression

34. Parmi les symptômes suivants lequel appartient aux symptômes positifs de la schizophrénie ? (Cocher la réponse juste)

- A. Aboulie.
- B. Apathie.
- C. Hallucinations auditives.
- D. Emoussement affectif.
- E. Alogie.

35. Quelle classe thérapeutique est recommandée en première ligne pour le traitement de la phase aiguë d'une schizophrénie ? (Cochez la réponse juste)

- A. Inhibiteur de la recapture de la dopamine.
- B. Antidépresseur tricyclique
- C. Antipsychotique de première génération.
- D. Antipsychotique de seconde génération.
- E. Benzodiazépine seule.

36. Parmi les affirmations suivantes concernant la schizophrénie, indiquez celle qui est vraie

- A. Son pic d'incidence et de survenue se situe après l'âge de 50 ans.
- B. Elle s'accompagne constamment d'un déficit intellectuel global et homogène
- C. Les formes à début précoce, avant l'âge de 16 ans, représentent la majorité des cas.
- D. Il s'agit d'une pathologie purement héréditaire liée à la mutation d'un gène unique.
- DE. Elle s'accompagne d'un retentissement fonctionnel marqué induisant une rupture avec le niveau de fonctionnement intérieur.

37. Sur le plan thérapeutique, face à une schizophrénie résistante définie par l'échec de deux antipsychotiques différents bien conduits à doses efficaces, quelle molécule représente le traitement de référence ?

- A. L'Halopéridol
- B. L'Olanzapine.
- C. La Clozapine.
- D. La Risperidone
- E. L'Aripiprazole.

38. Dans la schizophrénie, comment appelle-t-on la conviction du patient que ses pensées ou ses actes sont contrôlés par une force extérieure ?

- A. Le mécanisme intuitif.
- B. La fabulation.
- C. L'illusion de mémoire,
- D. Le mécanisme imaginatif.
- E. Le syndrome d'influence.

39. Parmi les propositions suivantes, laquelle ne correspond pas aux hallucinations acoustico- verbales dans la schizophrénie :

- A. Elles comportent des menaces et des insultes.
- B. Elles ne commentent jamais les actes du patient.
- C. Elles sont exprimées à la 2ème et la 3ème personne.
- D. Elles sont vécues de manière désagréable.
- E. Elles incluent les critiques et les ordres.

40. Parmi les outils d'évaluation standardisés mentionnés dans le suivi thérapeutique de la schizophrénie, quelle échelle clinique validée est spécifiquement utilisée pour mesurer l'intensité des syndromes positifs et négatifs ?

- A. L'échelle de Hamilton.
- B. La PANSS.
- C. L'échelle MADRS.
- D. Le score de Glasgow.
- E. Le test MMS.

41. Parmi les symptômes suivants, quels sont ceux qui caractérisent la dimension désorganisée ?

- 1. langage décousu
- 2. néologismes
- 3. comportement conforme aux normes sociales
- 4. troubles du cours de la pensée
- 5. rareté de l'expression gestuelle

A : 2+4 B : 1+4 C : 1+3+5 D : 1+2+4 E : 2+5

42. Parmi les éléments cliniques suivants, quels sont ceux qui évoquent des troubles de la dimension cognitive ? (Cocher la proposition juste)

- 1. Incapacité à tenir un langage cohérent.
- 2. Altération de l'identification des émotions faciales.
- 3. Difficultés à initier des actions.
- 4. Déficit de la théorie de l'esprit.
- 5. Altération de la prise de conscience de ses propres pensées.

A : 1+2+5 B : 1+3 C : 3+4+5 D : 2+3+4 E : 2+4+5

43. Parmi les propositions suivantes, indiquez laquelle caractérise un trouble à symptomatologie somatique ?

- A. Les symptômes sont volontairement produits.
- B. Le patient ne ressent aucune souffrance réelle.
- C. L'anxiété liée à la santé est fréquente,
- D. Les symptômes sont toujours de courte durée.
- E. Le patient évite toujours les soins

44. Laquelle des propositions suivantes correspond à l'hypocondrie ?

- A. Le patient est convaincu de souffrir d'une maladie grave malgré des examens rassurants.
- B. Le patient simule volontairement les symptômes,
- C. Le trouble disparaît spontanément après une seule consultation médicale.
- D. Le diagnostic repose sur la présence d'une maladie organique confirmée.
- E. Le patient présente une indifférence totale à son état de santé

45. La prise en charge du trouble à symptomatologie somatique repose sur l'une des propositions suivantes, indiquez laquelle :

- A. Procéder à des examens complémentaires répétés à chaque plainte.
- B. Multiplier les avis spécialisés pour rassurer le patient.
- C. Elle repose sur une relation thérapeutique stable et rassurante.
- D. Elle est exclusivement médicamenteuse.
- E. Elle nécessite toujours une hospitalisation.

46. Le délire de la bouffée délirante répond à tous les critères cliniques suivants sauf un. Indiquez lequel :

- A. Un début brutal comparable à "un coup de tonnerre dans un ciel serein".
- B. Un délire riche et polymorphe dans ses thèmes et ses mécanismes.
- C. Une thématique changeante et instable au cours de la journée.
- D. Une absence totale d'automatisme mental dans le tableau clinique.
- E. Des troubles thymiques associés pouvant simuler une exaltation maniaque.

47. Quelle conduite adoptez-vous en premier aux urgences devant une confusion mentale ? (Cochez la réponse juste)

- A. Demander un bilan biologique et le revoir à la consultation
- B. Hospitaliser le patient dans un service de psychiatrie.
- C. Prescrire un traitement sédatif par voie intramusculaire, et le revoir à la consultation
- D. Revoir le patient en consultation en vue d'une psychothérapie.
- E. Demander un scanner cérébral en urgence

Cas clinique :

Une femme de 39 ans secrétaire, sans antécédents psychiatriques est amenée aux urgences par sa famille pour des troubles du comportement évoluant depuis cinq jours ; elle ne dort plus, mange peu, paraît très angoissée, a tenté de se jeter par la fenêtre, elle a abandonné son travail, agressive envers ses collègues, très irritable.

A l'examen : humeur dysphorique, elle dit être possédée par un Djinn, persécutée par ses collègues de travail. Attention dispersée, bien orientée.

48. Tous ces éléments psychiatriques sont mis en évidence dans cette observation sauf un. Indiquez lequel ?

- A. Un délire de possession.
- B. Signe thymique.
- C. Un épisode dépressif majeur.
- D. Des troubles du comportement.
- E. Une tentative de suicide.

49. Quel est le diagnostic le plus probable ? (Cocher la réponse juste)

- A. Un état de stress post traumatique dû à un conflit professionnel
- B. Un trouble dépressif
- C. Confusion mentale
- D. Un trouble psychotique aigu
- E. Une Schizophrénie.

50. Quelle conduite adoptez-vous en premier aux urgences ? (Cocher la réponse juste)

- A. Prescrire un traitement antidépresseur et la revoir à la consultation.
- B. Hospitaliser la patiente.
- C. Prescrire un traitement sédatif par voie intramusculaire, et la revoir à la consultation.
- D. Revoir la patiente en consultation en vue d'une psychothérapie.
- E. Demander un scanner cérébral et la revoir à la consultation

51. L'intelligence se définit : (Cochez la réponse juste)

- a. Comme la capacité opératoire de travail à l'aide de schémas de plus en plus complexes et mobiles à la résolution d'un problème.
- b. Son émergence au cours de la vie est lente et continue, liée à une complexité croissante du système nerveux.
- c. Son évolution dépend exclusivement de facteurs extérieurs à l'individu.
- d. Pour les cognitivistes, à partir d'une succession de stades.
- e. A partir de la capacité d'un individu à tisser des relations avec autrui.

A: b+c+d B :a+b+d+e C:a+b+d D:a+b+e E :a+b+c+d+e

52. Pour les professionnels de la petite enfance, il est important de s'intéresser aux aspects suivants : (Cochez la réponse juste)

- a. Le corps et le développement moteur dès les premiers jours de vie.
- b. L'intégration du schéma corporel et la construction de la conscience de soi qui engage le bébé dans sa relation aux autres.
- c. Le développement du langage et ses précurseurs.
- d. La maturation et les structures cérébrales, de même que l'adaptation à l'environnement.
- e. Aux interactions primaires parents-bébé.

A : a+b+c+e B :a+b+c+d C : a+c+d+e .D: a+b+c+d+e E : b+d+c+e

53. L'adolescent : (Cochez la réponse juste)

- a. Pour se défendre des pertes liées au processus d'adolescence, il devra investir des substituts parentaux.
- b. Le groupe est dangereux pour l'adolescent.
- c. Les idées de grandeur retrouvées chez l'adolescent relèvent souvent de la pathologie.
- d. Peut éprouver des affects dépressifs sans que cela ne relève d'un trouble dépressif.
- e. L'adolescence est une période de vulnérabilité, au cours de laquelle souvent l'entourage reproche à l'adolescent de manifester de l'égoïsme et de la mégalomanie.

A:a+b+c B :c+d+e C :a+d+e D: b+c+e E:a+c+d+e

54. Les stéréotypies dans le trouble du spectre de l'autisme peuvent être : (Cocher la réponse juste)

- A. Gestuelles
- B. Tactiles
- C. Auditives
- D. Visuelles
- E. Gustatives

55. La dépression de l'adolescent : (Cochez la réponse juste)

- a. Le tableau clinique est similaire à celui de l'adulte.
- b. L'adolescent n'exprime pas systématiquement de façon claire sa tristesse.
- c. L'humeur peut être réactive : l'adolescent garde la capacité de se réjouir d'un événement positif.
- d. Le ralentissement psychomoteur est constant.
- e. Les conduites délinquantes ou addictives ne peuvent pas être expliquées par une dépression de l'adolescent.

A:a+b+c+d B : a+c+e C:a+b+d+e D:b+c E:b+c+d

56. Le retard mental léger se distingue par : (Cochez la réponse juste)

- a. QI d'environ 35-49.
- b. Un repérage dès les premiers mois de vie.
- c. Des possibilités d'apprendre à lire et à résoudre des mathématiques du niveau d'un enfant âgé de 9-12 ans.
- d. Un niveau d'intelligence qui correspond au stade des opérations formelles.
- e. Une dépendance vis-à-vis de l'entourage sans aucune possibilité d'autonomie et d'accéder à un emploi.

57. Le retard mental profond : (Cochez la réponse juste)

- a. Son diagnostic est souvent aisé et précoce.
- b. Le retard intellectuel est profond et restreint les possibilités d'autonomie.
- c. Est sans conséquence significative sur les autonomies à l'âge adulte.
- d. Les troubles du comportement sont constants. Dans les formes les plus graves, l'activité est purement réflexe associée à des comportements stéréotypés.
- e. N'est pas incompatible avec une scolarité ordinaire.

A: a+b+c B : a+c+e C:a+b+c+d+e D:a+b+d E:b+c+e

58. L'Hospitalisme de Spitz, est un syndrome de régression mentale, définit par : (Cochez la réponse fausse)

- A. Une séparation brusque et longue de l'enfant de ses parents quel que soit son âge.
- B. Une phase de pleurs.
- C. Une phase de glapissement.
- D. Une phase de retrait.
- E. Un risque de retard du développement et de dépérissement pouvant conduire à la mort.

59. Les carences affectives : (Cochez la réponse juste)

- a. Renvoient à un excès de soins maternels
- b. Elles sont quantitatives lorsque la mère est présente mais n'arrive pas à s'engager avec son bébé du fait de son indisponibilité psychique.
- c. Elles sont qualitatives lorsque la mère est physiquement absente.
- d. Elles sont mixtes par discontinuité du maternage, conditions de vie familiale chaotiques.
- e. Elles peuvent être aussi bien intrafamiliale qu'extra familiale.

A:a+b+c+d B : a+b+e C:b+c D:d+e E:b+c+d+e

60. La prévalence du trouble du spectre de l'autisme est, en moyenne de : (Cocher la réponse juste)

- A. 0.1% de la population générale
- B. 1% de la population générale
- C. 5% de la population générale
- D. 7% de la population générale
- E. 10% de la population générale

Examen URO G4 / 2026

Examen théorique :

QCS 01 : Une bandelette urinaire positive au sang sans hématies à l'ECBU évoque en priorité : (RJ)

- 1) Une myoglobulinurie
- 2) Une hématurie glomérulaire
- 3) Une hémoglobininurie
- 4) Une contamination vaginale
- 5) Une infection urinaire

A (1+3); B=(1+5) ; C=(2+3); D=(3+4); E=(4+5)

QCS 02 : Dans le bilan d'une hématurie glomérulaire suspectée, quels examens sont les plus pertinents ? (RJ)

- 1) Quantification de la protéinurie
- 2) Cystoscopie en première intention
- 3) Étude morphologique des hématies
- 4) Dosage des D-dimères
- 5) Uroscanner systématique

A=(2+5); B=(1+2); C =(1+3); D=(4+5); E=(3+4)

QCS 03 : Le syndrome néphrotique est défini par : (RJ)

- 1) Protéinurie ≥ 3 g/24 h
- 2) Hypoalbuminémie
- 3) Hématurie macroscopique obligatoire
- 4) HTA constante
- 5) Hyperuricémie

A=(1+3); B=(4+5) C=(1+2) ; D=(3+4) ; E=(2+5)

QCS 04 : Concernant les anomalies biologiques du syndrome néphrotique (RJ) :

- 1) Hypercholestérolémie
- 2) Hypocalcémie
- 3) Hyperkaliémie
- 4) Hypophosphatémie
- 5) Hypernatrémie

A=(1+5); B=(3+4); C=(2+5); D=(2+3); E=(1+2)

QCS 05 : Concernant la cystite simple de la femme : donnez (RF)

- A. La réalisation d'un ECBU est recommandée avant de débuter le Traitement
- B. La guérison spontanée peut survenir dans 1/3 des cas
- C. La fosfomycine-trométamol (Monuril®) est le traitement de choix en première intention
- D. Une bandelette urinaire positive est suffisante pour retenir le diagnostic et entamer le TRT
- E. ECBU n'est réalisée que si persistance des signes 03 jours après le début du traitement

QCS 06 : Quelles sont les principales complications précoces de la transplantation rénale?(RJ)

- 1) Nécrose tubulaire aiguë
- 2) Cancers cutanés
- 3) Rejet (hyper aigu, aigu accéléré, aigu).
- 4) Complications infectieuses.
- 5) Cancers digestifs

A=1+2+3; B= 1+2+4; C=2+4+5 ; D =1+ 3+4; E=2+3+4

QSC 07 : Quels sont les examens à réaliser obligatoirement pour confirmer le décès en état de mort encéphalique (DEME) dans le cadre du don d'organes ? (RJ)

- 1) Deux électroencéphalogrammes (EEG) fait à 4h d'intervalle.
- 2) Une angiographie cérébrale.
- 3) Une IRM cérébrale.
- 4) TDM cérébrale.
- 5) Echographie rénale

7+5; B=1+2 ; C=2+3; D>3+4;E=1+4

QCS 08 : Quel est le principal objectif du traitement de l'TRA

- A. Éliminer les toxines accumulées.
- E. Restaurer une volémie efficace.
- C. Protéger les tubules rénaux.
- D. Réduire l'inflammation glomérulaire.
- E. Traiter les troubles phosphocalciques

QCS 09 : Dans l'TRA fonctionnelle, quelle est l'adaptation rénale qui permet de maintenir la pression de filtration glomérulaire ? (RJ)

- A. Vasodilatation de l'artériole afférente.
- B. Vasoconstriction de l'artériole efférente.
- C. Vasodilatation de l'artériole efférente.
- D. Augmentation de la perméabilité glomérulaire.
- E. Diminution de la réabsorption tubulaire de sodium.

QCS 10 : Interprétation de gazométrie : PH :7,24,; HCO₃⁻ : 16 mmol/l ; PCO₂ : 45 mmHg (RJ)

- A. Alcalose métabolique décompensée
- B. Acidose respiratoire compensée
- C. Acidose métabolique décompensée
- D. Trouble respiratoire complexe
- E. Acidose mixte

QCS 11 : Principales indications des diurétiques : (RJ) &CM

- A. Anti-aldostérone: Surcharge hydro-sodée
- B. Diurétique thiazidique : lithiase rénale calcique
- C. Diurétique de l'anse : HTA
- D. Diurétique épargneur de potassium : Glaucome
- E. Diurétique de l'anse : Insuffisance surrénalienne

QCS 12 : Plusieurs facteurs interviennent dans le risque de développer des lésions rénales aiguës : (RJ) &

- 1) Potentiel néphrotoxique de la substance
- 2) prendre le médicament au milieu du repas fait baisser le risque
- 3) Diminuer la dose peut diminuer la toxicité du médicament
- 4) La forme injectable est plus toxique que la forme sirop
- 5) Age du patient

A (3+4+5) ; B=(1+3+5); C=(1+2+4) ; D=(1+2+5) ; E=(2+3+4)

QCS 13: Concernant la formation des œdèmes selon les forces de Starling, quelle affirmation est correcte ? (RJ)

- A. Une augmentation de la pression oncotique plasmatique
- B. Une diminution de la pression hydrostatique capillaire
- C Une augmentation de la pression hydrostatique capillaire
- D. Une augmentation du drainage lymphatique
- E. Aucune proposition juste

QCS 14 : Parmi les causes d'hypercalcémie suivantes, laquelle n'est pas accompagnée d'une concentration basse de PTH ? (RJ)

- A. Sarcoïdose
- B. Hypercalcémie d'immobilisation
- C. Intoxication à la vitamine D
- D. Hypercalcémie paranéoplasique (PTHrp)
- E. Hyperparathyroïdie primaire

QCS 15: Toutes les affirmations suivantes concernant le SHU typique sont vraies sauf une laquelle ? (RF)

- A. Il est plus fréquent chez l'enfant que chez l'adulte
- B. Anémie mécanique
- C. Des hématies fragmentées au frottis
- D L'agent en cause est un virus
- E. Son pronostic est favorable

QCM 16 : Parmi les principaux traitements de l'HTA, lesquels ne sont pas prescrits au cours de la grossesse ?(RF)

- A. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ;
- B. Les inhibiteurs calciques
- C. Les antihypertenseurs centraux
- D. Les diurétiques
- E. Les bêtabloquants

QCM 17 : Une femme enceinte de 28 semaines sans antécédents particuliers et avec un début de grossesse normal a une pression artérielle mesurée deux fois à 165/80 mmHg

Quelles sont les affirmations vraies ? (RJ) QCM

- A- Elle a une hypertension artérielle gravidique.
- B- Elle a une pré-éclampsie.
- C- Elle a une pression artérielle normale haute
- D- Elle a un HELLP syndrome.
- E- Elle a une grossesse à risque.

QCM 18 : Parmi les médicaments suivants, lequel (lesquels) est (sont) prescrit(s) en 1^{ère} intention dans le traitement de l'hypertension artérielle chez un patient diabétique ?

(RJ) QCM

A. Furosémide

B. Enalapril

C. Telmisartan

D. Propranolol

E Hydrochlorothiazide

QCM 19 : Le bilan de 1^{ère} intention de la MRC chez l'enfant, repose sur un ou plusieurs éléments, le ou lesquels ? (RJ) QCM

A. Bandelette urinaire

B. Echographie rénale

C. Uro-TDM

D. Echocoeur

E. L'estimation du DFG par MDRD.

QCM 20 : Lors d'une néphropathie tubulo-interstitielle, on peut retrouver : la ou les (RF)

A. Leucocyturie aseptique

B. Protéinurie massive

C. Natriuresse basse

D. Protéinurie < 1 gr

E. Polyurie

Urologie :

QCS 21 : A l'uretrographie rétrograde, une rupture complète de l'urètre postérieur avec décalage < 2 cm, est classée (RJ) :

A. Grade I

B. Grade II

C. Grade III

D. Grade IV

E. Grade V

QCS 22 : Devant la suspicion d'une rupture de l'urètre postérieur (RJ) :

A. Réaliser une cystoscopie

B. L'abondance de l'hématurie n'est pas corrélée à l'importance des lésions

C. L'UCR peut être réalisée à distance du traumatisme

D. Le globe vésical peut manquer en cas de rupture de l'urètre membraneux

E. La cystomanométrie est réalisée à J14 post-traumatique.

QCS 23 : Le saignement qui accompagne une rupture traumatique totale de l'urètre postérieur chez l'homme est (RJ) :

A. Hématurie terminale

B. Hématurie initiale

C. Hématurie totale

D Urétrorragie

E. Inexistant

QCS 24 : En cas de suspicion de rupture de l'urètre postérieur chez un patient présentant une fracture du bassin, il faut éviter de (RJ) :

- A. Faire un toucher rectal
- B. Installer une traction sur l'un des membres inférieurs
- C. Faire un cathétérisme urétral diagnostique
- D. Réaliser une laparotomie en cas de lésion intra-abdominale associée
- E. S'assurer de la stabilité du patient avant toute approche urologique

QCS 25 : L'examen qui permet de poser le diagnostic de la lésion de l'urètre en cas de fracture du bassin (RJ) :

- A. Echographie pelvienne
- B. Bilan urodynamique
- C. Urétrocystographie rétrograde
- D. Scanner abdominal avec injection du produit de contraste
- E. Cystoscopie

QCS 26 : En matière de diagnostic de tumeur de vessie, la réponse juste (RJ) :

- A. La cystoscopie est systématique devant toute hématurie,
- B. L'échographie sus-pubienne normale élimine le diagnostic de tumeur de vessie,
- C. L'échographie sus-pubienne détecte les tumeurs < 5mm,
- D. La cystoscopie est obligatoire même en cas d'échographie évoquant le diagnostic de tumeur de vessie
- E. La TVIM nécessite une TDM thoraco-abdomino-pelvienne dans le cadre du bilan d'extension

QCS 27 : Parmi les propositions suivantes, laquelle n'est pas un facteur de risque de tumeur de vessie ?

- A. Hydrocarbures aromatiques,
- B. Une infection vésicale récidivante,
- C. Antécédent d'irradiation pelvienne,
- D. Tabagisme.
- E. Cancer du rein

QCS 28 : La résection trans-urétrale de vessie est (RTUV) : (RF)

- A. Un moyen diagnostique et thérapeutique pour la tumeur de vessie,
- B. Une seconde RTUV peut-être nécessaire en cas de tumeur volumineuse ou multifocale,
- C. Elle a une place dans le traitement palliatif des tumeurs de vessie métastatiques.
- D. Une seconde RTUV doit être envisagée dans un délai de 4 à 6 semaines en cas d'absence de muscle identifié à la 1ère RTUV,
- E. Elle renseigne sur l'extension aux organes du voisinage

QCS 29 : Toutes les affirmations suivantes concernant la circoncision sont vraies, SAUF : donnez la (RF) :

- A. La circoncision peut être pratiquée pendant la période néonatale chez les nouveau-nés présentant un hypospadias distal, mais pas chez ceux présentant un hypospadias proximal.
- B. Les jeunes garçons souffrant d'infections urinaires récurrentes devraient envisager la circoncision.
- C. La complication la plus courante après la circoncision du nouveau-né est le saignement.
- D. Il a été démontré que la circoncision réduit le risque de transmission du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) chez les hommes hétérosexuels.
- E. La petite déhiscence cutanée survenant après une circoncision peut être prise en charge de manière conservatrice par des soins locaux de la plaie et une cicatrisation par seconde intention.

QCS 30 : Laquelle des affirmations suivantes concernant la fracture du bassin avec traumatisme urétral est VRAIE ? (RJ)

- A. Elle concerne les tissus de l'épithélium ainsi que les tissus érectiles sous-jacents des corps caverneux.
- B. Elle concerne l'épithélium ainsi que le tissu érectile sous-jacent du corps spongieux.
- C. Il ne s'agit pas d'une véritable sténose mais plutôt d'une fibrose résultant de la distraction de l'urètre.
- D. Le processus de sténose peut souvent être occulte en raison de l'implication imprévisible des tissus de l'urètre.
- E. Le défaut se situe généralement de manière prévisible en amont du sphincter externe, à la jonction de l'urètre prostatique avec l'urètre membraneux.

QCS 31 : Une masse non transilluminante et non douloureuse est remarquée dans l'épididyme lors de l'examen physique et confirmée comme étant solide par échographie.

Quel est le- diagnostic le plus probable ? (RJ)

- A. Kyste épидидymaire
- B. Tumeur adénomatoïde
- C. Spermatocèle
- D. Tumeur testiculaire
- E. Hydrocèle

QCS 32 : Lequel des facteurs physiopathologiques suivants est commun aux hommes et aux femmes présentant une incontinence urinaire (incapacité de retenir l'urine) due à une hypoactivité du sphincter ? (RJ)

- A. Hypermobilité du col de la vessie
- B. Dysfonction intrinsèque du sphincter
- C. Hypermobilité de l'urètre proximal
- D. Sphincter strié ne se relâche pas
- E. Dysfonction du col de la vessie

QCS 33 : Lequel des éléments suivants n'est pas un facteur de risque d'incontinence urinaire?(RF)

- A- IMC élevé
- B Sexe masculin
- C- Incontinence fécale
- D- Tabagisme
- E- Augmentation de l'âge

QCS 34 : L'examen urodynamique devrait être envisagée : (1RJ)

- A- Lorsque les mesures conservatrices ont échoué.
- B- Lorsque le tableau clinique est incertain.
- C- Lorsque les symptômes ne peuvent pas être confirmés par le clinicien
- D- Chez les patients ayant subi une reconstruction antérieure du plancher pelvien.
- E. Toutes les réponses ci-dessus.

QCS 35 : La conduite à tenir devant une pyélonéphrite aiguë obstructive : cochez la RF

- A. Le drainage urinaire n'est pas obligatoire
- B. ECBU
- C. Double antibiothérapie.
- D. Hémoculture au pic thermique
- E. NFS

QCS 36 : Les lithiases uriques : (RJ)

- A. Ce sont des lithiases radio-opaque à l'ASP.
- B. Leur densité estimée à 1500UH.
- C. Le traitement se base essentiellement sur l'alcalinisation des urines.
- D. Le traitement se base essentiellement sur l'acidification des urines.
- E. Il n'y a jamais des lombalgies.

QCS 37 : devant des lombalgies le premier examen radiologique complémentaire à réaliser à la recherche des lithiases urinaire (RJ)

- A Le couple ASP échographie Reno-vésicale
- B. La scintigraphie rénale
- C. L'IRM abdominale
- D. UIV.
- E. Echodoppler rénal.

QCS 38 : l'HBP se développe au dépend de : (RJ)

- A. La zone centrale
- B. La zone transitionnelle
- C. Dans la zone périphérique
- D. La zone fibromusculaire antérieur
- E. Aucune réponse n'est juste

QCS 39 : les examens suivant sont réalisés devant les troubles mictionnels chez un sujet âgé sauf un lequel ? (R)

- A. Débitmétrie urinaire (objectiver)
- B. Echographie vésico-prostatique + résidu
- C. Dosage PSA (dépistage cancer)
- D. Cystoscopie si anomalie ou hématurie
- E Spermogramme

QCS 40 : Laquelle des affirmations suivantes concernant les causes d'élévation des PSA est fausse ? (RF)

- A. Cancer de la prostate
- B. Hypertrophie bénigne de la prostate (HBP)
- C. Prostatite aigue ou chronique
- D Cancer de la vessie
- E. Manipulation prostatique récente

Partie pratique :

1ème Cas clinique de néphrologie :

Cas Clinique

Mademoiselle Z. M, 18 ans, suivie depuis l'enfance pour protéinurie hématurie, une biopsie rénale a été pratiquée 6 ans auparavant montrant des lésions glomérulaires minimales.

Depuis deux ans, existe une protéinurie plus importante : entre 3 et 5 g/24 heures et une élévation tensionnelle, Au mois de novembre 2025, l'état clinique est inchangé, la pression artérielle trop élevée pour l'âge ne donne pas lieu à un traitement (la patiente ne s'est pas présentée à la consultation), la créatinine plasmatique est trouvée à 142 micromoles/L (et les protéines sanguines à 58 g/L. Il y a un mois, l'enfant a présenté un syndrome grippal négligé avec des urines sombres. Depuis, elle est Fatigué, bouffiy, se plaint de céphalées, elle vomit depuis une semaine et présente un épistaxis depuis deux jours, sa tension est à 200/120 mmHg et vous notez encore une odeur particulière de l'haleine Les extrémités sont rémmulanttes et les réflexes extrêmement vifs. Elle dit uriner très peu depuis 48 heures.

QCS 41 : Quelle est votre hypothèse diagnostique : (RJ)

- A. Insuffisance thyroïdienne aiguë
- B. Diabète sucré décompensé méconnu
- C. Œdèmes idiopathiques
- D Insuffisance rénale chronique
- E. Hépatite au début

QCM 42 : Quel(s) élément(s) permet (tent) d'orienter vers le caractère chronique d'une insuffisance rénale ? (RJ) &CM

- A L'existence depuis plus de 3 mois d'une protéinurie et d'une anomalie du sédiment urinaire
- B. Une augmentation du débit de filtration glomérulaire évoluant depuis plus de 3 mois
- C. La présence d'une hyperkaliémie associée à une acidose métabolique
- D. La présence d'une anémie normochrome normocytaire et arégénérative au moment du diagnostic.
- E. La présence de reins dont la taille est significativement réduite.

QCS 43 : La découverte d'une kaliémie à 7,5 mmol/l dans ce contexte, s'interprète comme dû à : (RJ)

- A. Une intoxication à la glycirizhine (régliste-antésite)
- B Une insuffisance rénale avancée
- C. Une insuffisance thyroïdienne
- D. Une insuffisance surrénale
- E. La prise de laxatifs

QCS 44 : La découverte d'une natrémie à 119 mmol/L dans ce contexte s'interprète comme due à (RJ)

- A. Une insuffisance surrénale
- B. Une insuffisance thyroïdienne
- C. La prise de diurétique
- D. Un excès de boisson
- F. Une restriction sodée trop sévère.

QCM 45 : La correction de l'hyperkaliémie dans ce contexte peut reposer sur : (RJ)

- A. Perfusion de 2 litres de soluté de bicarbonate de sodium à 42 g pour mille
- B Prise de Kayexalate® en per os ou en lavement
- C. Hémodialyse
- D. Injection intramusculaire d'antialdostérone (Soludactone®)
- E. Prescription d'un diurétique thiazide à la dose habituelle.

QCM 46 : Le bilan trouve également une hypocalcémie à 1,8 mmol/L qui s'explique, au moins en partie, par : (RJ)

- A L'insuffisance rénale
- B. Une insuffisance parathyroïdienne associée
- C. L'hémodilution
- D. Le jeune âge
- E. L'hypoprotéinémie.

QCM 47 : Parmi les propositions suivantes quels sont les éléments qui ne sont pas corrigés par l'hémodialyse, (RJ) &CM

- A Production d'EPO
- B Activation de la vitamine D
- C. Troubles électrolytiques
- D. Correction de la volémie
- E. Correction de l'acidose

QCS 48 : Concernant l'hémodialyse : Le paramètre objectif le plus utilisé pour évaluer l'adéquation de l'hémodialyse est : (RJ)

- A. Clairance de la créatinine
- B Kt V
- C. Débit de dialysat
- D. Pression transmembranaire
- E. Débit sanguin

QCS 49 : La complication infectieuse la plus fréquente en dialyse péritonéale est (RJ) :

- A. Bactériémie
- B. Infection urinaire
- C. Péritonite
- D. Endocardite
- E. Septicémie

QCS 50 : Concernant la PBR, parmi les affirmations suivantes laquelle ne vous semble pas correcte?(RF)

- A. Est une procédure invasive.
- B. A un intérêt diagnostique et Pronostic
- C. Nécessite habituellement deux prélèvements.
- D. Peut-être réalisée sur un rein unique fonctionnel.
- E. Peut-être compliquée d'un hématome péri-rénal.

Cas clinique d'urologie :

Mr L.M, âgé de 56 ans, diabétique sous ADO, tabagique, cancer rectale opéré puis ayant subi de la radiothérapie adjuvante, se présente en consultation pour hématurie macroscopique, terminale, sans brulure mictionnelle, un ECBU confirme l'hématurie, avec absence d'infection urinaire.

QCS 51 : Le diagnostic de tumeur de vessie est suspecté, quels sont les éléments évocateurs de ce diagnostic ? (RF)

- A. Hématurie macroscopique
- B. Tabac
- C. Antécédent de radiothérapie
- D. Diabète
- E. Age

QCS 52 : Quel est l'examen complémentaire à réaliser en premier,? (RJ)

- A. Echographie endo-rectale,
- B. Cystoscopie
- C. Echographie sus-pubienne,
- D. TDM Thoraco-abdomino-pelvienne
- E. URO-Scanner

QCS 53 : Cet examen est revenu sans anomalie, mais le patient consulte pour la persistance de hématurie, quel est l'examen de seconde intention devant la persistance du doute concernant l'existence d'une tumeur de vessie ? (RJ)

- A. Echographie sus-pubienne
- B. Coloscopie
- C. Cystoscopie
- D. TDM Thoraco-abdomino-pelvienne
- E. URO-Scanner

QCS 54 : Ce second examen affirme l'existence d'une tumeur de vessie, quel est le geste à réaliser chez votre patient ? (RJ)

- A. Cystoprostectomie avec dérivation urinaire
- B. TDM Thoraco-abdomino-pelvienne à la recherche de localisation secondaire
- C. Résection trans-urétrale de la vessie (emportant le chorion)
- D. Cystectomie
- E. Résection trans-urétrale de vessie

QCS 55 : L'étude anatomo-pathologique révèle la présence d'un carcinome urothélial de haut grade, infiltrant le detrusor, le bilan d'extension ne révèle pas d'atteinte ganglionnaire locorégionale, ni d'atteinte métastatique à distance, quel est le stade de la tumeur ? (RJ)

- A. T1N1M0
- B. T1N0M0
- C. T2N1M0
- D. T2N0M0
- E. T2N0M1

QCS 56 : Quelle est votre attitude thérapeutique ? (RJ)

- A. Instillation endo-vésicale à base de BCG-thérapie
- B. Cystectomie avec dérivation urinaire
- C. Cystoprostectomie avec dérivation urinaire
- D. Néphro-urétérectomie totale
- E. RTUV de second look

QCS 57 : le type histologique le plus fréquent du cancer du rein est : (RJ)

- A. le carcinome papillaire
- B le carcinome à cellules claires
- C. le carcinome a cellules chromophobes
- D. le carcinome des tubes collecteurs
- E. l'Angiomyolipome

QCS 58 : L'examen de référence dans le diagnostic du cancer du rein est : (RJ)

- A. l'échographie rénale
- B. l'urino- scanner
- C. l'angioscanner
- D l'uro- scanner
- E. l'IRM renal

QCS 59 : Les propositions suivantes orientent vers des complications tardives du traumatisme du rein sauf une, laquelle ? (RF)

- A Hémorragie
- B. Hypertension artérielle
- C. Hydronéphrose
- D. Fistule artério veineuse
- E. Formations de calculs

QCS 60 : Le dépistage du cancer de la prostate se fait par : (RJ)

- A. Une biopsie prostatique
- B. Un toucher rectale et un dosage de PSA
- C. Une IRM prostatique
- D. Un PET scann
- E. Une échographie prostatique

Examen dermato G1 / 2026

1. Le diagnostic de l'acné repose sur les arguments suivant :(RJ)
 - A. Aspect clinique : la présence de papules, pustules et d'e comédons.
 - B. Siège : surtout les zones non séborrhéiques.
 - C. La mise en évidence du Propionibacterium acnés dans le pus.
 - D. La présence d'ADP et de lymphangite.
 - E. L'âge : l'acné touche uniquement le jeune adolescent.
- 2- Dans L'examen dermatologique, la démarche analogique est :(RF)
 - A. Une méthode rapide, qui fait le diagnostic dès l'inspection sur un aspect clinique caractéristique
 - B. Elle nécessite d'avoir déjà vu la lésion pour la reconnaître.
 - C. Elle correspond à une démarche médicale classique basée sur le raisonnement.
 - D. Le recueil de données (l'analyse) précède le diagnostic (la synthèse).
 - E. Elle comporte le risque d'erreur.
- 3- La vitropression :(RF)
 - A. Est pratiquée avec un verre d'e montre ou une lame de verre.
 - B. Elle permet de différencier une simple macule érythémateuse d'un purpura.
 - C. Un érythème est dû à une simple congestion vasculaire qui ne disparaît pas à la vitropression.
 - D. Un purpura persiste à la vitropression.
 - E. Elle n'a pas d'intérêt sur les lésions dyschromiques.
4. Quel est votre CAT devant un érysipèle ? (RF)
 - A-Repos au lit jusqu'à régression des signes inflammatoires.
 - B-Surélévation du membre inférieur.
 - C-Traitement antibiotique Peni G:10-20M UI /J en perfusion jusqu'à l'apyrexie puis relais Peni V per os.
 - D- Soulager la douleur par des anti inflammatoires non stéroïdiens (AINS).
 - E- Traitement de toute porte d'entrée.
5. Les macules (ou taches) sont des lésions primitives, avec modification de la couleur de la peau sans relief, ni infiltration. On distingue : (RF)
 - A- L'érythème
 - B- La cyanose.
 - C- Le purpura.
 - D- L'ulcération.
 - E- L'hyperpigmentation.
6. Les bulles. : (RF)
 - A. LESIONS PALPABLES
 - B. A CONTENU LIQUIDIEN
 - C- Les papules
 - D- Les pustules
 - E. Elles peuvent évoluer (s'agrandir) pour devenir des phlyctènes

7. LÉSIONS PALPABLES A CONTENU SOLIDE : (RF)

- A- Les papules
- B. Les nodules
- C. Le purpura
- D. La croute
- E. Les nouures

8. Qu'elle est l'examen de première intention à faire en cas de suspicion d'une leishmaniose cutanée :(RJ)

- A - Intradermoréaction a la leishmanine.
- B - Recherche des leishmanies sur sang veineux.
- C - Biopsie cutané.
- D- Examen parasitologique direct au microscope optique
- E- Echographie des parties molles.

9. Les parasites de la leishmaniose cutanée : (RF)

- A -Sont des protozoaires du genre leishmania.
- B - les formes amastigotes de leishmanies sont intracellulaires.
- C - les formes promastigotes de leishmanies sont extracellulaires.
- D - Ne sont pas visible au microscope optique.
- E - Inoculé à l'homme par la pique d'un insecte vecteur : phlébotome femelle.

10. La phtiriose : (RF)

- A- Est due à un insecte trapu accroché aux poils pubiens.
- B- Se transmet habituellement par contact indirect.
- C- La transmission de la pédiculose pubienne est surtout sexuelle.
- D- Peut se localiser au niveau des cils causant une blépharite.
- E- La phtiriose pubienne incite à proposer le dépistage d'autres MST associé.

Examen dermato g2 / 2026

1. Le mélanome acral lentigineux est caractérisé par : (RJ)
 - A. Localisation préférentielle sur le dos.
 - B. Survenue surtout chez les sujets à phototype clair.
 - Localisation sur les paumes, plantes ou ongles.
 - D. Évolution toujours rapide et nodulaire.
 - E. Ne se métastase jamais.
2. Après exérèse d'un mélanome < 1 mm sans ulcération, quelle est la conduite recommandée ? (RJ)
 - A. Scanner tous les 6 mois N
 - B. Surveillance clinique et dermoscopique régulière.
 - C. Immunothérapie préventive.
 - D. Biopsie systématique des ganglions sentinelles.
 - E. Ne nécessite aucune surveillance.
3. Les éléments suivants sont reconnus comme facteurs de risque dans le mélanome sauf un ? (RF)
 - A. Phototype clair (peau, yeux, cheveux).
 - B. Nombre élevé de nævus atypiques.
 - C. Exposition solaire intermittente intense.
 - D. Antécédent de psoriasis.
 - E. Antécédent familial de mélanome.
4. Le signe le plus évocateur d'un ulcère veineux est : (RJ)
 - A. Douleur intense nocturne.
 - B. Disparition des pouls périphériques.
 - C. Localisation malléolaire interne.
 - D. Nécrose noire profonde.
 - E. Peau froide et pale.
5. Devant un ulcère douloureux du bord externe du pied avec pouls abolis, le diagnostic le plus probable est : (RJ)
 - A. Ulcère veineux.
 - B. Ulcère artériel.
 - C. Impétigo.
 - D. Pyoderma gangrenosum.
 - E. Dermite de stase.
6. Le traitement de première intention de l'ulcère veineux
 - A. Antibiothérapie systématique.
 - B. Revascularisation chirurgicale.
 - Compression élastique.
 - D. Corticothérapie locale.
 - E. Anticoagulation curative.

7. Parmi les propositions suivantes, laquelle caractérise le mieux les dermatophytes ? (RJ)

- A. Ils atteignent fréquemment les muqueuses.
- B. Ils sont keratinophiles (couche cornée et phanères).
- C. Ils provoquent surtout des infections viscérales.
- D. Ils sont toujours saprophytes et jamais pathogènes.
- E. Ils sont exclusivement des levures.

8. Concernant la teigne tondante microscopique, la lampe de Wood montre typiquement : (RJ)

- A. Absence totale de fluorescence.
- B. Fluorescence jaune vert.
- C. Fluorescence rouge corail.
- D. Fluorescence bleue intense.
- E. Fluorescence blanc nacré.

9. Dans les teignes tondantes trichophytiques (TTT), le type de parasitisme mycologique est le plus souvent : (RJ)

- A. Ectothrix microsporique.
- B. Favique (absence de spores + filaments intrapilaires dans le godet).
- C. Pseudofilaments + levures bourgeonnantes.
- D. Endothrix.
- E. Spores isolées sans filaments.

10. La définition d'une alopécie est : (RJ)

- A. Raréfaction des cheveux.
- B. Disparition des cheveux.
- C. Raréfaction ou disparition des cheveux transitoire ou définitive.
- D. Grisonnement des cheveux.
- E. Squames du cuir chevelu.

11. parmi les signes suivants, quel est le signe clinique de la pelade ? (RJ)

- A. Le cheveu en virgule.
- B. Le cheveu en point d'exclamation.
- C. Le cheveu fourchu.
- D. cheveux en touffes.
- E. Aspect cicatriciel.

12. Le psoriasis : (R)

- A- Se définit comme une maladie inflammatoire chronique de la peau.
- B- Se voit à tout âge même chez le petit enfant.
- C- Survient sans prédominance de sexe.
- D- Habituellement pas ou peu prurigineux.
- E On trouve parfois une notion de contagion (atteinte d'autres membres de la famille).

13. Le diagnostic positif du psoriasis est porté sur : (RF)

- A- Des antécédents familiaux de psoriasis.
- B- L'aspect clinique de la lésion (papule érythémato-squameuse).
- C- La topographie des lésions (notamment les coudes et genoux).
- D- L'évolution par poussée/rémission.
- E- Le caractère chronique.

14. Le grattage méthodique de Brocq : (la ou les RF)

- A- Se fait sur une lésion érythémato-squameuse d'un eczéma à sa phase desquamative.
- B- Se fait sur la peau péri-lésionnelle.
- C- Permet de décrire quatre signes évocateurs de psoriasis.
- D- La rosée sanglante est le troisième signe de ce grattage.
- E- La rosée sanglante correspond à l'érosion du sommet des papilles dermiques.

15. Quels sont les signes histologiques associés à un pronostic défavorable dans le mélanome? (RJ)

- A. Épaisseur de Breslow > 4 mm.
- B. Présence d'ulcération.
- C. Mélanome superficiel extensif.
- D. Infiltration lymphocytaire tumorale intense.
- E. Mitoses élevées.

16. L'eczéma allergique de contact : (RJ)

- A. Réalise des lésions érythémato-vésiculeuses peu prurigineuses.
- B Est dû, dans la majorité des cas, aux produits manipulés en milieu professionnel.
- C. Régresse à l'arrêt du contact en laissant des macules hypochromiques.
- D. Les vésicules se rompent par le grattage ou spontanément.
- E. Peut siéger sur n'importe quelle partie du corps.

17. Concernant l'ulcère veineux : (RJ)

- A- Il est généralement situé au niveau malléolaire interne.
- B- Il est très douloureux,
- C- Il s'accompagne souvent d'un œdème et de varices.
- D- Les poulx périphériques sont souvent abolis.
- E- Le traitement repose sur la compression veineuse.

18. Concernant l'ulcère artériel : (RJ).

- A. Il est souvent localisé aux orteils ou au bord externe du pied.
- B. Il est peu douloureux.
- C. Il s'accompagne d'une peau froide et pâle.
- D. Les poulx périphériques sont diminués ou absents.
- E. La compression est le traitement principal

19. Concernant la Dermite séborrhéique, Cochez les propositions exactes : (RJ)

- A. Amélioration en période hivernale et aggravation à l'exposition solaire.
- B. Atteinte des zones séborrhéiques.
- C. Kétoconazole 2% shampooing est souvent efficace.
- D. Affection contagieuse nécessitant l'éviction scolaire.
- E Formes difficiles : itraconazole 200 mg/j peut être envisagé.

20. Parmi les facteurs favorisant des candidoses, lesquels sont corrects ? (RJ)

- A. Obésité et macération
- B. Humidité locale
- C. Antibiothérapie/corticoïdes au long cours (immunodépression induite).
- D. Exposition solaire régulière (photothérapie).
- E. Carence en kératine.

Examen Gériatrie G4/ 2026

1. Concernant les modifications pharmacocinétiques chez la personne âgée, nous avons (RJ)
 - a. L'augmentation de la masse grasse diminue la demi-vie des médicaments lipophiles
 - b. La diminution de l'eau totale augmente la concentration des médicaments hydrosolubles
 - c. La diminution de l'albumine augmente la fraction libre de certains médicaments
 - d. La fonction rénale augmente avec l'âge
 - e. La créatininémie normale élimine une insuffisance rénale

A=(c+e) B=(a+b+e) C=(b+c+d) D=(a+b+c) E= (b+c)
2. Les facteurs favorisant les effets indésirables médicamenteux chez la personne âgée sont (RF)
 - A. Polypathologie
 - B. Polypharmacie
 - C. Diminution de la sensibilité aux médicaments
 - D. Mauvaise observance
 - E. Les troubles cognitifs
3. L'évaluation clinique globale d'un patient âgé comprend (RF)
 - A. L'évaluation cognitive
 - B. L'évaluation fonctionnelle
 - C. La liste médicamenteuse complète
 - D. Uniquement les pathologies aiguës
 - E. L'évaluation de la fonction rénale
4. L'évolution de la démographie dans le monde, est caractérisée par (RJ)
 - A. Le déroulement en 4 étapes
 - B. Le déroulement en 3 étapes
 - C. Une augmentation de la mortalité infantile
 - D. N'a concerné que le sujet âgé
 - E. une augmentation de la fertilité de la femme.
5. Les deux premières phases de l'évolution démographique sont caractérisées par (RJ)
 - A. Raccourcissement de la durée de vie
 - B. Augmentation de la fertilité infantile.
 - C. Allongement de la durée de vie.
 - D. Une fertilité des femmes stable.
 - E. Ces changements ont commencé en Europe de l'Est.
6. La définition de L'autonomie correspond (RF)
 - A. L'absence de toute pathologie
 - B. La capacité à effectuer seul les activités de la vie quotidienne
 - C. L'indépendance psychologique vis à vis de l'entourage.
 - D. La capacité de faire des choix et de les assumer
 - E. Une absence de dépendance physique

7. La prise en charge d'une personne Agée fragile repose sur (RJ)
- A. Une hospitalisation systématique
 - B. Une prise en charge monodisciplinaire
 - C. Une approche globale, multidimensionnelle et interdisciplinaire
 - D. Une prescription systématique de suppléments nutritionnels
 - E. Une abstention thérapeutique
8. Les concepts d'autonomie et de dépendance comprennent (RF)
- A. Les termes d'autonomie et de dépendance sont complètement opposés.
 - B. L'autonomie est la capacité à se gouverner soi-même.
 - C. La dépendance est l'impossibilité partielle ou totale pour une personne d'effectuer sans aide humaine les activités de la vie quotidienne.
 - D. La perte d'indépendance fonctionnelle concerne les activités physiques, psychiques, ou sociales
 - E. L'autonomie associe la capacité du jugement à la liberté d'action.
9. Les outils d'évaluation fonctionnelle de la dépendance sont (RF)
- A. L'échelle des activités de la vie quotidienne = Activities of Daily Living [ADL] de Katz.
 - B. L'échelle des activités instrumentales de la vie quotidienne = Instrumental ADL ou IADL de Lawton.
 - C. Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources = AGGIR
 - D. L'évaluation gériatrique standardisée = EGS
 - E. Les fonctions cognitives = Mini Mental State Examination = MMSE.
10. Le concept de fragilité intègre (RF)
- A. La Dénutrition
 - B. La Sédentarité
 - C. Chute, confusion et perte d'autonomie.
 - D. La Diminution de la force musculaire
 - E. Sarcopénie
11. Les facteurs majeurs qui augmentent le risque d'iatrogénie médicamenteuse sont (RF)
- A. Polypathologie
 - B. Insuffisance rénale
 - C. Dénutrition
 - D. L'état fébrile
 - E. Démence
12. Le choix d'une classe médicamenteuse adaptée dépend de (RF)
- A. La pathologie
 - B. Des autres comorbidités
 - C. La posologie
 - D. Des autres prises médicamenteuses
 - E. Observance

13. Les macronutriments sont définis par RF

- A. Leur rôle est d'apporter énergie, structure et stockage aux cellules et tissus
- B. Les enzymes digestives permettent leur transformation en micronutriments
- C. Sont dépourvus de valeur énergétique
- D. Sont composés de glucides, protéines et lipides
- E. Toutes les réponses sont fausses

14. Concernant les besoins énergétiques de la personne âgée (RJ)

- A. Les apports énergétiques doivent être inférieurs à 35 kcal/kg/jour
- B. Les besoins en protéines représentent au minimum 40 % de l'apport énergétique total
- C. Les besoins en lipides représentent 35 à 40 % de l'apport énergétique total
- D. Les besoins en vitamine D sont souvent couverts seulement par l'alimentation
- E. Les apports recommandés en calcium sont de 2200 mg/j

15. La vitamine C présente toutes ces caractéristiques (RF)

- A. Est un macronutriment
- B. Est importante pour la synthèse du collagène
- C. Contribue à l'amélioration du fonctionnement du système nerveux
- D. Favorise l'absorption du fer
- E. Est un antioxydant efficace

16. Les conséquences de l'alitement de 10 jours chez la personne âgée présentent (RF)

- A. Une diminution de 30% de la synthèse protidique dans le muscle.
- B. Une diminution de la masse maigre d'environ 1,5 Kg.
- C. Retentissement rapide sur la capacité motrice.
- D. Une balance azotée positive.
- E. Diminution de la force du quadriceps d'environ 15%.

17. La perte des capacités en endurance (RF)

- A. Est une conséquence du syndrome d'immobilisation du sujet âgé.
- B. Résulte de l'augmentation de la capacité maximale à consommer l'oxygène (VO₂max).
- C. Résulte du déconditionnement à l'occasion d'un alitement.
- D. La VO₂ max peut s'améliorer par un entraînement spécifique.
- E. Le maintien d'une capacité aérobie élevée est indispensable pour une récupération maximale après un épisode de stress.

18. La prise en charge réussie du vieillissement comporte ces caractéristiques (RJ)

- a. l'objectif de supprimer le vieillissement
- b. L'activité physique améliore la capacité fonctionnelle
- c. La prise en charge doit être globale et individualisée
- d. La prévention des maladies chroniques est inutile après 65 ans
- e. Le maintien de l'activité sociale est recommandée

A=(a+e) B=(a+b+c) C=(b+c+e) D=(b+d+e) E=(b+c+d)

19. Concernant le vieillissement physiologique (RJ)

- a. Il correspond aux maladies liées à l'âge
- b. Il est un processus progressif et multifactoriel
- c. Il débute uniquement après 65 ans
- d. Il implique des facteurs intrinsèques et extrinsèques
- e. Il est totalement réversible

$A=(b+d)$ $B=(a+b+e)$ $C=(a+c+e)$ $D=(b+d+e)$ $E=(b+c)$

20. La loi 10-12 de 2010 concerne principalement (RJ)

- a. La protection de l'enfance
- b. La protection des personnes âgées
- c. L'organisation des hôpitaux uniquement
- d. La prise en charge sociale et sanitaire des personnes âgées
- e. La responsabilité des personnes âgées envers l'État

$A(a+d)$ $B(c+b+d)$ $C(a+b+c)$ $D(b+d)$ $E-(a+e)$

21. Devant une personne âgée abandonnée, dénutrie et sans soins, on peut suspecter (RF)

- A. Une négligence
- B. Un défaut de prise en charge
- C. Une situation de maltraitance
- D. Une urgence sociale et médicale
- E. Une situation normale liée au vieillissement

22. Quel processus est responsable de la sensation de fatigue qui incite à dormir (RJ)

- A. Processus C.
- B. Processus S
- C. Processus veille.
- D. Processus de sommeil paradoxal.
- E. Alternance veille-sommeil.

23. Quel pourcentage de patients de plus de 65 ans souffrent de troubles du sommeil ? (RJ)

- A. 12%
- B. 22%
- C. 32%
- D. 42%
- E. 52%.

24. Quel facteur de risque est associé à la victime et favorise la maltraitance ? (RJ)

- A. Troubles cognitifs
- B. Toxicomanie de l'aidant
- C. Dépendance financière de l'aidant
- D. Troubles psychiatriques de l'aidant
- E. Profession médicale de la victime«

25. L'isolement social d'une personne âgée se caractérise par (RJ)

- A. Le sentiment de solitude uniquement
- B. Le manque de relations sociales quantitatives et qualitatives
- C. Le refus de soins
- D. La polypharmacie
- E. La mobilité réduite uniquement

26. La confusion mentale du sujet âgé est due à (RF)

- A. Altération de la vigilance
- B. Une souffrance cérébrale secondaire à un processus organique
- C. L'Imagerie cérébrale est obligatoire
- D. Les troubles sont fluctuants
- E. Elle est irréversible

28. L'évaluation gériatrique standardisée (EGS) comprend (RJ)

- A. L'imagerie et les bilans biologiques uniquement
- B. L'évaluation médicale, fonctionnelle, cognitive, psychologique et sociale
- C. L'étude génétique du vieillissement
- D. Les examens ophtalmologiques spécialisés
- E. L'évaluation nutritionnelle et de la douleur

29. Concernant les troubles sphinctériens liés à l'immobilisation (RJ)

- a. Les protections absorbantes doivent être imposées à tous les patients
- b. Le sondage urinaire systématique est recommandé
- c. L'incontinence nécessite une évaluation de sa cause
- d. La constipation peut aggraver les troubles urinaires
- e. La continence ne nécessite aucune aide pratique

$A=(a+d)$ $B=(a+b+d)$ $C=(c+d)$ $D=(b+d+e)$ $E=(b+c)$

30. Parmi les conséquences de l'isolement de la personne âgée (RJ)

- a. Décompensation des maladies chroniques.
- b. Jouissance.
- c. Equilibre mentale
- d. détérioration de la santé mentale.
- e. Mortalité précoce.

$A=(a+d+e)$ $B=(a+b+e)$ $C=(a+b+d)$ $D=(a+b+e) = (c+d+e)$

31. Le rôle du médecin dans le maintien à domicile consiste à (RF)

- A. Évaluer les besoins médicaux et fonctionnels
- B. Coordonner les soins avec les intervenants
- C. Prescrire une hospitalisation si nécessaire
- D. Évaluer la situation sociale du patient
- E. Décider du financement de l'aide à domicile

32. Parmi les critères suivants, lequel (lesquels) fait (font) partie de la définition de l'immobilisation en gériatrie ? (RJ)

- a. Alitement quelle que soit sa durée
- b. Alitement de plus de 2 jours
- c. Incapacité à se retourner seul dans le lit
- d. Incapacités à réaliser ses transferts assis-debout
- e. Mise au fauteuil moins de deux heures par jour

$A=(a+b+c)$ $B=(a+d)$ $C=(a+b)$ $D=(a+e)$ $E=(b+e)$

34. Quels sont les risques des anticholinergiques chez la personne âgée ? (RF)

- A. Confusion
- B. Rétention urinaire
- C. Sécheresse buccale
- D. Chutes
- E. Bradycardie

35. Cas clinique : Mme A., 82 ans, vit seule à domicile. Elle présente comme antécédents une HTA traitée et une gonarthrose. Elle consulte car elle est tombée dans sa cuisine il y a deux semaines en voulant attraper un objet en hauteur. Elle n'a pas perdu connaissance, mais est restée au sol pendant 30 minutes, incapable de se relever seule malgré l'absence de fracture évidente. Depuis, elle limite ses déplacements par peur de retomber.

Comment classeriez-vous cliniquement la chute de Mme A. (RJ)

- A. Chute-symptôme
- B. Chute fortuite
- C. Chute-syndrome
- D. Chute-symbole
- E. Chute itérative

36. Lors de votre examen, vous réalisez un test Short Physical Performance Battery (SPPB). Mme A. obtient les résultats suivants : équilibre en position tandem tenu 10s, vitesse de marche 0,7 m/s, et lève de chaise effectuée en 15 secondes. Quel est son score total et son interprétation selon le cours sur l'APA ? (RJ)

- A. Score de 12 : Sujet robuste, sans incapacité significative.
- B. Score de 10 : Sujet indicatif d'un bon état fonctionnel.
- C. Score de 8 : Incapacité légère, sujet pré-fragile.
- D. Score de 5 : Incapacité modérée, sujet fragile.
- E. Score de 3 : Incapacité sévère, sujet dépendant.

37. Mme A. présente une appréhension à la marche et une tendance à se projeter vers l'arrière lors de passage à la station debout. Comment appelle-t-on cette phase secondaire de la chute ? (RJ)

- A. Phase de sidération psychomotrice immédiate.
- B. Syndrome de glissement précoce.
- C. Phase de régression posturale et fonctionnelle.
- D. Ataxie cérébelleuse post-traumatique
- E. Maladie de Parkinson post-chute.

38. Dans le cadre de la mise en place d'un programme d'Activité Physique Adaptée (APA) pour

Mme A., quel bilan est considéré comme "le premier facteur d'augmentation du niveau de risque et doit être réalisé prioritairement avant toute intensité modérée ? (RJ)

- A. L'évaluation de la densité minérale osseuse par ostéodensitométrie.
- B. Le bilan neuropsychologique par le test MMS.
- C. L'évaluation du risque cardiovasculaire.
- D. Le bilan podologique (recherche d'hallux valgus ou d'hyperkératose).
- E. Le questionnaire de niveau d'activité physique habituelle.

39. Vous décidez de prescrire des séances d'APA. Selon les principes de rééducation en gériatrie, quel est l'objectif principal de l'APA spécifiquement pour une patiente présentant le profil de fragilité de Mme A. ? (RJ)

- A. Maintenir uniquement l'autonomie actuelle.
- B. Inverser le statut de fragilité ou maintenir l'indépendance.
- C. Prévenir exclusivement la survenue d'une maladie d'Alzheimer.
- D. Ralentir le déclin fonctionnel d'une démence déjà installée.
- E. Préparer une institutionnalisation à court terme.

40. Parmi les professionnels suivants, lequel n'est pas cité comme un intervenant direct pour l'animation ou l'encadrement des séances d'APA ? (RJ)

- A. Enseignant en APA.
- B. Masseur-kinésithérapeute.
- C. Psychomotricien.
- D. Ergothérapeute.
- E Pharmacien d'officine.

Examen Légale G1 / 2026

1- Le Secret Médical : (RJ)

- a. Est une obligation destinée à sauvegarder la Santé des Individus qui peut se confier à un Médecin ou à un auxiliaire médical sans que leur Maladie ne soit dévoilée à un tiers.
- b. Se justifie par l'obligation de discrétion et de respect de la Personne d'autrui.
- c. Il s'agit par-là de créer et d'assurer une relation de confiance
- d. Est volontiers présenté comme une question de Déontologie dans la mesure où il ne s'agirait que d'un Devoir Professionnel.
- e. Toutes ses réponses sont justes

2- Quels sont les fondements textuels du Secret Médical ? (RF)

- a. La Constitution
- b. Loi N° 18-11 Relative à la santé
- c. Le Code de Déontologie Médicale
- d. Le Code Pénal
- e. Le code civil.

3- L'urgence à caractère médico-légal : (RF)

- a. S'inscrit de manière générale dans le contexte global de tout acte médical.
- b. Elle possède des caractéristiques particulières lorsqu'elle est à caractère médico- judiciaire.
- c. Est effectuée sur réquisition.
- d. L'acte peut-être différé
- e. L'intervention du médecin dans les situations d'urgence reste attachée à une obligation de moyens et non de résultat

4- La conduite à tenir du médecin requis : (RF)

- a. Il doit répondre à la mission de la réquisition.
- b. Il se présente à la personne examinée et ne lui explique pas l'objet de la mission.
- c. L'examen doit être fait en respectant les règles de la confidentialité et de la déontologie.
- d. En cas de refus d'examen, il doit être écrit, et ce refus doit être respecté.
- e. Pour un médecin, ne pas déférer aux réquisitions de l'autorité publique est considéré comme un délit.

5- L'intérêt d'un examen d'un gardé à vue : (RF)

- a. conduit à dire si l'état du gardé à vue est compatible ou incompatible avec la garde à vue
- b. doit se faire dans des conditions idéales de préférence en milieu hospitalier en raison de l'apport du plateau technique
- c. Le médecin se prononce sur l'opportunité d'une levée de la garde à vue, et sur l'opportunité du maintien de l'intéressé dans les locaux éventuellement inadaptés à son état.
- d. Terminer l'examen par un rapport en objectivant si l'examen est normal ; s'il nécessite des soins durant la garde à vue ou une hospitalisation.
- e. Toutes ses réponses sont justes

6- Une pétéchie de Tardieu est : (RJ)

- a. Un signe pathognomonique de strangulation.
- b. Un signe constant des traumatismes crâniens.
- c. Une hémorragie punctiforme liée à une asphyxie mécanique.
- d. Une hémorragie sous-cutanée secondaire aux coups.
- e. Un signe exclusif des noyades

7- Le positionnement du nœud en pendaison permet de : (RJ)

- a. Déterminer le type de corde.
- b. Déterminer l'hétéro-agression.
- c. Influencer le mécanisme lésionnel cervical.
- d. Identifier le temps de survie.
- e. Déterminer l'angle de chute.

8- La suffocation correspond à : (RJ)

- a. Une compression externe du cou.
- b. Une obstruction par un corps étranger.
- c. Une altération de l'échange gazeux par toxique.
- d. Une obstruction des orifices respiratoires externes
- e. Une asphyxie liée au barotraumatisme.

9- La noyade se caractérise par : (RJ)

- a. Absence d'eau dans les voies aériennes
- b. Eau dans les poumons + emphysème
- c. Rigidité instantanée
- d. Inhibition cardiaque
- e. Liquide gastrique jaune

10- Le champignon de mousse correspond à : (RJ)

- a. Cyanose périphérique
- b. Œdème pulmonaire spécifique
- c. Mélange d'air, eau, surfactant
- d. Réaction post-mortem
- e. Hémorragie intrapulmonaire

11- Le broiement : (RJ)

- a. Est caractérisé par un écrasement des tissus.
- b. L'évolution vers la mort est très rare.
- c. Détermine des suffusions sanguines sur un cadavre.
- d. Est une contusion du 3 degré.
- e. Est un traumatisme ouvert

12- Les blessures résultant de projectiles d'arme à feu: (RJ)

- a. Sont des contusions du 3^{ème} degré.
- b. La détermination de l'orifice d'entrée n'est pas un problème d'ordre médico-légal.
- c. Elles peuvent être soit d'origine accidentelle, criminelle suicidaire.
- d. sont caractérisées plus souvent par des plaies contuses et linéaires.
- e. elles dépendent seulement de l'arme incriminée.

13- Les brûlures: (RJ)

- a. Sont des contusions du 5^{ème} degré.
- b. sont secondaires à l'action de la chaleur, des rayonnements et des caustiques.
- c. Elles peuvent être accidentelles, criminelles mais jamais suicidaires
- d. l'identification n'est pas un problème médico-légal majeur.
- e. Leur gravité dépend seulement par rapport à la surface totale corporelle atteinte.

14- La cour suprême : (RF)

- a. Est une juridiction de quatrième degré de l'ordre judiciaire
- b. Comprend des magistrats du siège et des magistrats du parquet.
- c. Est constitué de chambre pénale, civile et d'accusation.
- d. Son objectif est de veiller au respect de la loi.
- e. Juge les affaires déjà jugées au niveau des cours.

15- L'avortement illégal : (RF)

- a. L'essence de persil fait partie des substances abortives.
- b. Les sanctions prévues par le code pénal sont l'emprisonnement de 01 à 02 ans.
- c. Est une dérogation absolue au secret médical.
- d. Le délit nécessite la réunion d'éléments matériels et intentionnels.
- e. Pratiqué le plus souvent dans le but d'éliminer une grossesse désirée.

16- Concernant les lividité cadavériques : (RJ)

- a- Elles apparaissent immédiatement après le décès.
- b- Avant environ 13 heures, elles peuvent changer de position si le corps est déplacé
- c- Elles permettent d'estimer l'intervalle post-mortem.
- d- Elles sont immuables dès la 10e heure.
- e- Elles apparaissent uniquement au niveau des zones d'appui.

17- Dessiccation cadavérique : (RJ)

- a- Correspond à la rigidité des muscles après la mort
- b- Correspond à la perte progressive d'eau des tissus entraînant leur dessèchement.
- c- Les zones exposées à l'air comme les lèvres, la peau et les extrémités sont les plus touchées
- d. Elle touche principalement les organes internes comme le cœur et les poumons à température ambiante
- e- Elle est favorisée par un environnement froid et humide.

18- Critères médico-légaux de la mort cérébrale : (RJ)

- a- Perte totale de la conscience.
- b- Conservation de la respiration spontanée.
- c- Abolition de toute réactivité.
- d- Hyperactivité neurologique.
- e- Augmentation des réflexes.

19- Dans la maltraitance des personnes vulnérables : (RJ)

- a- La présence de blessures multiples d'âges différents est un signe évocateur de maltraitance.
- b- Les blessures isolées suffisent toujours à prouver une maltraitance.
- c. Seuls les professionnels de santé peuvent signaler la maltraitance.
- d- Les professionnels de santé ne peuvent intervenir que sur décision judiciaire.
- e- La maltraitance est toujours une action volontaire, jamais une négligence.

20- Les infractions pénales pouvant être commises par le médecin sont : (RJ)

- a- La violation du secret médical.
- b- L'assistance à personne en danger.
- c- L'impartialité.
- d- La rédaction de faux certificats.
- e- Les atteintes volontaires à l'intégrité physique.

21- Le certificat médical descriptif (RF)

- a. Comporte le bilan lésionnel et la prise en charge établie.
- b. Comporte une durée d'incapacité totale de travail.
- c. Constitue une dérogation relative au secret médical.
- d. Est remis à chaque fois qu'il existe un événement traumatique.
- e. Est remis à la demande.

22- Le certificat médical de constat de décès (RJ)

- a. Comporte une seule partie contenant des informations médicales.
- b. Est rédigé après examen externe.
- c. Est Remis à la personne présente le jour du décès.
- d. Permet l'inhumation en cas de mort naturelle.
- e. Permet l'ouverture d'une enquête judiciaire en cas de mort violente.

23- L'examen d'une victime d'agression sexuelle permet de retrouver : (RF)

- a. Une brûlure de taser.
- b. Une morsure au niveau du cou.
- c. Des encoches congénitales à 10h de la membrane hyménale.
- d. Une déchirure hyménale ancienne à 06h de la membrane hyménale.
- e. Un paquet hémorroïdaire.

24- Le certificat d'arrêt de travail : (RJ)

- a. Est un certificat obligatoire.
- b. Comporte l'identité des autorités requérantes.
- c. Comporte l'identité de la victime.
- d. Comporte le diagnostic.
- e. Comporte une période d'incapacité de réaliser des actes professionnels

25- Le dossier médical : (RJ)

- a. Comporte l'examen clinique et complémentaire.
- b. Comporte l'histoire de la maladie du patient.
- c. Comporte les correspondances avec d'autres praticiens.
- d. Est remis aux mains propres de l'intéressé.
- e. Est tenue par les techniciens de la santé.

CAS CLINIQUE

Une femme de 32 ans sans antécédents particuliers consulte pour douleurs abdominales aiguës sans fièvre évoluant depuis 72 heures. Elle est accompagnée par sa famille. Elle est consciente et coopérante. Un logiciel basé sur l'intelligence artificielle utilisé pour le tri des malades la classe en urgence relative (niveau 3)

Urgence niveau 3 : prise en charge rapide mais non immédiate.

La patiente prend alors place en salle d'attente.

02 heures plus tard elle est victime d'un malaise et perd connaissance subitement en salle d'attente. Le médecin de garde constate alors un état de choc. Elle est transférée immédiatement vers la salle de déchocage. En cours de réanimation, elle présente deux arrêts cardiaques successifs. Elle décède 48 après au service de réanimation.

La famille dépose plainte. L'autopsie effectuée sur réquisition du procureur de la république a mis en évidence une grossesse extra-utérine rompue avec péritonite aiguë.

26- Concernant la responsabilité médicale : (RJ)

- a. Elle ne peut être engagée qu'en cas d'intention de nuire du médecin
- b. Elle peut être engagée en cas de non-respect des données acquises de la science
- c. Elle ne peut pas être engagée dans cette situation en raison du contexte d'urgence.
- d. Elle est engagée dans ce cas pour le concepteur du logiciel d'IA.
- e. Réponse b et c sont justes

27- Quel type de faute médicale est à retenir dans ce cas ? (RJ)

- a. Imprudence et négligence
- b. Non- assistance à personne en danger
- c. Négligence
- d. Négligence et inobservation des règlements
- e. Toutes ces réponses sont justes

28- Quelle responsabilité peut être engagée dans cette situation ? (RJ)

- a. Disciplinaire
- b. Civile et pénale
- c. Administrative
- d. Réponses b et c sont justes
- e. toutes ces propositions sont justes

29- Quelles sont les bases juridiques de l'évaluation de la responsabilité médicale civile ? (RF)

- a. La preuve de la faute
- b. L'existence d'un dommage
- c. Le non-respect de la loi pénale
- d. Le lien de causalité entre la faute et le dommage
- e. Le non- respect des conditions du contrat médical

30- La responsabilité disciplinaire peut- être retenue dans cette situation sur la base : (RJ)

- a. Des dispositions du code pénal.
- b. Des dispositions en lien avec l'obligation de compétence du médecin.
- c. Aucune disposition, la responsabilité disciplinaire n'est pas engagée dans ce cas.
- d. De la disposition en lien avec la non-assistance à personne en danger.
- e. Réponses b et d sont justes

Examen Ophtalmo G3 / 2026

1. Les structures constituant les milieux transparents de l'œil : (cochez la réponse fausse)

- A. Cornée
- B. Humeur aqueuse
- C. Choroïde
- D. Cristallin
- E. Vitré

2. Structures appartenant à la voie optique :(cochez la réponse juste)

- 1. Nerf optique
- 2. Chiasma optique
- 3. Tractus optique
- 4. Corps genouillé latéral
- 5. Cortex visuel

A-(1+2+3+4) B-(2+3+4+5) C-(1+3+4+5) D-(1+2+4+5) E-(1+2+3+4+5)

3. Muscles responsables de l'élévation du globe oculaire : (cochez la réponse juste)

- 1. Droit supérieur
- 2. Oblique inférieur
- 3. Droit inférieur
- 4. Oblique supérieur
- 5. Droit médial

A(1+2) B-(1+4) C-(2+3+4) D- (1+2+5) E-(1+3+5)

4. Signes de kératite herpétique épithéliale: (cochez la réponse juste)

- 1. Ulcère dendritique
- 2. Hypoesthésie cornéenne
- 3. Photophobie
- 4. Hypertonie constante
- 5. Anneau immunitaire stromal

A-(1+2) B-(3+4) C-(1+2+3) D-(2+3+4) E-(1+2+3+4+5)

5. Caractéristiques optiques de la myopie axile : (cochez la réponse fausse)

- A. Image formée en avant de la rétine
- B. Globe oculaire allongé
- C. Correction par lentilles divergentes
- D. Pouvoir réfractif diminué
- E. Punctum remotum situé à distance finie

6. Signes neuro-ophtalmologiques d'atteinte du VI nerf crânien :(cochez la réponse juste)

- 1. Diplopie horizontale
- 2. Plus marquée en regard latéral
- 3. Diplopie verticale
- 4. MI Ptosis associé
- 5. Atteinte pupillaire

A (1+2) B- (2+3) C-(1+2+4) D-(1+2+5) E-(3+4+5)

7. Complications cornéennes d'un trachome avancé: (cochez la réponse fausse)

- A. Entropion
- B. Trichiasis
- C. Pannus cornéen
- D. Sclérite
- E. Xérosis cornéenne

8. Glaucome aigu par fermeture de l'angle : mécanismes physiopathologiques : (cochez la réponse fausse)

- A. Bloc pupillaire
- B. Augmentation de la pression dans la chambre postérieure
- C. Hyperproduction primitive d'humeur aqueuse
- D. Bombement irien antérieur
- E. Fermeture mécanique du trabéculum

9. La rétinopathie diabétique non proliférante sévère : les critères diagnostiques (règle 4-2-1): (cochez la réponse juste)

- 1. Les hémorragies intrarétiniennes dans 4 quadrants
- 2. Les anomalies microvasculaires intrarétiniennes AMIR dans 1 quadrant
- 3. Anomalies veineuses en chapelet dans 2 quadrants
- 4. La néovascularisation papillaire
- 5. L'hémorragie intravitréenne

A (1+2+3) B- (2+3+4) C-(1+3+5) D- (3+4+5) E-(1+2+4+5)

10. signe déterminant de la rétinopathie diabétique proliférante : (cochez la réponse juste)

- A. Microanévrismes
- B. Exsudats durs
- C. Néovascularisation
- D. Œdème maculaire
- E. Drusen maculaires

11. Signes de neuropathie optique glaucomateuse : (cochez la réponse juste)

- 1. Œdème papillaire
- 2. Réduction des fibres nerveuses rétiniennes à l'OCT
- 3. Déficit du champ visuel
- 4. Excavation papillaire
- 5. Héméralopie (altération de la vision nocturne)

A-(1+2+3) B(2+3+4) C-(1+2+3+5)D-(1+3+4+5) E-(2+3+4+5)

12. Signes cliniques de mélanome choroïdien : (cochez la réponse juste)

- 1. Lésion pigmentée intraoculaire
- 2. Décollement séreux de rétine
- 3. Exophtalmie
- 4. Cataracte
- 5. Apparait uniquement sur un nævus choroïdien préexistant

A (1+2) B-(1+2+5) C-(2+3+4) D- (1+3+5) E- (1+2+3+4+5)

13. les facteurs de risque d'occlusion veineuse rétinienne : (cochez la réponse fausse)

- A. Hypertension
- B. Diabète
- C. Hyperlipidémie
- D. Myopie forte
- E. Glaucome

14. Indications de photocoagulation panrétinienne : (cochez la réponse juste)

- 1. Rétinopathie diabétique proliférante
 - 2. DMLA atrophique
 - 3. Kératite bactérienne
 - 4. Uvéite chronique
 - 5. Occlusion veineuse rétinienne avec néovascularisation
- A-(1+2) B-(1+5) C-(1+2+5) D-(3+4+5) E-(1+2+3+4+5)

15. Facteurs de risque du glaucome à angle ouvert : (cochez la réponse fausse)

- A. Âge avancé
- B. Antécédent familial
- C. Myopie
- D. Hyperlipidémie
- E. Diabète

16. Traitement du glaucome primitif à angle ouvert : (cochez la réponse Juste)

- 1. Analogues des prostaglandines
 - 2. Bêtabloquants
 - 3. Les corticoïdes
 - 4. Anti-VEGF
 - 5. Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique
- A-(1+2+3) B-(1+2+5) C-(2+3+5) D- (1+3+4+5) E-(1+2+3+4+5)

17. Signes cliniques d'un décollement de rétine rhégmatoïde : (cochez la réponse juste)

- 1. Hypertonie oculaire
- 2. Associé à une déchirure rétinienne
- 3. Perte de vision
- 4. Douleur oculaire
- 5. Flash lumineux

A-(1+2+3) B-(2+3+5) C-(1+2+3+4) D-(1+3+4+5) E-(2+3+9+5)

18. Effets secondaires oculaires des corticoïdes topiques : (cochez la réponse fausse)

- A. Hypertonie oculaire
- B. Cataracte sous-capsulaire postérieure
- C. Retard de cicatrisation cornéenne
- D. Surinfection herpétique
- E. Myosis

19. Indications d'une échographie oculaire mode B : (cochez la réponse juste)

1. Décollement de rétine rhégmatoïde ou exsudatif, avec milieux opaques
2. Masse intraoculaire (mélanome choroïdien, rétinoblastome, hémangiome)
3. Opacification cristallinienne dense empêchant l'examen du fond d'œil
4. Hyphéma total ou hémorragie intravitréenne post-traumatique
5. Glaucome chronique simple sans suspicion de masse ou hémorragie

A-(1+2+4) B-(2+3+4) C-(1+3+5) D-(1+3+3+4) E-(1+2+3+5)

20. Indications d'une OCT maculaire dans la DMLA : (cochez la réponse juste)

1. Suivi des drusen
2. Détection d'œdème sous-rétinien
3. Suivi post-injection anti-VEGF
4. Détection de cataracte
5. Détection de néovascularisation choroïdienne

A-(1+3+4) B- (2+3+5) C-(1+2+3+5) D- 1+2+4+5 E-(1+2+3+4+5)

21. voies d'administration des corticoïdes en ophtalmologie : (cochez la réponse juste)

1. Topique.
2. Intraveineuse .
3. Intravitréenne
4. Intracaméculaire (chambre antérieure)
5. Orale

A-(1+3+5) B- (1+2+3+4) C- (2+3+4+5) D-(1+2+4+5) E-(1+2+3+4+5)

22. Objectifs du traitement du glaucome primitif à angle ouvert :(cochez la réponse juste)

1. Réduire la pression intraoculaire
2. Préserver le champ visuel
3. Stabiliser l'excavation papillaire
4. Soulager la douleur
5. Éviter les complications chirurgicales

A-(1+2+3) B-(1+2+4) C-(2+3+5) D-(1+3+4+5) E-(1+2+3+4+5)

23. Caractéristiques de la papille optique normale :(cochez la réponse juste)

1. Rapport cup/disc $< 0,4$
2. Respect de la règle ISNT (Inférieur-Supérieur-Nasale-Temporale)
3. Absence d'encoche de la papille
4. Absence d'hémorragie papillaire
5. Excavation totale

A-(3+4+5) B-(2+3+4) C-(1+3+5) D (2+3+9) E-(1+2+3+5)

24. Contre-indications systémiques des bêtabloquants topiques :(cochez la réponse juste) :

1. Asthme
2. Bloc auriculoventriculaire (BAV)
3. Insuffisance cardiaque décompensée
4. Hypertension artérielle
5. Bradycardie

A-(1+3+4) B-(2+3+4) C(1+2+3+5) D-(1+3+4+5) E-(1+2+3+4+5)

25. Causes d'hyphéma post-traumatisme : (cochez la réponse juste)

- 1. Traumatisme contusif
- 2. Rupture des vaisseaux de l'iris
- 3. Infection cornéenne
- 4. Décollement de rétine
- 5. Tumeur choroïdienne

A (1+2) B- (1+2+5) C- (2+3+4) D- (1+4+5) E-(1+2+3+4+5)

26. Signes de rétinopathie hypertensive : (cochez la réponse fausse)

- A. Rétrécissement artériolaire
- B. Hémorragies en flammèche
- C. Pigment orange
- D. Œdème papillaire
- E. Exsudats cotonneux

27. Signes cliniques d'une crise de glaucome à angle fermé aigu : (cochez la réponse juste)

- 1. Hypertonie oculaire
- 2. Douleur oculaire intense
- 3. Vision floue
- 4. Nausées et vomissements
- 5. Semi mydriase aréfléxique

A-(1+2+3) B-(1+3+5) C-(1+2+3+4) D-(2+3+4+5) E-(1+2+3+4+5)

28. Signes cliniques de la paralysie du nerf oculomoteur commun (III) : (cochez la réponse

- 1. Ptosis
- 2. Déviation de l'œil en bas et en dehors
- 3. Mydriase aréactive
- 4. Diplopie horizontale pure
- 5. Déficit de l'adduction

B 2+3+4 C 1+4+5 D 1+2+3+5 E 1+2+3+4+5

29. Facteurs de risque d'occlusion artérielle rétinienne : (cochez la réponse juste)

- 1. Hypertension
- 2. Athérosclérose carotidienne
- 4. Insuffisance cardiaque
- 5. Dyslipidémie

C- (1+2+4+5) D-(1+3+5) E-(1+2+3+4+5)

30. Signes d'une neuropathie optique compressive : (coches la réponse fausse)

- A. Déficit du champ visuel progressif
- B. Œdème papillaire
- C. Altération de l'acuité visuelle
- D. Douleur oculaire
- E. Perte de contraste et vision des couleurs altérée

PARTIE PRATIQUE :

Cas clinique 1 :

Une patiente de 27 ans, consulte pour douleur oculaire, photophobie et baisse de vision de l'œil droit depuis 2 jours,

Examen : Cercle périkératique, précipités rétro-cornéens, effet Tyndall, myosis, PIO normale.

Segment postérieur sans anomalie.

31. quelle est la pathologie la plus probable chez cette patiente ? (cochez la réponse juste)

- A. Uvéite antérieure aiguë
- B- Conjonctivite bactérienne
- C- Crise de glaucome aigu par fermeture de l'angle
- D- Kératite herpétique
- E- Sclérite antérieure

32. Quelles complications doivent être surveillées en cas de prolongation ou de récurrence de cette pathologie ? (cochez la réponse juste)

- 1. Synéchies postérieures
 - 2. Hypertonie oculaire
 - 3. Cataracte
 - 4. Sècheresse oculaire
 - 5. Décollement de rétine rhégmato-gène
- A-(1+2) B-(1+2+3) C-(2+3+4) D-(1+4+5) E-(1+2+3+4+5)

33. Quels traitements sont indiqués en première intention pour contrôler l'inflammation et limiter les complications chez cette patiente ? (cochez la réponse juste)

- 1. Corticoïdes topiques
 - 2. Mydriatiques
 - 3. Hypotonisants
 - 4. Corticoïdes généraux
 - 5. Traitement étiologique
- A-(1+2) B-(1+2+5) C-(1+2+3+5) D-(1+3+4) E-(1+2+3+4+5)

34. Quels facteurs peuvent favoriser la récurrence ou la chronicité de cette inflammation ? (Cochez la réponse fautive)

- A. Antécédent familial d'uvéite
- B. Non observance du traitement
- C. Infections systémiques
- D. Maladies auto immunes
- E. Stress ou fatigue

35. Quels paramètres doivent être surveillés pour éviter aggravation et complications ? (cochez la réponse juste)

- 1. Pression intraoculaire
 - 2. Formation de synéchies
 - 3. Rougeur persistante
 - 4. Larmoiement chronique
 - 5. Acuité visuelle
- A-(1+2+3) B- (1+2+5) C-(3+4+5) D-(1+3+4) E-(1+2+3+4+5)

Cas clinique 2 :

Nourrisson de 6 mois présenté par ses parents pour larmoiement permanent, photophobie et blépharospasme. L'examen sous anesthésie générale révèle une cornée légèrement élargie et trouble, une pression intraoculaire élevée.

36. Quelle est la pathologie la plus probable chez ce nourrisson ? (cochez la réponse Juste)

- A- Kératite virale
- B- Conjonctivite néonatale
- C- Cataracte congénitale
- D- Glaucome congenital
- E- Dystrophie cornéenne

37. Quels signes observés orientent le plus vers une hypertension oculaire congénitale ? (cochez la réponse fausse)

- A. Cornée élargie
- B. Cornée trouble (hazy cornea)
- C. Mydriase aréfléxique
- D. Blépharospasme
- E. Larmoiement

38. Quels examens sont essentiels pour confirmer le diagnostic et évaluer la sévérité ? (cochez la réponse juste)

- 1. Tonométrie adaptée à l'âge
 - 2. Diamètre cornéen
 - 3. Gonioscopie sous anesthésie
 - 4. OCT cornéenne
 - 5. Champ visuel (coopération limitée)
- A-(1+3) B-(1+2+3) C-(2+4+5) D-(1+4+5) E-(1+2+3+4+5)

39. En cas de retard de prise en charge, quelles complications peuvent survenir ? (cochez la réponse juste)

- 1. Atrophie optique
- 2. Décollement rétinien
- 3. Opacification cornéenne
- 4. Cataracte secondaire
- 5. Strabisme

A-(1+3+4) B- (1+2+5) C-(2+3+4) D- (1+3+5) E-(1+2+3+4+5)

40. Quels traitements sont de première intention pour contrôler la pression intraoculaire et prévenir les complications ? (cochez la réponse juste)

- A Chirurgie filtrante pédiatrique
- B. Collyres hypotonisants traitement de choix
- C. Mydriatiques
- D. Corticoïdes topiques
- E. Traitement étiologique systémique

Cas clinique 3 :

Ouvrier de 35 ans consulte pour douleur et baisse de vision après choc métallique à l'œil droit.

Examen : Cornée perforée, hypopion modéré, chambre antérieure peu profonde, corps étranger intraoculaire visible à l'imagerie adaptée.

41. Quelle est la pathologie la plus probable après ce type de traumatisme ? (cochez la réponse juste)

- A- Traumatisme contusif isolé
- B- Traumatisme perforant avec corps étranger intraoculaire ferrique
- C- Glaucome aigu post-traumatique
- D- Décollement rétinien post-traumatique
- E- Kératite bactérienne

42. Quel examen complémentaire est essentiel pour localiser et caractériser ce corps étranger intraoculaire ? (cocher la réponse Juste)

- A. Echographie oculaire en mode
- B. IRM oculaire
- C. Tomodensitométrie (TDM) oculo-orbitaire
- D. OCT maculaire
- E. Champ visuel

43. Quelles complications peuvent survenir après ce type de traumatisme ? (cochez la réponse juste)

- 1. Endophtalmie
 - 2. Décollement rétinien
 - 3. Ophtalmie sympathique
 - 4. Cataracte post-traumatique
 - 5. Opacification cornéenne
- A-(2+4) B-(1+2+4) C- (2+3+5) D- (1+3+5) E (1+2+3+4+5)

44. Quels traitements doivent être envisagés en urgence pour préserver la vision ? (cochez la réponse juste)

- 1. Extraction chirurgicale du corps étranger
 - 2. Suture de la cornée
 - 3. Collyres antibiotiques
 - 4. Corticoïdes en intravitréen
 - 5. Traitement hypotonisant
- A. (1+2+3) B-(1+2+4) C-(1+3+5) D-(2+4+5) E-(1+2+3+4+5)

45. Quelle complication spécifique peut survenir si le corps étranger ferrique n'est pas extrait rapidement ? (cochez la réponse juste)

- A. Hémorragie intravitréenne
- B. Chalcose
- C. Sidérose
- D. Décollement rétinien
- E. Néovascularisation choroïdienne

Cas clinique 4 :

Enfant de 3 ans présenté par ses parents pour strabisme et reflet blanc pupillaire à l'œil droit.

A l'examen : Pupille avec reflet blanc, strabisme, segment antérieur normal, fond d'œil : masse rétinienne blanchâtre avec calcifications.

46. Quelle est la pathologie la plus probable chez cet enfant ? (cochez la réponse juste)

- A- Glaucome congénital
- B- Cataracte congénitale
- C- Coats maladie
- D- Retinoblastome
- E- Dystrophie rétinienne

47. Quels signes orientent le plus vers une tumeur rétinienne ? (cochez la réponse juste)

- 1. Leucocorie
- 2. Strabisme récent
- 3. Hémorragie intraoculaire
- 4. Opacité cornéenne
- 5. Pupille réactive

A(1+2) B-(1+3+4) C-(2+3+5) D-(1+2+5) E-(1+2+3+4+5)

48. Quels examens sont essentiels pour confirmer le diagnostic et planifier le traitement ? (cochez la réponse juste)

- 1. Échographie oculaire
- 2. Fond d'œil détaillé sous anesthésie générale
- 3. OCT maculaire
- 4. IRM orbitaire
- 5. Champ visuel

A- (1+2+3) B- (1+2+4) C (2+3+5) D-(1+4+5) E-(1+2+3+4+5)

49. Quelles complications peuvent survenir en cas de progression non traitée ? (cochez la réponse fausse)

- A. Extension orbitaire
- B. Glaucome secondaire o
- C. Œdème papillaire
- D. Métastases cérébrales
- E. Décollement rétinien

50. Quels traitements sont envisageables selon la taille et la localisation de la tumeur ? (cochez la réponse juste)

- 1. Chimiothérapie systémique
- 2. Thérapie locale (laser, cryothérapie)
- 3. Enucléation
- 4. Collyres corticoïdes
- 5. Radiothérapie externe

A-(1+2) B-(1+2+3) C-(1+3+4) D-(1+2+3+5) E-(1+2+3+4+5)

Examen Maladies Systémiques G1/ 2026

1. Parmi les propositions suivantes concernant le purpura vasculaire aigu au cours des vascularites systémiques, laquelle est fausse :
 - A- Se caractérise par des lésions d'âges différents.
 - B- Son siège de prédilection est les membres inférieurs.
 - C- Peut se manifester par des lésions plus monomorphes nécrotiques.
 - D- Peut s'associer à un livedo s'il est dû à une inflammation pariétale.
 - E- Se caractérise cliniquement par un purpura infiltré.
2. Le syndrome pneumo-rénal au cours des vascularites systémiques se caractérise par (choisissez les réponses justes) :
 - A- La présence d'une atteinte pulmonaire type asthme bronchique.
 - B- La présence d'une atteinte rénale type syndrome néphrotique pur.
 - C- La présence obligatoire des anticorps anticytoplasme des neutrophiles (ANCA).
 - D- c'est une urgence diagnostique et thérapeutique
 - E- La présence de croissants glomérulaires à l'histologie rénale.
3. Quels sont les vaisseaux atteints au cours de la maladie de Behçet ? (Choisissez les réponses justes) :
 - A- Les vaisseaux de gros calibre.
 - B- Les vaisseaux de moyen calibre
 - C- Les vaisseaux de petit calibre
 - D- Les veines.
 - E- Toutes les réponses sont fausses.
4. Le syndrome de Cogan est caractérisé par (choisissez les réponses justes):
 - A- Une aortite possible.
 - B- Une fréquence rare.
 - C- Un vertige.
 - D- Une évolution lente favorable.
 - E- Toutes les réponses sont justes.
5. Concernant l'artérite à cellules géantes, choisissez la ou les réponses fausses:
 - A- Elle peut provoquer une cécité brutale si elle n'est pas traitée rapidement.
 - B- Elle touche les femmes âgées de moins de 40 ans.
 - C- L'imagerie par PET-scan n'a aucune utilité au diagnostic en cas d'atteinte des gros vaisseaux
 - D- La biopsie de l'artère temporale est l'examen de référence pour le diagnostic.
 - E- Elle peut s'associer à une pseudopolyarthrite rhizomélique.
6. Toutes les propositions suivantes sont une cause du syndrome pneumo-rénal sauf une, laquelle:
 - A- Le lupus érythémateux systémique.
 - B- L'endocardite infectieuse subaigüe.
 - C- La polyarthrite rhumatoïde.
 - D- Le syndrome de Goodpasture.
 - E- La cryoglobulinémie.

7. Parmi les signes cliniques de la maladie de Takayasu, on peut retrouver (choisissez la réponse fausse) :

- A- Une claudication des membres supérieurs à l'effort.
- B- Un accident vasculaire cérébral ischémique.
- C- Une hypertension artérielle rénovasculaire.
- D- Une VS (vitesse de sédimentation) calme.
- E- Une abolition asymétrique des pouls périphériques.

8. À propos de la périartérite noueuse (PAN), choisissez les réponses justes:

- A- Une atteinte neurologique périphérique avec mononévrite multiple est fréquente.
- B- Une ischémie digestive ou infarctus mésentérique peut survenir.
- C- Une glomérulonéphrite rapidement progressive est typique de la PAN.
- D- Elle touche préférentiellement les petits vaisseaux.
- E- Une biopsie musculaire ou nerveuse peut permettre le diagnostic histologique.

9. Parmi les manifestations cliniques du LES, on retrouve fréquemment (choisissez les réponses justes):

- A- Une atteinte cutanée photosensible.
- B- Une fièvre inexpliquée.
- C- Des arthrites érosives invalidantes appelées arthropathie de Jaccoud.
- D- La pleurésie est la manifestation respiratoire la plus fréquente du LES.
- E- Les ulcérations buccales font partie des critères diagnostiques.

10. Un homme de 35 ans atteint de lupus sous corticoïdes et Rituximab développe des convulsions. Parmi les étiologies possibles, on peut évoquer (choisissez les réponses justes):

- A- Une poussée neuro-lupique.
- B- Une crise comitiale hypoglycémique.
- C- Une leuco-encéphalopathie iatrogène.
- D- Une thrombose cérébrale liée au SAPL.
- E- Toutes les réponses sont justes.

11. Concernant les manifestations hématologiques du LES (choisissez la réponse fausse):

- A- Les cytopénies peuvent toucher toutes les lignées.
- B- La lymphopénie profonde est associée à une activité élevée de la maladie.
- C- Le syndrome d'Evans associe une anémie hémolytique et une thrombopénie.
- D- La thrombopénie est parfois satellite d'un syndrome des anti-phospholipides.
- E- L'anémie est exclusivement périphérique hémolytique auto-immune.

12. Lesquels des éléments suivants est un facteur de risque majeur de développement des granulomatoses systémiques ? (Choisissez les réponses justes):

- A- Le mycobacterium tuberculosis.
- B- La syphilis.
- C- Le béryllium
- D- Le déficit immunitaire commun variable.
- E- L'histiocytose langerhansienne.

13. Au cours de la maladie de Behçet, l'atteinte vasculaire (choisissez la proposition fausse) :

- A- Peut se manifester par des anévrismes.
- B- Peut se manifester par des sténoses artérielles.
- C- Peut toucher les vaisseaux cérébraux.
- D- Peut toucher les vaisseaux digestifs.
- E- Touche exclusivement les vaisseaux de gros calibre.

14. Quels sont les facteurs prédictifs de la survenue de la crise rénale sclérodermique?

(Choisissez les réponses fausses) :

- A- La forme cutanée diffuse.
- B- Prise de corticothérapie à 30 mg/j.
- C- Après 5 ans d'évolution.
- D- Présence d'AC anti ARN polymérase III.
- E- Présence d'AC anti topoisomérase I.

15. La vasculopathie au cours de la sclérodermie systémique est responsable de (Choisissez les réponses justes) :

- A- La pneumopathie interstitielle diffuse.
- B- La crise rénale sclérodermique.
- C- L'HTAP
- D- Les ulcères digitaux
- E- Les troubles du rythme cardiaque.

16. Quels éléments permettent de suspecter un VEDOSS (Very Early Diagnosis Of Systemic Sclerosis) ? (Choisissez les réponses justes) :

- A- Phénomène de Raynaud.
- B- PID avec une extension supérieure à 20 % au scanner thoracique
- C- Doigts boudiné.
- D- Anticorps antinucléaires.
- E- Syndrome restrictif à la spirométrie.

17. L'atteinte digestive de la sclérodermie systémique peut se manifester par tous les signes suivants sauf un, lequel ?

- A- Une incontinence fécale.
- v B- Un micro anévrisme des artères digestives.
- C- Une gastrite antrale télangiectasique
- D- Un syndrome de pseudo-obstruction intestinale.
- E- Une constipation.

18. Quelle est la principale protéine impliquée dans l'amylose AL ? (Choisissez la réponse juste) :

- A- Transthyrétine.
- B- Sérum amyloïde A.
- C- Chaînes légères d'immunoglobulines.
- D- Fibrinogène.
- E- Beta-2 microglobuline.

19. Quel signe est évocateur d'une atteinte cardiaque dans l'amylose AL ? (Choisissez la réponse juste) :

- A- La tachycardie sinusale.
- B- L'hypotrophie du VG.
- C- L'angor avec obstruction athéromateuse des coronaires.
- D- L'épanchement péricardique abondant.
- E- L'épaississement pariétal granuleux à l'échocardiographie.

20. L'atteinte digestive de l'amylose peut se manifester par (Choisissez les réponses justes) :

- A- Un syndrome de malabsorption intestinal.
- B- Une hémorragie digestive.
- C- Un endobrachyœsophage.
- D- Une maladie hémorroïdaire.
- E- Une macroglossie.

21. SAPL, on peut retrouver (choisissez la réponse fausse) :

- A- Végétations valvulaires.
- B- Une thrombose intracardiaque.
- C- Une dysfonction diastolique.
- D- Une Hypertension pulmonaire.
- E- Une endocardite bactérienne.

22. A propos du déficit immunitaire en IgA, choisissez les propositions justes :

- A- Il se manifeste exclusivement par des infections.
- B- Il peut être une forme du déficit immunitaire secondaire.
- C- Il peut être associé à une maladie cœliaque.
- D- Il peut parfois être en cause dans des accidents transfusionnels.
- E- Il peut se compléter par un déficit en IgG2 et IgG4.

23. Le Traitement des déficits immunitaires humoraux fait appel à (les réponses justes) :

- VA- Une substitution par immunoglobulines polyvalentes par voie intraveineuse.
- B- Une antibiothérapie précoce, prolongée et adaptée en cas d'infections.
- C- Une vaccination par des vaccins vivants atténués.
- D- Un arrêt impératif du tabac.
- E- Toutes les réponses sont justes.

24. A propos du déficit en complément C1 inhibiteur, choisissez les propositions justes :

- A- Il est exclusivement d'origine acquise.
- B- Il peut être à l'origine d'un angioœdème bradykinique.
- C- Il peut se voir au cours des hémopathies lymphoïdes.
- D- Son diagnostic repose uniquement sur le dosage antigénique du C1 inhibiteur.
- E- Toutes les réponses sont justes.

25. Les myosites inflammatoires associées aux anticorps anti-MDA 5 sont caractérisées par (choisissez les réponses justes) :

- A- Une atteinte musculaire obligatoire.
- B- Une atteinte respiratoire rapidement progressive.
- C- Une atteinte cutanée à type de calcifications.
- D- Une atteinte articulaire
- E- Toutes les réponses sont justes.

26. Concernant la maladie de Fabry, choisissez les réponses justes:

- A- C'est une maladie autosomique dominante.
- B- Le gène impliqué est GLA.
- C- L'activité enzymatique de l' α -galactosidase A est toujours effondrée chez les femmes.
- D- L'atteinte cardiaque est la cause de décès la plus fréquente.
- E- L'atteinte rénale est plus fréquente chez la femme que chez l'homme.

27. Concernant les atteintes neurologiques de la maladie de Fabry, la réponse fausse :

- A- Les AVC ischémiques sont fréquents.
- B- L'atteinte périphérique se manifeste par des acroparesthésies.
- C- La surdité est fréquente et liée à une atteinte cochléo-vestibulaire.
- D- La substance blanche n'est jamais touchée.
- E- La dolichoectasie du tronc basilaire est une anomalie possible.

28- Quels sont les signes précoces à l'ECG de la maladie de Fabry : RJ

- a) Raccourcissement du PQ +++
- b) Sus décalage du segment ST
- c) Raccourcissement de la durée de l'onde P
- d) Arythmies atriales
- e) Bloc auriculo ventriculaire de troisième degré

29- À propos des formes cliniques de la maladie de Gaucher, choisissez les réponses fausses

- A- Le type 2 est la forme la plus fréquente.
- B- Le type 3 peut être diagnostiqué chez l'adulte.
- C- Le type 2 associe splénomégalie et atteinte neurologique précoce.
- D- La forme fœtale se traduit souvent par un décès in utero.
- E- Le type 1 présente toujours une atteinte neurologique.

30- A propos de la maladie de Gaucher, choisissez les propositions justes

- A- Elle expose à un risque accru de maladie de Parkinson.
- B- Elle pourrait exposer à un risque de développement des pics monoclonaux et de myélome multiple.
- C- Les réducteurs de substrat sont le traitement de choix chez les métaboliseurs ultra-rapides.
- D- La splénectomie est systématiquement recommandée.
- E- La thérapie génique est largement utilisée.

31-À propos de la maladie de Kawasaki, choisissez les réponses justes :

- A- Elle touche préférentiellement les enfants de plus de 10 ans.
- B- La conjonctivite de la maladie de Kawasaki est bilatérale et purulente.
- C- L'atteinte cardiaque détermine la gravité de la maladie.
- D- L'éruption cutanée de type exanthème non vésiculeux est spécifique de la maladie.
- E- Les immunoglobulines sont le traitement de première intention.

32-A propos de l'atteinte rénale du purpura rhumatoïde chez l'enfant, choisissez les réponses fausses :

- A- Elle survient dans un quart des cas.
- B- Elle peut se présenter sous forme de syndrome néphrotique.
- C- L'atteinte rénale est toujours réversible.
- D- Une biopsie rénale est indiquée en cas de protéinurie isolée minime
- E- Les symptômes rénaux apparaissent dans 98 % des cas avant le 2e mois

33-À propos de la physiopathologie des maladies auto-immunes chez l'enfant, choisissez les réponses justes :

- A- Implique une rupture de la tolérance au soi.
- B- S'explique uniquement par des facteurs génétiques.
- C- Fait intervenir l'immunité adaptative.
- D- Implique parfois un dérèglement des lymphocytes T et B.
- E- Le stress psychologique est un facteur déclenchant possible.

34- Madame Nadia âgée de 47 ans est hospitalisée pour asthénie, fièvre, hématurie macroscopique et dyspnée. Elle présente un syndrome inflammatoire, une insuffisance rénale aiguë et protéinurie, et une hémoptysie modérée.

La recherche d'ANCA anti-Mpo est fortement positive. Une biopsie montre une glomérulonéphrite nécrosante pauci-immune, le diagnostic de polyangéite microscopique est posé. La patiente débute un traitement par bolus de méthylprednisolone puis prednisone Per Os avec une proposition du cyclophosphamide. Quels sont les effets indésirables classiques du cyclophosphamide à surveiller ? (Choisissez les réponses justes)

- A- Cystite hémorragique.
- B- Aplasie médullaire.
- C- Cécité rapide.
- D- Risque tératogène.
- E- Risque infectieux.

35- Nadia a refusé un traitement par le cyclophosphamide, vous optez pour un traitement biologique par Rituximab, avant de commencer le rituximab, quels examens sont indispensables ? (Choisissez les réponses justes) :

- A- Hémogramme.
- B- Sérologie virale B, C et HIV.
- C- Dosage pondéral des Immunoglobulines.
- D- Bilan lipidique.
- E- Intradermoréaction à la tuberculine (IDR) et/ou un test sanguin IGRA (Quantiféron®).

36- Quel élément biologique évoque fortement une poussée lupique (Choisissez la réponse juste)?

- A. Augmentation du C3 et C4
- B. Hyperleucocytose franche
- C. Hypocomplémentémie + élévation des anti-dsDNA
- D. Hyperkaliémie
- E. Éosinophilie à plus de 1500/mm³

37- Expression clinique du DICV (choisissez la réponse fausse)

- A-Des infections récurrentes.
- B- Des manifestations auto-immunes:
- C- Un syndrome lymphoprolifératif.
- D- Les granulomes
- E- Angiooedème bradykinique

38- Quelles sont les signes cutanés des principales des maladies auto-inflammatoires (choisissez les réponses justes)?

- A. Le pseudo-érysipèle de la cheville est classique dans la FMF
- B. L'urticaire au froid environnemental se voit dans les cryopyrinopathies
- C. Une urticaire est pathognomonique du déficit en MVK
- D. L'œdème périorbitaire se voit dans le syndrome TRAPS
- E. Les aphtes sont fréquents dans le déficit en MVK et le syndrome PFAPA.

39- Quel traitement, est obligatoirement associé avec le méthotrexate ? (choisissez la réponse juste) :

- A- Les anti-inflammatoires non stéroïdiens.
- B- Les antalgiques.
- C- L'acide folique.
- D- Les corticoïdes.
- E- Un antihistaminique.

40- Quels sont les déficits primitifs de la lignée B: RF

- A- Déficit sélectif en Ig A
- B- Déficit immunitaire commun variable (DICI)
- C- Agammaglobulinémie de Bruton
- D- Syndrome hyper- Ig M (SHIGM)
- E- Syndrome de DI-GEORGE

41- Concernant la grossesse au cours du lupus érythémateux systémique (LES), choisissez les propositions justes:

- A- La grossesse est formellement contre-indiquée au cours du LES.
- B- Une grossesse peut induire une poussée lupique
- C- La présence d'Anti-Ro/SSA est associée à un risque accru de lupus néonatal.
- D- L'azathioprine est contre-indiquée au cours de la grossesse pour éviter la toxicité fœtale.
- E- Les œstrogènes sont recommandés en cas de SAPL associé au LES au cours de la grossesse

42- Selon les critères de classification de l'ACR /EULAR 2019 du LES, Le diagnostic de lupus systémique est retenu lorsque le score (Choisissez la réponse juste) :

- A- Est supérieur à 6.
- B- Est supérieur à 7.
- C- Est supérieur à 8.
- D- Est supérieur à 10.
- E- Est supérieur à 20.

43- Selon les recommandations KDIGO 2024, la biopsie rénale au cours du LES est indiquée devant (choisissez la réponse juste) :

- A- Protéinurie des 24h ≥ 300 mg/24h.
- B- Le rapport protéine/créatinine urinaire ≥ 1000 mg/g.
- C- Protéinurie des 24h ≥ 300 mg et ≤ 500 mg/24h.
- D- Protéinurie des 24h ≥ 500 mg/24h et Le rapport protéine/créatinine urinaire ≥ 500 mg/g
- E- Clairance de la créatinine sanguine ≤ 60 ml/mn

44-Le syndrome pneumo-rénal peut se voir au cours des vascularites primitives suivantes (choisissez les réponses justes) :

- A- Les vascularites nécrosantes à ANCA.
- B- La vascularite lupique.
- C- L'endocardite infectieuse subaiguë.
- D- Le syndrome de Goodpasture.
- E- Toutes les réponses sont justes

45-A propos de l'atteinte rénale au cours des vascularites systémiques, choisissez les propositions justes :

- A- L'HTA réno-vasculaire est toujours présente.
- B- L'atteinte microvasculaire glomérulaire peut se manifester par un syndrome néphrotique.
- C- La détection des ANCA et les anticorps anti-MBG peut orienter l'étiologie.
- D- La glomérulonéphrite rapidement progressive peut se manifester par des croissants glomérulaires.
- E- Toutes les propositions sont justes.

46- Une femme âgée de 35 ans consulte pour asthénie, fièvre modérée et claudication des membres supérieurs chez qui le diagnostic de maladie de TAKAYASU IIb a été posé, l'exploration clinico-paraclinique chez cette patiente peut retrouver (choisissez les réponses justes):

- A- Une rétinopathie ischémique.
- B- Un souffle à l'auscultation des artères rénales.
- C- Une VS accélérée.
- D- Une infiltration granulomateuse vasculaire histologiquement.
- E- Toutes les réponses sont justes.

47-A propos du bilan immunologique réalisé au cours de la sclérodermie systémique, (choisissez les propositions justes) :

- A- Les anti-centromères sont associés à la forme cutanée limitée.
- B- Les anticorps anti-Scl70 sont associés à la forme cutanée diffuse.
- C- Les anti-ARN polymérase III sont associés à la crise rénale sclérodermique.
- D- Les anti-ARN polymérase III sont associés à une myosite.
- E- Toutes les propositions sont justes.

48- Au cours de la sclérodermie systémique, l'atteinte cutanée : RF

- A- Est souvent bilatérale.
- B- Est suffisante pour retenir le diagnostic si l'épaississement des doigts dépasse les articulations métacarpo-phalangiennes
- C- S'évalue habituellement par la mesure du score de Rodnan modifié.
- D- Peut être responsable de troubles de la pigmentation.
- E- Commence toujours au niveau du tronc et s'étend vers les membres supérieurs.

49-Concernant les granulomatoses systémiques, quelle proposition est juste ? RJ

- A. Elles sont toujours d'origine infectieuse
- B. La présence d'un granulome élimine une vascularite
- C. La granulomatose avec polyangéite peut atteindre les voies ORL
- D. L'atteinte pulmonaire est exceptionnelle
- E. Les ANCA sont constamment négatives

50-Concernant la sarcoïdose, quelle proposition est juste ? RJ

- A. Le granulome est caséeux
- B. L'atteinte pulmonaire est rare
- C. L'hypercalcémie peut être observée
- D. Les adénopathies médiastinales éliminent le diagnostic
- E. La biopsie n'a aucun intérêt diagnostique

Examen Maladies Systémique G3/ 2026

1. Parmi les propositions suivantes concernant le purpura vasculaire aigu au cours des vascularites systémiques, laquelle est fausse :
 - A- Se caractérise par des lésions d'âges différents.
 - B- Son siège de prédilection est les membres inférieurs.
 - C- Peut se manifester par des lésions plus monomorphes nécrotiques.
 - D- Peut s'associer à un livedo s'il est dû à une inflammation pariétale
 - E- Se caractérise cliniquement par un purpura infiltré.
2. Le syndrome pneumo-rénal au cours des vascularites systémiques se caractérise par (choisissez les réponses justes) :
 - A- La présence d'une atteinte pulmonaire type asthme bronchique.
 - B- La présence d'une atteinte rénale type syndrome néphrotique pur.
 - C- La présence obligatoire des anticorps anticytoplasme des neutrophiles (ANCA).
 - D- c'est une urgence diagnostique et thérapeutique
 - E- La présence de croissants glomérulaires à l'histologie rénale.
3. Au cours des vascularites systémiques, l'exploration radiologique par scanner associé à des séquences angioscannographiques peut montrer (choisissez les réponses fausses) :
 - A- Une aortite spécifique des vascularites à ANCA.
 - B- Des micro-anévrismes des artères viscérales au cours des vascularites des vaisseaux de moyen calibre.
 - C- Des sténoses vasculaires au cours de la maladie de TAKAYASU.
 - D- Des lésions de vascularites pulmonaires spécifiques de l'artérite à cellules géantes,
 - E- Des lésions de vascularite coronaire spécifique de la polyangéite microscopique. .
4. Quels sont les vaisseaux atteints au cours de la maladie de Behçet ? (Choisissez les réponses justes) :
 - A- Les vaisseaux de gros calibre.
 - B- Les vaisseaux de moyen calibre
 - C- Les vaisseaux de petit calibre.
 - D- Les veines.
 - E- Toutes les réponses sont fausses.
5. Le syndrome de Cogan est caractérisé par (choisissez les réponses justes):
 - A- Une aortite possible.
 - B- Une fréquence rare
 - C- Un vertige.
 - D- Une évolution lente favorable.
 - E- Toutes les réponses sont justes.
6. Concernant l'artérite à cellules géantes, choisissez la ou les réponses fausses:
 - A- Elle peut provoquer une cécité brutale si elle n'est pas traitée rapidement.
 - B- Elle touche les femmes âgées de moins de 40 ans. t
 - C- L'imagerie par PET-scan n'a aucune utilité au diagnostic en cas d'atteinte des gros vaisseaux.
 - D- La biopsie de l'artère temporale est l'examen de référence pour le diagnostic.
 - E- Elle peut s'associer à une pseudopolyarthrite rhizomélique.

7. Toutes les propositions suivantes sont une cause du syndrome pneumo-rénal sauf une ; laquelle .

A- Le lupus érythémateux systémique.

B- L'endocardite infectieuse subaigüe.

C- La polyarthrite rhumatoïde.

D- Le syndrome de Goodpasture.

E- La cryoglobulinémie.

8. Parmi les signes cliniques de la maladie de Takayasu, on peut retrouver (choisissez la réponse fausse) :

A- Une claudication des membres supérieurs à l'effort.

B- Un accident vasculaire cérébral ischémique.

C- Une hypertension artérielle renovasculaire)

D- Une VS (vitesse de sédimentation) calme. ,

E- Une abolition asymétrique des pouls périphériques.

9. À propos de la périartérite noueuse (PAN), choisissez les réponses justes:

A- Une atteinte neurologique périphérique avec mononévrite multiple est fréquente.

B- Une ischémie digestive ou infarctus mésentérique peut survenir.

C- Une glomérulonéphrite rapidement progressive est typique de la PAN. .

D- Elle touche préférentiellement les petits vaisseaux.

E- Une biopsie musculaire ou nerveuse peut permettre le diagnostic histologique.

10. Parmi les manifestations cliniques du LES, on retrouve fréquemment (choisissez les réponses justes):

A- Une atteinte cutanée photosensible.

B- Une fièvre inexpliquée

C- Des arthrites érosives invalidantes appelées arthropathie de Jaccoud.

D- La pleurésie est la manifestation respiratoire la plus fréquente du LES.

E- Les ulcérations buccales font partie des critères diagnostiques.

11. Un homme de 35 ans atteint de lupus sous corticoïdes et Rituximab développe des convulsions. Parmi les étiologies possibles, on peut évoquer (choisissez les réponses justes):

A- Une poussée neuro-lupique.

B- Une crise comitiale hypoglycémique.

C- Une leuco-encéphalopathie iatrogène

D- Une thrombose cérébrale liée au SAPL

E- Toutes les réponses sont justes.

12. Concernant les manifestations hématologiques du LES (choisissez la réponse fausse):

A- Les cytopénies peuvent toucher toutes les lignées.

B- La lymphopénie profonde est associée à une activité élevée de la maladie.

C- Le syndrome d'Evans associe une anémie hémolytique et une thrombopénie.

D- La thrombopénie est parfois satellite d'un syndrome des anti-phospholipides.

E- L'anémie est exclusivement périphérique hémolytique auto-immune.

13. Lesquels des éléments suivants est un facteur de risque majeur de développement des granulomatoses systémiques ? (Choisissez les réponses justes):

- A- Le mycobacterium tuberculosis.
- B- La syphilis.
- C- Le béryllium.
- D- Le déficit immunitaire commun variable.
- E- L'histiocytose langerhansienne.

14. Au cours de la maladie de Behçet, l'atteinte vasculaire (choisissez la proposition fausse) :

- A- Peut se manifester par des anévrismes.
- B- Peut se manifester par des sténoses artérielles.
- C- Peut toucher les vaisseaux cérébraux
- D- Peut toucher les vaisseaux digestifs.
- E- Touche exclusivement les vaisseaux de gros calibre.

15. Quels sont les acteurs principaux intervenant dans la physiopathologie de la sclérodermie systémique ? (Choisissez les propositions justes)

- A- La cellule musculaire striée.
- B- La cellule endothéliale.
- C- Le lymphocyte B.
- D- Le fibroblaste.
- E- Le kératinocyte.

16. Quels sont les facteurs prédictifs de la survenue de la crise rénale sclérodermique? (Choisissez les réponses fausses) :

- A- La forme cutanée diffuse.
- B- Prise de corticothérapie à 30 mg/J.
- C- Après 5 ans d'évolution.
- D- Présence d'AC anti ARN polymérase III.
- E- Présence d'AC anti topoisomérase I.

17. La vasculopathie au cours de la sclérodermie systémique est responsable de (Choisissez les réponses justes) :

- A- La pneumopathie interstitielle diffuse.
- B- La crise rénale sclérodermique.
- C- L'HTAP
- D- Les ulcères digitaux
- E- Les troubles du rythme cardiaque. .

18. Quels éléments permettent de suspecter un VEDOSS (Very Early Diagnosis Of Systemic Sclerosis) ? (Choisissez les réponses justes) ;

- A- Phénomène de Raynaud.
- B- PID avec une extension supérieure a 20% au scanner thoracique
- C- Doigts boudiné.
- D- Anticorps antinucléaires.
- E- Syndrome restrictif à la spirométrie.

19. L'atteinte digestive de la sclérodermie systémique peut se manifester par tous les signes suivants sauf un, lequel ?
- A- Une incontinence fécale.
 - B- Un micro anévrisme des artères digestives.
 - C- Une gastrite antrale télangiectasique.
 - D- Un syndrome de pseudo-obstruction intestinale.
 - E- Une constipation.
20. Quelle est la principale protéine Impliquée dans l'amylose AL ? (Choisissez la réponse juste) :
- A- Transthyrétine.
 - B- Sérum amyloïde A.
 - C- Chaînes légères d'immunoglobulines.
 - D- Fibrinogène.
 - E- Beta-2 microglobuline.
21. Quel signe est évocateur d'une atteinte cardiaque dans l'amylose AL ? (Choisissez la réponse juste) :
- A- La tachycardie sinusale.
 - B- L'hypotrophie du VG.
 - C- L'angor avec obstruction athéromateuse des coronaires.
 - D- L'épanchement péricardique abondant.
 - E- L'épaississement pariétal granuleux à l'échocardiographie.
22. L'atteinte digestive de l'amylose peut se manifester par (Choisissez les réponses justes) :
- A- Un syndrome de malabsorption intestinal.
 - B- Une hémorragie digestive.
 - C- Un endobrachyœsophage
 - D- Une maladie hémorroïdaire.
 - E- Une macroglossie.
23. Au cours du syndrome de Sjörge, le test de Schirmer est considéré positif si (choisissez la réponse juste) :
- A- > 10 mm à 5 minutes.
 - B- Entre 5 et 10 mm à 5 minutes.
 - C- > 15 mm à 5 minutes.
 - D- < 5 mm à 5 minutes.
 - E- Toutes les réponses sont fausses.
24. Au cours du syndrome de Sjörge, les manifestations extra-glandulaires peuvent être (choisissez les réponses justes) :
- A- Des arthrites destructrices.
 - B- Une pneumopathie interstitielle diffuse.
 - C- Une neuropathie périphérique.
 - D- Un purpura vasculaire.
 - E- Toutes les réponses sont justes.

25. Parmi les manifestations cardiaques du SAPL, on peut retrouver (choisissez la réponse fausse) :
- A- Des végétations valvulaires.
 - B- Une thrombose intracardiaque.
 - C- Une dysfonction diastolique.
 - D- Une Hypertension pulmonaire.
 - E- Une endocardite bactérienne.
26. A propos du déficit immunitaire en IgA, choisissez les propositions justes :
- A- Il se manifeste exclusivement par des infections.
 - B- Il peut être une forme du déficit immunitaire secondaire.
 - C- Il peut être associé à une maladie cœliaque.
 - D- Il peut parfois être en cause dans des accidents transfusionnels.
 - E- Il peut se compléter par un déficit en IgG2 et IgG4.
27. Le Traitement des déficits immunitaires humoraux fait appel à (choisissez les réponses justes) :
- A- Une substitution par immunoglobulines polyvalentes par voie intraveineuse.
 - B- Une antibiothérapie précoce, prolongée et adaptée en cas d'infections.
 - C- Une vaccination par des vaccins vivants atténués
 - D- Un arrêt impératif du tabac. .
 - E- Toutes les réponses sont justes.
28. A propos du déficit en complément C1 inhibiteur, choisissez les propositions justes :
- A- Il est exclusivement d'origine acquise.
 - B- Il peut être à l'origine d'un angioedème bradykinique.
 - C- Il peut se voir au cours des hémopathies lymphoïdes.
 - D- Son diagnostic repose uniquement sur le dosage antigénique du C1 inhibiteur.
 - E- Toutes les réponses sont justes.
29. Les myosites inflammatoires associées aux anticorps anti-MDA 5 sont caractérisées par (choisissez les réponses justes) :
- A- Une atteinte musculaire obligatoire.
 - B- Une atteinte respiratoire rapidement progressive
 - C- Une atteinte cutanée à type de calcifications.
 - D- Une atteinte articulaire.
 - E- Toutes les réponses sont justes
30. Concernant la maladie de Fabry, choisissez les réponses justes:
- A- C'est une maladie autosomique dominante.
 - B- Le gène impliqué est GLA.
 - C- L'activité enzymatique de l' α -galactosidase A est toujours effondrée chez les femmes.
 - D- L'atteinte cardiaque est la cause de décès la plus fréquente.
 - E- L'atteinte rénale est plus fréquente chez la femme que chez l'homme.

31. Concernant les atteintes neurologiques de la maladie de Fabry, choisissez la réponse fausse :

- A- Les AVC ischémiques sont fréquents.
- B- L'atteinte périphérique se manifeste par des acroparesthésies.
- C- La surdité est fréquente et liée à une atteinte cochléo-vestibulaire.
- D- La substance blanche n'est jamais touchée.
- E- La dolichoectasie du tronc basilaire est une anomalie possible.

32- Quels sont les signes précoces à l'ECG de la maladie de Fabry : RJ

- a) Raccourcissement du PQ +++
- b) Sus décalage du segment ST
- c) Raccourcissement de la durée de l'onde P
- d) Arythmies atriales
- e) Bloc auriculo ventriculaire de troisième degré

33- À propos des formes cliniques de la maladie de Gaucher, choisissez les réponses fausses :

- A- Le type 2 est la forme la plus fréquente.
- B- Le type 3 peut être diagnostiqué chez l'adulte.
- C- Le type 2 associe splénomégalie et atteinte neurologique précoce."
- D- La forme fœtale se traduit souvent par un décès in utero.
- E- Le type 1 présente toujours une atteinte neurologique.

34-A propos de la maladie de Gaucher, choisissez les propositions justes :

- A- Elle expose à un risque accru de maladie de Parkinson.
- B- Elle pourrait exposer à un risque de développement des pics monoclonaux et de myélome multiple.
- C- Les réducteurs de substrat sont le traitement de choix chez les métaboliseurs ultra-rapides
- D- La splénectomie est systématiquement recommandée.
- E- La thérapie génique est largement utilisée.

35-À propos de la maladie de Kawasaki, choisissez les réponses justes :

- A- Elle touche préférentiellement les enfants de plus de 10 ans.
- B- La conjonctivite de la maladie de Kawasaki est bilatérale et purulente.
- C- L'atteinte cardiaque détermine la gravité de la maladie.
- D- L'éruption cutanée de type exanthème non vésiculeux est spécifique de la maladie!
- E- Les immunoglobulines sont le traitement de première intention.

36-À propos de l'atteinte rénale du purpura rhumatoïde chez l'enfant, choisissez les réponses fausses : RF

- A- Elle survient dans un quart des cas.
- B- Elle peut se présenter sous forme de syndrome néphrotique.
- C- L'atteinte rénale est toujours réversible.
- D- Une biopsie rénale est indiquée en cas de protéinurie isolée minime. "
- E- Les symptômes rénaux apparaissent dans 98 % des cas avant le 2e mois .. ,

37- Madame Nadia âgée de 47 ans est hospitalisée pour asthénie, fièvre, hématurie macroscopique et dyspnée.

Elle présente un syndrome inflammatoire, une insuffisance rénale aiguë avec protéinurie, et une hémoptysie modérée.

La recherche d'ANCA anti-MPO est fortement positive. Une biopsie rénale montre une glomérulonéphrite nécrosante pauci-immune, le diagnostic de polyangéite microscopique est posé. La patiente débute un traitement par bolus de méthylprednisolone puis prednisone Per Os avec une proposition du cyclophosphamide. Quels sont les effets indésirables classiques du cyclophosphamide à surveiller ? (Choisissez les réponses justes) :

A- Cystite hémorragique.

B- Aplasie médullaire.

C- Cécité rapide.

D- Risque tératogène.

E- Risque infectieux.

38- Nadia a refusé un traitement par le cyclophosphamide, vous optez pour un traitement biologique par Rituximab, avant de commencer le rituximab, quels examens sont indispensables ? (Choisissez les réponses justes) :

A- Hémogramme.

B- Sérologie virale B, C et HIV.

C- Dosage pondéral des Immunoglobulines.

D- Bilan lipidique.

E- Intradermoréaction à la tuberculine (IDR) et/ou un test sanguin IGRA (Quantiféron®).

39- Les facteurs prédictifs de lymphome au cours du syndrome de Gougerot-Sjögren sont (choisissez les réponses justes):

A- La présence d'un purpura vasculaire.

B- L'atrophie des glandes salivaires principales.

C- La présence de cryoglobulinémie.

D- L'absence d'un composant monoclonal.

E- L'absence de lymphopénie.

40- Quel élément biologique évoque fortement une poussée lupique (Choisissez la réponse Juste)?

A. Augmentation du C3 et C4

B. Hyperleucocytose franche

C. Hypocomplémentémie + élévation des anti-dsDNA

D. Hyperkaliémie

E. Éosinophilie à plus de 1500/mm³

41- Selon L'OMS on parle d'une maladie rare lorsque (choisissez la réponse juste)

a) Une personne sur 100 est atteinte

b) Une personne sur 200 est atteinte

c) Une personne sur 1000 est atteinte

d) Une personne sur 2000 est atteinte

e) Une personne sur 20 est atteinte

42- Expression clinique du DICV (choisissez la réponse fausse)

- 1) Des infections récurrentes.
- 2) Des manifestations auto-immunes
- 3) Un syndrome lymphoprolifératif
- 4) Les granulomes
- 5) Angiooedème bradykinique

43- Quelles sont les signes cutanés des principales des maladies auto-inflammatoires (choisissez les réponses justes)?

- A. Le pseudo-erysipèle de la cheville est classique dans la FMF
- B. L'urticaire au froid environnemental se voit dans les cryopyrinopathies
- C. Une urticaire est pathognomonique du déficit en MVK
- D. L'œdème périorbitaire se voit dans le syndrome TRAPS
- E. Les aphtes sont fréquents dans le déficit en MVK et le syndrome PFAPA

44- Quel traitement, est obligatoirement associé avec le méthotrexate ? (choisissez la réponse juste) :

- A- Les anti-inflammatoires non stéroïdiens.
- B- Les antalgiques.
- C- L'acide folique.
- D- Les corticoïdes.
- E- Un antihistaminique.

45- Quels sont les déficits primitifs de la lignée B: RF

- 1. Déficit sélectif en Ig A
- 2. Déficit immunitaire commun variable (DICV)
- 3. Agammaglobulinémie de Bruton
- 4. Syndrome hyper- Ig M (SHIGM)
- 5. Syndrome de DI-GEORGE

46- Les Indications du traitement enzymatique substitutif dans la maladie de Gaucher sont (choisissez les réponses justes):

- A- Thrombopénie symptomatique ou taux de plaquettes ≤ 50 G/L.
- B- Anémie symptomatique et/ou taux d'hémoglobine ≤ 10 g/dL.
- C- Hépatomégalie et/ou splénomégalie.
- D- Atteinte osseuse cliniquement symptomatique.
- E- Atteinte osseuse radiologique à type d'infarctus, ostéonécrose ou fracture pathologique:

47- Concernant la grossesse au cours du lupus érythémateux systémique (LES), choisissez les propositions justes:

- A- La grossesse est formellement contre-indiquée au cours du LES.
- B- Une grossesse peut induire une poussée lupique.
- C- La présence d'Anti-Ro/SSA est associée à un risque accru de lupus néonatal.
- D- L'azathioprine est contre-indiquée au cours de la grossesse pour éviter la toxicité foetale.
- E- Les œstrogènes sont recommandés en cas de SAPL associé au LES au cours de la grossesse

48- Selon les critères de classification de l'ACR/EULAR 2019 du LES, Le diagnostic de lupus systémique est retenu lorsque le score (Choisissez la réponse juste) :

- A- Est supérieur à 6.
- B- Est supérieur à 7.
- C- Est supérieur à 8.
- D- Est supérieur à 10.
- E- Est supérieur à 20.

49- Selon les recommandations KDIGO 2024, la biopsie rénale au cours du LES est indiquée devant (choisissez la réponse juste) :

- A-Protéinurie des 24h $\geq$ 300mg/24h.
- B- Le rapport protéine/créatinine urinaire $\geq$ 1000 mg/g.
- C- Protéinurie des 24h $\geq$ 300mg et $\leq$ 500 mg/24h.
- D- Protéinurie des 24h $\geq$ 500 mg/24h et Le rapport protéine/créatinine urinaire $\geq$ 500 mg/g
- E- Clairance de la créatinine sanguine $\leq$ 60ml/mn.

50- Dans le cadre de la sclérodermie Cochez la ou les réponses justes

- a) Le phénomène de Raynaud comporte 3 phases et parmi les signes de gravités, on décrit : ulcères digitaux et nécrose digitale.
- b) La capillaroscopie fait partie des examens complémentaires en présence d'un phénomène de Raynaud.
- c) La sclérose cutanée au cours de la sclérodermie est évaluée par le score de Rodnan
- d) Le diagnostic de la pneumopathie interstitielle et de la fibrose se fait par une TDM thoracique HR
- e) L'HTAP est dépistée par l'écho doppler cardiaque

Examen Med de Travail G1 / 2026

1) Quel élément clinique permet de distinguer l'épuisement professionnel d'un épisode dépressif caractérisé ? (RJ)

- A. Altération globale et sévère de l'estime de
- B. Apparition de troubles du sommeil non éparateur
- C. Conservation du goût pour les activités extra-professionnelles
- D. Présence d'une fatigue émotionnelle et psychique intense
- E. Sentiment de désespoir étendu à tous les aspects de la vie

2) Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond spécifiquement une manifestation cognitive du burn-out ? (RJ)

- A. Anxiété, irritabilité et humeur dépressive
- B. Baisse de la tolérance à la frustration
- C. Comportements addictifs et isolement
- D. Diminution des capacités de concentration social
- E. Douleurs et tensions musculaires

3) Parmi les propositions suivantes, laquelle constitue l'une des trois dimensions fondatrices modèle tridimensionnel de Maslach relatif au Burnout ? (RJ)

- A. Augmentation de l'accomplissement personnel
- B. Dépersonnalisation de la relation à l'autre
- C. Développement progressif de conduites addictives
- D. Présence chronique de troubles musculosquelettiques
- E. Sentiment constant d'insécurité socio-économique

4) Le travail prolongé sur écran génère une sollicitation visuelle intense susceptible de provoquer une fatigue oculaire. Parmi les mesures préventives suivantes, laquelle est recommandée pour limiter le risque de fatigue visuelle liée à l'aménagement du poste de travail ? (RJ)

- A. Augmenter la température ambiante pour limiter l'assèchement oculaire
- B. Maintenir un éclairage direct et intense dirigé vers le centre de l'écran
- C. Placer les écrans de manière perpendiculaire par rapport aux fenêtres
- D. Positionner le moniteur de l'ordinateur nettement au-dessus du niveau des yeux
- E. Réduire le taux d'humidité ambiant dans les différents locaux de travail

5) Le syndrome du canal carpien est le syndrome canalaire le plus fréquemment rencontré lors de l'utilisation prolongée des TIC. Quel élément clinique ou paraclinique est caractéristique de cette pathologie ? (RJ)

- A. Allongement des latences de conduction à électromyogramme (EMG)
- B. Apparition de douleurs irradiant exclusivement vers la région de l'épaule
- C. Atteinte sensitive prédominante sur les deux derniers doigts de la main
- D. Paresthésies bilatérale dans le territoire du nerf cubital
- E. Signe de Tinel négatif lors de l'examen clinique

- 6) Selon la législation algérienne, quelle est la plage horaire définissant légalement le travail de nuit ? (RJ)
- A. Entre 19 heures et 05 heures du matin
 - B. Entre 19 heures et 07 heures du matin
 - C. Entre 21 heures et 05 heures du matin
 - D. Entre 21 heures et 07 heures du matin
 - E. Entre 22 heures et 06 heures du matin
- 7) Parmi les pathologies suivantes, quel type de cancer est spécifiquement reconnu comme un risque probable lié au travail posté selon le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) ? (RJ)
- A. Cancer colorectal
 - B. Cancer de l'endomètre
 - C. Cancer de l'ovaire
 - D. Cancer du poumon
 - E. Cancer du sein
- Un homme de 35 ans, exerçant comme peintre en carrosserie automobile depuis 4 ans, consulte en médecine du travail pour l'apparition progressive d'une dyspnée accompagnée de toux et d'une sensation sifflante d'oppression thoracique. Lors de l'interrogatoire, il précise que ses symptômes s'aggravent en fin de journée de travail et s'améliorent de façon spectaculaire pendant les week-ends et lors de ses congés annuels. À son poste, il utilise quotidiennement des peintures appliquées au pistolet. La spirométrie met en évidence un trouble ventilatoire obstructif réversible sous bronchodilatateur.
- 8) Sur le plan physiopathologique, comment se comporte l'agent chimique (de faible poids moléculaire) responsable de l'asthme chez ce travailleur ? (RJ)
- A. Il agit comme un antigène complet d'origine animale
 - B. Il agit comme un antigène complet d'origine végétale
 - C. Il agit comme un haptène (antigène incomplet)
 - D. inhibe l'enzyme cholinestérase induisant un bronchospasme
 - E. Il provoque une irritation directe sévère des voies aériennes
- 9) Compte tenu de l'évolution des symptômes, comment se classifie cette pathologie respiratoire ? (RJ)
- A. Asthme professionnel avec période de latence
 - B. Asthme professionnel sans période de latence chronique
 - C. Bronchopneumopathie obstructive
 - D. Pneumopathie d'hypersensibilité
 - E. Syndrome de Brooks

Un patient de 52 ans, chaudronnier depuis plus de 20 ans, consulte le médecin du travail. Son poste de travail implique l'utilisation quotidienne de marteaux pneumatiques sans protections auditives adaptées. Il se plaint d'une baisse progressive de l'audition. Il signale également des bourdonnements d'oreilles très gênants socialement. Un audiogramme tonal et vocal est prescrit.

10) Quel aspect audiométrique caractérise la lésion initiale (stade 1) de la pathologie auditive développée par ce travailleur ? (RJ)

- A - Déficit prédominant sur les fréquences ayes (250-500 Hz)
- B. Dissociation entre la conduction aérienne et conduction osseuse
- C. Scotome bilatéral sur la fréquence 4000 Hz
- D. Perte auditive asymétrique touchant principalement l'oreille droite
- E. Surdit  mixte

11)   l' ge de 52 ans, ce patient pr sente un facteur individuel physiologique pouvant s'ajouter au traumatisme sonore chronique et majorer sa perte auditive sur les fr quences aigu s. De quel ph nom ne s'agit-il ? (RJ)

- A. L'otospongiose bilat rale
- B. La maladie de M ni re
- C. La presbyacousie
- D. Le neurinome de l'acoustique
- E. Le ph nom ne de recrutement

12) Selon le tableau n'42 des maladies professionnelles de la l gislation alg rienne, quelle condition audiométrique est exig e pour ouvrir droit   la r paration d'une surdit  professionnelle ? (RJ)

- A. L'audiom trie de confirmation doit  tre r alis e imm diatement apr s l'arr t de l'exposition
- B. Le d ficit audiom trique moyen doit  tre calcul  exclusivement sur les fr quences conversationnelles
- C. Le d ficit moyen sur la meilleure oreille doit  tre strictement inf rieur   35 d cibels
- D. Le d ficit moyen sur la meilleure oreille doit  tre sup rieur ou  gal   35 d cibels
- E. Il s'agit d'une surdit  de transmission bilat rale et sym trique

13) Parmi les polluants professionnels suivants, quel est incrimin  dans plus de 80 % des cas de m soth liome pleural malin ? (RJ)

- A. Fibres d'amiante
- B. Hydrocarbures aromatiques polycycliques
- C. Particules de plomb
- D. Poussi res de bois exotiques
- E. Silice cristalline

14) Parmi les agents  tiologiques suivants, lequel constitue le r servoir antig nique responsable du d veloppement de la « maladie du poumon du fermier » ? (RJ)

- A. D jections et s rums d'oiseaux
- B. Fibres d'amiante (chrysolite)
- C. Foin et substances v g tales moisies
- D. Poussi res de silice cristalline
- E. Vapeurs d'oxydes m talliques

15) Quel est le rôle du médecin du travail en entreprise ? (1RJ)

1. Réaliser des visites de lieux
2. Sanctionner l'employeur en cas de défaut de prévention
3. Sanctionner le travailleur en cas de défaut de prévention
4. Réaliser des métrologies
5. Toutes les réponses sont justes

A/5 B/1+4 C/ 2+4 D/1+2 E/ 1+2+3

16) Quels sont les critères de déclaration d'un accident de travail ? (1 RJ)

1. Lien de causalité
2. Cause soudaine et extérieure
3. Il doit survenir exclusivement sur le lieu du travail
4. L'accord de l'employeur
5. Lien de subordination

A/1+2+5 B/1+2 C/1+2+4+5 D/1+2+3+5 E/ 1+2+3

17) A propos d'un agent biologique: RF

- A. Les prions sont dénués d'ADN
- B. Les mycotoxines sont à l'origine de cancers
- C. Les bactéries gram - sont à l'origine du syndrome des égoutiers
- D. Peuvent être à l'origine d'une hypersensibilité type I
- E. Leur transmission dépend de l'état immunitaire de l'hôte

18) Un psycho syndrome se caractérise par : RF

- A. Débute par des troubles de la mémoire et de la concentration.
- B. Est à l'origine de troubles de l'humeur
- C. Est à l'origine de troubles de sommeil.
- D. Peut Evoluer vers un syndrome démentiel
- E. Est caractérisé par une neuropathie périphérique

19) Un certificat médical d'aptitude est délivré suite à : (1RJ)

1. Visite médicale de reprise suite à un AT
2. Visite d'embauche
3. Visite périodique
4. Visite à la demande de l'employeur
5. Visite à la demande de l'employé

A/4+5 B/ 2+3 C/2+4 D/1+2+3 E/1+2+3+4+5

20) Lorsqu'un salarié se présente en consultation pour une aggravation d'un accident de travail survenu 2mois auparavant avec un certificat médical initial établi avec une IT à 00 jour. Quel type de certificat allez-vous rédiger ?

- A. Certificat médical de consolidation
- B. Certificat médical de guérison
- C. Certificat médical initial (rechute)
- D. Certificat médical de prolongation rechute)
- E. Certifiât de déclaration d'un accident de travail

21) A propos de l'anamnèse professionnelle : (1RJ)

1. Est réalisée par le médecin traitant
2. A pour but d'identifier les expositions antérieures
3. Permet de déterminer l'aptitude médicale
4. Permet de déterminer l'aptitude technique
5. Toutes les réponses sont justes

A/1+2+3 B/2+3 C/5 D/1+2+4 E/ 2+3+4

22) Quels sont les critères de déclaration d'une maladie professionnelle (1RF)

1. Le poste de travail doit figurer au niveau du tableau lorsqu'il s'agit d'une liste indicative
2. Respect du délai de prise en charge lorsque le salarié est toujours à son poste de travail
3. Le salarié est exposé de façon occasionnelle au risque
4. La maladie doit figurer dans les 85 tableaux
5. Durée d'exposition pour certains postes de travail

A/ 1+2+3 B/2+3 C/ 1+2+5 D/2+4 E/+3+4

23) Un cardiologue s'apprête à effectuer une coronographie, Quelles sont les précautions qu'il doit prendre ? RF

- A. Réduite le temps d'exposition
- B. Port de dosimétrie afin de réduire l'intensité des rayonnements
- C. Port de tablier plombé afin de réduire l'intensité des rayonnements
- D. Port de cache thyroïde afin de réduire l'intensité des rayonnements
- E. Optimiser les doses

24) Il s'agit d'une coiffeuse qui présente un eczéma de contact. Comment confirmer l'origine professionnelle : (1RJ)

1. Prick tests
2. Patch tests
3. Prélèvement cutanés
4. Test d'éviction- réintroduction
5. Mise en route d'un traitement à base de Corticoïdes

A/ 1+2 B/2+5 C/ 1+2+4 D/1+5 E/2+4

25) Il s'agit d'un homme travaillant dans la métallurgie depuis 10 ans, qui présente depuis 1 mois des coliques abdominales associés à une paralysie des longs extenseurs de 3^{ème} et 4^{ème} doigts. Quel diagnostic évoquez- vous ? RJ

- A. Intoxication aiguë au plomb
- B. Intoxication chronique au plomb
- C. Intoxication aiguë au mercure
- D. Intoxication chronique au mercure
- E. Intoxication aux solvants

26) Quel est le but de la santé au travail : RF

- A. Promouvoir un haut degré de bien être
- B. Adapter l'homme au travail
- C. Prévenir les effets néfastes sur la santé des
- D. Maintenir les travailleurs dans un environnement salubre
- E. Elle est régit par une réglementation stricte

27) A propos des perturbateurs endocriniens:

- A. Affecte le système endocrinien
- B. provoque des effets néfastes sur l'organisme intact
- C. Ne possède pas d'effets sur la descendance
- D. La plasturgie constitue l'une des sources d'exposition.
- E. Peuvent être naturelle ou artificielle.

28) A propos de la pollution atmosphérique : RF

- A. Peut-être naturelle et anthropique.
- B. Les valeurs limites à ne pas dépasser sont réglementées.
- C. Sa prévention est régie par la loi
- D. son mécanisme se déroule en une seule étape : l'émission.
- E. Provoque des atteintes cardio respiratoires.

29) Selon la classification de CIRC, Un agent du groupe 2B est : RJ

- A. Probablement non cancérigène pour l'homme
- B. Cancérigène pour l'homme
- C. Inclassable quant à sa cancérigénicité pour l'homme.
- D. Possiblement cancérigène pour l'homme.
- E. Probablement cancérigène pour l'homme.

30) A propos des sources d'exposition de nanoparticules : RF

- A. Uniquement liée à la fabrication et à l'utilisation intentionnelle des nanomatériaux.
- B. Liée aux procédés générant des particules ultrafines
- C. Peuvent être produites de manière+ involontaire
- D. Secteur de la métallurgie.
- E. Secteur automobile

Examen Travail G2 / 2026

1) Concernant l'accident de travail, la constatation de lésions : (RF)

- A. La victime doit consulter un praticien de son choix.
- B. Le médecin doit établir deux certificats.
- C. La victime déclare à l'employeur l'accident du travail sur un imprimé de déclaration d'accident du travail dans un délai de 48h.
- D. Le certificat initial est établi lors du premier examen médical qui suit l'accident.
- E. Le certificat de guérison en absence d'incapacité permanente et de consolidation si incapacité permanente, établis à la fin des arrêts de travail.

2) Une réponse est fausse concernant les caractéristiques du travail posté : (RF)

- A. C'est une organisation du travail dans laquelle plusieurs équipes se relaient successivement aux mêmes postes de travail.
- B. Travail à des horaires aléatoires.
- C. Le rythme est court ou long.
- D. Le sens de rotation normale ou inversé.
- E. Les équipes sont toujours fixes

3) Le mode d'action des perturbateurs endocriniens (RJ) :

- A. Effet uniquement antagoniste avec les hormones naturelles.
- B. N'est pas encore connu.
- C. N'interfèrent pas avec l'action des hormones naturelles.
- D. Agissent en simulant ou en bloquant les hormones naturelles.
- E N'interfèrent pas avec la synthèse des hormones naturelles.

4) Le psychosyndrome organique aux solvants : (RF)

- A. Débute par des troubles de la mémoire et de concentration.
- B. Est à (origine de troubles de l'humeur
- C. Est à l'origine de troubles de sommeil.
- D. N'évolue jamais vers un syndrome démentiel.
- E. Les premières phases sont. Réversibles lorsqu'on écarte le travailleur de l'exposition aux solvants.

5) Le syndrome intermédiaire : (R))

- 1. Est observée au cours de l'intoxication aiguë par des insecticides organo phosphorés.
- 2 Survient 10 à 14 jours après une exposition unique à un insecticide organophosphoré.
- 3. Est un syndrome neurotoxique retarde
- 4. Est un syndrome paralytique.
- 5. Implique une paralysie des muscles respiratoires, racines des membres et du coup.

A 1+2+4 B 1+2+5 C 3+4+5 D 3+5 E 4+5

6) Quels éléments peuvent provoquer des TMS liés aux TICs 7 (1RJ)

- 1. Travail en position debout uniquement
- 2. Absence d'appui pour les avant-bras
- 3. Position statique assise prolongée
- 4. Équipement ergonomique adéquat
- S. Utilisation prolongée du clavier

A 1+2+5 B 2+3+5 C 3+4 D 1+2+3 E 2+5

7) Quels éléments font partie des facteurs de risques psychosociaux liés au travail ? (1RF)

1. Conflits éthiques
2. Violences au travail
3. Travail de nuit
4. Manque de sommeil
5. Relations sociales harmonieuses

A 1+2-3 B 1+3+4 C 3+4 D 1+2 E 2+5

8) Concernant l'intoxication aiguë par les pesticides organophosphorés :(1RJ)

1. Entraînent une stimulation de l'acétylcholinestérase.
2. Les métabolites sont éliminés par voie urinaire
3. Les effets muscariniques apparaissent en premier.
4. Sont toutes réparées au titre du tableau N°34.
5. Le diagnostic de l'intoxication aiguë par les OP se base sur la détermination de l'activité cholinestérasique des globules ou du sérum.

A 1+2+3 B) 2+5 C 3+5 D 2-3+4+5 E 2+3+5

9) Le travail de nuit : (RF)

- A. Tout travail exécuté entre 21 heures et 5 heures du matin.
- B. Est une forme particulière du travail posté
- C. Les personnes âgées de moins de 19 ans révolus ne peuvent occuper un travail de nuit
- D. Est interdit au personnel féminin sauf dérogation spéciale.

Le diabète non insulino-dépendant constitue un motif d'inaptitude au travail de nuit.

10) Une réponse est fautive concernant l'exposome :(1 RF)

1. Signifie toutes les expositions subies par une personne au cours de sa vie.
2. Les expositions professionnelles d'une personne font partie du catalogue.
3. C'est l'association de facteurs génétiques, internes et externes.
4. Tiens compte des influences psychologiques.
- S. N'inclut pas le niveau socioéconomique du sujet.

A 1+3 B 1+5 C 2+3 D 2+4 E 3+5

11) Les pathologies respiratoires : (RJ)

- A Les BPCO professionnelles présentent une spécificité clinique et radiologique.
- B. L'asthme professionnel est de mécanisme allergique exclusivement.
- C. L'évolution des pneumoconioses se fait toujours vers la fibrose.
- D Les cancers broncho-pulmonaires ne présentent aucune particularité clinique, radiologique ou histologique.
- E. Les plaques pleurales sont des pathologies malignes de l'exposition à l'amiante

12) Concernant la surdité professionnelle : (1RJ)

1. Est une surdité de perception.
2. Débute par un scotome auditif au 4000 Hz.
3. Peut-être unilatérale.
4. Est toujours réversible après cessation de l'exposition au bruit.
5. Est toujours bilatérale.

A 1+2+3 B 1+3+4 C 1+2+5 D 2+4+5 E 1+2+3+4+5

13) Les pneumoconioses : (RF)

- A. Sont des pathologies pulmonaires provoquées par l'inhalation de particules Inorganiques.
- B. Peuvent évoluer vers la surcharge ou la fibrose pulmonaire
- C. Toutes les pathologies pleurales dus à l'amiante sont bénignes.
- D. L'exposition aux fibres d'amiante peut provoquer des cancers génito-urinaires.
- E. En cas d'empoussièrement massif, des silicozes graves peuvent se développer après quelques mois d'exposition,

14) Les sources d'exposition de Nanoparticules NP: RJ

- A. Uniquement liée à des procédés dont la finalité n'est pas la production de nanomatériaux.
- B. Uniquement liée à la fabrication et à l'utilisation Intentionnelle de nanomatériaux.
- C) liées aux procédés générant des particules ultrafines et à la fabrication et l'utilisation intentionnelle de nanomatériaux.
- D. Pas d'exposition aux NP dans les fonderies.
- E. Pas d'exposition aux NP lors d'émission de moteur diesel.

15) Le groupe 28 de la classification de CIRC correspond: RI

- A. Agent est cancérigène pour l'homme.
- B. Agent probablement cancérigène pour l'homme.
- C. Agent peut être cancérigène pour l'homme.
- D. Agent n'est probablement pas cancérigène pour l'homme.
- E. Agent inclassable quant à sa cancérigénicité.

16) L'évaluation du risque chimique se base sur : (RF)

- A. Analyse des fiches de données de sécurité
- B. Analyse des fiches toxicologiques
- C. Lecture des pictogrammes
- D. Réalisation de mesures atmosphériques
- E. Seuls les produits très dangereux sont évalués

17) Quels éléments sont Inclus dans une visite médicale d'aptitude (1RJ)?

- 1. Interrogatoire professionnel
- 2. Examen clinique complet
- 3. Prescription d'examens complémentaires
- 4. Évaluation des compétences techniques
- 5. Étude du poste de travail

A 1+3+4 B 1+2+3+5 C 1+3+5 D 1+2+4 E 1+2+3

18) Lorsqu'un travailleur présente une séquelle consécutive à un accident du travail, le médecin lui délivre : (RJ)

- A Un certificat médical de guérison
- Un certificat médical initial.
- Un certificat médical descriptif consolidation
- D. Une déclaration d'accident du travail.
- E. Un certificat médical d'aptitude.

19) Pourquoi l'anamnèse est-elle Importante en santé au travail (RJ) ?

- A. Elle permet uniquement d'évaluer les compétences du patient.
- B. Elle aide à établir un diagnostic en recueillant des antécédents professionnels.
- C. Elle est utilisée pour juger la performance du patient au travail.
- D. Elle ne concerne que les aspects psychologiques du patient.
- E. Elle se limite exclusivement au recueil des expositions du poste de travail actuel.

20) Les valeurs limites d'exposition aux polluants atmosphériques (RF) :

- A. Sont régies par la loi,
- B. Les mesures atmosphériques des toxiques sont réglementées.
- C. Ne sont pas réglés par la loi.
- D. Les méthodes d'échantillonnage sont effectuées selon les normes Algériennes.
- E. Permettent Le contrôle des rejets atmosphériques.

21) propos du risque biologique: RF

- A. Le risque infectieux dépend du mode de contamination
- B. Les mycotoxines peuvent être cancérogène
- C. Le traitement des déchets à risque Infectieux se fait par banalisation
- D. Le risque toxinique est lié à des phénomènes d'hypersensibilité
- E. La vaccination du réservoir est une étape essentielle de la rupture de la chaine de transmission

22) A propos des rayonnements ionisants: (1RF)

- 1. La radioactivité correspond aux nombre de désintégration par seconde
- 2. L'unité de mesure de la radioactivité est le sievert
- 3. Les effets stochastiques sont liés à la mort cellulaire
- 4. Les effets moléculaires sont liés principalement à la radiolyse de l'eau
- 5. Les effets déterministes sont secondaires aux mutations cellulaires

A 2+3 B 2+3+5 C 3+5 D 1+4 E 1+4+5

23) Quels sont les obligations de l'employeur: (RF)

- A Etablir une convention type
- B. Prise en charge de la médecine du travail
- C. Formation des salariés
- D. Prise en charge des examens complémentaires nécessaires pour déterminer l'aptitude
- E Aucune obligation en matière de sécurité, seul le travailleur est responsable

24) Les sources d'exposition des solvants : (RF)

- A, Secteur d'extraction
- B. Industrie pharmaceutique
- C. Agent de dégraissage
- D. Agent de soudage et découpage de la tôle
- E. Imprimerie

25) A propos des AES : (1RJ)

1. Sont secondaires à une piqure par aiguille stérile sur peau saine
2. Sont secondaires à une piqure par aiguille sur peau lésée
3. Les AES par aiguille pleine constituent un risque le plus important de contamination
4. Nécessitent une surveillance sérologique à 0-3- 6 mois
5. Toutes les réponses sont justes

A 5 B 1+3 C 2 D 1+4 E 2+3

26) La nocivité d'un bruit dépend de : (RF)

A. Pureté du bruit V

B. Intensité

C. Association avec des rayonnements

D. Type du bruit

E. Susceptibilité individuelle

27) Dermatoses professionnelles (1RF)

1. Une dermatose d'irritation est liée à 3 des phénomènes inflammatoires
2. Une eczéma de contact est lié à une hypersensibilité type I
3. Les dermatoses allergiques évoluent en 4 temps
4. La gale au ciment est favorisée par les conditions climatiques
5. Une dermite d'irritation disparaît dès l'arrêt de l'exposition

A 1+3+4+5 B 2+5 C 2 D 3+4 E 2+3+5

28) A propos de la prévention des toxiques: (1 RF)

1. la VME est la valeur seuil à ne pas dépasser pour une exposition de courte durée
2. Le niveau de contamination s'effectue par le dosage des toxiques dans le sang
3. Le niveau de d'exposition s'effectue par le dosage du toxique dans l'air
4. Les signes d'intoxication consistent à rechercher les signes cliniques pathologiques
5. Le port de protections individuelles représente le seul moyen efficace de prévention

A/2+3+4 B/ 1+2+3+4 C/ 2+3+5 D/3+4 E/1+5

29) A propos du mercure: (1RJ)

1. Il est stocké au niveau de l'os
2. Il est à l'origine d'une atteinte neurologique centrale et périphérique
3. Il est à l'origine d'un tremblement de repos
4. Son intoxication est appelée saturnisme
5. Le suivi des salariés est réalisé par le dosage du mercure urinaire

A 2+3+5 B 1+2+3 C 1+3 D 2+5 E 2+3+4

30) Les critères de déclaration maladie professionnelle (1RF) :

1. Le poste doit figurer au niveau du tableau en cas de liste indicative
2. Respect du délai de prise en charge
3. Le sujet est habituellement exposé au risque
4. Maladie répertoriée dans l'un des 88 tableaux
5. Durée d'exposition minimale pour certains tableaux

A 1+4 B 2+4+5 C 1+3+5 D 1+3+4 E 2+3+5

Examen UMC G3/ 2026

Q1. Les signes de gravité d'une envenimation scorpionique sont (RJ) :

1. Priapisme
2. Fièvre
3. Vomissements répétés
4. Encombrement bronchique
5. Sujet adulte

A:1+2+3 B : 2+4+5 C: 1+3+4 D:2+3+4 E:1+3+5

Q2. Le traitement de l'envenimation scorpionique grade III repose sur (RF) :

- A. Sérothérapie anti-scorpionique
- B. Drogue inotrope positive : Dopamine
- C. Oxygénothérapie ?
- D. Rappel sérique antitétanique (SAT) systématique
- E. Traitement de la douleur 2.

Q3. En cas d'envenimation Ophidienne le venin est de nature (RJ) :

1. Neurotoxique
2. Cardiotoxique
3. Histotoxique
4. Gastrotoxique
5. Hématotoxique

A:3+5 B:1+2+4 C : 2+5 D : 1+2+3 E : 1+5

Q4. Lors d'une réaction toxique en cas d'envenimation par hyménoptères la clinique est faite par (RF):

- A. Insuffisance rénale aiguë
- B. Rhabdomyolyse
- C. Hémolyse
- D. Insuffisance cardiaque aiguë
- E. Troubles de la coagulation

Q5. Cochez la réponse la ou les réponses fausses :

- A, L'être humain est homéotherme : sa température centrale varie entre 35°C et 37°C.
- B. L'abdomen est organe qui fait partie du noyau central.
- C. La mesure de la température de l'artère pulmonaire est la référence pour déterminer la température centrale.
- D. La mesure de la température rectale est peu fiable pour déterminer la température centrale
- E. Toutes les propositions sont justes.

Q6. La thermolyse : (cochez la ou les réponses justes)

- A. Se fait essentiellement à travers la peau
- B. Peut se faire par mouvement de fluides
- C. Peut se faire par transformation de liquides en vapeur
- D. Toutes les réponses sont justes. ?.
- E. Toutes les réponses sont fausses.

Q7. L'hypothermie : (cochez la ou les réponses justes)

- A. Est la baisse de la température de l'écorce (périphérique) en dessous de 35°C
- B. La baisse de la température centrale en dessous de 37°C A
- C. Est sévère entre 28 et 32°C
- D. A un effet protecteur sur le cœur et le cerveau
- E. Les causes accidentelles sont plus fréquentes.

Q8. En cas d'hypothermie le réchauffement doit être progressif car : (la ou les réponses justes)

- A. Il peut engendrer des troubles du rythme mortels.
- B Il peut engendrer un collapsus cardiovasculaire.
- C. Il peut engendrer des convulsions.
- D. Il peut engendrer des troubles des consciences irréversibles
- E. Toutes ses réponses sont justes.

Q9. Concernant la physiopathologie de la pendaison, le mécanisme responsable de la perte de connaissance rapide est principalement (RJ) :

- A. Une rupture trachéale
- B. Une obstruction bronchique bilatérale
- C. Une compression vasculaire cervicale entraînant une ischémie cérébrale
- D. Une fracture systématique des vertèbres cervicales
- E. Une embolie gazeuse cérébrale

Q10. Chez un patient victime de pendaison retrouvé inconscient avec suspicion de traumatisme cervical, la priorité initiale en urgence est :

- A. Administrer des diurétiques osmotiques
- B. Retirer immédiatement le collier cervical
- C. Réaliser une ponction lombaire
- D. Assurer la liberté des voies aériennes avec protection du rachis cervical
- E. Administrer un thrombolytique

Q11. La principale cause immédiate de dâche au cours d'une noyade est (RJ) :

- A. L'embolie pulmonaire
- B. L'arrêt cardiaque primaire
- C. L'hypoxémie secondaire à l'inhalation d'eau et au trouble ventilatoire
- D. L'insuffisance rénale aiguë
- E. L'hémorragie intracrânienne

Q12. Concernant la prise en charge pré hospitalière d'une noyade, laquelle des propositions est correcte ?

- A. Les compressions thoraciques doivent précéder toute ventilation
- B. L'antibiothérapie systématique est obligatoire
- C. L'intubation est indiquée chez tous les patients conscients
- D. L'oxygénothérapie précoce est essentielle²
- E. L'eau inhalée doit être évacuée par drainage postural prolongé

Q13. L'exploration radiologique initiale d'un polytraumatisé instable comprend

- A. Fast échographie au lit du patient
- B. Bodyscanner chez tous les patients
- C. IRM du rachis si une fracture est suspectée
- D. Des radiographies des membres si hypotension
- E. TDM cérébrale même si pas d'impact crânien

Q14. L'état de choc du polytraumatisé peut être secondaire à (les RJ)

- A. Un hémopéritoine
- B. Une Plaie du cuir chevelu
- C. Fracture du bassin
- D. Un hémopéricarde
- E. Fracture des deux os de la jambe

Q15. L'état de choc hémorragique nécessite (les RJ)

- A. Un remplissage par des cristaalloïdes
- B. Introduction des catécholamines
- C. Perfusion de dobutamine
- D. Perfusion d'acide tranexamique (Exacyl)
- E. Réchauffement

Q16. Le polytraumatisé est considéré grave R

- A. Femme enceinte au 1^{er} trimestre
- B. Un traumatisme pénétrant
- C. Décès dans l'accident 1
- D. Ischémie d'un membre
- E. État de choc initial

Q17. Le triage doit être réalisé : (RJ)

- A. Après l'examen médical
- B. Après les examens biologiques
- C. Dès l'arrivée du patient
- D. Après l'installation en salle de soins
- E. Après l'accord du médecin senior

Q18. Parmi les paramètres suivants, lequel est essentiel lors du triage ? (RJ)

- A. Groupe sanguin
- B. Tension artérielle
- C. Bilan hépatique
- D. Sérologie virale
- E. Électrophorèse des protéines

Q19. Le triage ne doit pas être confondu avec : #RF

- A. L'évaluation de la gravité
- B. La priorisation des soins
- C. Le diagnostic médical définitif
- D. L'organisation du flux des patients
- E. L'évaluation clinique initiale

Q20. Le professionnel le plus fréquemment responsable du triage est (RJ) :

- A. L'agent administratif
- B. L'infirmier formé au triage
- C. Le brancardier
- D. Le pharmacien
- E. Le biologiste

Q21. En préhospitalier le médecin régulateur va : (les RF)

- A. Prodiquer des conseils médicaux
- B. Relever les coordonnées de la personne en détresse
- C. Mobiliser une équipe mobile du SAMU
- D. Mobiliser une ambulance privée
- E. Est chargé de la réception et de la régulation des appels d'urgence

Q22. Lors du transport en pré hospitalier (RF)

- A. Le transport doit être le plus atraumatique et confortable possible
- B. Le lit vasculaire est très sensible aux accélérations/décélérations qui engendrent un déplacement brutal de la masse sanguine
- C. Risque d'inhalation/perturbations hémodynamiques
- D. Les contraintes imposées au corps humain sont 2 fois moins importantes lors d'un transport hélicoptéré que celles retrouvées lors d'un transport routier.
- E. Risque de déplacement du foyer de fracture surtout au niveau du rachis 2

Q23. Concernant la prise en charge de l'état de choc hémorragique en pré hospitalier ; quelles propositions sont correctes ? (Les RJ)

- A. Le garrot pneumatique est recommandé pour les hémorragies des membres non contrôlables par compression directe
- B. L'objectif tensionnel en cas de traumatisme pénétrant sans trauma crânien est une PAS entre 80-90mmhg
- C. Il faut perfuser le maximum de cristaalloïdes possible pour restaurer la volémie
- D. L'adrénaline est actuellement le vasopresseur le plus utilisé chez le traumatisé.
- E. L'apport de produits sanguins est très fréquent en pré hospitalier.

Q24. Concernant la détresse respiratoire aiguë en pré hospitalier (les RF)

- A. Un pneumothorax suffoquant doit être exsufflé en urgence ; sans attendre l'imagerie,
- B. L'intubation de la trachée est réalisée par voie orale avec une induction de l'anesthésie en séquence rapide
- C. Une oxygénation à haut débit est toujours nécessaire.
- D. L'intubation orotrachéale est réalisée si le score de Glasgow est inférieur à 7 X
- E. Une SPO2 cible entre 94-98% est recommandée chez l'adulte

Q25. L'effet Haldane correspond à : R J

- A. Une augmentation de l'affinité de l'Hb pour le CO₂ quand la PaO₂ diminue
- B. Une diminution de l'affinité de l'Hb pour le CO₂ quand la PaO₂ augmente
- C. Une augmentation de l'affinité de l'Hb pour l'O₂ quand la PaCO₂ diminue dans les tissus métaboliquement actifs
- D. Une diminution de l'affinité de l'Hb pour l'O₂ quand le pH diminue
- E. Une augmentation de la libération de radicaux libres pulmonaires

Q26. L'effet Bohr décrit :

- A. Une augmentation de l'affinité de l'Hb pour l'O₂ quand la PaCO₂, augmente
- B. Une diminution de l'affinité de l'Hb pour l'O₂ quand la PaCO₂ augmente ou que le pH diminue
- C. Une augmentation de l'affinité de l'Hb pour le CO₂ quand la PaO₂ diminue
- D. Une diminution de l'affinité de l'Hb pour le CO₂ quand la PaO₂ augmente
- E. Une augmentation de la PaO₂ lors d'une hyperventilation

Q27. Chez un patient insuffisant respiratoire chronique, l'hypercapnie sous oxygénothérapie est aggravée par : (les RJ)

- A. La levée du stimulus hypoxique au niveau des centres respiratoires
- B. La levée de la vasoconstriction hypoxique et augmentation de l'espace mort
- C. L'effet Bohr (libération accrue de CO₂)
- D. Une hyperventilation alvéolaire
- E. Une augmentation de la FiO₂ au-delà de 50 %

Q28. L'hypoxémie correspond à : (RJ)

- A. Une diminution de la PaCO₂
- B. Une réduction de l'apport d'oxygène aux tissus
- C. Une PaO₂ inférieure à 80 mmHg
- D. Une saturation en O₂ supérieure à 98 %
- E. Une hyperventilation alvéolaire

Q29. Une situation sanitaire exceptionnelle (RJ)

- 1. Correspond à l'arrivée d'un nombre de blessés pendant une période.
- 2. Est un événement inhabituel.
- 3. Survient dans un système de santé défaillant.
- 4. Relève de la médecine de catastrophe.
- 5. Est responsable d'une augmentation des besoins ou diminution des moyens.

A (1.2.4) B (3.4.5) C (2.4. 5) D (1.2.3) E (2.3.5)

Q30. Lors d'une catastrophe les objectifs seront :(RJ)

- 1. Sauver le plus grand nombre de vie possible.
- 2. Évacuer le maximum de blessés vers les structures quel que soit leurs capacités.
- 3. Traiter le maximum de victimes.
- 4. S'adapter aux moyens disponibles pendant cette période.
- 5. Le maintien de l'organisation initiale des structures médicale.

A (2.4.5) B (1.4.5) C (2.3.4) D (3.4.5) E (1.3.4)

Q31. : La gestion d'une catastrophe requière:(RJ)

- 1. Un renfort humain et matériel.
- 2. Un seul responsable de la gestion de crise.
- 3. Le triage des victimes.
- 4. L'organisation et la formation cible le personnel médical seulement.
- 5. Une priorisation des soins

A (2.4.5) B (1.3.5) C (1.2.3) D (3.4.5) E (2.3.5)

Q32. Pendant les catastrophes la classification des blessés en fonction du nombre (RI)

1. Catégorie 3 : plus d'une quarantaine de blessés appartenant au même accident.
2. Catégorie 2 : trente à cinquante blessés appartenant au même accident. .
3. Catégorie 2 : trente à quarante blessés appartenant au même accident.
4. Catégorie 1 : Jusqu'à trente blessés appartenant au même accident.
5. Catégorie 3 : plus d'une cinquantaine de blessés appartenant au même accident.

A (3.4.5) B (1.4.5) C (1.2.3) D (2.4.5) E (2.3.4)

Q33. La régulation médicale est définie comme : (RJ)

- A. Un acte administratif de tri des appels
- B. Un acte médical pratiqué au téléphone par un médecin régulateur
- C. Une simple orientation vers un médecin généraliste
- D. Une fonction paramédicale assurée par les assistants de Régulation Médicale (ARM)
- E. Une téléconsultation systématique

Q34. Parmi les missions légales du SAMU, on retrouve : (les RJ)

- A. Déterminer et déclencher la réponse adaptée dans le délai le plus rapide
- B. Assurer la disponibilité des moyens d'hospitalisation publics ou privés
- C. Organiser le transport vers un établissement approprié
- D. Veiller à l'admission du patient dans l'unité de soins concernée
- E. Fournir uniquement des conseils téléphoniques sans engagement de moyens

Q35. La médecine de catastrophe se caractérise par : (RF)

- A. Une médecine de l'exception et de l'urgence collective
- B. Une désorganisation initiale nécessitant des décisions rapides
- C. Un équilibre parfait entre besoins et ressources
- D. Un triage médical obligatoire
- E. Une prise en charge graduée du terrain vers l'hôpital

Q36. Les principes éthiques fondamentaux de la régulation médicale incluent : (les RI)

- A. Solidarité active
- B. Neutralité absolue envers tous les acteurs de santé (public / privé)
- C. Équité dans l'accès aux soins
- D. Prescription systématique de tous les moyens disponibles
- E. Obligation d'assistance à personne en péril

Cas clinique (les questions 37, 38, 39, 40)

Un homme de 35 ans, 70 kg, est admis aux urgences après un incendie domestique. Il présente des brûlures du thorax antérieur, de l'abdomen et des deux membres supérieurs.

A l'examen, certaines zones sont érythémateuses, d'autres présentent des phlyctènes. La surface brûlée est estimée à 36% de la surface corporelle totale.

Q37. Concernant l'évaluation de la gravité de cette brûlure (RF)

- A. Une brûlure de 36 % chez l'adulte est une brûlure grave.
- B. La règle des 9 peut être utilisée pour estimer la surface brûlée.
- C. Les brûlures du visage sont considérées comme des brûlures graves.
- D. La présence de phlyctènes évoque une brûlure du 2^e degré.
- E. La profondeur de la brûlure n'a aucun intérêt pronostique.

Q38. Concernant la physiopathologie des brûlures étendues (RF)

- A. Il existe une augmentation de la perméabilité capillaire.
- B. Une fuite liquidienne vers le secteur interstitiel survient précocement.
- C. Une hypovolémie peut apparaître rapidement.
- D. Une réponse inflammatoire systémique peut se développer
- E. Les brûlures n'entraînent aucune modification immunitaire.

Q39. Concernant la réanimation liquidienne initiale (RF)

- A. La formule de Parkland est couramment utilisée.
- B. Le remplissage se fait préférentiellement par cristalloïdes.
- C. La moitié du volume calculé est administrée durant les 8 premières heures.
- D. La diurèse est un paramètre de surveillance important.
- E. La réanimation liquidienne est inutile si le patient est conscient.

Q40. Concernant les complications des brûlures (RF)

- A. Le choc hypovolémique est une complication précoce.
- B. L'infection est une complication fréquente,
- C. Une insuffisance rénale aiguë peut survenir.
- D. Les brûlures peuvent entraîner une défaillance multiviscérale,
- E. Les cicatrices hypertrophiques sont impossibles après guérison.

Examen UMC 04/ 2026

Q1. Quel examen d'imagerie est considéré comme la "clé de voute "du bilan lésionnel chez un patient polytraumatisé stabilisé ? (RJ)

- A. La radiographie du thorax et du bassin au lit
- B. L'échographie FAST (Focussed Assesment with Sonography for Trauma) seule
- C Le scanner corps entier (Body-CT)
- D. L'IRM corps entier
- E. Le doppler transcrânien

Q2. Les causes de l'intubation orotrachéale chez le polytraumatisé sont : (RF)

- A. Des troubles de conscience.
- B. Une hypotension
- C. Une insuffisance respiratoire aiguë (traumatisme thoracique, pneumo ou hémothorax, inhalation)
- D. La nécessité d'une chirurgie sous anesthésie générale
- E. Un traumatisme facial important

Q3. Concernant l'hémodynamique chez un polytraumatisé sans traumatisme crânien, quelle affirmation est vraie ? (Les RI)

- A. Il faut maintenir une pression artérielle systolique (PAS>140 mmhg)
- B. Il faut remplir avec des cristalloïdes > 3 L durant les 3 premières heures de la prise en charge
- C. Il faut viser une hypotension permissive pour limiter le saignement
- D. Avoir un objectif de PA systolique de 80-90 mmHg jusqu'à la réalisation de l'hémostase
- E. Il faut une transfusion sanguine avec une hémoglobine cible>10g/l

Q4. Quel est le rôle du trauma leader aux urgences ? (Les RF)

- A. Assure la coordination des activités de chaque membre de l'équipe
- B. Assure la communication et a le pouvoir décisionnel définitif sur les choix thérapeutiques.
- C. Réaliser personnellement l'intubation et la pose des voies veineuses centrales
- D. Remplir le dossier administratif et appeler la famille
- E. C'est à lui que revient la décision ou non d'accepter le patient en fonction des données cliniques et de la disponibilité du plateau medicotechnique

Q5. Dans la prise en charge initiale d'un brulé : (RJ)

- A. Il faut continuer le refroidissement de la victime jusqu'à l'arrivée des secours
- B. Dans le cas d'un polytraumatisme la prise en charge de la brûlure est prioritaire
- C. Le remplissage vasculaire doit être débuté en milieu hospitalier
- D. La formule de CARJAVAL est celle utilisée chez l'adulte
- E. Doit commencer sur les lieux de l'accident

Q6. Les caractéristiques de la brûlure cutanée : (les RF)

- A La profondeur de la brûlure détermine le pronostic
- B. L'évaluation de la surface brûlée a un impact direct sur le traitement initial
- C. Les brûlures superficielles sont les moins douloureuses
- D. Les Âges extrêmes sont de meilleur pronostic
- E. La brûlure des mains expose à un risque fonctionnel

Q7. Lors d'une brûlure caustique : (les RF)

A/ L'endoscopie digestive haute reste le gold standard

B /Le scanner thoraco-abdominal est le gold standard

C/ L'endoscopie digestive trouve son indication dans le traitement des séquelles post caustiques

D/ Un TOGD est impératif à la phase aigue

E/ Une radiographie ASP peut imposer une chirurgie en urgence

Q8. Lors de la prise en charge d'une ingestion de caustique : (RJ)

A. Transfert de la victime en décubitus dorsal strict

B. La voie veineuse centrale jugulaire gauche est à proscrire

C. Il faut assurer une bonne analgésie avec sédation

D. Il faut mettre une sonde naso-gastrique pour vidange et lavage gastrique

E. Les Antiacides sont systématiques

Q9. Organisation générale des secours sur le terrain se fait de la façon suivante : (RF)

A. Collaboration étroite entre équipe médicale et SP (sapeurs-pompiers).

B Le Commandant des Opérations de Secours (C.O.S) est le SP le plus ancien dans le grade le plus élevé.

C. Le Directeur des Secours Médicaux (D.S.M) est le médecin le plus compétent sur le terrain.

D. Aucun soin sur le terrain avant la phase de reconnaissance et la mise en place du poste médical avancé (P.M.A).

E. Alerte des services de prévention pour rationaliser les soins d'urgences.

Q10. L'implantation des secours sur le lieu de l'accident doit se faire de la façon suivante : (RJ)

A. Le lieu est choisi par le COS et le DSM, qui en informent le SAMU. Il draine 500 à 1000 victimes.

B. L'emplacement est toujours dans l'hôpital de l'arrière.

C. Il doit être à proximité des voies de communication

D. Il doit être loin du lieu de la catastrophe.

E. Le COS est la seule habilité à désigner le lieu de secours en fonction des moyens disponibles

Q11. Le rôle du SAMU dans la prise en charge des victimes en cas de catastrophe consiste à : (RF)

A/ Prise en charge des moyens logistiques au niveau des hôpitaux d'arrière.

B/ L'envoi de la première équipe SAMU (médecin le plus qualifié).

C/ Préparer le matériel.

D/ Assurer du personnel supplémentaire.

E/ PC mobile.

Q12. Une catastrophe à effet limitée d'un risque majeur se définit par : (RJ)

4. Notion d'évènement habituel.

B. Un faible rayon.

C. Caractère collectif.

D. Des structures de commandement et de soins intacts.

E. Pas de risque évolutif

Q13. L'hyperthermie est : (RF)

- A/ Déséquilibre entre la thermogenèse et la thermolyse en faveur de la première
- B/ Une température centrale > ou égale 41 C
- C/ Risque de convulsion à 43 C
- D/ La fièvre est le maître symptôme
- E/ Coup de chaleur signifie la perte de la thermorégulation

Q14. La température centrale (les RJ)

- A/ Peut être mesurée au niveau rectale, buccale, œsophagienne et tympanique
- B/ Représente la température au niveau des organes situés dans la cavité crânienne, thoracique et abdominale
- C/ Elle est normale à l'alentour de 37 C
- D/ Elle est plus basse que la température périphérique
- E/ Elle est équivalent à la température périphérique

Q15. Le centre de la thermorégulation (thermostat représente) (Les RJ)

- A. Hypothalamus joue le rôle de régulateur
- B. La partie antérieure est le centre de la thermolyse
- C. La partie antérieure est le centre de la thermogenèse
- D. La partie postérieure est le centre de la thermogenèse
- E. La partie postérieure est le centre de la thermolyse

Q16. Cochez la réponse juste (RJ)

- A. Les mécanismes de la thermogenèse sont le rayonnement, conduction, convection et l'évaporation
- B. Lors de la thermolyse on a une vasodilatation des artérioles cutanées, une augmentation de la transpiration (sueur)
- C. Les mécanismes de la thermogenèse sont les frissons, augmentation de la libération de la tyrosine et l'augmentation de l'activité musculaire
- D. Selon la température, l'hypothermie a plusieurs stades allant de 35 C à 24 C
- E. Toutes ces réponses sont justes

Q17. Les signes de gravité d'une envenimation scorpionique sont (RJ) :

- 1. Priapisme
- 2. Fièvre
- 3. Vomissements répétés
- 4. Encombrement bronchique
- 5. Sujet adulte

A : 1+2+3 B : 2+4+5 C: 1+3+4 D : 2+3+4 E: 1+3+5

Q18. Le traitement de l'envenimation scorpionique grade III repose sur (RF) :

- A. Sérothérapie anti-scorpionique
- B. Drogue inotrope positive : Dopamine
- C. Oxygénothérapie
- D. Rappel sérique antitétanique (SAT) systématique
- E. Traitement de la douleur

Q19. En cas d'envenimation Ophidienne le venin est de nature (RJ) :

1. Neurotoxique
2. Cardiotoxique
3. Histotoxique
4. Gastrotoxique
5. Hematotoxique

A: 1+3 B : 1+2+4 C : 2+5 D : 1+2+3 E : 3+5

Q20. Lors d'une réaction toxique en cas d'envenimation par hyménoptères la clinique est faite par (RF) :

- A. Insuffisance rénale aigue
- B. Rhabdomyolyse
- C. Hémolyse
- D. Insuffisance cardiaque aigue
- E. Troubles de la coagulation

Q21. Concernant les objectifs fondamentaux du triage médical structuré à l'accueil des urgences, quelles sont les affirmations exactes ? (les RJ)

- A. Le triage vise prioritairement à identifier, dès l'accueil, les patients présentant une détresse vitale ou un risque de dégradation immédiate.
- B. Le triage permet d'attribuer à chaque patient un niveau de priorité associé à un délai maximal cible de prise en charge médicale
- C. Le triage a pour finalité d'orienter le patient vers la filière de soins la plus adaptée à son état (pédiatrie/adulte, consultation/urgence vitale, ambulatoire/hospitalisation).
- D. Le triage médical garantit systématiquement une prise en charge médicale complète dans un délai inférieur à 30 minutes, quel que soit le niveau de gravité.
- E. Le triage constitue un acte médical diagnostique permettant d'établir avec certitude l'étiologie de la pathologie du patient avant l'examen médical approfondi.

Q22. Parmi les outils suivants, lesquels sont utilisés pour le triage et l'évaluation initiale du patient traumatisé grave ? (Les RJ)

- A. Score NISS (New Injury Severity Score)
- B. Critères de Vittel
- C. Score ROSIER (Recognition of Stroke in the Emergency Room)
- D. Score ISS (Injury Severity Score)
- E. Score qSOFA (Quick Sequential Organ Failure Assessment)

Q23. Concernant les critères de Vittel, quelles sont les propositions exactes ? (Les RI)

A. Les critères de Vittel comportent cinq domaines d'évaluation : variables physiologiques, cinétique de l'accident, lésions anatomiques, gestes de réanimation préhospitalière et terrain du patient.

B. La présence d'un volet thoracique constitue un critère anatomique suffisant pour retenir un traumatisme grave selon Vittel.

C. Un remplissage vasculaire préhospitalier supérieur à 1 000 ml représente un critère de réanimation préhospitalière valide au sens des critères de Vittel.

D. La définition du traumatisme grave selon Vittel requiert la présence simultanée d'un score de Glasgow < 13, d'une pression artérielle systolique < 90 mmHg et d'une saturation pulsée en oxygène < 90 %.

E. L'identification d'un seul critère de Vittel, quel que soit son domaine, justifie l'orientation prioritaire du patient vers un trauma center de niveau adapté.

Q24. Concernant l'Index de Choc (Shock Index - SI) et son utilisation clinique, quelles sont les affirmations exactes ? (Les RJ)

A. L'Index de Choc se calcule par le rapport Fréquence Cardiaque / Pression Artérielle Systolique ($SI = FC / PAS$).

B. Un Index de Choc $\geq 0,9$ indique une instabilité hémodynamique et un Index $> 1,0$ suggère un choc précoce.

C. L'Index de Choc est un indicateur tardif qui ne s'élève qu'après la chute de la pression artérielle systolique.

D. L'Index de Choc est utile pour détecter précocement l'hypovolémie avant même la baisse de la pression artérielle systolique et corrèle avec l'élévation du lactate et la mortalité.

E. L'Index de Choc n'est pas influencé par les médicaments β -bloquants ou bradycardisants, ce qui en fait un outil fiable dans toutes les situations cliniques.

Q25. La régulation médicale correspond à (RJ)

A. L'organisation hospitalière des urgences

B. Une réponse médicale à une demande urgente par téléphone

C. Une consultation spécialisée à distance

D. Un tri administratif des patients

E. L'orientation systématique de tous les appelants vers des centres spécialisés

Q26. les objectifs de la régulation médicale (RF)

A. Optimiser l'utilisation des ressources

B. Apporter une réponse rapide et adaptée

C. Réduire le nombre d'appels

D. Assurer la sécurité du patient

E. Soulager les centres d'urgences intra hospitaliers

Q27. Après discussion médecin régulateur- appellant, le médecin régulateur peut (RF)

A. Orienter le patient vers son médecin traitant

B. Orienter le patient vers un service d'urgence

C. Donner un simple conseil à domicile

D. Faire une simple prescription médicamenteuse

E. Obliger le patient à se rendre aux urgences malgré son refus

Q28. Concernant les acteurs de la régulation médicale (RF) :

- A. Le médecin régulateur prend les décisions médicales
- B. L'assistant de régulation médicale (ARM) pose le diagnostic
- C. L'ARM recueille les informations essentielles
- D. Le médecin régulateur peut déclencher un SMUR
- E. La responsabilité médico-légale du médecin régulateur est engagée

Q29. Le rôle de l'équipe de la médecine préhospitalière est de : (RJ)

- A. Éliminer avec certitude la présence d'une détresse vitale
- B. Prise en charge immédiate d'une défaillance d'organe.
- C. Transporter le patient vers la structure sanitaire la plus proche
- D. Ajustement thérapeutique d'une maladie chronique
- E. Réaliser le bilan lésionnel d'un patient accidenté.

Q30. Dans la terminologie de la médecine préhospitalière : (RJ)

- A. SAMU désigne l'équipe mobile qui accompagne le patient.
- B. Le médecin régulateur est celui qui assure l'évacuation du malade.
- C. La protection civile fait partie intégrante du SAMU, et elle assure les mêmes fonctions.
- D. SMUR est l'unité qui coordonne les appels d'urgences et organise les interventions.
- E. Toutes ces réponses sont fausses.

Q31. La médecine préhospitalière en ALGERIE répond à quel concept ? (Les RJ)

- A. Le concept de la « GOLDEN HOUR »

Le concept du « SCOOP AND RUN »

Le concept du « STAY AND PLAY »

- D. Le concept du « SCOOP AND PLAY »

Le concept du « PLAY AND RUN »

Q32. L'équipe du SAMU est tenue de : (RJ)

- A. Gérer les détresses vitales du patient
- B. Transmettre les données du recueil et du transport au médecin de garde au niveau de la structure sanitaire de prise en charge.
- C. Choisir la structure sanitaire la mieux adaptée pour la prise en charge des patients.
- D. Maintenir l'état du malade le plus stable durant le transport.
- E. Toutes ces réponses sont justes.

Q33. Dans la pénétration, la stimulation du sinus carotidien peut provoquer (RJ)

- A. Une tachycardie
- B. Une bradycardie sévère
- C. Une hypertension artérielle
- D. Une hyperthermie
- E. Une polyurie

Q34. Une dysphonie ou une dyspnée après pénétration doit faire suspecter en priorité (RJ)

- A. Une pneumonie
- B. Une lésion laryngée
- C. Une embolie pulmonaire
- D. Une crise d'asthme
- E. Une insuffisance cardiaque

Q35. Les complications de l'oxygénothérapie : (Les RJ)

- A. Toxicité pulmonaire de l'oxygène
- B. Atélectasie d'absorption
- C. Hypercapnie chez certains patients
- D. Hypoglycémie
- E. Hypoxie

Cas clinique

Suite à une explosion dans une usine, un afflux massif de victimes arrive aux urgences. Le plan blanc est avancé. Une femme de 28 ans est prise en charge au SAU : confuse (SGG 13/15), présentant une plaie thoracique latérale droite avec bruit de succion (plaie soufflante), SpO₂ = 88 % sous air ambiant, FR = 28/min, FC = 130 bpm, PA = 80/50 mmHg, TRC = 4 seconds, Fracture fermée du fémur gauche, Température = 35°C

Q36. Selon le triage START-ABC, cette patiente est classée (RJ):

- A. Urgence relative (UR)
- B. Urgence absolue (UA)
- C. U1
- D. Décédée
- E. E U2

Q37. Quel élément est PRIORITAIRE dans la prise en charge immédiate (RJ)

- A. Un cathéter veineux
- B. Intubation immédiate
- C. Pansement occlusif 3 côtés
- D. Immobilisation de la fracture du fémur
- E. Administration d'antalgiques

Q38. Selon l'algorithme MARCHE, l'ordre correct de priorité est (RJ):

- A. Voies respiratoires > Circulation > Respiration-> Hypothermie
- B. Hémorragie massive -> Voies respiratoires -> Respiration -> Circulation -> Hypothermie
- C. Circulation > Voies respiratoires > Respiration-> Hémorragie
- D. Respiration -> Circulation > Voies respiratoires > Hypothermie
- E. E Hémorragie > Circulation > Respiration -> Voies Respiratoires

Q39. Quelle stratégie thérapeutique est la plus adaptée dans ce contexte ? (RJ)

- A. Chirurgie complète immédiate
- B. Attente des examens complémentaires
- C. Damage control
- D. Traitement orthopédique prioritaire
- E. E Surveillance simple en salle de déchocage

Q40. Concernant la prise en charge hémodynamique initiale, quelle est la meilleure stratégie? (RJ)

- A. Remplissage massif par cristaalloïdes seuls (2-3 L rapide)
- B. Transfusion précoce avec ratio CGR/PFC/Plaquettes 1/1/1
- C. Noradrénaline en première intention sans remplissage
- D. Attendre le bilan biologique avant toute correction
- E. Remplissage modéré + acide tranexamique précoce